Минздрав России
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ
Декан лечебного факультета
_____ И.Ю. Якимович
29 мая 2025

ПРОГРАММА
государственного экзамена

Для специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
Форма обучения очная

Томск 2025 г.

Кафедра госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии
и спортивной медицины
Заведующий кафедрой, д-р мед. наук, профессор _____ В.В. Калюжин
«27» 03 2025 г

Кафедра госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии
Заведующий кафедрой, д-р мед. наук,
профессор, член-корреспондент РАН _____ Г.Ц. Дамбаев
«27» 03 2025 г

Кафедра акушерства и гинекологии
Заведующий кафедрой, д-р мед. наук _____ И.Г. Куценко
«27» 03 2025 г

Согласовано:
Научно-медицинская библиотека,
заведующий отделом _____ Е.В.Рыбакова
«27» 03 2025 г

Председатель методической комиссии по специальностям
31.05.01 «лечебное дело» и
31.05.03 «стоматология» _____ И.Ю. Якимович

Протокол от « 29 » 05 2025 г. № 4

1. Цель

Целью государственного экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) № 95 от 9 февраля 2016 г.).

2. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения основной образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные образовательной программой:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала;
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности;
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности;
- способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности;
- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;
- готовность к ведению медицинской документации;
- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач;
- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач;
- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач;
- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи;
- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи;

- способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;
- способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;
- способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения;
- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания;
- способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра;
- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека;
- способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами;
- готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
- готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
- готовность к ведению физиологической беременности, приему родов;
- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;
- готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
- готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний;
- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни;
- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей;
- способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;
- готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины;
- способность к участию в проведении научных исследований;
- готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан.

3. Структура

Государственный экзамен состоит из двух этапов:

I этап проводится в форме проверки уровня теоретической подготовленности путем тестового экзамена;

II этап проводится в форме итогового собеседования по ситуационным задачам.

Этап первый (тестирование)

1. К первому этапу государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по актуальной образовательной программе высшего образования.

2. I этап государственного экзамена проводится в форме проверки уровня теоретической подготовленности путем тестового экзамена.

3. Тесты включают вопросы, направленные на проверку общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

4. Государственный экзамен на I этапе проводится в аудиториях ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России в соответствии с расписанием.

5. Проведение I этапа государственного экзамена контролируют члены государственной экзаменационной комиссии.

6. При прохождении I этапа государственного экзамена студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

7. Непосредственно подготовка студента к государственному экзамену на I этапе включает:

- повторение пройденного теоретического материала;
- изучение тестовых заданий прошлых лет.

8. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого из Единой базы оценочных средств.

9. Время для выполнения заданий устанавливается в соответствии с требованиями образовательного стандарта и составляет 1 час.

10. Результат тестирования формируется с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий и оценки: «зачтено», «не зачтено».

11. Критерии оценки результатов I этапа государственного экзамена:

- оценка «зачтено» выставляется выпускнику, давшему правильные ответы на70% и более вопросов;
- оценка «не зачтено» выставляется выпускнику, правильно ответившему менее, чем на 70% вопросов.

12. По итогам I этапа государственного экзамена в протокол проставляются соответствующие оценки.

13. Результаты I этапа государственного экзамена объявляются выпускнику в день его проведения.

Этап второй (решение ситуационных задач)

1. Ко второму этапу государственного экзамена допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по актуальной образовательной программе высшего образования.

2. Для проведения II этапа государственного экзамена из числа членов утвержденной в установленном порядке государственной экзаменационной комиссии формируется 6 экзаменационных комиссий, в состав которых входят специалисты: терапевты, хирурги, акушер-гинекологи, и дополнительно инфекционист/эндокринолог/фтизиатр/онколог/уролог.

3. II этап государственного экзамена проводится в форме итогового собеседования по ситуационным задачам в двух лекционных аудиториях госпитальных клиник по расписанию.

4. При подготовке к II этапу государственного экзамена на выпускающих кафедрах для выпускников проводятся консультации по ситуационным задачам в соответствии с расписанием.

5. Ситуационные задачи для II этапа государственного экзамена включают клинические дисциплины: терапию, хирургию, акушерство и гинекологию, эндокринологию, инфекционные болезни, фтизиатрию, онкологию, урологию. Каждая ситуационная задача для проверки теоретических знаний выпускника рассматривает 3-8 ключевых вопросов, главным образом касающихся основных синдромов и их механизмов, предварительного диагноза и его верификации, дифференциальной диагностики и современных подходов к лечению.

6. Студент обязан явиться на II этап государственного экзамена, согласно расписанию.

7. Каждый выпускник у секретаря государственной экзаменационной комиссии получает экзаменационный пакет/билет, который включает 3 ситуационные задачи: одна задача по терапии; одна задача по хирургии или акушерству и гинекологии; одна задача по инфекционным болезням, или фтизиатрии, или эндокринологии, или онкологии, или урологии. К каждой задаче прилагаются параклинические данные, а также по возможности компьютерные иллюстрации.

8. Секретарь экзаменационной комиссии фиксирует в ведомость сведения о выпускнике (фамилия, имя, отчество, номер ситуационных задач) и выдает чистые бланки для подготовки.

9. Выпускнику отводится 60 минут для подготовки к экзамену, в процессе которой запрещено пользование техническими средствами (компьютерами, телефонами), справочными и информационными материалами.

10. По результатам собеседования экзаменационная комиссия выставляет три оценки по трем ситуационным задачам, которые заносятся в протокол.

11. По завершении II этапа государственного экзамена на закрытом заседании проводится обсуждение результатов ответов каждого выпускника. Членами государственной экзаменационной комиссии принимается решение большинством голосов, при обязательном присутствии председателя государственной экзаменационной комиссии, выставляется окончательная оценка знаний выпускника. При равном числе голосов председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами.

12. Критерии оценки результата II этапа государственного экзамена:

- оценку "отлично" заслуживает студент, показавший всестороннее и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания и решать задачи по программе курса, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший творческие способности в понимании, изложении и применении учебно-программного материала;

- оценку "хорошо" заслуживает студент, показавший полное знание программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, при ответе показывает пробелы знаний в некоторых разделах, самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах, способный к самостоятельному пополнению и "обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

- оценку "удовлетворительно" заслуживает студент, показавший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на государственном экзамене, но обладающим необходимыми знаниями для их последующего устранения в процессе профессиональной деятельности;

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно"

ставится студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза.

14. Результаты II этапа государственного экзамена объявляются выпускнику в тот же день.

15. Итоговая оценка и присуждение квалификации происходит на заключительном заседании государственной экзаменационной комиссии. В протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена вносятся оценки по результатам I, II этапов государственной итоговой аттестации по специальности и итоговая оценка за государственный экзамен.

16. Итоговый результат двух этапов государственной итоговой аттестации объявляют выпускнику в тот же день после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.

4. Содержание

Перечень тестов для I этапа государственного экзамена

1. К основному рентгенологическому признаку хронической левожелудочковой недостаточности относят
a. перераспределение кровотока в пользу верхних долей лёгких
b. гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту
c. картину ателектаза
d. очаговые тени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

2. Наиболее чувствительным симптомом хронической сердечной недостаточностью является
a. сердцебиение
b. утомляемость
c. кашель
d. одышка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

3. Наиболее простым клиническим показателем эффективности диуретической терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью является
a. снижение массы
b. снижение конечного диастолического давления в правом желудочке
c. снижение частоты сердечных сокращений
d. уменьшение размеров печени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

4. К рентгенологическим признакам интерстициального отека лёгких относят
a. сливные инфильтративные тени в прикорневых и базальных отделах
b. линии Керли (Kerley)
c. картину ателектаза
d. множественные мелкие очаговые тени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

5. Антиальдестероновой активностью обладает
a. торасемид
b. фуросемид

c. этакриновая кислота
d. маннитол
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

6. Спиронолактон при декомпенсации хронической сердечной недостаточности используется в суточной дозе (мг)
a. 50-100
b. 25-50
c. 100-300
d. 12,5-25
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

7. При отсутствии на фоне приёма бета-адреноблокаторов необходимого снижения частоты сердечных сокращений у больных хронической сердечной недостаточностью с синусовым ритмом к терапии можно добавить
a. Ивабрадин
b. Гидрохлоротиазид
c. Эналаприл
d. Нифедипин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

8. Для диагностики гипертрофии левого желудочка наиболее диагностически значимы данные
a. сцинтиграфии
b. электрокардиографии
c. эхокардиографии
d. физического исследования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

9. Для контроля эффективности диуретиков у больных с отеками кардиального генеза наибольшее значение имеет оценка
a. суточного диуреза
b. окружности живота
c. уровней креатинина и мочевины в сыворотке крови
d. уровней калия и натрия в сыворотке крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

10. Обычная физическая активность не вызывает усталости, сердцебиения и одышки у больных с _____ функциональным классом хронической сердечной недостаточности
a. I
b. II
c. III
d. IV
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

11. Симптомы сердечной недостаточности отмечаются в покое и резко возрастают при минимальной физической активности у больных с ____ функциональным классом хронической сердечной недостаточности
a. I
b. II
c. III
d. IV

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

12. Признаки венозного застоя только в малом круге кровообращения могут отмечаться при ____ стадии хронической сердечной недостаточности
a. I
b. IIA
c. IIБ
d. III
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

13. Клиническим признаком гипоперфузии при кардиогенном шоке является
a. олигурия
b. полиурия
c. брадикардия
d. гиперемия кожных покровов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

14. Биохимическим маркером хронической сердечной недостаточности является
a. мозговой натрийуретический пептид
b. белок связывающий жирные кислоты
c. высокочувствительный тропонин I
d. МВ-фракция креатинфосфокиназы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

15. К антагонистам минералокортикоидных рецепторов относится
a. Торасемид
b. Триамтерен
c. Эплеренон
d. Индапамид
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

16. В сомнительных случаях диагноз «хроническая сердечная недостаточность» можно исключить при нормальном уровне в крови
a. натрийуретических пептидов
b. катехоламинов
c. альдостерона
d. ренина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

17. При развитии у больного хронической сердечной недостаточности препаратами первого ряда являются
a. селективные и неселективные антагонисты минералокортикоидных рецепторов
b. ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и бета-адреноблокаторы
c. петлевые и тиазидные диуретики
d. сердечные гликозиды и негликозидные инотропные стимуляторы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

18. Клиническим признаком 1-й стадии хронической сердечной недостаточности является
a. скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при физической нагрузке
b. наличие признаков недостаточности кровообращения по малому кругу в покое
c. наличие признаков недостаточности кровообращения по большому кругу в покое

d. наличие признаков застоя в малом и большом кругах кровообращения в покое
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

19. Самой распространенной причиной развития хронической сердечной недостаточности является
a. ишемическая болезнь сердца
b. артериальная гипертензия
c. миокардит
d. дилатационная кардиомиопатия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

20. Показанием для назначения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента является
a. наличие отеков
b. синусовая тахикардия
c. низкое артериальное давление
d. хроническая сердечная недостаточность любого функционального класса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

21. У женщины 50 лет, страдающей артериальной гипертензией, в течение 3 месяцев появились першение в горле и сухой кашель, не поддающиеся терапии отхаркивающими препаратами (не курит, аллергологический анамнез не отягощен, на рентгенограмме органов грудной клетки изменений не выявлено). Наиболее вероятной причиной кашля является прием
a. ингибиторов АПФ
b. блокаторов ангиотензиновых рецепторов
c. диуретиков
d. блокаторов кальциевых каналов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

22. К препаратам, улучшающим сократимость миокарда, относят
a. Добутамин
b. Атропин
c. Атенолол
d. Триметазидин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

23. К рекомендациям по диете больных с хронической сердечной недостаточностью относят
a. ограничение потребления жидкости
b. ограничение потребления сахара
c. ограничение потребления белков
d. увеличение в рационе поваренной соли
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

24. Стремительно развивающийся застой по малому кругу кровообращения приводит к
a. отеку лёгких
b. почечной недостаточности
c. асциту
d. отекам голеней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

25. Лечение сердечной недостаточности при дилатационной кардиомиопатии включает назначение

a. ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
b. антагонистов кальция (фенилалкиламинов)
c. ингибиторов фосфодиэстеразы
d. ингибиторов карбоангидразы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

26. Для оценки эффективности антитромботической терапии варфарином определяют
a. международное нормализованное отношение (МНО)
b. время кровотечения
c. тромбиновое время
d. уровень ретикулоцитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

27. При лечении гипертонической болезни у беременных абсолютно противопоказано назначение
a. ингибиторов АПФ
b. метилдопы
c. блокаторов кальциевых каналов
d. бета-адреноблокаторов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

28. При наличии противопоказаний к приёму бета-адреноблокаторов больным со стабильной стенокардией напряжения может быть назначен
a. ивабрадина гидрохлорид
b. гидрохлоротиазид
c. эналаприл
d. нифедипин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

29. При использовании варфарина для профилактики рецидивов тромбоэмболии лёгочной артерии значение целевого международного нормализованного отношения должно поддерживаться в пределах
a. 2,0–3,0
b. 1,5–2,5
c. 2,5–3,5
d. 3,0–4,0
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

30. Для кардиогенного отека лёгких характерны хрипы
a. влажные
b. сухие экспираторные
c. свистящие бифазные
d. сухие высокотональные
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

31. Для кардиогенного шока характерным изменением пульсового давления является
a. снижение
b. повышение
c. сначала снижение, потом повышение
d. сначала повышение, потом снижение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

32. При выборе ингибитора АПФ для лечения больного с ХСН и нарушением функции почек следует отдать предпочтение
a. фозиноприлу
b. лизиноприлу
c. периндоприлу
d. каптоприлу
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

33. Прием сердечных гликозидов у больных ХСН противопоказан при
a. A-V блокаде II ст.
b. A-V блокаде I ст.
c. фибрилляции предсердий
d. синусовой тахикардии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

34. Одышка при хронической сердечной недостаточности характеризуется
a. инспираторным или смешанным характером
b. экспираторным или смешанным характером
c. уменьшением в положении лежа
d. проявлением только при тяжелой ХСН
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

35. Каптоприл относится к группе
а) ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
б) бета-адреноблокаторов
в) антагонистов кальция
г) альфа-адреноблокаторов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

36. При появлении кашля на фоне использования эналаприла у больного хронической сердечной недостаточностью наиболее рациональной заменой будет применение
a. кандесартана
b. каптоприла
c. квинаприла
d. лизиноприла
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

37. Эхокардиографическими критериями концентрической гипертрофии левого желудочка являются
a. увеличение индекса массы миокарда левого желудочка и относительной толщины стенок левого желудочка
b. увеличение индекса массы миокарда левого желудочка и нормальная величина относительной толщины стенок левого желудочка
c. нормальный индекс массы миокарда левого желудочка и увеличение относительной толщины стенок левого желудочка
d. нормальный индекс массы миокарда левого желудочка и нормальная относительная толщина стенок левого желудочка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

38. Эхокардиографически при лёгочном сердце обнаруживают
a. гипертрофию и дилатацию правых отделов сердца
b. гипертрофию и дилатацию левых отделов сердца

c. дилатацию всех камер сердца
d. гипертрофию левого желудочка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

39. К признакам левожелудочковой сердечной недостаточности относят
a. мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами лёгких
b. отеки ног
c. гепатомегалию
d. видимую пульсацию вен на шее
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

40. Для болезни Берже (IgA-нефрита) неверно утверждение, что
a. у большинства больных отмечается нефротический синдром
b. наиболее частым клиническим проявлением является бессимптомная гематурия
c. чаще болеют мальчики и мужчины
d. патогномоничны депозиты IgA в мезангии клубочков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

41. При световой микроскопии биоптата почек клубочки не изменены при
a. болезни минимальных изменений
b. мембранозном нефрите
c. IgA-нефрите
d. экстракапиллярном нефрите
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

42. Исчезновение малых ножек подоцитов в клубочках определяется при
a. болезни минимальных изменений
b. фибропластическом гломерулонефрите
c. гломерулосклерозе
d. мезангиопролиферативном гломерулонефрите
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

43. К проявлениям нефротического синдрома не относится
a. артериальная гипертензия
b. протеинурия более 3,5 г/сутки
c. гипоальбуминемия
d. отеки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

44. Наиболее существенного эффекта от иммуносупрессивной терапии следует ожидать при
a. гломерулонефрите с минимальными изменениями (липоидном нефрозе)
b. амилоидозе
c. диабетическом гломерулосклерозе
d. очаговом (фокальном) гломерулосклерозе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

45. Для гломерулонефрита с минимальными изменениями (липоидного нефроза) неверно утверждение, что
a. применение глюкокортикоидов неэффективно
b. заболевание может развиться у ребенка в возрасте 3 года
c. заболевание имеет характерную картину развивающегося нефротического синдрома
d. заболевание может давать спонтанные ремиссии

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

46. Развитие глухоты сопровождает
a. синдром Альпорта
b. синдром Гудпасчера
c. нефротический синдром
d. амилоидоз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

47. Преднизолон не назначают при
a. нефрите в стадии ХПН
b. давности нефрита менее двух лет
c. наличии нефротического синдрома
d. нефрите с минимальными изменениями
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

48. Нефропатия с абдоминальным синдромом не характерна при
a. нефрите с минимальными изменениями
b. узелковом периартериите)
c. болезни Шенлейн-Геноха
d. васкулите с криоглобулинемией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

49. Наиболее быстрое прогрессирование гломерулонефрита характерно для
a. смешанной формы гломерулонефрита
b. латентного гломерулонефрита
c. нефротической формы гломерулонефрита
d. гипертонической формы гломерулонефрита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

50. В клинической классификации гломерулонефрита понятию «смешанная форма» соответствует сочетание
a. гипертензии и нефротического синдрома
b. гематурии и отеков
c. гематурии и артериальной гипертонии
d. нефротического синдрома и гематурии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

51. При нефротическом синдроме наиболее частыми клиническими проявлениями являются
a. отеки
b. повышение артериального давления
c. сердцебиение
d. олигурия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

52. Наиболее характерное клиническое проявление очагового сегментарного гломерулосклероза
a. протеинурия
b. острая почечная недостаточность
c. микрогематурия
d. острый нефритический синдром
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

53. Для ремиссии хронического гломерулонефрита характерны
a. редукция мочевого синдрома
b. нарастание суточной протеинурии
c. нарастание гематурии
d. снижение функции почек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

54. Высокое содержание эритроцитарных цилиндров в моче наиболее характерно для
a. нефритического синдрома
b. острого пиелонефрита
c. канальцевого некроза
d. нефротического синдрома
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

55. Пролиферацией эпителия капсулы клубочков и макрофагов с формированием полулуний, сдавливающих клубочки почек, сопровождается
a. быстропрогрессирующий гломерулонефрит
b. мембранопролиферативный гломерулонефрит
c. фокальный сегментарный гломерулярный склероз
d. острый постинфекционный гломерулонефрит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

56. Современная классификация гломерулонефритов основана на
a. преимущественно морфологических данных
b. присутствии/отсутствии артериальной гипертензии
c. оценке протеинурии
d. данных о течении и клинической картине болезни
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

57. Уменьшение размеров одной из почек не характерно для
a. быстропрогрессирующего гломерулонефрита
b. хронического пиелонефрита
c. врожденной аномалии почки
d. инфаркта почки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

58. Нарушения со стороны органов дыхания обязательны
a. при синдроме Гудпасчера
b. при остром гломерулонефрите
c. при хронической почечной недостаточности
d. при компенсированной стадии кистозных заболеваний почек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

59. Характерным признаком быстропрогрессирующего гломерулонефрита является
a. быстро нарастающая почечная недостаточность при нормальных или увеличенных размерах почек
b. изолированный нефротический синдром
c. возможность спонтанных (без терапии) ремиссий
d. скудный мочевой синдром
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

60. В индукционной терапии быстропрогрессирующего гломерулонефрита применяют
a. комбинированные внутривенные «пульсы» метилпреднизолона с пероральным приемом кортикостероидов и болюсным введением циклофосфана
b. монотерапию метилпреднизолоном внутривенно
c. высокие дозы кортикостероидов с азатиоприном
d. высокие дозы кортикостероидов внутрь с ингибиторами АПФ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

61. Анти-ГБМ гломерулонефрит характеризуется
a. линейным свечением иммуноглобулинов вдоль базальных мембран капилляров клубочков
b. умеренным мочевым синдромом
c. очаговым свечением иммуноглобулинов вдоль базальных мембран капилляров клубочков
d. предполагает выполнение трансплантации почек в любые сроки после начала заболевания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

62. По характеру течения выделяют варианты гломерулонефрита
a. острый, быстропрогрессирующий, хронический
b. пролиферативный, склерозирующий
c. коллабирующий, непролиферативный
d. идиопатический, вторичный, рецидивирующий
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

63. Наиболее частой причиной быстропрогрессирующего гломерулонефрита является
a. поражение почек в рамках системных васкулитов;
b. туберкулезное поражение мочеполовой системы;
c. контакт с органическими растворителями;
d. болезнь минимальных изменений.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

64. Обнаружение гиалиновых цилиндров в моче
a. не имеет диагностической ценности
b. свидетельствует о хроническом гломерулонефрите
c. свидетельствует о хроническом пиелонефрите
d. свидетельствует об амилоидозе почек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

65. Для поражения почек при системной красной волчанке наиболее характерным является развитие
a. гломерулонефрита
b. амилоидоза
c. пиелонефрита
d. папиллярного некроза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

66. Нефротическим синдромом чаще всего осложняется
a. системная красная волчанка
b. хронический пиелонефрит
c. хронический тубулоинтерстициальный нефрит
d. поликистозная болезнь почек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

67. В клинической практике скорость клубочковой фильтрации обычно определяют по клиренсу
a. креатинина
b. альбумина
c. глюкозы
d. электролитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

68. Стадия хронической болезни почек определяется по величине
a. скорости клубочковой фильтрации
b. артериальной гипертензии
c. длительности заболевания
d. протеинурии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

69. К маркерам повреждения почек не относится
a. глюкозурия при выраженной гипергликемии
b. протеинурия
c. альбуминурия
d. изменения мочевого осадка (гематурия, лейкоцитурия)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

70. Расчетные методы оценки скорости клубочковой фильтрации корректно можно использовать
a. у взрослых здоровых лиц
b. при остром повреждении почек
c. у беременных
d. при выраженном ожирении и истощении
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

71. К диагностическим критериям ХБП не относится
a. артериальная гипертензия
b. снижение скорости клубочковой фильтрации в течение более 3 месяцев
c. клинико-лабораторные признаки повреждения почек в течение более 3 месяцев
d. необратимые структурные изменения почек, выявленные при инструментальных или морфологических исследованиях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

72. Повышение относительной плотности мочи может наблюдаться
a. при неконтролируемом сахарном диабете
b. при острой почечной недостаточности
c. при идиопатическом несахарном диабете
d. при хронической почечной недостаточности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

73. Нефропротективный эффект имеют сахароснижающие препараты из группы
a. ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа
b. сульфонилмочевины
c. бигуанидов
d. ингибиторов α-глюкозидазы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

74. Значимым показателем для диагностики инфекционного эндокардита по данным ЭХОКГ-исследования выступает
a. вегетация на клапанах
b. высокое давление наполнения левого желудочка
c. наличие диастолической дисфункции
d. наличие систолической дисфункции
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

75. «Большими» диагностическими DUKE-критериями инфекционного эндокардита являются
a. вегетации/деструкции клапанов сердца и положительная гемокультура
b. порок сердца и гломерулонефрит
c. внутривенное употребление наркотиков и фебрильная лихорадка
d. фебрильная лихорадка и порок сердца
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

76. Для лечения инфекционного эндокардита, вызванного стрептококками, препаратами выбора являются
a. пенициллины и аминогликозиды
b. фторхинолоны и аминогликозиды
c. макролиды и аминогликозиды
d. макролиды и фторхинолоны
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

77. Препаратом выбора при грибковой этиологии инфекционного эндокардита является
a. амфотерицин В
b. даптомицин
c. ванкомицин
d. канамицин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

78. Основным антибиотиком для лечения инфекционного эндокардита, вызванного метициллин-резистентными кокками, является
a. ванкомицин
b. оксациллин
c. цефтриаксон
d. кларитромицин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

79. Показанием к проведению чреспищеводной эхокардиографии является подозрение на
a. инфекционный эндокардит
b. ишемическую болезнь сердца
c. миокардит
d. перикардит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

80. Исходом гипертензивной нефропатии является
a. первично сморщенная почка
b. вторично сморщенная почка
c. третично сморщенная почка
d. амилоидоз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

81. Артериальная гипертензия может быть заподозрена у пациента с жалобами на
a. боль в теменной и затылочной областях
b. зуд
c. запор
d. асимметричные отеки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

82. Артериальная гипертензия пароксизмального типа наблюдается преимущественно при
a. феохромоцитоме
b. альдостероме
c. узелковом полиартериите
d. синдроме Иценко-Кушинга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

83. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента абсолютно противопоказаны к назначению при
a. двустороннем стенозе почечных артерий
b. снижении уровня креатинина
c. симптомной гипертензии
d. декомпенсации хронической сердечной недостаточности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

84. Абдоминальный сосудистый шум выслушивается при
a. реноваскулярной артериальной гипертензии
b. ренопаренхиматозной артериальной гипертензии
c. недостаточности аортального клапана
d. гипертонической болезни
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

85. Пороговый уровень офисного артериального давления для диагностики артериальной гипертензии составляет (мм рт. ст.)
a. 140/90
b. 130/80
c. 135/85
d. 145/90
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

86. 2-я степень гипертонической болезни подразумевает наличие артериальной гипертензии (мм рт. ст.)
a. 160/100 и выше
b. выше 130/80
c. выше 140/90
d. выше 180/110 и выше
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

87. Диагностический критерий длительности кашля при хроническом бронхите составляет
a. 3 месяца в течение 2 лет подряд
b. 2 месяца в течение 2 лет подряд
c. 3 месяца в течение 1 года
d. 1 месяц в течение 1 года
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

88. Эффективность антибактериального лечения при нетяжелой внебольничной пневмонии следует клинически оценивать через
a. 2-3 дня
b. 12 часов
c. 1 сутки
d. 5 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

89. Треугольная инфильтративная тень на рентгенограмме лёгких характерна для
a. ТЭЛА
b. аспирационной пневмонии
c. параканкрозной пневмонии
d. шокового лёгкого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

90. Наиболее частым возбудителем внебольничной пневмонии является
a. стрептококк
b. микоплазма
c. гемофильная палочка
d. клебсиелла пневмонии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

91. При пневмонии, вызванной микоплазмой, применяют
a. азитромицин
b. цефтриаксон
c. гентамицин
d. амоксициллин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

92. При классическом течении пневмококковой пневмонии на рентгенограммах лёгких выявляют
a. интенсивная гомогенная долевая инфильтрация
b. инфильтрация в форме треугольника с верхушкой, направленной к корню
c. инфильтрация с ранним формированием полостей распада
d. прикорневая инфильтрация с полициклическим контуром
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

93. Для диагностики пневмонии принципиально важным является наличие
a. рентгенологически подтвержденного лёгочного инфильтрата
b.температуры тела пациента выше 38°С
c. гнойной мокроты
d. торакалгии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

94. Внутрибольничная пневмония диагностируется
a. через 48 и более часов после поступления в стационар
b. в момент поступления в стационар и позднее
c. через 12 и более часов после поступления в стационар
d. через 24 и более часов после поступления в стационар
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

95. «Золотым стандартом» диагностики и оценки ХОБЛ является
a. спирометрия
b. бронхоскопия
c. компьютерная томография
d. пикфлоуметрия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

96. Антибактериальную терапию при ХОБЛ следует назначать
a. при гнойной мокроте
b. при усилении кашля
c. при появлении кровохарканья
d. при нарастании одышки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

97. Значение индекса Тиффно для диагностики ХОБЛ составляет менее (%)
a. 70
b. 50
c. 60
d. 80
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

98. Признаком отличия первой стадии астматического статуса от приступа бронхиальной астмы является
a. рефрактерность к использованию ингаляционных b2-агонистов
b. появление цианоза носогубного треугольника
c. аускультация свистящих хрипов
d. изменение гемодинамических показателей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

99. Проявлением астматического статуса III стадии является
a. гипоксическая кома
b. свистящее дыхание
c. амфорическое дыхание
d. немое лёгкое
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

100. К аускультативным признакам бронхиальной астмы относят
a. свистящие хрипы на выдохе
b. бронхиальное дыхание
c. амфорическое дыхание
d. влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

101. В медицинской организации окончательное решение о необходимости направления больного на медико-социальную экспертизу принимает
a. Лечащий врач
b. Заведующий отделением
c. Заместитель главного врача по КЭР
d. Врачебная комиссия
e. Главный врач
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

102. При инкурабельных злокачественных новообразованиях, впервые диагностируемых, первую группу инвалидности устанавливают
a. на 6 месяцев
b. на 1 год
c. на 2 года
d. на 3 года
e. без срока переосвидетельствования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

103. Из перечисленных учреждений, направлять на медико-социальную экспертизу имеет право
a. служба занятости населения
b. служба социальной защиты населения
c. судебные инстанции
d. пенсионный фонд
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

104. Датой установления инвалидности считается
a. дата направления на МСЭ лечебным учреждением
b. дата регистрации заявления гражданина о проведении МСЭ
c. дата проведения освидетельствования в бюро МСЭ
d. дата выдачи инвалиду на руки индивидуальной программы реабилитации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

105. Лист временной нетрудоспособности у пациента, направленного на МСЭ и признанного инвалидом, должен быть закрыт
a. датой направления на МСЭ лечебным учреждением
b. датой регистрации заявления гражданина о проведении МСЭ
c. днем, непосредственно предшествующим дате регистрации заявления гражданина о проведении МСЭ
d. датой проведения освидетельствования в бюро МСЭ
e. датой выдачи инвалиду на руки индивидуальной программы реабилитации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

106. Основанием для установления 2-й группы инвалидности может быть стойкое нарушение функций организма в диапазоне
a. от 10% до 30%
b. от 30% до 50%
c. от 40% до 60%
d. от 70% до 80%
e. от 90% до 100%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

107. Основанием для установления 1-й группы инвалидности может быть стойкое нарушение функций организма в диапазоне
a. от 10% до 30%
b. от 30% до 50%
c. от 40% до 60%
d. от 70% до 80%
e. от 90% до 100%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

108. Основанием для установления 3-й группы инвалидности может быть стойкое нарушение функций организма в диапазоне
a. от 10% до 30%
b. от 30% до 50%
c. от 40% до 60%
d. от 70% до 80%
e. от 90% до 100%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

109. Направление на МСЭ пациента с явным неблагоприятным клиническим и трудовым прогнозом должно выполняться
a. не позже 2 месяцев временной нетрудоспособности
b. не позже 3 месяцев временной нетрудоспособности
c. не позже 4 месяцев временной нетрудоспособности
d. не позже 5 месяцев временной нетрудоспособности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

110. Индивидуальная программа реабилитации/абилитации инвалида должна быть разработана после освидетельствования инвалида в течение
a. трех дней
b. семи дней
c. двух недель
d. одного месяца
e. двух месяцев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

111. Тифлотехнические средства – это
a. средства реабилитации для глухих и слабослышащих
b. средства реабилитации для слепых и слабовидящих
c. средства реабилитации детей-инвалидов с ДЦП
d. технические средства реабилитации инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

112. Взрослому инвалиду с диагнозом ИБС, стенокардия напряжения 3 ФК, ПИКС, ХСН 2А, при отсутствии положительной динамики, инвалидность без срока переосвидетельствования будет установлена
a. не позднее 1 года после первичного освидетельствования
b. не позднее 2 года после первичного освидетельствования
c. не позднее 4 года после первичного освидетельствования
d. не позднее 5 года после первичного освидетельствования
e. не позднее 6 года после первичного освидетельствования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

113. В рамках проведения медико-социальной экспертизы выделяют
a. 5 категорий жизнедеятельности
b. 6 категорий жизнедеятельности
c. 7 категорий жизнедеятельности
d. 8 категорий жизнедеятельности
e. 10 категорий жизнедеятельности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

114. Способность к осуществлению жизнедеятельности с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств соответствует
a. 1 степени ограничения жизнедеятельности
b. 2 степени ограничения жизнедеятельности
c. 3 степени ограничения жизнедеятельности
d. 4 степени ограничения жизнедеятельности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

115. Неспособность к самостоятельному осуществлению жизнедеятельности, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе соответствует
a. 1 степени ограничения жизнедеятельности
b. 2 степени ограничения жизнедеятельности
c. 3 степени ограничения жизнедеятельности
d. 4 степени ограничения жизнедеятельности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

116. Критерием категории «ребенок-инвалид» является:
a. 1 степень ограничения способности к передвижению в сочетании с 1 степенью ограничения способности к обучению
b. 2 степень ограничения способности к обучению
c. 1 степень ограничения способности к самообслуживанию в сочетании с 1 степенью ограничения способности к общению
d. любая степень ограничения любой категории жизнедеятельности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

117. Основанием для установления 3 группы инвалидности может являться
a. 1 степень ограничения жизнедеятельности в любой категории
b. 1 степень ограничения жизнедеятельности, как минимум в двух категориях
c. 2 степень ограничения жизнедеятельности в любой категории
d. 2 степень ограничения жизнедеятельности, как минимум в двух категориях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

118. Основанием для установления 2 группы инвалидности может являться
a. 1 степень ограничения жизнедеятельности в любой категории
b. 1 степень ограничения жизнедеятельности, как минимум в двух категориях
c. 2 степень ограничения жизнедеятельности в любой категории
d. 2 степень ограничения жизнедеятельности, как минимум в двух категориях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

119. В случае вызова гражданина на освидетельствование в федеральное бюро МСЭ, расходы на дорогу и проживание возмещаются за счет средств
a. фонда ОМС
b. самого гражданина
c. фонда социального страхования
d. пенсионного фонда
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

120. При незначительных нарушениях функций организма человека процент утраты функций находится в диапазоне
a. 15-20%
b. 10-20%

c. 5-15%
d. 10-30%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

121. При оценке интенсивности хронической боли, в первую очередь следует учитывать
a. данные клинического обследования
b. данные параклинического обследования
c. оценку интенсивности боли пациентом
d. оценку интенсивности боли родственниками пациента
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

122. Препаратами выбора для лечения нейропатической боли при злокачественных новообразованиях являются
a. препараты липоевой кислоты
b. антиконвульсанты центрального действия
c. антиконвульсанты периферического действия
d. витамины группы В
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

123. Один накожный пластырь с фентанилом рассчитан на использование в течение
a. 24 часов
b. 48 часов
c. 72 часов
d. 96 часов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

124. По сравнению с морфином, обезболивающее действие фентанила
a. слабее в 10 раз
b. не отличается
c. сильнее в 50 раз
d. сильнее в 100 раз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

125. У паллиативных пациентов с интенсивным болевым синдромом, употреблявших в прошлом наркотики с немедицинской целью, препаратом выбора будет
a. бупренорфин
b. оксикодон
c. фентанил
d. морфин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

126. Из перечисленных препаратов, на первой ступени терапии хронической боли, в качестве основного анальгетика, следует использовать
a. просидол
b. трамадол
c. парацетамол
d. морфин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

127. Основным показанием для назначения просидола является
a. плановое лечение хронической слабой боли
b. плановое лечение хронической умеренной боли

c. плановое лечение хронической сильной боли
d. купирование прорыва боли
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

128. «Потолок» обезболивающего действия для трамадола достигается при суточной дозе:
a. 300 мг
b. 400 мг
c. 500 мг
d. 600 мг
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

129. Из перечисленных наркотических анальгетиков лекарственную форму в виде трансдермальной терапевтической системы имеет
a. просидол
b. бупренорфин
c. оксикодон
d. тапентадол
e. морфин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

130. Из перечисленных наркотических анальгетиков, наиболее безопасным при почечной недостаточности является:
a. морфин
b. оксикодон
c. фентанил
d. дигидрокодеин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

131. Риск развития опиоид-индуцированной нейротоксичности повышается на фоне приема
a. сердечных гликозидов
b. трициклических антидепрессантов
c. парацетамола
d. антибиотиков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

132. При переходе с приема трамадола на пероральный морфин, стартовая суточная доза морфина должна составлять
a. 20 мг
b. 30 мг
c. 40 мг
d. 60 мг
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

133. У пациента с хроническим болевым синдромом достигнута адекватная анальгезия на 3-х инъекциях морфина (30 мг в сутки). Эквивалентная доза перорального морфина составляет минимум:
a. 30 мг
b. 40 мг
c. 60 мг
d. 100 мг
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

134. При выписке пациента с хроническим болевым синдромом из стационара, ему можно выдать наркотические лекарственные средства на срок лечения до
a. двух дней
b. трех дней
c. пяти дней
d. семи дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

135. На фоне приема морфина запоры развиваются
a. у 30% больных
b. у 50% больных
c. у 70% больных
d. у 100% больных
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

136. Для лечения запоров, вызванных опиатами, предпочтительны препараты из группы
a. осмотических слабительных
b. солевых слабительных
c. слабительных стимулирующего действия
d. энтерокинетиков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

137. Обезболивающее действие пластырей с фентанилом достигает максимума
a. через один час после приклеивания пластыря
b. через 6 часов после приклеивания пластыря
c. через 12 часа после приклеивания пластыря
d. через 24 часа после приклеивания пластыря
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

138. Из перечисленных НПВП, к селективным ингибиторам ЦОГ-2 относится:
a. диклофенак
b. лорноксикам
c. мелоксикам
d. кетопрофен
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

139. Основным побочным эффектом парацетамола является гастротоксичность
a. гастротоксичность
b. гепатотоксичность
c. нефротоксичность
d. ототоксичность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

140. Паллиативная помощь, как дисциплина, является
a. частным разделом медицины, задачи которого заключаются в лечении болевого синдрома у терминальных больных
b. частным разделом социальной помощи, задачи которого заключаются в оказании социальной и психологической поддержки терминальным больным
c. направлением медико-социальной деятельности, задачи которого заключаются в улучшении качества жизни больных и их семей, оказавшихся перед лицом смертельного заболевания
d. частным разделом медицины, задачи которого заключаются в обеспечении надлежащего

ухода терминальным больным
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

141. Под заболеваемостью с временной утратой трудоспособности понимают
a. все случаи, сопровождающиеся временной утратой трудоспособности у рабочих и служащих
b. все случаи заболеваний (исключая травму), сопровождающиеся временной утратой трудоспособности у рабочих и служащих
c. все случаи заболеваемости, по которым выдан листок нетрудоспособности;
d. наличие инфекционного заболевания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

142. Единицей наблюдения при учете заболеваемости с временной утратой трудоспособности является
a. листок временной нетрудоспособности
b. случай временной нетрудоспособности
c. первичное заболевание
d. справка о временной нетрудоспособности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

143. Ориентировочной оценкой показателя тяжести заболевания с временной утратой трудоспособности является:
a. листок временной нетрудоспособности
b. длительность заболевания, превышающая 1 месяц
c. характер патологического процесса
d. наличие сопутствующих заболеваний
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

144. Право выдачи больничного листа имеет врач:
a. приемного отделения
b. скорой помощи
c. травматологического пункта (поликлиники)
d. станции переливания крови
e. грязелечебницы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

145. Листок нетрудоспособности по уходу за больным (взрослым), находящимся на лечении в стационаре
a. выдается на 3 дня
b. выдается на 7 дней
c. выдается на весь период лечения
d. не выдается
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

146. Максимальный срок, на который может выдать больничный лист сельский врач, работающий на участке один
a. 5 дней
b. 7 дней
c. 10 дней
d. 15 дней
e. 3 месяца
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

147. Гражданам, работающим в организациях общественного питания при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности
a. не выдается
b. выдается на весь период дегельминтизации
c. выдается на срок до 3 дней
d. выдается на срок до 5 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

148. Справка произвольной формы выдается
a. при бытовой травме
b. при заболеваниях вследствие опьянения или злоупотребления алкоголем
c. трудоспособным лицам, направленным в период медицинских осмотров на обследование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

149. К обследованию, проведенному в амбулаторных условиях, при котором может быть выдан листок нетрудоспособности на период этого обследования относится
a. колоноскопия
b. ЭХО-КГ
c. рентгеноскопия грудной клетки
d. подбор контактных линз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

150. Листок нетрудоспособности при физиологическом течении беременности и неосложненных родах выдают на
a. 180 дней
b. 140 дней
c. 156 дней
d. 160 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

151. В период отпуска без сохранения заработной платы дворник заболел пневмонией. Пациенту следует выдать
a. листок нетрудоспособности в форме электронного документа
b. выписку из медицинской карты
c. листок нетрудоспособности на бумажном носителе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

152. К документу, разрешающему врачу частной практики выдачу листка нетрудоспособности, относится
a. диплом об окончании вуза
b. удостоверение о присвоение квалификационной категории
c. удостоверение об окончании сертификационного цикла усовершенствования по экспертизе временной нетрудоспособности
d. лицензия на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

153. Формирование листков нетрудоспособности в форме электронного документа осуществляется при предъявлении
a. документа удостоверяющего личность

b. документа удостоверяющего личность и страхового полиса
c. документа удостоверяющего личность и СНИЛС
d. страхового полиса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

154. При отказе больного от освидетельствования в бюро МСЭ листок нетрудоспособности
a. продлевается по решению ВК
b. продлевается до 10 месяцев
c. продлевается до 12 месяцев
d. не продлевается и закрывается датой отказа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

155. Гражданам, направленным на лечение в санаторно-курортные организации листок нетрудоспособности формируется:
a. санаторно-курортной организацией
b. Фондом социального страхования
c. Департаментом здравоохранения
d. направившей медицинской организацией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

156. Лицам, проходящим по решению суда судебно-медицинскую экспертизу и признанными нетрудоспособными, выдается
a. листок нетрудоспособности со дня явки гражданина на судебно-медицинскую экспертизу
b. листок нетрудоспособности со дня окончания экспертизы
c. справка произвольной формы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

157. Плановые и внеплановые проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности проводит
a. Департамент здравоохранения
b. страховые компании
c. Фонд социального страхования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

158. Листок нетрудоспособности выдают прерывисто:
a. при лечении в дневном стационаре, когда не требуется постоянное пребывание больного
b. не выдают
c. при сложных медицинских манипуляциях (химиотерапия, урологические манипуляции)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

159. Листок нетрудоспособности по уходу можно выдать в период
a. ежегодного оплачиваемого отпуска
b. отпуска без сохранения заработной платы
c. отпуска по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет
d. выходных и праздничных дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

160. Врачебная комиссия создается на основании
a. приказа Департамента здравоохранения
b. приказа Министерства здравоохранения

c. приказа руководителя медицинской организации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

161. Существуют эффективные скрининговые мероприятия в отношении злокачественных новообразований
a. молочной железы
b. поджелудочной железы
c. мочевого пузыря
d. яичников
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

162. Существуют эффективные скрининговые мероприятия в отношении злокачественных новообразований
a. почки
b. ободочной кишки
c. поджелудочной железы
d. пищевода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

163. Лица с установленными облигатными предраковыми заболеваниями должны в обязательном порядке находиться на диспансерном наблюдении у
a. терапевта
b. онколога
c. хирурга
d. врача общей врачебной практики
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

164. Лица с установленными факультативными предраковыми заболеваниями должны в обязательном порядке находиться на диспансерном наблюдении у
a. терапевта
b. онколога
c. хирурга
d. офтальмолога
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

165. Мероприятие, относящееся к первичной профилактике
a. проведение колоноскопии для выявления колоректального рака
b. вакцинация
c. прием аспирина при ишемической болезни сердца
d. отказ от курения при выявлении хронической болезни лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

166. В отличие от ранней диагностики, скрининговые мероприятия
a. проводятся при наличии симптомов болезни
b. дешевле
c. проводятся при отсутствии симптомов болезни
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

167. Вред скрининга заключается в
a. снижении заболеваемости
b. снижении смертности
c. гипердиагностике

d. снижении тяжести заболевания, в том числе более щадящее лечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

168. Диспансеризация проводится лицам в возрасте с 18 до 39 лет
a. ежегодно
b. по мере обращения гражданина к врачу по месту жительства
c. 1 раз в 2 года
d. 1 раз в 3 года
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

169. Диспансеризация проводится лицам в возрасте 40 лет и старше
a. ежегодно
b. по мере обращения гражданина к врачу по месту жительства
c. 1 раз в 2 года
d. 1 раз в 3 года
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

170. Граждане, у которых по результатам диспансеризации не установлены ХНИЗ, отсутствуют факторы риска их развития и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении относятся к
a. I группе здоровья
b. II группе здоровья
c. IIIА группе здоровья
d. IIIБ группе здоровья
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

171. Граждане, у которых по результатам диспансеризации не установлены ХНИЗ, но выявлены факторы риска их развития (гиперхолестеролемия 8 ммоль/л) относятся к
a. I группе здоровья
b. II группе здоровья
c. IIIА группе здоровья
d. IIIБ группе здоровья
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

172. К метаболическим факторам риска относятся
a. курение, употребление алкоголя, гиподинамия, нерациональное питание
b. гиподинамия, избыток массы тела, нерациональное питание, повышение артериального давления
c. гиперхолестеролемия, курение, злоупотребление алкоголем
d. гипергликемия, избыток массы тела, повышение артериального давления, гиперхолестеролемия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

173. К поведенческим (корригируемым) факторам риска относятся
a. курение, употребление алкоголя, гиподинамия, нерациональное питание
b. гиподинамия, избыток массы тела, нерациональное питание, повышение артериального давления
c. гиперхолестеролемия, курение, злоупотребление алкоголем
d. гипергликемия, избыток массы тела, повышение артериального давления, гиперхолестеролемия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

174. Слабоалкогольные напитки – это напитки в которых
a. содержание спирта до 50%
b. содержание спирта не превышает 3%
c. содержание спирта до 30%
d. содержание спирта не превышает 8%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

175. Мерой потребления алкоголя является
a. литр
b. промилле
c. дринк
d. бокал
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

176. Дринк составляет
a. 45 г 96% этилового спирта
b. 15 г 96% этилового спирта
c. 5 г 96% этилового спирта
d. 100 г 96% этилового спирта
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

177. Степень никотиновой зависимости оценивается с помощью
a. опросника AUDIT
b. теста Фагерстрема
c. GATE-теста
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

178. Варениклин относится к группе
a. никотинзамещаюшей терапии
b. антиникотиновых препаратов
c. антидепрессантов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

179. Для получения существенной пользы для здоровья взрослые должны заниматься
a. умеренной физической активностью, по крайней мере, 50 минут в неделю
b. умеренной физической активностью, по крайней мере, 150 минут в неделю
c. умеренной физической активностью, по крайней мере, 100 минут в неделю
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

180. Высокий риск возникновения осложнений ожирения диагностируется у женщин с окружностью талии
a. 75-80 см
b. 80-88 см
c. 88 см и выше
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

181. У лиц пожилого возраста из-за высокого содержания жиров в организме
a. увеличивается экскреция лекарств почками
b. жирорастворимые препараты имеют большой объем распределения, но при этом медленно выводятся
c. водорастворимые препараты имеют низкую концентрацию в крови

d. увеличивается элиминация лекарств печенью
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

182. С возрастом в организме человека
a. процентное количество воды увеличивается
b. процентное содержание жиров уменьшается
c. содержание альбумина плазмы снижается
d. мышечная масса увеличивается
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

183. Основным медиатором в организме пожилого человека является
a. ацетилхолин
b. норадреналин
c. серотонин
d. адреналин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

184. К категории лиц пожилого возраста можно отнести людей
a. 75-90 лет
b. 60-74 лет
c. 45-59 лет
d. моложе 40 лет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

185. Гериатрия изучает
a. первичные механизмы старения
b. приспособительные механизмы организма в процессе старения
c. геронтопсихологию
d. особенности развития, клинического течения, лечения и профилактики различных заболеваний у людей пожилого и старческого возраста
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

186. Старению способствует
a. счастливый брак
b. депрессия
c. хорошее финансовое положение
d. дозированные физические нагрузки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

187. Выявить, описать и разъяснить различные проблемы, влияющие на способность пожилого человека справляться самостоятельно, а также выяснить сильные стороны и ресурсы человека позволяет
a. всесторонняя гериатрическая оценка
b. оценка физического здоровья
c. оценка психического здоровья
d. оценка социального и экономического статуса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

188. При помощи индекса Лаутона и Бартела проводят
a. оценку условий жизни
b. оценку степени депрессии
c. оценку психического здоровья

d. оценку способностей к самообслуживанию и независимому существованию
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

189. Запоры у пожилых людей часто обусловлены
a. большим количеством употребляемой жидкости
b. гипердинамией
c. усилением перистальтики кишечника
d. ослаблением перистальтики кишечника
e. спазмом сфинктеров
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

190. В рационе питания пожилого человека соотношение животных и растительных белков должно приближаться
a. 1:1
b. 2:1
c. 1:3
d. 1:2
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

191. Приоритетная проблема при аденоме предстательной железы у лиц пожилого и старческого возраста
a. боль в пояснице
b. головная боль
c. отёки
d. задержка мочеиспускания
e. лихорадка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

192. При аденоме предстательной железы у лиц пожилого и старческого возраста увеличивается вероятность развития
a. гломерулонефрита
b. пиелонефрита
c. колита
d. гепатита
e. энтерита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

193. Причина снижения эффективности пероральных препаратов железа у лиц пожилого и старческого возраста
a. увеличение всасывания
b. уменьшение всасывания
c. ускоренная эвакуация из желудка
d. повышение кислотности желудочного сока
e. понижение кислотности желудочного сока
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

194. Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен
a. бактериальной инфекцией
b. психоэмоциональными перегрузками
c. недостаточным употреблением углеводов
d. снижением чувствительности тканей к инсулину
e. наследственностью

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

195. Болевой синдром при стабильной стенокардии у пожилых и старых людей чаще
a. типичный
b. атипичный
c. проявляется болью значительной интенсивности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

196. Категории долгожителей соответствует возраст
a. моложе 100 лет
b. старше 80 лет
c. старше 75 лет
d. старше 90 лет
e. старше 95 лет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

197. К категории лиц старческого возраста можно отнести людей
a. старше 90 лет
b. 75-90 лет
c. 60-74 лет
d. 50-59 лет
e. 45-55
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

198. Геронтология – это
a. раздел социологии и психологии, изучающий изменение психики при старении человека
b. раздел биологии и медицины, изучающий процессы старения человека
c. область клинической медицины, изучающая болезни людей старших возрастных групп
d. раздел психологии
e. раздел патофизиологии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

199. Старение органа зрения характеризуется
a. ухудшением аккомодации
b. улучшением аккомодации
c. конъюнктивитами
d. расширением полей зрения
e. увеличением адаптации к темноте
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

200. Затруднение жевательного процесса при старении обусловлено
a. потерей зубов
b. атрофией языка
c. гипертрофией жевательных мышц
d. атрофией мышц дна полости рта
e. гипертрофией альвеолярных отростков челюстей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

201. Для системной склеродермии из поражений сердечно-сосудистой системы наиболее типичным является развитие
a. митрального стеноза

b. аортальной недостаточности
c. экссудативного перикардита
d. крупноочагового кардиосклероза
e. асептического бородавчатого эндокардита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

202. Поражение век является одним из критериев диагностики одного из перечисленных ниже заболеваний
a. ревматизма
b. системной красной волчанки
c. дерматомиозита
d. ревматической полимиалгии
e. системной склеродермии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

203. При диффузной форме системной склеродермии поражается кожа преимущественно следующих участков тела
a. лица, пальцев кистей и стоп
b. туловища, лица и конечностей
c. в основном туловища
d. в основном лица
e. в основном пальцев кистей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

204. Препаратом выбора при развитии истинной склеродермической почки является
a. бета-адреноблокаторы
b. ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
c. нативная плазма
d. глюкокортикостероиды
e. цитостатики.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

205. Патогномоничным проявлением дерматомиозита служит
a. параорбитальный отек с лиловой ("гелиотропной") эритемой верхнего века и синдромом Готтрона (эритемой над пястно-фаланговыми суставами)
b. эритема на открытых участках кожи
c. пойкилодермия
d. алопеция
e. синдром Рейно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

206. При системной склеродермии преимущественно поражаются следующие кровеносные сосуды
a. артериолы и капилляры
b. сосуды среднего калибра
c. сосуды любого диаметра
d. крупные сосуды
e. венозные сосуды
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

207. Выберите лабораторный тест, который наиболее информативен для подтверждения диагноза полимиозита

a. СОЭ
b. антинуклеарный фактор
c. ревматоидный фактор
d. антитела к мышечным антигенам
e. повышение в крови уровня креатинкиназы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

208. Первая фаза синдрома Рейно проявляется
a. реактивной гиперемией кожи пальцев кистей и стоп
b. цианозом дистальных отделов конечностей
c. "побелением" пальцев кистей и стоп в результате вазоконстрикции
d. парастезиями по всей руке, ноге
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

209. Для синдрома Рейно характерен следующий признак
a. ослабление или отсутствие пульсации на артериях конечностей среднего диаметра
b. одностороннее изменение цвета пальцев кистей и стоп
c. развитие некротических поражений в области пальцев кистей и стоп
d. отсутствие висцеральных поражений
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

210. Какое поражение кожи не характерно для системной склеродермии:
a. эритематозная сыпь
b. единичные очаги фиброза
c. кальциноз кожи
d. телеангиэктазии
e. фиброз кожи проксимальнее суставов, включая шею, туловище
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

211. Для СКВ справедливы следующие утверждения
a. характерно развитие эрозивного артрита
b. часто возникает дисфагия
c. для высокой активности заболевания характерен лейкоцитоз
d. прогностически неблагоприятным органным поражением является гломерулонефрит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

212. Диагностическими критериями (АРА, 1987) системной красной волчанки являются все, кроме
a. Эрозивного артрита
b. Полисерозита
c. Фотосенсибилизации
d. Поражения ЦНС
e. Изъязвлений полости рта
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

213. Истинные LE-клетки представляют собой
a. сегменто-ядерные нейтрофилы, содержащие обломки ядер других клеток
b. моноциты, содержащие ядра других клеток
c. гематоксилиновые тельца
d. моноциты, образующие "розетки" с эритроцитами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

214. Развитию узелкового полиартериита способствуют все, кроме
a. персистенции вируса гепатита В
b. повышения титра противострептококковых антител
c. лекарственной непереносимости
d. повышенной чувствительности к охлаждению и солнечным лучам
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

215. Сочетание одностороннего синдрома Рейно с отсутствием пульса на лучевой артерии той же руки и повышением АД на ногах позволяет предположить
a. атеросклероз
b. облитерирующий тромбангит
c. болезнь Такаясу
d. болезнь Хортона
e. коарктацию аорты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

216. При болезни Хортона типично поражение
a. аорты
b. коронарных артерий
c. почечных артерий
d. височных артерий
e. лёгочной артерии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

217. Кардиоваскулярная симптоматика при узелковом полиартериите включает все перечисленное, кроме
a. острого инфаркта миокарда
b. диффузных поражений мышцы сердца
c. пристеночного эндокардита
d. артериальной гипертензии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

218. Группа гранулематозных артериитов включает все перечисленное, за исключением
a. узелкового полиартериита
b. эозинофильного гранулематозного васкулита
c. височного артериита
d. неспецифического аортоартериита
e. гранулематоза Вегенера
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

219. Для артрита при системной красной волчанке характерно все перечисленное, кроме
a. сходства с ревматоидным артритом, с симметричным поражением проксимальных межфаланговых суставов
b. развития деструктивных изменений в суставах
c. регрессирования под влиянием терапии нестероидными противовоспалительными препаратами
d. подвывихов суставов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

220. Оптимальным глюкокортикоидом для проведения длительной терапии системной красной волчанки является

a. триамцинолон
b. гидрокортизон
c. дексаметазон
d. метилпреднизолон
e. бетаметазон
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

221. Заболевания суставов, к которым относится ревматоидный артрит
a. воспалительным
b. дегенеративным
c. метаболическим
d. реактивным
e. сочетающимся со спондилоартритом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

222. При ревматоидном артрите чаще всего поражаются суставы
a. позвоночника
b. коленные
c. проксимальные межфаланговые
d. крестцово-подвздошное сочленение
e. дистальные межфаланговые
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

223. При каком осложнении ревматоидного артрита анализ мочи является информативным тестом
a. синдром Хаммена–Рича
b. перикардит
c. амилоидоз
d. дигитальный ангиит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

224. Лабораторными признаками активности ревматоидного артрита являются
a. повышение уровня СРБ
b. ускорение СОЭ
c. повышение уровня ЛДГ
d. лейкоцитоз
e. титр АСЛ-О
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

225. Паннус – это
a. агрессивная грануляционная ткань
b. утренняя скованность больше 1 ч
c. повышение АЛТ
d. узелок Гебердена
f. высокий титр АСЛ-О
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

226. Ведущий патогенетический механизм прогрессирования остеоартроза
a. синовит
b. дегенерация суставного хряща
c. выпадение в полость сустава кристаллов гидроксиапатита кальция

d. ремоделирование костной ткани
f. атрофия близлежащих мышечных групп
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

227. Ограничение подвижности в пораженном суставе при остеоартрозе не связано с наличием
a. мышечного спазма
b. подвывихов
c. костных анкилозов
d. фиброзом и сморщиванием капсулы сустава
f. наличием крупных остеофитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

228. Наиболее информативным диагностическим методом при остеоартрозе
a. биопсия синовиальной оболочки
b. исследование синовиальной жидкости
c. рентгенография суставов
d. клинический и биохимический анализ крови
f. ультразвуковое исследование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

229. Узелки Бушара – это костные утолщения
a. пястнофаланговых суставов
b. дистальных межфаланговых суставов кисти
c. плюснефаланговых суставов
d. проксимальных межфаланговых суставов кисти
f. проксимальных межфаланговых суставов стопы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

230. При какой из локализаций остеоартроза в наибольшей степени страдает функция кисти
a. дистальные межфаланговые суставы
b. первый запястно-пястный сустав
c. проксимальные межфаланговые суставы
d. пястнофаланговые суставы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

231. Укажите концентрацию мочевой кислоты в сыворотке крови, при которой диагностируется гиперурикемия у мужчин
a. более 0,460 ммоль/л
b. более 0,420 ммоль/л
c. более 0,400 ммоль/л
d. более 0,360 ммоль/л
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

232. Моноартрит, как правило, встречается при
a. подагра
b. СКВ
c. системная склеродермия
d. РА
f. болезнь Бехтерева
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

233. Для лечения подагры может использоваться
a. ритуксимаб
b. галимумаб
c. канакинумаб
d. адалимумаб
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

234. Для подагры характерно
a. ассиметричное поражение суставов стоп в дебюте
b. симметричное поражение суставов кистей
c. поражение тазобедренных суставов
d. поражение плечевых суставов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

235. Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) чаще поражает
a. молодых мужчин
b. людей пожилого возраста
c. маленьких детей
d. женщин среднего возраста
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

236. Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) исключает
a. двусторонний сакроилеит
b. энтезопатии
c. узелки Гебердена
d. ночные боли в поясничной области
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

237. При болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилите) первыми вовлекаются суставы
a. позвоночника
b. корневые
c. дистальные
d. проксимальные
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

238. У пациентов с анкилозирующим спондилитом препаратом первой линии является
a. метотрексат
b. сульфасалазин
c. НПВП
d. ингибитор ФНО-а
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

239. К рентгенологическим признакам анкилозирующего спондилита относят
a. односторонний сакроилеит
b. эрозии мелких суставов кистей
c. односторонний сакроилеит
d. двусторонний сакроилеит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

240. Патогномоничными клиническими признаками болезни Крона являются
a. Запоры, вздутие живота, повышение температуры

b. Понос, боли в суставах
c. Постоянное кровотечение из прямой кишки, тошнота, температура
d. Боли в животе, понос, примесь крови и гноя в кале
e. Наличие инфильтратов в животе, поражение кожи, глаз и суставов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

241. Рентгенологическим симптомом, не характерным для болезни Крона, является
a. Наличие сужений и стриктур по ходу пораженных участков кишки
b. Множественные выпячивания стенки толстой кишки
c. Наличие одинаковых очагов поражения, как в толстой, так и в тонкой кишке
d. Наличие спикул по контуру кишки
e. Наличие внутренних и наружных кишечных свищей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

242. Выберите наиболее характерную зону поражения кишки при язвенном колите
a. Прямая кишка
b. Терминальный отдел подвздошной кишки
c. Любой отдел толстой кишки сегментарного характера
d. Вся толстая кишка
e. Анальная и перианальная зона
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

243. Выберите наиболее характерный морфологический признак болезни Крона при эндоскопическом исследовании
a. Язвы щелевидные, образующие «булыжную» мостовую
b. Усиление сосудистого рисунка слизистой
c. Множественные полипы
d. Налет фибрина
e. Гиперемия и отек слизистой
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

244. При каком заболевании наиболее часто образуются кишечные стриктуры
a. Язвенный колит
b. Болезнь Крона
c. Дивертикулез
d. Ишемический колит
e. Болезнь Гиршпрунга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

245. Укажите заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется преимущественно в слизистой оболочке
a. Ишемический колит
b. Болезнь Крона
c. Дивертикулез
d. Язвенный колит
e. Болезнь Гиршпрунга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

246. Для диагностики язвенного колита наиболее информативным является
a. Копрология
b. Посев кала на микрофлору
c. Колоноскопия

d. Рентгенологическое исследование тонкой кишки
e. Фиброгастроскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

247. При поражении хвоста у больных с панкреатитом боль локализуется
a. В левом подреберье или слева от пупка
b. В эпигастрии
c. В правом подреберье
d. Носит опоясывающий характер
e. В виде полупояса в верхней части живота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

248. Характерным клиническим признаком хронического панкреатита является
a. Развитие сахарного диабета
b. Снижение функции внешней секреции
c. Желтуха
d. Повышение активности трансаминаз
e. Гепатомегалия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

249. Для хронического панкреатита не характерны
a. Опоясывающие боли в эпигастрии
b. Боли в левом подреберье с иррадиацией в спину
c. Поносы
d. Рвота, приносящая облегчение
e. Снижение или отсутствие аппетита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

250. Для подавления активности ферментов поджелудочной железы применяются
a. Антациды
b. М-холиноблокаторы
c. H_2-гистаминоблокаторы
d. Сандостатин
e. Бета-адреноблокаторы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

251. Этиологическими факторами развития хронического панкреатита не являются
a. Заболевания желчных путей
b. Злоупотребление алкоголем
c. Иммунологические факторы
d. Пищевая аллергия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

252. Для хронического панкреатита не характерны
a. Абдоминальные боли
b. Стеаторея
c. Креаторея
d. Водная диарея
e. Сахарный диабет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

253. Метод выбора в лечении хронического калькулезного холецистита:

a. Растворение конкрементов литолитическими препаратами
b. Микрохолецистостомия
c. Дистанционная волновая литотрипсия
d. Холецистэктомия
e. Комплексная консервативная терапия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

254. Наиболее информативный метод исследования при интенсивной длительной желтухе – это
a. Внутривенная инфузионная холангиография
b. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
c. Чрескожная чреспеченочная холангиография
d. Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей
e. Пероральная холецистохолангиография
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

255. Наиболее информативный метод диагностики калькулезного холецистита
a. Пероральная холецистохолангиография
b. Лапароскопия
c. Обзорный рентгеновский снимок брюшной полости
d. Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей
e. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

256. В лечении гиперкинетической формы дискинезии желчевыводящих путей используют
a. Спазмолитические средства
b. Н2-блокаторы гистамина
c. Беззондовые тюбажи
d. Сукралфат и его аналоги
e. Хирургическое лечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

257. Желчный пузырь в норме располагается
a. В точке пересечения наружного края правой прямой мышцы живота и реберной дуги
b. В точке пересечения передне-аксилярной линии справа и реберной дуги
c. В точке пересечения срединно-ключичной линии и реберной дуги
d. На 5 см ниже вышеуказанной точки
e. Справа от пупка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

258. Положительный симптом Мерфи патогномоничен для
a. Язвенной болезни 12-перстной кишки
b. Холецистита
c. Панкреатита
d. Гастрита
e. Дуоденита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

259. Толщина стенки желчного пузыря по результатам УЗИ в норме составляет
a. 1-2 мм
b. 3-4 мм
c. 5-6 мм

d. 7-8 мм
e. 9-10 мм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

260. Для фазы обострения хронического холецистита наиболее типично сочетание следующих синдромов
a. Болевой, холестаза, портальной гипертензии
b. Болевой, диспепсический, воспалительный
c. Астено-вегетативный, диспепсический, общедистрофический
d. Диспепсический, холестаза, цитолиза гепатоцитов
e. Диспепсический, астено-вегетативный, анемический
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

261. Для цирроза печени не характерно наличие
a. Асцита.
b. Спленомегалии
c. Варикозного расширения вен желудка
d. Расширения поверхностных вен живота типа «головы медузы»
e. Гиперальбуминемии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

262. Наиболее информативный метод диагностики цирроза печени – это
a. Проба с бромсульфалеином
b. Определение уровня билирубина и аминотрансфераз
c. Тимоловая проба
d. Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей
e. Морфологическое исследование биоптата печени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

263. Асцит при циррозе печени образуется вследствие
a. Вторичного гиперальдостеронизма
b. Гипоальбуминемии
c. Портальной гипертензии
d. Всего из перечисленного
e. Ничего из перечисленного
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

264. Решающим основанием в постановке диагноза хронического гепатита является
a. Перенесенный вирусный гепатит
b. Данные гистологического исследования печени
c. Выявление в сыворотке крови «австралийского антигена»
d. Периодический субфебрилитет, иктеричность, боли в правом подреберье, умеренная гепатомегалия
e. Выявление в сыворотке α-фетопротеина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

265. Характерный гистологический признак хронического активного гепатита – это
a. Воспалительная инфильтрация портальных трактов
b. Расширение желчных капилляров
c. Некроз гепатоцитов
d. Наличие очагов гиалина (телец Маллори)
e. Уменьшение количества звездчатых ретикулоэндотелиоцитов (клеток Купфера)

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

266. Для синдрома холестаза характерно увеличение
a. Показателей бромсульфалеиновой пробы
b. Уровня γ-глобулинов
c. Уровня щелочной фосфатазы
d. Уровня кислой фосфатазы
e. Уровня аминотрансфераз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

267. Синдром мезенхимального воспаления характеризуется увеличением в крови:
a. Уровня γ-глобулинов
b. Уровня холестерола
c. Активности щелочной фосфатазы
d. Уровня билирубина
e. Уровня альбумина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

268. Для первичного билиарного цирроза характерен симптомокомплекс – это
a. Желтуха, зуд, ксантомы, гепатоспленомегалия, высокие уровни щелочной фосфатазы и холестерола
b. Желтуха, анорексия, тошнота, мягкая печень, высокие трансаминазы и нормальная щелочная фосфатаза
c. Желтуха, гепатоспленомегалия, умеренно увеличенные трансаминазы, гипер-γ-глобулинемия, положительные антитела к гладкой мускулатуре
d. Желтуха, боль в правом верхнем квадранте живота, гепатомегалия, лейкоцитоз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

269. Для аутоиммунного гепатита характерен симптомокомплекс – это
a. Желтуха, зуд, ксантомы, гепатоспленомегалия, высокие уровни щелочной фосфатазы и холестерола
b. Желтуха, анорексия, тошнота, мягкая печень, высокие трансаминазы и нормальная щелочная фосфатаза
c. Желтуха, гепатоспленомегалия, умеренно увеличенные трансаминазы, гипер-γ- глобулинемия, положительная реакция на антитела к гладкой мускулатуре
d. Желтуха, боль в правом верхнем квадранте живота, гепатомегалия, лейкоцитоз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

270. При малом и умеренном асците целесообразно проведение следующих мероприятий, кроме
a. Диеты с содержанием поваренной соли до 2 г в сутки
b. Ограничения суточного употребления жидкости до 1 л
c. Спиронолактона внутрь по 100 мг и более в день
d. Парааабдоминоцентеза с удалением асцитической жидкости
e. Фуросемида (40-120 мг в сутки) или торасемида (5-15 мг в сутки)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

271. Наиболее частая причина развития хронических диффузных заболеваний печени
a. Гепатотропные вирусы
b. Алкоголь
c. Наследственные заболевания - болезни накопления
d. Токсические гепатотропные агенты

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

272. Наиболее информативным методом диагностики хронического гастрита является
a. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
b. Эзофагогастродуоденоскопия с морфологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки желудка
c. Исследование желудочного сока
d. Рентгенологическое исследование желудка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

273. Референсный метод первичной диагностики H. pylori – это
a. Дыхательный тест с мочевиной, меченной ^{13}C
b. Бактериологический
c. Цитологический
d. Определение антител к H. Pylori в крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

274. Основные препараты терапии синдрома боли в эпигастрии при функциональной диспепсии – это
a. Антисекреторные препараты
a. Антациды
b. Спазмолитики
c. Прокинетики
d. Ферменты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

275. Основные препараты в лечении постпрандиального дистресс-синдрома при функциональной диспепсии – это
a. Антисекреторные препараты
b. Антациды
c. Спазмолитики
d. Прокинетики
e. Ферменты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

276. Стандартная схема тройной терапии 1-й линии для эрадикации H. pylori – это
a. Ингибиторы протонной помпы + прокинетик + метронидазол
b. Амоксициллин + кларитромицин + левофлоксацин
c. Ингибиторы протонной помпы + амоксициллин + кларитромицин
d. Ингибиторы протонной помпы + висмут трикалия дицитрат + тетрациклин
e. Висмут трикалия дицитрат + тетрациклин + метронидазол
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

277. Для повышения эффективности эрадикационной терапии H. pylori используют
a. Увеличение длительности терапии до 30 дней
b. Добавление к стандартной терапии висмута трикалия дицитрата
c. Назначение удвоенной дозы амоксициллина и кларитромицина
d. Замена ингибиторов протонной помпы Н2-блокаторами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

278. Контроль эффективности эрадикации H. pylori проводится
a. Сроки проведения контроля эффективности значения не имеют

b. В течение первой недели после окончания эрадикационной терапии
c. Спустя 2 недели после окончания эрадикационной терапии
d. Спустя 4 недели после окончания эрадикационной терапии
e. Спустя 8 недель после окончания эрадикационной терапии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

279. Для язвенной болезни луковицы ДПК характерно возникновение боли
a. Через 0,5-1 ч после приема пищи
b. В правом подреберье
c. Натощак и ночью
d. Сразу после еды
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

280. При длительном незаживлении язвы желудка и в первую очередь показано
a. Повторное рентгенологическое исследование желудка
b. Проведение курса гипербарической оксигенации
c. Повторная ЭФГДС с биопсией ткани из краев язвы
d. Продолжение курса противоязвенной терапии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

281. Язвенной болезни с локализацией язвы в пилорическом отделе свойственны
a. Наличие ранних болей
b. Редкие рецидивы заболевания
c. Изжога
d. Короткие и редкие ремиссии с частым осложнением кровотечением и стенозированием выходного отдела желудка
e. Все перечисленное верно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

282. Характерная боль при язвенной болезни ДПК – это
a. Тупая, давящая боль в эпигастральной области, усиливающаяся при приеме пищи
b. Схваткообразные боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо при приеме жирной пищи
c. Постоянная тупая боль в эпигастрии, не связанная с приемом пищи
d. Боли в эпигастральной области, возникающие натощак и через 2-3 ч после приема пищи
e. Давящие боли в левом подреберье, усиливающиеся после приема пищи и иррадиирующие в спину
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

283. Появление жалобы на отрыжку «тухлым яйцом», рвотой принятой накануне пищей у пациента с обострением язвенной болезни желудка указывает на развитие
a. Пенетрации
b. Кровотечения
c. Перфорации
d. Малигнизации язвы
e. Стенозирования пилорического отдела желудка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

284. Железодефицитная анемия характеризуется
a. гиперхромией, макроцитозом
b. гипохромией, макроцитозом

c. гипохромией, микроцитозом
d. гиперхромией, микроцитозом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

285. При хроническом лимфолейкозе могут быть обнаружены
a. “тени” Боткина-Гумпрехта
b. Ph-хромосома
c. LE-клетки
d. тельца Жолли
e. кольца Кебота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

286. Наиболее информативным методом для подтверждения миелопролиферативного синдрома при хроническом миелолейкозе
a. Определение лейкоцитарной формулы крови
b. Трепанобиопсия костного мозга
c. Пункция лимфатического узла
d. Пункция печени
e. Стернальная пункция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

287. В12-дефицитная анемия характеризуется
a. гиперхромией, макроцитозом
b. гипохромией, макроцитозом
c. гипохромией, микроцитозом
d. гиперхромией, микроцитозом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

288. Наиболее информативным методом для подтверждения лимфопролиферативного синдрома при хроническом лимфолейкозе является
a. Определение лейкоцитарной формулы крови
b. Трепанобиопсия костного мозга
c. Пункция лимфатического узла
d. Пункция печени
e. Стернальная пункция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

289. Острые и хронические лейкозы отличаются друг от друга
a. остротой клинических проявлений
b. степенью дифференцировки опухолевых клеток
c. длительностью заболевания
d. распространенностью процесса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

290. С целью контроля эффективности и безопасности терапии варфарином требуется определение
a. D-димера
b. АЧТВ
c. ПТИ
d. МНО
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

291. Для уточнения диагноза в случае выявления мегалобластной анемии дополнительно проводят исследование
a. уровня ферритина в сыворотке крови
b. ОЖСС
c. содержания витамина В12 и фолатов в сыворотке крови
d. пробу Кумбса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

292. Одним из критериев диагностики множественной миеломы является
a. обнаружение в костном мозге 10% и более плазматических клеток
b. эозинофильно-базофильная ассоциация
c. увеличение количества бластов в костном мозге более 30%
d. увеличение количества лимфоцитов в миелограмме более 30%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

293. Характерным для хронического миелолейкоза изменением миелограммы является обнаружение
a. “теней” Боткина-Гумпрехта
b. Ph-хромосомы
c. LE-клеток
d. телец Жолли
e. колец Кебота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

294. Для дефицита VII фактора свертывания характерно
a. удлинение АЧТВ и ПВ
b. удлинение ПВ, нормальное АЧТВ
c. удлинение АЧТВ, нормальное ПВ
d. нормальное ПВ и АЧТВ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

295. Развитие плеторического синдрома характерно для
a. острого лейкоза
b. хронического миелолейкоза
c. хронического лимфолейкоза
d. В12-дефицитной анемии
e. эритремии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

296. Лейкемическое зияние характерно для
a. острого лейкоза
b. хронического миелолейкоза
c. хронического лимфолейкоза
d. множественной миеломы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

297. Согласно классификации ВОЗ, анемии тяжелой степени диагностируется при уменьшении концентрация гемоглобина менее
a. 60 г/л
b. 66 г/л
c. 70 г/л
d. 80 г/л

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

298. Для выявления латентного дефицита железа следует определить концентрацию
a. ферритина
b. гемоглобина
c. железа
d. трансферрина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

299. В основе наследственного микросфероцитоза лежит
a. нарушение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
b. дефект мембраны эритроцита
c. образование аутоантител к собственным эритроцитам
d. дефект синтеза цепей глобина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

300. Для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры характерен тип кровоточивости
a. пятнисто-петехиальный
b. гематомный
c. смешанный микроциркуляторно-гематомный васкулитно-пурпурный
d. ангиоматозный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

301. Наиболее неблагоприятное сочетание факторов риска рака яичников **(High Grade):**
a. бесплодие, асцит, диплоидия
b. светлоклеточный вариант, генетическая нестабильность, G2-G3
c. интактная капсула опухоли, папиллярная серозная опухоль в анамнезе, G1
d. низкий ядерно-цитоплазматический индекс, возраст старше 40 лет, возникновение опухоли de Novo
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

302.Признаки пограничной серозной опухоли:
a. двусторонний процесс
b. пролиферация с нарушением стратификации, формированием многорядности и сосочков
c. инвазия в подлежащие ткани
d. кровоизлияния в полость опухоли
e. жидкостное строение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

303.Объем операции при СПОЯ (серозных пограничных опухолях яичников) в период менопаузального перехода:
a. лапароскопия, цистомэктомия
b. лапароскопия, овариоэктомия
c. лапароскопия, гистерэктомия с придатками
d. лапаротомия, резекция яичников
e. лапаротомия, овариоэктомия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

304.Объем операции при I и II стадиях рака яичников:
a. двусторонняя овариоэктомия
b. экстрафасциальная гистерэктомия с придатками

c. тотальная гистерэктомия с придатками, резекция большого сальника, биопсия брюшины карманов брюшной полости, лимфодиссекция парааортальных лимфатических узлов
d. расширенная тотальная гистерэктомия с придатками, верхней третью влагалища, тазовая лимфаденэктомия
e. резекция опухолей яичников
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

305.Объем операции при III и IV стадиях рака яичников:
a. тотальная гистерэктомия с придатками, резекция большого сальника, биопсия брюшины карманов брюшной полости, лимфодиссекция парааортальных лимфатических узлов
b. расширенная тотальная гистерэктомия с придатками, верхней третью влагалища, тазовая лимфаденэктомия
c. промежуточная циторедукция
d. резекция опухолей яичников
e. диагностическая лапароскопия (лапаротомия), биопсия опухолей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

306.Для I патогенетического варианта рака эндометрия характерно КРОМЕ:
a. нейро-обменные нарушения
b. дифференцировка клеток G2 и G3
c. возникновение аденокарциномы на фоне эндометриальной интраэпителиальной неоплазии
d. рецепторположительная опухоль
e. в анамнезе бесплодие, обусловленное хронической ановуляцией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

307.Доказательный метод диагностики рака эндометрия:
a. ультразвуковое исследование в 3D формате с допплерографией
b. гистологическое, гистохимическое и морфоколичественное исследование эндометрия
c. определение опухолевых маркеров СА-125, НЕ4, СА-19-9, СА-72-4
d. ПЭТ+КТ
e. МРТ с контрастированием
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

308.Комплексное лечение рака эндометрия Ib стадии:
a. тотальная гистерэктомия с придатками и верхней третью влагалища+адъювантная химиотерапия
b. расширенная гистерэктомия с придатками и верхней третью влагалища+сочетанная лучевая терапия
c. расширенная гистерэктомия с придатками и верхней третью влагалища, тазовая лимфаденэктомия+дистанционная лучевая терапия+гормонотерапия
d. расширенная гистерэктомия с придатками и верхней третью влагалища+сочетанная лучевая терапия+ адъювантная химиотерапия
e. сочетанная лучевая терапия+ адъювантная химиотерапия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

309.Наиболее частая локализация сторожевого лимфатического узла при раке эндометрия:
a. парааортальный
b. наружный подвздошный
c. обтураторный
d. внутренний подвздошный
e. паховый
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

310.Основной клинический симптом при подозрении на рак эндометрия:
a. АМК по типу обильный маточных кровотечений
b. АМК по типу межменструальных маточных кровотечений
c. болевой симптом в виде постоянных тянущих болей
d. обильные гнойные зловонные выделения из половых путей
e. олиго-аменорея
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

311.К факторам риска эмболии амниотической жидкости не относится:
a. дискоординированная родовая деятельность
b. многоводие
c. индукция родов
d. снижение биохимических маркеров по результатам I скрининга
e. разрыв матки или шейки матки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

312.Экстренная терапия эмболии амниотической жидкостью начинается со следующих мероприятий:
a. введение раствора промедола, димедрола, диазепама
b. инфузионная терапия, введение глюкокортикоидов
c. эпидуральная анестезия
d. экстренное родоразрешение
e. переливание эритроцитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

313.Способ родоразрешения при эмболии амниотической жидкостью в первом периоде родов:
a. операция наложения акушерских щипцов (applicatio forcipes obstetricae)
b. кесарево сечение (sectio caesarea)
c. стимуляция родовой деятельности (stimulatio uteri)
d. роды через естественные родовые пути (partus per vias naturales)
e. плодоразрушающая операция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

314.Материнская смертность вследствие эмболии амниотической жидкостью является:
a. управляемой причиной материнской смертности
b. не входит в структуру причин материнской смертности
c. малоуправляемой причиной материнской смертности
d. входит в группу причин смертности от экстрагенитальных заболеваний
e. входит в группу причин смертности от кровотечений
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

315.Эмболия амниотической жидкости может произойти:
a. во время беременности, в родах и в течение 12 часов после родов
b. во время беременности и в родах
c. в родах
d. во время беременности, в родах и в течение 24 часов после родов
e. в 1 и 2 периодах родов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

316.С целью уточнения состояния клапанного аппарата сердца беременным выполняется

a. эхокардиография
b. компьютерная томография
c. магнито-резонансная томография
d. контрастная вентрикулография
e. суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

317.Беременной 2 года назад произведена операция протезирования митрального клапана двустворчатым шарнирным протезом. Жалобы при поступлении в перинатальный центр на одышку и сердцебиение при умеренной нагрузке. Кожные покровы нормальной окраски, небольшие отеки на стопах. Пульс в покое: 96 в минуту, единичные экстрасистолы. АД 100/70, 110/70 мм рт. ст., ЧДД 21 в минуту. Тоны сердца ясные, на верхушке и в точке Боткина систолический и диастолический шум, акцент II тона на лёгочной артерии, щелчки открытия клапана. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Определите стадию ХСН -
a. I стадия
b. III стадия
c. II Б стадия
d. II А стадия
e. 0 стадия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

318.Тактика ведения беременной с ХСН I стадии предполагает -
a. родоразрешение путем планового кесарева сечения в 37 недель
b. родоразрешение путем экстренного кесарева сечения
c. спонтанное родоразрешение
d. выключение потужного периода наложением полостных акушерских щипцов
e. выключение потужного периода наложением выходных акушерских щипцов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

319.Родоразрешение беременной с оперированным сердцем будет проводиться:
a. в стационаре 1 уровня
b. в стационаре 2 уровня
c. в стационаре 3 уровня
d. в НИИ кардиологии
e. в дежурном акушерском стационаре
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

320.Беременная с протезированным клапаном в течение всей беременности принимала варфарин с целью:
a. улучшения маточно-плацентарного кровотока
b. профилактики тромбо-эмболических осложнений
c. профилактики гнойно-септических осложнений
d. профилактика ранней преэклампсии
e. лечение ЗРП
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

321.Комбинированная оральная контрацепция – это
a. циклический оральный прием препаратов, содержащих эстрогены и прогестагены
b. непрерывный прием препаратов, содержащих эстрогены и прогестагены
c. циклический оральный прием препаратов, содержащих эстрогены
d. циклический оральный прием препаратов, содержащих прогестагены

e. непрерывный прием препаратов, содержащих эстрогены
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

322.Частота беременностей при приеме комбинированных оральных контрацептивов на 100 женщин в год составляет
a. 6–8
b. 20–30
c. 1–2
d. 15–20
e. 75
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

323.К доказательным лечебным эффектам комбинированных оральных контрацептивов относят
a. снижение риска развития РЭ и яичников, а также колоректального рака
b. снижение риска развития миомы матки
c. снижение риска внематочной беременности
d. лечебное действие при ПМС и предменструальном дисфорическом расстройстве
e. снижение риска пороков развития плода и осложнений беременности, ассоциированных с гипергомоцистеинемией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

324.Комбинированные оральные контрацептивы по количеству этинилэстрадиола бывают
a. монофазные
b. содержащие этинилэстрадиол
c. трехфазные
d. низкодозированные
e. содержащие эндогенный эстрадиол
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

325.Относительные противопоказания к применению комбинированных оральных контрацептивов
a. ишемическая болезнь сердца, инсульт (в том числе в анамнезе)
b. лактация – первые 6 нед после родов
c. РМЖ в настоящее время, а также подозрение на него
d. лактация от 6 нед до 6 мес после родов
e. курение более 15 сигарет в сутки в возрасте старше 35 лет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

326.Лучше всего прослушивается сердцебиение плода при первой позиции в переднем виде затылочного предлежания плода:
a. справа ниже пупка
b. слева ниже пупка
c. слева выше пупка
d. слева на уровне пупка
e. справа выше пупка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

327.Для оценки состояния плода применяется
a. аускультация
b. кардиотокография
c. ультразвуковое исследование

d. гормональное исследование
e. все перечисленное
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

328.Что включает в себя наружное акушерское исследование?
a. определение размеров живота, таза, плода, приемы Леопольда-Левицкого
b. определение размеров живота, таза, плода, ромба Михаэлиса, индекса Соловьева, приемы Леопольда-Левицкого
c. ОЖ, ВДМ, тазоизмерение, длина плода, лобно-затылочный размер головки, выслушивание сердцебиении плода
d. определение размеров живота, таза, плода, ромба Михаэлиса, индекса Соловьева, приемы наружного акушерского исследования, выслушивание сердцебиения плода, УЗИ
e. осмотр, определение размеров живота, плода, таза, ромба Михаэлиса, индекса Соловьева, приемы Леопольда-Левицкого, выслушивание сердцебиения плода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

329.Какие методы включает в себя специальное акушерское исследование беременной и роженицы?
a. наружное акушерское исследование, внутреннее акушерское исследование и дополнительные методы
b. приемы Леопольда-Левицкого, внутреннее акушерское исследование и дополнительные методы
c. определение положения, предлежания, вида, позиции плода, тазоизмерение, влагалищное исследование
d. приемы Леопольда-Левицкого, выслушивание сердцебиение плода, тазоизмерение, влагалищное исследование
e. приемы наружного акушерского исследования, измерение ОЖ, ВДМ, вычисление массы плода. влагалищное исследование, УЗИ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

330.Наиболее информативно определение срока беременности по
a. результату первого скринингового УЗИ в 11–14 недель
b. результату второго скринингового УЗИ на 18–21 неделе
c. дате последней менструации
d. дате овуляции
e. бипариетальному размеру головки плода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

331.Гетеротопическая беременность – это
a. любая внематочная беременность
b. сочетание маточной локализации одного плотного яйца и внематочной локализации другого
c. сочетание внематочной локализации двух плодных яиц
d. синоним интралигаментарной внематочной беременности
e. многоплодная беременность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

332.При наличии здоровой контралатеральной маточной трубы при трубной беременности предпочтительнее выполнять
a. сальпингэктомию
b. сальпинготомию

c. аднексэктомию
d. резекцию маточной трубы
e. консервативное лечение мататрексатом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

333.Основной УЗ-признак внематочной беременности при положительном тесте на ХГЧ –
a. гравидарная гиперплазия эндометрия
b. наличие желтого тела в яичнике
c. отсутствие плодного яйца в полости матки
d. наличие плодного яйца в полости матки
e. жидкость в позадиматочном пространстве
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

334.Основной скрининговый лабораторный метод для проведения дифференциальной диагностики острого живота -
a. общий (клинический) анализ крови
b. биохимический анализ крови
c. свертывающая система крови
d. томбоэластограмма
e. общий анализ мочи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

335.Основной метод дифференциальной диагностики внематочной беременности и апоплексии яичника –
a. общий (клинический) анализ крови
b. УЗИ ОМТ
c. кульдоцентез
d. исследование мочи/крови на хорионический гонадотропин
e. PAPP-A
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

336.По классификации National Institute for Health and Care Excellence, NICE, Великобритания, продолжительность фаз заболевания COVID-19 (острый, продолжающийся симптоматический и постковидный синдром) составляют соответственно:
a. 4 – 4 – 4 недели
b. 2 – 4 – 12 недель
c. 3 – 12 – 24 недели
d. 4 – 8 – все дальнейшее время
e. 4 – 12 – все дальнейшее время
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

337.Основные клинические проявления постковидного синдрома это
a. неспецифическая неврологическая симптоматика, коагулопатия, кожный васкулит
b. психические отклонения, нарушения функций отдельных органов, офтальмопатия
c. артрит крупных суставов, мигрень, психические отклонения
b. нарушения сердечного ритма, коагулопатия, венозные тромбозы
e. стойкая гипертензия, нарушения функции почек, артериальные тромбозы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

338.Начавшаяся через несколько недель или месяцев после заболевания COVID-19 острая воспалительная быстропрогрессирующая демиелинизирующая полирадикулоневропатия с

развитием вялых парезов и плегий, восходящими нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами это:
a. синдром Кавасаки
b. синдром Фишер – Мюллера
c. синдром Гийена – Барре
d. синдром Аперта
e. синдром Гайе – Вернике
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

339.Основная симптоматика Кавасаки подобного постковидного синдрома это:
a. демиелинизирующая полирадикулоневропатия, с развитием офтальмоплегии, мозжечковой атаксии и арефлексии при отсутствии или незначительно выраженной слабости скелетной мускулатуры
b. некротизирующий системный васкулит с поражением преимущественно средних и мелких артерий с развитием аневризм сосудов различного калибра
c. быстро прогрессирующая демиелинизирующая полирадикулоневропатия с развитием вялых парезов и плегий
d. когнитивные нарушения («мозговой туман», потеря концентрации или проблемы с памятью), головная боль, нарушение сна
e. желудочно-кишечные симптомы: боль в животе, тошнота, диарея, анорексия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

340.Стартовая доза метилпреднизолона при лечении постковидного синдрома это:
a. 24 мг 2 раза в сутки
b. 30 мг 2 раза в сутки
c. 4 мг 2 раза в сутки
d. 4 мг 1 раз в сутки утром
e. 24 мг 1 раз в сутки утром
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

341.Олигоменорея – частота менструаций
a. менее 6 в год
b. менее 3 в год
c. менее 9 в год
d. менее 7 в год
e. менее 5 в год
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

342.Первичная аменорея – это отсутствие менструаций
a. в 13 лет
b. в 14 лет
c. в 11 лет
d. через 3 года после телархе
e. через год после телархе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

343.Вторичная аменорея
a. отсутствие менструаций с течение 6 месяцев при ранее нерегулярном цикле
b. отсутствие менструаций с течение 8 месяцев при ранее нерегулярном цикле
c. отсутствие менструаций в течение 2 месяцев при ранее регулярном цикле
d. отсутствие менструаций с течение 4 месяцев при ранее нерегулярном цикле
e. отсутствие менструаций с течение 5 месяцев при ранее нерегулярном цикле

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

344.Маточная форма аменореи наблюдается при синдромах
a. Свайера
b. Тернера
c. Рокитанского-Кюстнера
d. СПКЯ
e. чистой формой дисгенезии гонад
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

345.При бесплодии N97.1 (sterilitas tubaria) показано:
a. выжидательная тактика (ожидание спонтанной беременности в течение 6 мес)
b. ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
c. ИИСМ (искусственная инсеминация спермой мужа)
d. стимуляция яичников антиэстрогенами (кломифен)
e. суррогатное материнство
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

346.Продолжительность нормального менструального цикла
a. 21–35 дней
b. 28–30 дней
c. 24–35 дней
d. 24–38 дней
e. 21–28 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

347.Объем кровопотеря во время менструации в норме
a. 5–10 мл
b. 10–50 мл
c. 5–100 мл
d. 60–70 мл
e. 5–80 мл
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

348.Аномальные маточные кровотечения – это кровотечения
a. с интервалом более 38 дней и 60 мл
b. с интервалом менее 28 дней и объемом кровопотери 70 мл;+
c. объемом кровопотери 60-70 мл, длительностью более 8 дней, интервалом менее 24 дней
d. длительностью более 8 дней и объемом кровопотери более 80 мл и интервалом менее 24 дней
e. длительностью 6 дней и интервалом менее 24 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

349.Аномальные маточные кровотечения вследствие органических причин
a. leiomyoma (лейомиома)
b. coagulopathy (коагулопатия)
c. endometrial (эндометриальные)
d. not yet classified (не относящиеся ни к какой из категорий или еще не классифицированные)
e. iatrogenic (ятрогенные)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

350.Лекарственные препараты, провоцирующие АМК, кроме

a. препараты половых гормонов
b. антикоагулянт непрямого действия (варфарин)
c. цефалоспорины
d. модуляторы эстрогеновых рецепторов (тамоксифен)
e. фенотиазины и трициклические антидепрессанты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

351.Критерии тяжелой преэклампсии: (выбери один вариант)
a. САД≥160 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. независимо от уровня АД в анамнезе в сочетании с протеинурией ≥5 г в сутки или ≥3 г/л в 2-х порциях мочи взятых с интервалом 12 часов, или хотя бы одним другим параметром свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности
b. САД≥160 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. у женщин с хронической артериальной гипертензией, в сочетании с протеинурией ≥5 г в сутки или ≥3 г/л в 2-х порциях мочи взятых с интервалом 12 часов
c. САД≥160 мм рт. ст. и ДАД ≥ 110 мм рт. ст. независимо от уровня АД в анамнезе в сочетании с протеинурией ≥5 г в сутки или ≥3 г/л в 2-х порциях мочи взятых с интервалом 12 часов
d. САД≥160 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. независимо от уровня АД в анамнезе в сочетании с протеинурией ≥5 г в сутки или ≥3 г/л в 2-х порциях мочи взятых с интервалом 12 часов, наличие периферических отеков
e. серия судорог у женщины на фоне САД≥160 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 110 мм рт. ст. независимо от уровня АД в анамнезе в сочетании с протеинурией ≥5 г в сутки или ≥3 г/л в 2-х порциях мочи взятых с интервалом 12 часов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

352.Лабораторные исследования необходимые для уточнения диагноза тромботическая микроангиопатия
a. шизоциты, ЛДГ, ЩФ, АСТ, АЛТ
b. тромбоциты, ЩФ, ЛДГ, уровень печеночных ферментов
c. фрагментированные эритроциты, ЛДГ, непрямой билирубин, гаптоглобин
d. тромбоциты, креатинин, уровень печеночных ферментов, гемоглобин, гематокрит
e. общий белок, АЛТ, АЛТ, креатинин, билирубин, мочевая кислота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

353.Профилактика присоединения преэклампсии включает:
a. назначение с 12 по 36 нед - препаратов кальция 1 г/сут + ацетилсалициловая кислота 75 мг/сут
b. назначение с 12 по 36 нед - препаратов кальция 1 г/сут + ацетилсалициловая кислота 150 мг/сут
c. назначение с 12 по 36 нед - препаратов кальция 1 г/сут+ ацетитсалициловая кислота 150 мг/сут + ограничение потребления соли
d. назначение с 12 по 36 нед - препаратов кальция 1 г/сут+ ацетитсалициловая кислота 150 мг/сут + фоливая кислота 800 мкг/сут
e. препараты группы гепарина с момента установления факта беременности у женщин группы риска присоединения преэклампсии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

354.К основным препаратам для плановой терапии АГ у пациенток во время беременности, родов и в послеродовом периоде НЕ ОТНОСИТСЯ
a. метилдопа
b. метопролол
c. амлодипин

d. нифедипин
e. урапидил
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

355.Найди неверное утверждение
a. сульфат магния может вводиться с целью нейропротекции плода при сроке менее 34 нед
b. применение сулльфата магния не повышает частоту кесарева сечения, кровотечений, инфекционных заболеваний
c. при тяжелой преэклампсии и эклампсии сульфат магния препарат 1-ой линии для профилактики и лечения судорог
d. сульфат магния обладает нейропротективным действием, противосудорожным и гипотензивным действием
e. режим введения сультафа магния – 16 мл 25 % в/в болюсно, затем 4 мл/ч
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

356.Жалобы, характерные для нормальной беременности это:
a. регулярные боли внизу живота, сопровождающиеся повышением тонуса матки
b. запоры, масталгия
c. тошнота, рвота, выраженные боли в эпигастрии
d. изжога, не купирующаяся диетой и медикаментозно
e. диарея
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

357.Наиболее достоверный расчет срока беременности при регулярном цикле проводится по
a. первому дню последней менструации
b. КТР при первом визите беременной
c. КТР при первом ультразвуковом скрининге в 11–12 недель
d. размерам плода при втором скрининге в 19–20 недель
e. первому дню последней менструации, если он не различается с расчетом по КТР при первом ультразвуковом скрининге в 11–12 недель более чем на 5 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

358.Нормальная еженедельная прибавка массы тела беременной в первом триместре беременности это:
a. 400–500 грамм
b. 500–800 грамм
c. 1000–1500 грамм
d. 500–1500 грамм
e. 500–2000 грамм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

359.Рекомендовано обследовать беременную женщину на наличие антител к следующим возбудителям:
a. краснуха, токсоплазма, цитомегаловирус
b. краснуха, токсоплазма
c. краснуха
d. токсоплазма
e. краснуха, токсоплазма, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 2 типа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

360.Беременной женщине группы высокого риска самопроизвольного выкидыша следует назначить гестагены:

a. с 6 до 12 недель
b. с первого визита до 34 недель
c. с первого визита до 12 недель
d. с первого визита до 20 недель
e. рутинно не следует назначать
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

361.Шоковый индекс это:
a. отношение систолического давления к пульсу
b. отношение систолического давления к диастолическому
c. отношение диастолического давления к пульсу
d. отношение пульса к систолическому давлению
e. отношение пульса к диастолическому давлению
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

362.Для какого этапа выкидыша характерна следующая клиническая картина: прерывание беременности, сопровождающееся лихорадкой, ознобом, недомоганием, болями внизу живота, кровяными, иногда гноевидными выделениями из половых путей.
a. неполный выкидыш
b. инфицированный выкидыш
c. выкидыш в ходу
d. неразвивающаяся беременность
e. угрожающий выкидыш
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

363.Что из нижеперечисленного НЕ относится к основным этиологическим факторам раннего послеродового кровотечения:
a. нарушение сокращения матки
b. предлежание, плотное прикрепление или врастание плаценты
c. послеродовая инфекция
d. травма родовых путей
e. нарушения свертывания крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

364.Основным клиническим признаком центрального предлежания плаценты (placenta praevia centralis) является:
a. кровяные выделения из половых путей яркого цвета при болезненной матке
b. тянущие боли внизу живота без кровяных выделений из половых путей
c. кровяные выделения из половых путей яркого цвета при безболезненной матке
d. тянущие боли внизу живот и кровяные выделения из половых путей яркого цвета
e. гипертонус матки с симптомами геморрагического шока, без наружного кровотечения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

365.Выжидательная тактика при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты возможна при:
a. любой ее форме при постоянном наблюдении за состоянием беременной и плода
b. легкой форме при удовлетворительном состоянии беременной и плода
c. легкой форме независимо от состояния беременной и плода
d. легкой и средней степени при удовлетворительном состоянии беременной и плода
e. никогда не возможна. При постановке диагноза ПОНРП независимо от ее формы показано экстренное родоразрешение путем КС
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b.

366.Характерные особенности миомы матки:
a. это доброкачественная, гормонально-зависимая опухоль
b. исходит из поперечнополосатой мышечной ткани
c. наиболее часто встречается в пубертатном возрасте и у женщин раннего репродуктивного периода
d. склонна к малигнизации
e. все перечисленное верно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a.

367.Миома матки:
a. при общих размерах более 12 недель является показанием к оперативному лечению
b. в случаях наступления беременности является противопоказанием для искусственного аборта
c. рассматривается как противопоказание для диагностического выскабливания полости матки
d. является показанием к химиотерапии
e. может сопровождаться неврологическими расстройствами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a.

368.Наиболее информативный метод диагностики межмышечной миомы матки:
a. влагалищное исследование
b. ультразвуковое исследование
c. гистеросальпингография
d. гистероскопия
e. лапароскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b.

369.Плановая гинекологическая операция должна проводиться:
a. в дни менструации
b. в первую неделю после прекращения менструации
c. в дни ожидаемой менструации
d. накануне менструации
e. выбор дня менструального цикла не имеет значения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b.

370.Характерными особенностями субмукозной миомы матки являются:
a. быстрый рост;
b. кровотечение;
c. некроз миоматозного узла;
d. схваткообразные боли внизу живота;
e. злокачественное перерождение.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a.

371.Своевременными называются роды, которые происходят в сроке
a. 22 и более недель
b. 28 и более недель
c. 36^{6}–42^{0} недель
d. 37^{0}–41^{6} недель
e. 34^{0}–41^{6} недель
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

372.Время от начала родов до полного раскрытия маточного зева называют

a. прелиминарным периодом
b. первым периодом родов
c. вторым периодом родов
d. третьим периодом родов
e. активной фазой первого периода родов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

373.Время от полного раскрытия маточного зева до рождения плода называют
a. латентной фазой первого периода родов
b. активной фазой первого периода родов
c. вторым периодом родов
d. третьим периодом родов
e. последовым периодом родов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

374.Время от рождения плода до рождения последа называют
a. прелиминарным периодом
b. латентной фазой первого периода родов
c. активной фазой первого периода родов
d. сворым периодом родов
e. третьим периодом родов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

375. Объективными признаками начала родов являются
a. опускание живота и отхождение слизистой пробки
b. любые сокращения матки, которые фиксируются рукой акушера или посредством КТГ
c. околоплодные воды, подтекающие из половых путей
d. регулярные сокращения матки и структурные изменения шейки матки (укорочение-сглаживание-раскрытие)
e. кровянистые выделения из половых путей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

376.Гистеросальпингография в диагностике внутреннего эндометриоза матки наиболее информативна:
a. за 1–2 дня до начала менструации
b. сразу после менструации
c. на 12–14-й день
d. на 16–18-й день
e. на 20–22-й день
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

377.Основной клинический симптом эндометриоза шейки матки:
a. дисменорея
b. менометроррагия
c. пред- и постменструальные кровянистые выделения
d. бесплодие
e. все ответы правильные
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c.

378.Аденомиоз – это:
a. воспаление слизистой оболочки тела матки
b. предраковое заболевание эндометрия

c. предраковое заболевание шейки матки
d. характеризуется поражением миометрия маточной полости клетками эндометрия
e. доброкачественная опухоль матки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d.

379.Укажите противопоказания к назначению агонистов гонадотропин-релизинг-гормона:
a. эндометриоз яичников
b. миома матки
c. бесплодие эндокринного генеза
d. рак молочной железы
e. ничего из перечисленного выше
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c.

380.Синтетические эстраген-гестагенные препараты в комплексной терапии эндометриоза:
a. применяются редко
b. могут назначаться с 5 по 25 день менструального цикла
c. используются при сочетании эндометриоза и миомы матки
d. применяются в комбинации с андрогенами
e. влияют на активность пролиферативных процессов в эндометриоидных очагах
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e.

381.Главным эстрогенным гормоном в организме женщины в период постменопаузы является:
a. эстрадиол
b. эстрон
c. эстриол
d. альдостерон
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

382.Для диагностики постменопаузального периода используется определение уровня:
a. лютеинизирующего гормона
b. эстрадиола
c. прогестерона
d. фолликулостимулирующего гормона
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

383.Величина м-эхо в норме у пациенток в постменопаузальном периоде составляет:
a. 5 мм
b. 8 мм
c. 7 мм
d. 6 мм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

384.Для фазы поздней постменопаузы характерно:
a. истощение фолликулярного запаса яичников
b. прогрессирующее повышение ФСГ
c. соматическое старение
d. снижение эстрадиола и АМГ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

385.В постменопаузе при кольпоскопии эпителий шейки матки:
a. атрофичный

b. метапластический
c. цилиндрический
d. многослойный плоский
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

386.Перименопауза включает в себя период:
a. менопаузы и постменопаузы
b. постменопаузы и старости
c. от первых симптомов менопаузы и 2 года после прекращения самостоятельных менструаций
d. перименопаузы и менопаузы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

387.Период постменопаузы характеризуется развитием:
a. гипергонадотропного гипогонадизма
b. гипогонадотропного гипогонадизма
c. вторичной надпочечниковой недостаточности
d. вторичного гипотиреоза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

388.К морфологическим изменениям яичников женщины в постменопаузе относят:
a. утолщение мозгового вещества яичников с увеличением количества примордиальных фолликулов
b. непрерывное увеличение толщины коркового слоя яичников с уменьшением количества фолликулов
c. хорошо различимое, как макроскопически так и микроскопически, корковое и мозговое вещество
d. постепенное истончение толщины коркового слоя яичников с уменьшением количества фолликулов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

389.В период постменопаузы наиболее часто наблюдается относительная:
a. гиперпролактинемия
b. гиперандрогения
c. гиперпрогестеронемия
d. гиперэстрогения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

390.Поздняя менопауза характеризуется наступлением последней менструации в возрасте старше:
a. 60
b. 51
c. 55
d. 57
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

391.Повышение уровня гонадотропинов в период менопаузы связано с:
a. утратой обратной отрицательной связи от яичниковых гормонов
b. увеличением продукции андрогенов в надпочечниках и жировой ткани
c. снижением продукции прогестерона в яичниках
d. возрастными изменениями в гипофизе и гипоталамусе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

392.Если менопауза наступает в возрасте до 40 лет, то ее называют:
a. поздней
b. своевременной
c. ранней
d. преждевременной
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

393.Основной причиной наступления менопаузы является:
a. снижение уровня эстрогенов и прогестерона
b. наличие возрастных изменений в гипофизе и гипоталамусе
c. истощение фолликулярного аппарата яичников
d. повышение уровня фолликулостимулирующего гормона
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

394.Большие железы преддверия влагалища расположены:
a. в толще задних отделов больших половых губ
b. в основании малых половых губ
c. в толще средних отделов больших половых губ
d. в бороздке между нижними третями малых и больших половых губ
e. в области передней спайки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

395.Брюшина покрывает матку:
a. с середины передней поверхности до середины задней поверхности
b. только в области дна матки
c. с середины передней поверхности, переходя на дно и по задней поверхности до уровня наружного зева
d. с уровня перешейка по ее передней поверхности, переходя на дно и по задней поверхности, надвлагалищную часть шейки матки.
e. с уровня перешейка по ее передней поверхности до середины задней поверхности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

396.Границей между наружными и внутренними половыми органами является:
a. малые половые губы
b. девственная плева
c. большие железы преддверия влагалища
d. наружный маточный зев
e. внутренний маточный зев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

397.Диафрагма таза образуется:
a. седалищно-пещеристой мышцей
b. глубокой поперечной мышцей промежности
c. мочеполовой диафрагмой
d. поверхностной поперечной мышцей промежности
e. мышцей, поднимающей задний проход
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

398.К фиксирующему аппарату внутренних половых органов относят:
a. крестцово-маточные связки
b. круглые маточные связки
c. широкие маточные связки

d. собственные связки яичника
e. воронко-тазовые связки яичника
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

399.Кровоснабжение яичника осуществляется:
a. маточной артерией
b. яичниковой артерией
c. маточной и яичниковой артериями
d. внутренней половой и яичниковой артериями
e. подвздошно-поясничной артерией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

400.Частота беременностей при приеме комбинированных оральных контрацептивов на 100 женщин в год составляет
a. 6–8
b. 20–30
c. 1–2
d. 15–20
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

401. Для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни первоочередным исследованием является
a. эндоскопическое
b. рентгенологическое
c. гистологическое
d. pH-метрия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

402. Эндоскопическое исследование позволяет выявить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь в форме
a. гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом
b. диффузного эзофагоспазма
c. синдрома Мэллори-Вейса
d. кандидозного эзофагита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

403. Желудочную секрецию стимулирует
a. гастрин
b. секретин
c. холецистокинин
d. серотонин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

404. Внутренний фактор Кастла образуется в
a. фундальной части желудка
b. толстой кишке
c. двенадцатиперстной кишке
d. тонкой кишке
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

405. К признакам внутрисекреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите относят

a. гипергликемию
b. снижение массы тела
c. дефицит жирорастворимых витаминов
d. стеаторею
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

406. Препаратами выбора при лечении больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью являются
a. ингибиторы протонной помпы
b. блокаторы Н2-рецепторов гистамина
c. алюминийсодержащие гастропротекторы
d. блокаторы дофаминовых рецепторов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

407. Самым опасным осложнением асцита является
a. спонтанный бактериальный асцит-перитонит
b. пупочная грыжа
c. развитие венозных коллатералей на брюшной стенке
d. одышка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

408. В консервативную терапию хронического панкреатита не включаются
a. кортикостероиды
b. Сандостатин
c. анальгетики
d. ферментные препараты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

409. Лабораторным показателем обострения хронического панкреатита является уровень
a. амилазы
b. аминотрансферазы
c. щелочной фосфатазы
d. глюкозы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

410. При боли в животе, тошноте, изжоге, отрыжке следует назначить
a. эзогогастродуоденоскопию
b. рентгенография органов брюшной полости
c. клинический анализ крови
d. компьютерную томографию органов брюшной полости
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

411. Ингибиторы протонового насоса обеспечивают уровень внутрижелудочного pH на уровне ___ и выше более 18 часов в сутки
a. 3
b. 7,5
c. 7
d. 5
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

412. Исследованием, характеризующим внутрисекреторную функцию поджелудочной железы, является

a. гликемический профиль
b. реакция Грегерсена
c. диастаза мочи
d. копрограмма
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

413. Противопоказанием для фиброэндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта является
a. астматическое состояние
b. рак кардии
c. дивертикул пищевода
d. варикозное расширение вен пищевода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

414. Для оценки функциональных последствий хронического панкреатита следует определить в крови уровень
a. глюкозы и инсулина натощак
b. железа и витамина В12 после пробного завтрака
c. холестерола и триацилглицеролов натощак
d. липазы и амилазы после пробного завтрака
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

415. Наиболее информативным методом в диагностике эндоскопически негативной гастроэзофанеальной рефлюксной болезни является
a. суточное мониторирование внурипищеводного pH
b. рентгенологичское исследование пищевода
c. сцинтиграфия пищевода
d. УЗИ органов брюшной полости
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

416. Риск развития острого панкреатита велик при значительном повышении в плазме крови
a. ЛПОНП
b. ЛПНП
c. ЛПВП
d. ЛП(а)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

417. При гастроэзофагеальном рефлюксе необходимо
a. дробное питание
b. назначение апоморфина
c. горизонтальное положение после еды
d. ограничение животных жиров
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

418. Фактором риска панкреатита является
a. злоупотребление алкоголем
b. работа в ночную смену
c. непереносимость молочных продуктов
d. чрезмерная физическая нагрузка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

419. При ультразвуковом исследовании невозможно охарактеризовать ____ изучаемых органов и структур
a. микроструктуру
b. макроструктуру
c. топографо-анатомические взаимоотношения
d. и макроструктуру, и топографо-анатомические взаимоотношения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

420. Наиболее значимым симптомом, указывающим на наличие дуоденального рефлюкса, является
a. наличие желчи в рвотных массах
b. тошнота
c. отрыжка воздухом
d. тяжесть в эпигастрии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

421. Ведущим механизмом, играющим роль в патогенезе гастроэзогафеальной рефлюксной болезни, является
a. снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера
b. повышение тонуса нижнего пищеводного сфинктера
c. гипосекреция соляной кислоты
d. усиление пищеводного клиренса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

422. Наиболее достоверным подтверждением панкреатита является
a. высокий уровень амилазы в крови (диастазы в моче)
b. гипергликемия
c. боль опоясывающего характера
d. стеаторея
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

423. Частой причиной панкреатита является
a. заболевание желчного пузыря
b. инфекция
c. ожирение
d. хеликобактер пилори
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

424. Для подавления активности поджелудочной железы применяется
a. Апротинин
b. Магния гидроксид + Алгелдрат
c. Окспренолол
d. Полиметелсилоксана полигидрат
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

425. К ранним проявлением внешнесекреторной недостаточности поджеледочной железы относят
a. полифекалию
b. кахексию
c. сахарный диабет
d. "пакреатическую холеру"
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

426. Основное значение в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни придается
a. ингибиторам протонной помпы
b. антибиотикам
c. антацидам
d. спазмолитикам
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

427. Общее количество желудочного сока, отделяющегося у человека при обычном пищевом режиме, составляет (л)
a. 1,5-2
b. 0,5-1
c. 2-2,5
d. 1-1,5
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

428. Симптом изжоги выражен при
a. гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
b. хроническом пиелонефрите
c. хроническом холецистите
d. хроническом панкреатите
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

429. Достоверным признаком стеноза привратника является
a. шум плеска через 3-4 часа после приема пищи
b. видимая перистальтика
c. резонанс под пространством Траубе
d. рвота желчью
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

430. Синтез соляной кислоты в железах желудка осуществляют
a. париетальные клетки
b. мукоциты
c. нейроэндокринные клетки
d. главные клетки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

431. Доминирующим симптомом рецидивирующего панкреатита является
a. боль в животе
b. тошнота
c. горечь во рту
d. разжижение стула
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

432. Диагностически значимым для хронического панкреатита является наличие
a. кальцинатов в головке поджелудочной железы
b. пониженной активности диастазы мочи
c. большого количества жира в кале
d. повышенной активности эластазы в кале
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

433. Наиболее характерным симптомом инфекционного эзофагита является

a. одинофагия (боль при глотании)
b. изжога
c. отрыжка воздухом
d. икота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

434. При хроническом панкреатите с внешнесекреторной недостаточностью характер стула
a. обильный, кашецеобразный, блестящий
b. жидкий, с примесью алой крови
c. водянистый с хлопьями
d. скудный, фрагментированный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

435. Об обострении хронического панкреатита свидетельствует
a. повышение уровня диастазы мочи
b. повышение эхогенности поджелудочной железы при УЗИ
c. желтуха
d. нарушение толерантности к глюкозе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

436. Желчный пузырь сокращается под влиянием
a. холецистокинина
b. гастрина
c. пакреатического сока
d. секретина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

437. Осложнением, не характерным для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является
a. полипоз пищевода
b. аденокарцинома пищевода
c. пищевод Баррета
d. появление стриктур пищевода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

438. Для снятия болей при эзофагите наиболее эффективен
a. рабепразол
b. дротаверин
c. платифиллин
d. метоклопрамид
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

439. Для оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы определяют активность
a. эластазы кала
b. липазы кала
c. липазы крови
d. эластазы крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

440. Абсолютным противопоказанием к колоноскопии является
a. декомпенсированная сердечная недостаточность
b. кровоточащий геморрой

c. острый парапроктит
d. тяжелая форма неспецифического язвенного колита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

441. Причиной пищеводного кровотечения при циррозе печени является
a. повышение давления в портальной вене
b. снижение гемоглобина крови
c. желтуха
d. высокая вирусная нагрузка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

442. Методов выбора при определении лечебной тактики у пациентов с прогрессирующей печеночноклеточной недостаточностью любого генеза является
a. проведение трансплантации печени
b. массивная кортикостероидная терапия
c. массивная кортикостероидная терапия в сочетании с цитостатиками
d. массивная интерферонотерапия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

443. Наиболее надежным методом дифференциальной диагностики печеночной и подпеченочной желтухи служит
a. УЗИ ОБП
b. БАК исследование крови на содержание билирубина, щелочной фосфатазы
c. эндоскопическое исследование пищевода и желудка
d. БАК исследование на содержание АЛТ и АСТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

444. При подозрении на хронический калькулезный холецистит с целью уточнения диагноза необходимо провести
a. УЗИ ОБП
b. дуоденальное зондирование
c. обзорную рентгенографию ОБП
d. ЭГДС
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

445. Варикозное расширение вен пищевода и кардиального отдела желудка наиболее часто встречается при
a. циррозе печени
b. вирусном гепатите
c. болезни Кароли
d. метастатическом поражении печени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

446. Положительный симптом Кера является признаком
a. хронического холецистита
b. язвы ДПК
c. рака головки поджелудочной железы
d. хронического панкреатита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

447. Портальная гипертензия может наблюдаться при
a. циррозе печени

b. хроническом гепатите
c. метастатическом раке печени
d. хроническом панкреатите
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

448. Наиболее частой причиной портальной гипертензии выступает
a. внутрипеченочный блок при циррозе печени
b. внутрипеченочный блок при жировом гепатозе
c. синдром Бадда-Киари
d. внепеченочный блок в результате тромбоза селезеночной вены
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

449. Осложнение язвенной болезни
a. Пенетрация
b. Почечная колика
c. Портальная гипертензия
d. Желчекаменная болезнь
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

450. О пенетрации язвы не свидетельствует
a. мелена
b. уменьшение ответной реакции на антациды
c. появление упорных болей
d. изменение характерного ритма болей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

451. Нормальный сроки рубцевания язвы ДПК составляют
a. 1,5 месяца
b. 6 месяцев
c. 3 месяца
d. 1,5 недели
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

452. Эндоскопическим признаком активного Н.Р.-ассоциированного гастрита является
a. гиперемия слизистой с точечными кровоизлияниями
b. наличие рубцовых изменений на слизистой желудка
c. бледная слизистая (рельеф складок сглажен)
d. резко выраженная складчатость слизистой и большое количество слизи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

453. Выявленная при рентгенографии плоская ниша в антральном отделе желудка диаметром 2,5 см неправильной формы с обширной аперистальтической зоной вокруг характерна для
a. язвы-рака
b. острой язвы желудка
c. неосложненной язвы антрального отдела
d. неосложненной язвы антрального отдела
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

454. В дифференциальной диагностике между язвенной болезнью и раком желудка наиболее важным является
a. гистологическое исследование

b. исследование желудочной секреции с ее стимуляцией гистамином
c. фиброгастродуоденоскопия
d. фиброгастродуоденоскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

455. Наиболее подвержены малигнизации ____полипы желудка
a. аденоматозные
b. ювенильные
c. гиперплазиогенные
d. гиперпластические
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

456. У пациентки с железодефицитной анемией, наличием в анамнезе резекции тощей и части подвздошной кишки наиболее оптимальным будет назначение
a. Феррум Лек внутримышечно
b. Витамина В12 внутримышечно
c. Фолиевой кислоты перорально
d. Феррум Лек перорально
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

457. Показанием для парентерального введения препаратов железа является резекция
a. тонкой кишки
b. толстой кишки
c. правого лёгкого
d. поджелудочной железы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

458. Причиной тромбоза воротной вены и её ветвей является дефицит
a. Протеинов С и S
b. Витамина К
c. Иммуноглобулинов G
d. алкогольдегидрогеназы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

459. При использовании варфарина для профилактики рецидивов тромбоэмболии лёгочной артерии целевое международное нормализованное отношение равно
a. 2,0-3,0
b. 1,5-2,5
c. 2,5-3,5
d. 3,0-4,0
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

460. Длительность применения апиксабана в дозе 10 мг два раза в сутки для лечения острой венозной тромбоэмболии составляет (в днях)
a. 7
b. 14
c. 21
d. 28
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

461. «Д»-димер является продуктом лизиса
a. Фибрина

b. X фактора
c. Тромбина
d. Тромбоцитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

462. Длительность антикоагулянтной терапии после первого эпизода венозной тромбоэмболии (ВТЭ) составляет не менее (в месяцах)
a. 3
b. 6
c. 9
d. 12
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

463. Основными факторами, предрасполагающими к тромбозу, являются
a. повреждение эндотелия, турбулентный ток крови, гиперкоагуляция
b. тромбоцитопения, рарефикация микроциркуляторного русла, эмболия
c. спазм сосудов, атеросклероз, высокая активность ренина плазмы
d. атероматозные бляшки, гемостаз, гипокоагуляция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

464. Остеоартроз характеризуется наличием
a. нормальных показателей крови
b. анемии
c. лейкоцитоза
d. тромбоцитоза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

465. Для неосложненного остеоартроза в ОАК
a. изменений нет
b. имеется лейкоцитоз
c. имеется тромбоцитопения
d. определяется лейкопения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

466. Периодическое заклинивание сустава наиболее характерно для
a. остеортроза
b. РА
c. подагры
d. псориатической артропатии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

467. Под кистой Бейкера понимают
a. скопление жидкости в заднем завороте коленного сустава
b. скопление жидкости в препателлярной бурсе
c. скопление жидкости в полости сустава
d. околосуставное кистовидное просветление костной ткани на Rg
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

468. Образование абсцессов в печени характерно для
a. амёбиаза
b. альвеококкоза
c. токсоплазмоза

d. эхинококкоза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

469. Яркая гиперемия кожи с четкими границами, неправильной формы в сочетании с лихорадкой свойственна
a. роже
b. флегмоне
c. абсцессу
d. плоскому лишаю
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

470. 40-летний мужчина получил глубокие раны при падении с трактора. Не следует вводить противостолбнячную сыворотку (ПСС), если
a. он получил полный курс иммунизации и 2 года назад ревакцинацию
b. последнее введение столбнячного анатоксина было 12 лет назад
c. он получил 2 инъекции столбнячного анатоксина в течение жизни
d. пять лет назад вводилась ПСС
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

471. Причиной кишечного кровотечения при брюшном тифе является
a. язвенное поражение лимфоидных образований подвздошной кишки
b. язвенно-некротическое поражение двенадцатиперстной кишки
c. универсальный деструктивно- пролиферативный эндотромбоваскулит
d. длительная бактериемия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

472. Для язвенного колита характерно
a. наличие частых кровотечений
b. сегментарное поражение
c. безрецидивное течение
d. появление трансмуральных язв
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

473. Наиболее характерным осложнением для болезни крона является
a. кишечная непроходимость
b. развитие токсического мегаколона
c. кровотечение
d. повышенный риск малигнизации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

474. Риск тромбоэмболических осложнений при нарушениях ритма сердца увеличивается при
a. фибрилляции предсердий
b. желудочковой экстрасистолии
c. предсердной экстрасистолии
d. предсердной тахикардии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

475. Множественные травмы, обширные хирургические вмешательства, септические состояния, злокачественные опухоли могут быть причиной развития
a. ДВС-синдрома
b. болезни Рандю-Ослера

c. гемолитической анемии
d. геморрагического васкулита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

476. Методом остановки кровотечения при остром ДВС-синдроме является
a. переливание достаточных объемов свежезамороженной плазмы
b. назначение препаратов фактор протромбинового комплекса
c. введение не менее 1 л теплой донорской крови
d. проведение плазмафереза в объёме 1 л эксфузии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

477. Скринингом для диагностики рака ободочной кишки является
a. кал на скрытую кровь
b. ирригоскопия
c. УЗИ толстой кишки
d. фиброколоноскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

478. Наиболее вероятной предпосылкой к раку лёгкого выступает
a. курение
b. алкоголизм
c. наркомания
d. ожирение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

479. Наиболее ранним симптомом при локализации рака в кардиальном отделе желудка является
a. дисфагия
b. боль за грудиной
c. рвота
d. боль в эпигастрии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

480. Маммография с целью раннего выявления рака молочной железы показана женщинам в возрасте от
a. 40
b. 18
c. 50
d. 30
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

481. Наиболее простым и достаточно информативным методом ранней диагностики центрального рака лёгкого является
a. цитология мокроты
b. спирометрия
c. бронхоскопия
d. флюрография
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

482. Наиболее частой локализацией рака желудка является
a. антрум
b. тело

c. большая кривизна
d. кардиальный отдел
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

483. Наиболее ранним специфическим синдромом у больных раком билиопанкреатодуоденальной зоны является
a. механическая желтуха
b. частая рвота
c. боль в эпигастрии и спине
d. потеря веса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

484. К скрининговому исследованию рака молочной железы относят
a. маммографию
b. УЗИ молочных желез
c. самообследование
d. осмотр маммологом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

485. Синдром анорексии-кахексии наиболее выражен при раке
a. желудка, поджелудочной железы
b. кожи
c. шейки матки
d. почек, надпочечников
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

486. В дифференциальной диагностике между язвенной болезнью и раком желудка наиболее важным является
a. эндоскопическое исследование с биопсией
b. кал на скрытую кровь
c. рентген
d. исследование желудочной секреции
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

487. Для рака среднеампулярного отдела прямой кишки характерны
a. частые тенезмы с отхождением крови и слизи
b. опухоль в правой подвздошной области
c. запоры и поносы
d. боль в правой подвздошной области и над лоном
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

488. Паллиативная помощь означает
a. подход, позволяющий облегчить страдания больного и улучшить качество жизни пациентов и их семей в терминальной стадии заболеваний
b. метод лечения, позволяющий полностью излечить пациента
c. лечение сопутствующих заболеваний
d. профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития тяжелых заболеваний
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

489. При опухолевых метастатических выпотах плевральная жидкость чаще предоставляет собой

a. экссудат
b. гемоторакс
c. транссудат
d. хилоторакс
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

490. Решающая роль в дифференциальной диагностике абсцесса лёгкого от туберкулеза и полостной формы рака лёгкого принадлежит
a. биопсии
b. бронхоскопии
c. клиническому методу исследования
d. рентгенологическому методу исследования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

491. Рак лёгкого чаще метастазирует в лимфоузлы
a. надключичные
b. подмышечные
c. подчелюстные
d. заднешейные
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

492. Наиболее характерным клиническим симптомом для центрального рака лёгких является
a. кровохарканье
b. ослабление голосового дрожания
c. зловонная мокрота
d. коробочный звук
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

493. Рекомендуемые сроки временной утраты трудоспособности при обострении хронического холецистита среднетяжелого течения составляют
a. 10-14 дней
b. 21-42 дня
c. 7-10 дней
d. 14-21 день
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

494. Абсолютным противопоказанием к бронхоскопии является
a. инсульт
b. внебольничная пневмония
c. бронхогенный рак с метастазами
d. инородное тело бронхов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

495. Дифференциальную диагностику абсцесса лёгких целесообразно проводить с
a. кавернозным туберкулезом лёгких
b. бронхиальной астмой
c. хроническим бронхитом
d. синдромом Хаммена-Рича
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

496. Поражение лёгких при сепсисе чаще всего проявляется

a. билатеральными инфильтратами на рентгенограмме
b. экссудативным плевритом
c. лёгочной гипертензией
d. субтотальным поражением лёгочной ткани
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

497. Больному с округлым периферическим образованием в лёгком неуточненной этиологии следует провести
a. биопсию лёгких
b. противотуберкулезную терапию
c. гормональную терапию
d. динамическое наблюдение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

498. Трехслойность мокроты после отстаивания характерна для
a. абсцесса лёгкого и бронхоэктазов
b. саркоидоза
c. хронический обструктивный бронхит
d. экзогенного аллергического альвеолита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

499. О деструкции ткани лёгкого свидетельствует обнаружение в мокроте
a. эластических волокон
b. большого числа эритроцитов
c. кристаллов Шарко-Лейдена
d. большого числа лейкоцитов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

500. Основным диагностическим методом, позволяющим обнаружить кисту лёгкого, является
a. рентгенография и компьютерная томография лёгкого
b. радиоизотопное сканирование лёгких
c. бронхография
d. бронхоскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

501. Рентгенограмму в прямой проекции считают выполненной с повышением жесткости рентгеновского излучения, если видны
a. более 4 верхних грудных позвонков
b. отчетливо 2 верхних грудных позвонка
c. менее 3 верхних грудных позвонков
d. отчетливо 3-4 верхних грудных позвонков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

502. Сцинтиграфия лёгких с изотопами позволяет уточнить состояние
a. капиллярного кровотока лёгких
b. крупных сосудов лёгких
c. реактивности бронхов
d. бронхиальной проводимости
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

503. Отсутствие болевого синдрома при фибринозном плеврите связано с локализацией в _____ области
a. междолевой
b. верхушечной
c. костальной
d. парамедиастенальной
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

504. Основным диагностическим критерием дыхательной недостаточности является снижение
a. сатурации кислорода
b. пиковой скорости выдоха
c. сатурации углекислого газа
d. гемоглобина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

505. Развитие абсцесса лёгкого вызывает
a. золотистый стафилококк
b. пневмококк
c. стрептококк
d. палочка Пфейффера
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

506. Рентгенологическое исследование при заболеваниях органов дыхания следует начинать с
a. обзорной рентгенографии в прямой и боковой проекциях
b. томографии лёгких в прямой и боковой проекциях
c. флюорографии в прямой и боковой проекциях
d. рентгеноскопии в различных проекциях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

507. Правильность установки больного на обзорной рентгенограмме оценивается
a. по одинаковому расстоянию между медиальными контурами ключиц и остистыми отростками позвонков
b. когда тени лопаток не наслаиваются на лёгочные поля
c. по одинаковым межреберным промежуткам
d. по симметричности лёгочных полей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

508. Острый абсцесс лёгкого отличается от пневмонии, протекающей с абсцедированием
a. преобладанием некротических изменений в лёгких над воспалительными
b. более тяжелым клиническим течением
c. выделением гнойной мокроты полным ртом и неприятным запахом
d. одномоментным отхождением большого количества гнойной мокроты, чаще с неприятным запахом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

509. При подозрении на осумкованный плеврит перед плевральной пункцией нужно провести
a. УЗИ
b. микроскопию мокроты
c. сцинтиграфию лёгких

d. бронхоскопию
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

510. Причиной тотального затемнения лёгочного поля со смещением органов средостения в сторону затемнения может быть
a. ателектаз лёгкого
b. осумкованный плеврит
c. экссудативный плеврит
d. тотальная пневмония
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

511. Кровохарканье и лёгочное кровотечение может возникнуть при
a. абсцессе лёгкого
b. муковисцидозе
c. экссудативном плеврите
d. бронхиальной астме
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

512. Для лечения спонтанного пневмоторакса применяют
a. дренирование плевральной полости по Беллау во II-III межреберье
b. наложение давящей повязки на грудную клетку во II-III межреберье
c. наложение искусственного пневмоторакса во II-III межреберье
d. медикаментозное лечение химиопрепаратами резервного ряда
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

513. Главным мероприятием в лечении спонтанного пневмоторакса являются
a. плевральная пункция, активный дренаж и аспирация
b. наложение пневмоперитонеума и наблюдение
c. кардиотропная терапия и аналептики
d. наблюдение и лечение основного заболевания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

514. Антикоагуляционный эффект и риск геморрагических осложнений увеличивается при сочетании антикоагулянтов с
a. НПВС
b. блокаторами CD20-рецепторов В-лимфоцитов
c. частичными агонистами никотиновых рецепторов
d. агонистами I1-имидазолиновых рецепторов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

515. Наибольшим ульцерогенным эффектом обладает
a. кеторолак
b. парацетамол
c. ибупрофен
d. трамадол
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

516. Тендинит и/или разрыв ахиллова сухожилия могут развиться на фоне применения
a. фторхинолонов
b. цефалоспоринов
c. карбапенемов
d. аминогликозидов

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

517. Побочную реакцию в виде отека лодыжек и стоп может вызывать
a. амлодипин
b. метопролол
c. дигоксин
d. эналаприл
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

518. К гастропротекторам относится
a. ребамипид
b. атропин
c. омепразол
d. фамотидин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

519. К самым частым побочным эффектам противовоспалительных препаратов относят
a. боль в животе, неустойчивый стул
b. бронхоспазм
c. психические нарушения
d. повышение креатинина в сыворотке крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

520. Для профилактики эрозивно-язвенных осложнений при НПВС-терапии рекомендуется
a. омепразол
b. Метилурацил
c. Алгедрат+Магния гидроксид
d. Сукралфат
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

521. Механизм обезболивающего действия наркотических анальгетиков заключается в
a. угнетении проводимости болевых стимулов в центральной нервной системе
b. снижении активности циклооксигеназы с ингибированием синтеза простагландинов и брадикинина
c. угнетении холинергической иннервации гладкомышечных органов и спазмолитическом действии
d. уменьшении чувствительности рецепторов к медиаторам боли - брадикинину и гистамину
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

522. При угрожающем жизни варфариновом кровотечении кроме свежезамороженной плазмы необходимо ввести
a. Витамин К
b. Кальция хлорид
c. этамзилат
d. Аминокапроновую кислоту
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

523. Контроль эффективности и безопасности терапии варфарином осуществляется с помощью
a. международного нормализованного отношения(МНО)
b. активированного времени рекальцификации (АВР)

c. активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
d. растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

524. Реже других вызывает язвенные изменения желудочно-кишечного тракта
a. нимесулид
b. диклофенак
c. вольтарен
d. индометацин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

525. Группой антибиотиков, которая чаще других вызывает аллергические реакции, являются
a. пенициллины
b. фторхинолоны
c. аминогликозиды
d. линкозамиды
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

526. Наиболее частыми осложнениями терапии нестероидными противовоспалительными препаратами являются
a. желудочно-кишечные
b. кожные
c. гепатотоксические
d. нефротоксические
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

527. Побочным эффектом препаратов урсодезоксихолевой кислоты является
a. диарея
b. задержка стула
c. сухость во рту
d. головная боль
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

528. В проведении диагностической плевральной пункции нет необходимости при
a. малом объеме плеврального выпота у больного с пневмонией
b. стойком выпоте
c. подозрении на эмпиему плевры
d. неясном происхождении выпота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

529. Дивертикулом Ценкера является дивертикул
a. глоточно-пищеводный
b. эпибронхиальный
c. бифуркационный
d. эпифренальный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

530. Показанием к экстренному хирургическому вмешательству при болезни Крона является
a. перфорация и\или кишечная обструкция
b. наличие кишечный свищей

c. неэффективность консервативной терапии
d. хроническая анемия средней степени тяжести
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

531. Осложнением дивертикулярной болезни кишечника является
a. дивертикулит
b. запор
c. язвенный колит
d. рак толстой кишки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

532. Кровь при лёгочном кровотечении выделяется
a. алая, пенистая
b. цвета кофейной гущи
c. темная, со сгустками
d. темная, пенистая
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

533. К заболеванию желудочно-кишечного тракта, клинически сходному со стенокардией, относят
a. диафрагмальную грыжу
b. проктосигмоидит
c. болезнь крона
d. хронический колит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

534. При установлении этиологии экссудативного плеврита необходимо провести
a. плевральную пункцию с микробиологическим и цитологическим исследованием экссудата
b. исследование мокроты на микобактерии туберкулеза
c. торакоскопию с биопсией плевры
d. радиоизотопное исследование лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

535. С диагностической целью при экссудативном плеврите выполняют
a. рентгенографию, плевральную пункцию, фибробронхоскопию, торакоскопию
b. фибробронхоскопию, ангиопульмонографию, компьютерную томографию
c. рентгенографию, торакоскопию
d. бронхографию, плевральную пункцию, МРТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

536. Наиболее частым симптомом спонтанного пневмоторакса является
a. боль в груди
b. сосудистый коллапс
c. лёгочное кровотечение
d. сухой кашель
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

537. При спонтанном пневмотораксе на стороне поражения грудной клетки аускультативно определяется
a. Ослабленное дыхание
b. шум трения плевры

c. бронхиальное дыхание
d. усиление бронхофонии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

538. Через 20 дней после ушивания язвы желудка при появлении фебрильной лихорадки, боли в правом боку, высоком стоянии правого купола диафрагмы можно предположить развитие
a. поддиафрагмального абсцесса
b. холангита
c. острого холецистита
d. ателектаза лёгкого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

539. Гипертония нижнего пищеводного сфинктера встречается при
a. ахалазии кардии
b. хроническом рефлюкс-эзофагите
c. халазии кардии
d. грыже пищеводного отверстия диафрагмы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

540. Характерным осложнением спонтанного пневмоторакса является
a. медиастинальная эмфизема
b. воздушная эмболия
c. викарная эмфизема
d. лёгочное кровотечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

541. При спонтанном пневмотораксе на стороне поражения грудной клетки определяется
a. отставание при дыхании
b. уменьшение в объеме
c. усиление голосового дрожания
d. притупление перкуторного звука
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

542. Нарастание одышки, боли в груди, одностороннего тимпанита или коробочного звука при перкуссии, исчезновение дыхательных шумов при аускультации характеризуется
a. клапанный пневмоторакс
b. пневмоперитонеум
c. открытый пневмоторакс
d. закрытый пневмоторакс
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

543. Лечебный парацентез больному циррозом печени с асцитом должен проводиться при
a. напряженном или рефрактерном к терапии асците
b. болях в животе
c. отсутствии артериальной гипотонии
d. нарастание желтухи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

544. Показанием к экстренной плевральной пункции является
a. уровень жидкости в плевральной полости до 2 ребра
b. нормальное насыщение крови кислородом

c. отсутствие признаков острой дыхательной недостаточности
d. отсутствие смещения органов средостения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

545. При пенетрации язвы в поджелудочную железу в крови повышается уровень
a. амилазы
b. щелочной фосфатазы
c. липазы
d. глюкозы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

546. Для варикозной болезни нижних конечностей характерны
a. трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки; отек стопы и тупые боли в ноге, появляющиеся к концу рабочего дня; судороги икроножных мышц голени в покое
b. постоянный отек всей конечности; трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки; судороги икроножных мышц голени в покое
c. боли в икроножных мышцах, появляющиеся при ходьбе; трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки; судороги икроножных мышц голени в покое
d. боли в икроножных мышцах, появляющиеся при ходьбе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

547. Достоверным рентгенологическим признаком перфорации гастродуоденальной язвы является
a. свободный газ в брюшной полости
b. пневматизация кишечника
c. высокое стояние диафрагмы
d. "чаши" Клойбера
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

548. Прокол при плевральной пункции необходимо проводить
a. По верхнему краю ребра
b. между ребрами
c. по нижнему краю ребра
d. на середине расстояния между ребрами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

549. Ослабление или полное исчезновение боли в груди при вертикальном положении тела характерно для
a. грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
b. стенокардии напряжения
c. нейроциркуляторной астении
d. острого инфаркта миокарда
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

550. Признаком перфорации язвы желудка является
a. ригидность передней брюшной стенки
b. исчезновение или ослабление болей
c. рвота кофейной гущей
d. гиперперистальтика
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

551. После окончания стернальной пункции следует

a. наклеить стерильную повязку на место прокола
b. положить на место прокола пузырь со льдом
c. наложить на место прокола давящую повязку
d. оставить больного под наблюдением медицинского персонала
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

552. У взрослых самой частой причиной стеноза привратника является
a. язвенная болезнь
b. рак желудка
c. гипертрофия мышц привратника
d. пролапс слизистой оболочки через пилорический канал
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

553. Мелена при наличии гепатоспленомегалии подозрительна на
a. кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода
b. кровоточащую язву 12-перстной кишки
c. язвенный колит
d. тромбоз мезентериальных артерий
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

554. Скрининговым методом исследования для диагностики калькулезного холецистита является
a. УЗИ органов брюшной полости
b. холецистография
c. дуоденальное зондирование
d. рентгеноскопия желудка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

555. Для холеры характерны начальные проявления в виде
a. Тошноты и рвоты
b. Диареи
c. Лихорадки
d. Схваткообразных болей в животе
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

556. Для холеры типичны испражнения в виде
a. «Рисового отвара»
b. «Малинового желе»
c. «Горохового супа»
d. «Ректального плевка»
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

557. При тяжелом течении холеры имеет место температурная реакция
a. Нормальная
b. Субнормальная
c. Фебрильная
d. Гиперпиретическая
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

558. Стул при колитическом варианте острого шигеллеза
a. Обильный, водянистый, без патологических примесей
b. Жидкий, пенистый, желтого цвета, с резким запахом

c. Скудный, с примесями слизи и крови
d. Неоформленный дегтеобразный (мелена)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

559. Боли при остром шигеллезе наиболее часто локализуются в
a. Левой подвздошной области
b. Илеоцекальной области
c. Околопупочной области
d. Правой подвздошной области
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

560. Для этиотропной терапии острого шигеллеза (среднетяжелое течение) применяют
a. Ципрофлоксацин (per os)
b. Амоксициллин
c. Ципрофлоксацин (внутривенно) + гентамицин (внутримышечно)
d. Нифуроксазид
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

561. Типичный стул при сальмонеллезе имеет вид
a. «Малинового желе»
b. «Горохового супа»
c. «Рисового отвара»
d. «Болотной тины»
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

562. Типичная сыпь при брюшном тифе
a. Петехиальная
b. Розеолезная
c. Уртикарная
d. Полиморфная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

563. К специфическим осложнениям брюшного тифа относят
a. Кишечное кровотечение
b. Миокардит
c. Острый холецистит
d. Пиелит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

564. К основным клиническим проявлениям пищевых токсикоинфекций относят
a. Схваткообразные боли в нижних отделах живота
b. Рвоту и частый водянистый стул
c. Кашицеобразный стул со слизью и кровью
d. Разлитые боли в животе постоянного характера
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

565. Ведущим синдромом при ботулизме является
a. Судорожный
b. Паралитический
c. Диспепсический
d. Энцефалитический
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

566. Типичным симптомом ботулизма является
a. Нарушение сознания
b. Нечеткость зрения
c. Неукротимая рвота
d. Нарушение мочеиспускания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

567. Абдоминальную форму иерсиниозов характеризует
a. Энтеритический стул
b. Генерализованная лимфаденопатия
c. Увеличение печени и селезенки
d. Симптом Падалки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

568. Скарлатиноподобный вариант псевдотуберкулеза отличает наличие
a. Болей в илеоцекальной области
b. Энтеритического стула
c. Гепато- и спленомегалии
d. Экзантемы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

569. В гемограмме при иерсиниозах имеет место
a. Лейкопения с лимфо- и моноцитозом
b. Нормоцитоз
c. Нейтрофильный лейкоцитоз с эозинофилией
d. Лейкоцитоз с наличием атипичных мононуклеаров
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

570. Для этиотропной терапии иерсиниозов у взрослых используют
a. Ципрофлоксацин
b. Бензилпенициллин
c. Орнидазол
d. Азитромицин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

571. Продолжительность курса этиотропной терапии иерсиниозов составляет
a. 7 дней
b. 14 дней
c. 21 день
d. 28 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

572. При остром описторхозе в периферической крови определяют
a. Гиперэозинофилию
b. Анемию
c. Лимфоцитоз
d. Лейкопению
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

573. Основным методом специфической диагностики острого описторхоза является
a. ИФА крови (детекция специфических IgM)

b. ИФА крови (детекция специфических IgG)
c. Копроовоскопическое исследование
d. Микроскопическое исследование дуоденального содержимого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

574. Препаратом выбора для лечения описторхоза является
a. Метронидазол
b. Празиквантел
c. Албендазол
d. Никлозамид
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

575. При токсокарозе наиболее часто наблюдают поражение
a. Миокарда
b. Бронхолёгочной системы
c. Желудочно-кишечного тракта
d. Мочеполовой системы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

576. Для лечения токсокароза применяют
a. Албендазол
b. Празиквантел
c. Метронидазол
d. Никлозамид
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

577. В клиническом профиле парагриппа регистрируют преимущественно
a. Ринофарингит и трахеит
b. Бронхит и бронхиолит
c. Ринофарингит и конъюнктивит
d. Ринофарингит и острый стенозирующий ларинготрахеит
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

578. Аденовирусная инфекция отличается от других ОРВИ
a. Поражением лимфоидной ткани
b. Поражением лёгких
c. Лихорадкой
d. Наличием ринита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

579. К местным осложнениям ангины относят
a. Паратонзиллярный абсцесс
b. Острый миокардит
c. Гломерулонефрит
d. Ревматизм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

580. Сыпь при менингококкемии
a. Геморрагическая «звездчатая»
b. Уртикарная
c. Розеолезная
d. Папулезная

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

581. К типичным клиническим проявлениям менингококкового менингита относят
a. Ригидность затылочных мышц
b. Судороги
c. Нарушение сознания
d. Парезы черепных нервов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

582. Типичным осложнением менингококкового менингита является
a. Отек головного мозга
b. Абсцесс головного мозга
c. Инфекционно-токсический шок
d. Острая надпочечниковая недостаточность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

583. Клиническим признаком цитолиза при вирусных гепатитах является
a. Слабость
b. Гепатомегалия
c. Иктеричность кожных покровов и склер
d. Потемнение мочи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

584. Клиническим признаком холестаза при вирусных гепатитах является
a. Гепато- и спленомегалия
b. Геморрагическая сыпь
c. Иктеричность склер
d. Отсутствие аппетита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

585. Клиническим признаком мезенхимального воспаления при вирусных гепатитах является
a. носовое кровотечение
b. потемнение мочи
c. выраженный кожный зуд
d. гепатомегалия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

586. Синдрому цитолиза при вирусных гепатитах соответствует повышение
a. Активности трансаминаз
b. Активности щелочной фосфатазы
c. Показателя тимоловой пробы
d. Содержания холестерола
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

587. Синдрому холестаза при вирусных гепатитах соответствует
a. Повышение активности АЛТ
b. Увеличение показателя международного нормализованного отношения
c. Гипербилирубинемия
d. Диспротеинемия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

588. При острых вирусных гепатитах в гемограмме имеет место
a. Лейкопения
b. Лейкоцитоз
c. Ускорение СОЭ
d. Эозинофилия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

589. Для острого вирусного гепатита Е характерно
a. Частое формирование вирусоносительства в исходе заболевания
b. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой
c. Тяжелое течение у беременных
d. Преобладание парентерального пути передачи инфекции
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

590. Для вирусного гепатита В характерно
a. Преобладание в преджелтушном периоде артралгического синдрома
b. Острое начало заболевания
c. Улучшение состояния больных с появлением желтухи
d. Частое формирование хронизации инфекционного процесса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

591. К маркерам репликации HBV относят
a. HBsAg
b. anti-HBe
c. HBeAg
d. Anti-HBc IgG
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

592. Маркером поствакцинального иммунитета против вирусного гепатита В являются
a. Anti-HBc IgM
b. Anti-HBc IgG
c. Anti-HBe
d. Anti-HBs
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

593. При герпетической инфекции возможно развитие
a. Эзофагита
b. Гастрита
c. Энтерита
d. Дистального колита
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

594. Для опоясывающего лишая характерны высыпания
a. На коже лица
b. Равномерно на всем теле
c. По ходу чувствительных нервов
d. На коже верхних конечностей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

595. В периоде разгара инфекционного мононуклеоза в ИФА крови определяют
a. Anti-VCA IgM
b. Anti-VCA IgG

c. Anti-EBNA IgM
d. Anti-EBNA IgG
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

596. ВИЧ-инфицированный человек является источником инфекции
a. Только в инкубационном периоде
b. Только в стадии первичных проявлений
c. Только в стадии вторичных заболеваний
d. Пожизненно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

597. ВИЧ передается
a. От инфицированной матери ребенку при уходе за ним
b. При длительном бытовом контакте
c. При грудном вскармливании
d. При поцелуях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

598. Продолжительность инкубационного периода при ВИЧ-инфекции составляет
a. 3 недели–3 месяца
b. 10–14 дней
c. 14–28 дней
d. 1–6 месяцев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

599. Клиническим признаком стадии первичных проявлений 2Б ВИЧ-инфекции является
a. Мононуклеозоподобный синдром
b. Кандидоз пищевода
c. Кахексия
d. Пневмоцистная пневмония
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

600. Типичным клиническим признаком субклинической стадии ВИЧ-инфекции является
a. Цитомегаловирусный ретинит
b. Внелёгочный туберкулез
c. Генерализованный кандидоз
d. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

601. Клиническим проявлением стадии вторичных заболеваний 4Б ВИЧ-инфекции является
a. Рецидивирующий сальмонеллезный сепсис
b. Генерализованная форма саркомы Капоши
c. Прогрессирующая потеря массы тела
d. Кандидоз пищевода, трахеи, бронхов и лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

602. При ВИЧ-инфекции в полости рта часто имеет место
a. Многоформная экссудативная эритема
b. Кандидоз
c. Плоский лишай
d. Веррукозная лейкоплакия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

603. В перечне ВИЧ-оппортунистических заболеваний фигурирует
a. Токсоплазмоз
b. Лимфогрануломатоз
c. Микоплазменная пневмония
d. Хронический шигеллез
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

604. Скрининговым методом диагностики ВИЧ-инфекции является
a. Иммунный блоттинг
b. ИФА крови
c. ПЦР
d. Светооптическая микроскопия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

605. Лихорадка при малярии в разгар заболевания
a. Ремиттирующая
b. Постоянная
c. Интермиттирующая
d. Гектическая
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

606. Злокачественное течение заболевания характерно для
a. Трехдневной малярии
b. Овале-малярии
c. Тропической малярии
d. Четырехдневной малярии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

607. Основным методом специфической диагностики малярии является
a. Паразитологический
b. Иммунологический
c. Биологический
d. Молекулярно-генетический
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

608. Типичным клиническим проявлением клещевого риккетсиоза является
a. Диарея
b. Полиаденопатия
c. Первичный аффект
d. Возвратная лихорадка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

609. Продолжительность инкубационного периода при клещевом энцефалите составляет
a. 1–30 дней
b. 6–24 часа
c. 24–48 часов
d. 7–14 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

610. Лихорадочная форма клещевого энцефалита характеризуется
a. Острым началом и кратковременной лихорадкой

b. Постепенным началом с субфебрильной температурной реакцией
c. Наличием менингеального синдромокомплекса
d. Наличием выраженных катаральных проявлений
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

611. Менингоэнцефалитическая форма клещевого энцефалита характеризуется
a. Постепенным началом с нормальной температурной реакцией
b. Наличием вялых парезов конечностей
c. Наличием расстройств сознания
d. Наличием вялых параличей мышц шеи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

612. При клещевом энцефалите возможны отдаленные последствия в виде
a. Атрофических параличей мышц плечевого пояса, шеи и верхних конечностей
b. Гидроцефалии
c. Слепоты
d. Глухоты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

613. Лихорадочная реакция при иксодовых клещевых боррелиозах преимущественно
a. Фебрильная
b. Гиперпиретическая
c. Отсутствует
d. Субфебрильная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

614. Патогномоничным симптомом иксодовых клещевых боррелиозов является
a. Серозный менингит
b. Эритема в области присасывания клеща
c. Увеличение регионарных лимфатических узлов
d. Неврит лицевого нерва
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

615. К характерным признакам поражения нервной системы при боррелиозах относят
a. Неврит лицевого нерва
b. Вялые параличи мышц шеи, плечевого пояса и верхних конечностей
c. Гиперкинезы и эпилептические припадки
d. Деменцию
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

616. Характерным признаком поражения кожи при боррелиозах является
a. Доброкачественная лимфоцитома кожи
b. Твердый шанкр
c. Эозинофильная гранулема
d. Узловатая эритема
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

617. К типичным артрологическим проявлениям при боррелиозах относят
a. Олигоартрит с поражением крупных суставов
b. Артрозо-артриты мелких суставов
c. Плечелопаточный артрит
d. Полиартрит с поражением крупных суставов

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

618. Препаратом выбора в лечении иксодовых клещевых боррелиозов является
a. Амоксициллин + клавулановая кислота
b. Левофлоксацин
c. Гентамицин
d. Цефазолин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

619. Продолжительность курса этиотропной терапии при остром боррелиозе составляет
a. 5 дней
b. 7 дней
c. 14 дней
d. 28 дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

620. Продолжительность курса этиотропной терапии при хроническом боррелиозе составляет
a. 10 дней
b. 14 дней
c. 21 день
d. 28 и более дней
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

621. Наиболее ранним симптомом при первичной роже является
a. Эритема с четкими границами и неровными контурами
b. Отек мягких тканей в очаге поражения
c. Боль в области воспалительного очага
d. Повышение температуры тела с ознобом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

622. Местные изменения при роже характеризуются
a. Резкой болезненностью в центре воспалительного очага
b. Выраженным отеком мягких тканей плотной консистенции
c. Яркой гиперемией с четкими границами и неровными контурами
d. Гиперемией с нечеткими границами и округлыми контурами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

623. Воспалительный очаг при роже локализуется преимущественно в области
a. Спины
b. Верхних конечностей
c. Нижних конечностей
d. Живота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

624. К типичным осложнениям рожи относят
a. Полиартриты
b. Тромбофлебит
c. Митральный порок сердца
d. Токсический нефроз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

625. Препаратом выбора для лечения первичной рожи в амбулаторных условиях является
a. Азитромицин
b. Бензилпенициллин
c. Рифампицин
d. Цефазолин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

626. Препаратом выбора для лечения первичной рожи в стационарных условиях является
a. Бензилпенициллин
b. Азитромицин
c. Цефатоксим
d. Ципрофлоксацин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

627. Препаратом выбора для лечения рецидивирующей рожи является
a. Бензилпенициллин
b. Офлоксацин
c. Эритромицин
d. Цефтриаксон
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

628. Для профилактики рецидивов рожи важное значение имеет
a. Санация хронических очагов стрептококковой инфекции
b. Полноценное питание
c. Прием поливитаминов и адаптогенов
d. Дезинфекция жилого помещения (ультрафиолетовое облучение, влажная уборка)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

629. Сибиреязвенный карбункул характеризуется
a. Формированием резко болезненного регионарного бубона
b. Снижением болевой чувствительности
c. Развитием по краям язвы отека плотной консистенции
d. Наличием обильного гнойного отделяемого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

630. При генерализованной форме сибирской язвы типично преимущественное поражение
a. Сердца
b. Головного мозга
c. Лёгких
d. Почек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

631. Для экстренной профилактики сибирской язвы применяют
a. Хлорамфеникол
b. Доксициклин
c. Цефиксим
d. Специфический противосибиреязвенный иммуноглобулин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

632. К ранним симптомам столбняка относят
a. Тризм
b. Опистотонус

c. Тетанические судороги
d. Гиперсаливацию
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

633. Типичным осложнением столбняка является
a. Менингоэнцефалит
b. Компрессионный перелом позвоночника
c. Отек лёгких
d. Острая сердечно-сосудистая недостаточность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

634. Основной причиной летального исхода при столбняке является
a. Отек головного мозга
b. Асфиксия
c. Инфекционно-токсический шок
d. Сепсис
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

635. Наиболее характерным признаком бешенства в стадии возбуждения является
a. Гидрофобия
b. Клаустрофобия
c. Паралич дыхания
d. Стойкое нарушение сознания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

636. Классическим типом температурной кривой при остром бруцеллезе является
a. Интермиттирующий
b. Постоянный
c. Гектический
d. Волнообразный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

637. При хроническом бруцеллезе отмечают преимущественное поражение
a. Опорно-двигательного аппарата и нервной системы
b. Органов дыхания
c. Урогенитального тракта
d. Сердечно-сосудистой системы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

638. Для антибактериальной терапии бруцеллеза применяют комбинацию
a. Доксициклина и цефтриаксона
b. Ампициллина и гентамицина
c. Доксициклина и гентамицина
d. Ципрофлоксацина и цефтриаксона
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

639. Продолжительность антибактериальной терапии при бруцеллезе составляет не менее
a. 2 недель
b. 3 недель
c. 4 недель
d. 6 недель
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

640. Чумной бубон характеризуется
a. Резкой болезненностью
b. Отсутствием болевой чувствительности
c. Подвижностью
d. Четкими контурами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

641. Типичным проявлением лёгочной формы чумы является
a. Кашель с пенистой кровянистой мокротой
b. Обилие данных при физическом исследовании
c. Кашель с обильной гнойной мокротой
d. Сухой непродуктивный кашель
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

642. Для экспресс-диагностики чумы применяют
a. Бактериологическое исследование биообразцов
b. Реакцию иммунофлюоресценции с определением в биообразцах антигена возбудителя
c. Биологический метод
d. Серологическое тестирование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

643. Для экстренной профилактики чумы применяют
a. Азитромицин
b. Хлорамфеникол
c. Амоксициллин
d. Доксициклин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

644. Туляремийный бубон характеризуется
a. Умеренной болезненностью
b. Частым развитием нагноения
c. Спаянностью с окружающими тканями в остром периоде болезни
d. Нечеткими контурами
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

645. Для антибактериальной терапии при туляремии применяют
a. Аминогликозиды
b. Макролиды
c. Пенициллины
d. Карбапенемы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

646. К наиболее информативным клиническим признакам лептоспироза относят
a. Увеличение лимфоузлов
b. Интенсивные миалгии (преимущественно в икроножных мышцах)
c. Специфическую пневмонию
d. Выраженную лихорадку
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

647. Наиболее частым осложнением лептоспироза является
a. Острая почечная недостаточность

b. Перитонит
c. Острая сердечно-сосудистая недостаточность
d. Отек головного мозга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

648. К проявлениям начального периода ГЛПС относят
a. Олигурию
b. Бледность кожных покровов
c. Высокую лихорадку
d. Петехиальную сыпь
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

649. К типичному клиническому признаку олигурического периода ГЛПС относят
a. Головную боль
b. Боли в поясничной области
c. Миалгии
d. Интоксикационный синдром
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

650. Типичным изменением мочи при ГЛПС является
a. Гипоизостенурия
b. Лейкоцитурия
c. Повышение относительной плотности
d. Глюкозурия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

651. Наиболее частым специфическим осложнением ГЛПС является
a. Паранефрит
b. Острая печеночная недостаточность
c. Острая почечная недостаточность
d. Разрыв почки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

652. Типичным клиническим проявлением сепсиса является
a. Полилимфаденопатия
b. Гектическая лихорадка
c. Поражение органов пищеварения
d. Постоянная лихорадка
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

653. В прекоме I имеет место
a. Снижение концентрации внимания
b. Дезориентация во времени и пространстве
c. Симптом «плавающих» глазных яблок
d. «Хлопающий» тремор конечностей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

654. К типичным признакам комы II относят
a. Спутанное сознание
b. Приступообразные клонические судороги
c. Арефлексию
d. Симптом «плавающих» глазных яблок

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

655. Важным свойством микобактерий туберкулеза является
a. Образование спор
b. Кислотоустойчивость
c. Подвижность
d. Неподвижность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

656. Что является основным фактором вирулентности МБТ является?
a. Фактор изменчивости
b. Фактор некроза опухоли
c. Корд-фактор
d. Фактор толерантности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

657. МБТ устойчивы к действию
a. Низких температур
b. Высоких температур
c. Ультрафиолетовых лучей
d. Хлорсодержащих веществ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

658. МБТ под действием прямых солнечных лучей
a. Погибают через 2-5минут
b. Не погибают
c. Погибают через -2-4 часа
d. Погибают через 7-10 часов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

659. Для микробиологической диагностики туберкулеза в РФ применяют следующие лабораторные методы
a. Микроскопия, посев диагностического материала на плотные и жидкие питательные среды, молекулярно-генетические методы
b. Микроскопия и посев диагностического материала на плотные питательные среды
c. Микроскопия и посев диагностического материала на плотные и жидкие питательные среды
d. Микроскопия, посев диагностического материала на плотные питательные среды, молекулярно-биологические методы, серологические методы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

660. Исследование мокроты с окраской мазка по Цилю-Нильсену осуществляется с целью выявления
a. Микобактерий
b. Пневмококков
c. Грамотрицательных бактерий
d. Стафилококков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

661. В основе метода люминесцентной микроскопии патологического материала при туберкулёзе лежит
a. Способность МБТ, окрашенных флюорохромами, светиться под воздействием сине-

фиолетовых лучей
b. Способность МБТ воспринимать окраску по Цилю-Нильсону
c. Микроскопия мазков мокроты в иммерсионных средах
d. Способность МБТ светиться под воздействием сине-фиолетовых лучей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

662. К молекулярно-генетическим методам выявления МБТ относят
a. Метод GeneXpert MTB/RIF
b. Посев на среду Левенштейна-Иенсена
c. Автоматизированный метод BACTEC MGIT 960/320
d. Иммунохроматографический метод
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

663. Для ускоренного выявления МБТ с одновременной диагностикой его устойчивости к рифампицину рекомендован метод
a. GeneXpert MTB/RIF
b. ПЦР в режиме реального времени
c. Метод BACTEC MGIT 960/320
d. Технология DNA-STRIP
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

664. Длительность выявления МБТ и устойчивости МБТ к рифампицину методом GeneXpert MTB/RIF составляет
a. 2 часа
b. 1 час
c. 5-6 часов
d. 2 суток
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

665. Лекарственная устойчивость МБТ подразделяется на
a. Медленная, быстрая
b. Первичная, вторичная
c. Латентная, текущая
d. Неактивная, активная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

666. Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях муниципального уровня включает обязательные исследования такие, как исследование мокроты методом микроскопии
a. Трехкратно в течение 2-х дней, обзорная рентгенография органов грудной клетки, проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
b. Двукратно в течение 2-х дней, обзорная рентгенография органов грудной клетки, проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
c. Трехкратно в течение 2-х дней, проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
d. Трехкратно в течение 2-х дней, обзорная рентгенография органов грудной клетки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

667. В случае невозможности исключения туберкулеза при проведении обязательных диагностических исследований в медицинских организациях муниципального уровня больному проводится
a. Мультиспиральная компьютерная томография
b. Бронхоскопия с комплексом биопсий

c. Тест-терапия туберкулеза
d. Культуральное исследование диагностического материала
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

668. Доказал инфекционную природу туберкулеза
a. Кох
b. Пастер, Кальметт
c. Вильмен, Кальметт
d. Пастер, Герен
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

669. Туберкулин содержит
a. Отдельные антигенные компоненты *Mycobacterium tuberculosis*
b. Живые ослабленные *Mycobacterium tuberculosis*
c. Антитела к *Mycobacterium tuberculosis*
d. Убитые *Mycobacterium bovis*
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

670. Виражом туберкулиновой чувствительности называют
a. Впервые положительную пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л после ранее отрицательной в течение года не связанную с вакцинацией или ревакцинацией БЦЖ
b. Впервые отрицательную пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л после ранее положительной в течение года не связанную с вакцинацией или ревакцинацией БЦЖ
c. Впервые положительную пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л после ранее отрицательной в течение года после вакцинации или ревакцинации БЦЖ
d. Впервые гиперергическую пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л после ранее положительной в течение года
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

671. Аллерген туберкулезный рекомбинантный представляет собой
a. Фильтрат бульонной культуры МБТ, содержащий большое количество антигенов
b. Культуру убитых МБТ бычьего вида
c. Белки вирулентных штаммов МБТ, гены которых экспрессируются при размножении МБТ
d. Вытяжку из культуры МБТ человеческого и бычьего видов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

672. Положительный результат пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным может наблюдаться при инфицировании
a. *Mycobacterium tuberculosis humanis, Mycobacterium leprae* и *Mycobacterium bovis* BCG
b. *Mycobacterium bovis* BCG и *Mycobacterium tuberculosis humanis*
c. Только *Mycobacterium leprae* и *Mycobacterium tuberculosis bovis*
d. Mycobacterium tuberculosis bovis, Mycobacterium tuberculosis humanis и *Mycobacterium leprae*
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

673. Диагностические мероприятия требуются детям, у которых при массовой иммунодиагностике туберкулеза выявлена
a. Положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л
b. Впервые положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л
c. Впервые отрицательная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л

d. Сомнительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

674. Профилактические прививки после проведения пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным можно ставить
a. Сразу после прочтения пробы при ее отрицательном результате
b. Сразу после прочтения пробы независимо от ее результата
c. Спустя 14 дней после постановки пробы
d. Сразу после прочтения пробы при ее положительном результате
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

675. Диагностические мероприятия требуются подросткам, у которых при массовой иммунодиагностике туберкулеза выявлена
a. Только сомнительная реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
b. Отрицательная реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
c. Только гиперергическая реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
d. Сомнительная и положительная реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

676. Отличием иммунодиагностической пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (проба АТР) от теста QuantiFERON-TB Gold является то, что
a. Проба с АТР проводится *in vivo,* QuantiFERON-TB® Gold - *in vitro*
b. В состав аллергена туберкулезного рекомбинантного входит множество антигенов, а в QuantiFERON-TB® Gold используются три антигена
c. Положительная проба с АТР указывает на туберкулез, а положительный QuantiFERON-TB® Gold указывает на латентную туберкулезную инфекцию
d. Положительная проба с АТР указывает на латентную туберкулезную инфекцию, а положительный QuantiFERON-TB® Gold указывает на туберкулез
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

677. Отличием иммунодиагностической пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (проба с АТР) от пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л является то, что
a. Проба с АТР проводится *in vivo*, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - *in vitro*
b. В состав туберкулина входит множество антигенов, а в аллергене туберкулезном рекомбинантном только два антигена
c. Положительная проба с АТР всегда указывает на туберкулез, а положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л указывает на латентную туберкулезную инфекцию
d. Положительная проба с АТР всегда указывает на латентную туберкулезную инфекцию, а положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л указывает на туберкулез
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

678. Факторами, повышающими чувствительность кожи к туберкулину, являются
a. Сахарный диабет и онкологические заболевания
b. Аллергические заболевания и глистные инвазии
c. Десенсибилизирующая терапия и избыточная масса тела
d. Курение и саркоидоз
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

679. Очаги туберкулезной инфекции подразделяются на
e. Пять групп
f. Две группы

g. Шесть групп
h. Три группы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

680. Составной частью социальной профилактики туберкулеза является
a. Работа в очагах туберкулезной инфекции
b. Бесплатное санаторно-курортное лечение больного туберкулезом
c. Изоляция больного туберкулезом
d. Раннее выявление туберкулеза среди населения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

681. Составной частью санитарной профилактики туберкулеза является
a. Работа в очагах туберкулезной инфекции
b. Улучшение условий труда, борьба с профессиональными вредностями
c. Получение листка нетрудоспособности сроком на 12 месяцев
d. Бесплатное санаторно-курортное лечение больного туберкулезом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

682. Наиболее высокий риск возникновения новых случаев туберкулеза наблюдается в очагах
a. Первой группы
b. Третьей группы
c. Второй группы
d. Четвертой группы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

683. Самый опасный с эпидемиологической точки зрения очаг туберкулезной инфекции формирует больной
a. Туберкулезом органов дыхания с выделением МБТ и с наличием в его окружении детей или подростков
b. Туберкулезом органов дыхания с выделением МБТ и с наличием в его окружении только взрослых
c. Туберкулезом органов дыхания без выделения МБТ
d. Туберкулезом внелёгочной локализации с выделением МБТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

684. Необходимым условием для формирования искусственного специфического противотуберкулезного иммунитета является
a. Инфицирование МБТ
b. Вакцинация БЦЖ или БЦЖ-М
c. Регулярная иммунодиагностика
d. Превентивное лечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

685. В большинстве случаев источником туберкулезной инфекции является
a. Больной туберкулезом человек
b. Больное туберкулезом животное
c. Вода
d. Продукты питания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

686. Искусственный специфический противотуберкулезный иммунитет формируется после введения вакцины БЦЖ через
a. 6 – 8 недель
b. 6 – 8 месяцев
c. 1 год
d. 1 мес
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

687. К противоэпидемическим мероприятиям в очаге туберкулезной инфекции относится
a. Получение листка нетрудоспособности сроком на 12 месяцев
b. Раннее выявление туберкулеза среди населения
c. Проведение текущей и заключительной дезинфекции
d. Улучшение условий проживания больного и членов его семьи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

688. Противопоказанием для вакцинации БЦЖ-М является
a. Недоношенность (масса тела менее 2500 г)
b. Недоношенность (масса тела менее 2300 г)
c. Перинатальный контакт по ВИЧ
d. Оценка по шкале Апгар при рождении менее 7 баллов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

689. Понятие «малой формы» туберкулеза внутригрудных лимфоузлов подразумевает
a. Невыраженную гиперплазию 1-2 лимфоузлов с минимальным центральным казеозом
b. Двустороннюю гиперплазию лимфоузлов с выраженной перифокальной воспалительной реакцией
c. Одиночный очаг ацинозной или лобулярной казеозной пневмонии, располагающийся субплеврально
d. Казеозное перерождение 2 и более лимфоузлов с небольшой зоной перифокальной воспалительной реакции
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

690. К морфологическим критериям, позволяющим разграничить инфильтративную и туморозную формы туберкулеза внутригрудных лимфоузлов, относят
a. Количество групп лимфоузлов, вовлеченных в патологический процесс
b. Степень кальцинации в лимфоузлах
c. Соотношение гиперпластических и казеозных изменений в ткани лимфоузла
d. Вовлечение в процесс бронхов и лёгочной ткани
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

691. Рентгенологический симптом биполярности при первичном туберкулезном комплексе соответствует фазе
a. Инфильтрации
b. Рассасывания
c. Уплотнения
d. Кальцинации
e. Петрификации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

692. При первичном туберкулезе параспецифические изменения проявляются
a. Плевритом, перитонитом, перикардитом
b. Ринитом, синуситом, тонзиллитом

c. Кератоконъюнктивитом, блефаритом, узловатой эритемой
d. Пневмонией, хроническим обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой
e. Явлениями экссудативного, аллергического диатеза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

693. Первичный туберкулезный комплекс состоит из
a. Первичная гранулема, системный васкулит, очаги отсева
b. Первичный аффект, регионарный лимфангиит, регионарный лимфаденит
c. Первичная туберкулома, системный лимфангиит, системный васкулит
d. Первичная каверна, регионарный геморрагический васкулит, туберкулез бронхов
e. Первичная гранулема, туберкулез бронхов, параспецифические изменения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

694. Основной морфологической чертой острого (милиарного) гематогенно-диссеминированного туберкулёза лёгких является
a. Мелкие мономорфные продуктивные очаги в лёгких
b. Множественные экссудативно-казеозные очаги в лёгких
c. Множественные каверны в лёгких
d. Поражения бронхов туберкулёзом
e. Бронхогенные очаги отсева в лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

695. Необходимо предполагать острый (милиарный) гематогенно-диссеминированный туберкулёз лёгких
a. При кашле, не поддающемся лечению и полиморфной диссеминации в лёгких
b. При выраженной одышке и тотальном затемнении лёгкого
c. При гиперергических туберкулиновых пробах, синдроме интоксикации и диссеминации в лёгких
d. При тяжёлой воспалительной интоксикации неясного генеза в сочетании с тотальной мономорфной диссеминацией в лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

696. Характерной формой полостей распада при подостром диссеминированном туберкулезе лёгких является
a. Двухсторонние симметричные тонкостенные каверны
b. Двухсторонние асимметричные толстостенные каверны
c. Односторонние множественные каверны разной формы
d. Одна толстостенная каверна и множественные тонкостенные «дочерние» каверны
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

697. Наиболее характерными рентгенологическими признаками хронического гематогенно-диссеминированного туберкулёза лёгких являются
a. Преимущественное поражение средних отделов лёгких, двусторонняя мономорфная очаговая диссеминация в лёгких
b. Одностороннее массивное поражение лёгких, множественные каверны в лёгком, очаги бронхогенного отсева
c. Двустороннее поражение верхне-кортикальных отделов лёгких, полиморфная очаговая диссеминация на фоне диффузного пневмосклероза
d. Двустороннее поражение нижних отделов лёгких, двусторонняя мелкоочаговая диссеминация в лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

698. Характерными признаками подострого диссеминированном туберкулеза лёгких являются
a. Мономорфная мелкоочаговая диссеминация, распределение очагов равномерное, распад лёгочной ткани нехарактерен, бактериовыделение нехарактерно
b. Мономорфная крупноочаговая диссеминация, распределение очагов равномерное, распад лёгочной ткани характерен, бактериовыделение характерно
c. Полиморфная очаговая диссеминация, распределение очагов неравномерное, распад лёгочной ткани характерен, бактериовыделение характерно
d. Полиморфная очаговая диссеминация, распределение очагов неравномерное, распад лёгочной ткани нехарактерен, бактериовыделение нехарактерно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

699. Вторичный туберкулез развивается у
a. Детей, родители которых больны туберкулезом
b. Лиц, перенесших туберкулезную инфекцию в любой форме (инфицированность, заболевание)
c. Взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту
d. Подростков из очагов туберкулеза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

700. Чаще всего очаговый туберкулез выявляется при
a. Клиническом обследовании пациентов, обратившихся с характерными жалобами
b. Профилактическом флюорографическом осмотре
c. Микроскопическом анализе мокроты
d. Бронхоскопическом обследовании
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

701. Наиболее частые жалобы у больного очаговым туберкулезом
a. Слабость, потливость, быстрая утомляемость, незначительное повышение температуры
b. Лихорадка до 38°С
c. Кашель с большим количеством гнойной мокроты
d. Лёгочное кровотечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

702. Характерным рентгенологическим синдромом очагового туберкулеза является
a. Синдром затемнения.
b. Синдром округлой тени
c. Синдром патологии корня лёгкого
d. Синдром очаговой тени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

703. При очаговом туберкулезе лёгких очаги чаще локализуются в
a. 1-ом и 2-ом сегментах
b. 4-ом и 5-ом сегментах
c. Нижнедолевых сегментах
d. Корне лёгкого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

704. При исследовании мокроты у больных очаговым туберкулезом лёгких МБТ обнаруживаются чаще

a. При бактериоскопии
b. При культуральном методе исследования
c. Молекуляно-генетическим методом
d. Ни одним из методов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

705. Полости распада при очаговом туберкулезе лёгких характеризуются
a. Тонкими стенками
b. Толстыми стенками
c. Относительно тонкими, но неравномерно утолщенными стенками
d. Наличием горизонтального уровня жидкости
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

706. Морфологические особенности инфильтрата заключаются в
a. Преобладании казеоза
b. Специфическом поражении бронха
c. Быстром формировании распада
d. Сочетании казеоза в центре и перифокального экссудативного воспаления
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

707. Решающим диагностическим значением при подозрении на инфильтративный туберкулез лёгких является
a. Нахождение МБТ в мокроте или промывных водах бронхов.
b. Гиперергическая туберкулиновая чувствительность пробы Манту с 2ТЕ-ППДЛ
c. Обнаружение МБТ или ДНК МБТ в мокроте или промывных водах бронхов и наличие на рентгенограмме инфильтрата в лёгких
d. Наличие на рентгенограмме тени, локализованной в 1, 2 или 6 сегментах
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

708. Характерным рентгенологическим синдромом инфильтративного туберкулеза является:
a. Синдром затемнения.
b. Синдром округлой тени
c. Синдром патологии корня лёгкого
d. Синдром очаговой тени
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

709. В основу клинико-рентгенологических вариантов инфильтратов положено
a. Степень выраженности специфического воспаления и его распространенность
b. Объем поражения
c. Клинические проявления болезни
d. Пораженность бронхов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

710. Деструктивные формы инфильтративного туберкулеза лёгких чаще выявляются при
a. профилактической флюорографии
b. Обследовании на предприятиях
c. Обращении в учреждения общей лечебной сети
d. Обращении к фтизиатру
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

711. Особенностью лечения больного инфильтративным туберкулезом при специфическом поражении бронха является
a. Применение кортикостероидов
b. Использование лазерного облучения
c. Местное введение противотуберкулезных препаратов и гидрокортизона
d. Ингаляции бронхолитиков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

712. Основным морфологическим отличием казеозной пневмонии от вариантов инфильтративного туберкулеза является
a. Большой объем поражения
b. Преобладание казеозного некроза
c. Более частый распад
d. Склонность к бронхогенной диссеминации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

713. Типичными жалобами для казеозной пневмонии являются
a. Высокая температура тела, профузный пот, боль в груди, одышка, кашель со слизисто-гнойной мокротой, быстрое нарастание симптомов интоксикации
b. Ухудшение аппетита, потливость, субфебрильная температура, раздражительность, ослабление памяти
c. Сухой кашель, общая слабость, одышка, периодическое кровохарканье, непостоянный субфебрилитет
d. Высокая температура, головная боль, рвота, диарея, простуда
e. Периодическая боль на стороне поражения, субфебрильная температура
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

714. При эффективном лечении казеозной пневмонии чаще формируются
a. участки пневмофиброза
b. пневмофиброз с очагами
c. множественные туберкулемы
d. фиброзно-кавернозный и цирротический туберкулез
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

715. Характерной рентгенологической картиной для туберкулемы лёгких является
a. интенсивная тень с размытыми контурами, в центре с просветлением
b. гомогенная тень, низкой интенсивности с нечеткими контурами
c. округлая интенсивная тень в III, IV сегментах с бугристыми контурами
d. округлая гомогенная, иногда негомогенная, тень с четкими контурами, с очагами в окружающей лёгочной ткани
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

716. Для туберкулемы лёгких характерным является
a. малосимптомное или бессимптомное течение
b. острое начало, быстрое ухудшение состояния
c. подострое, напоминает грипп или пневмонию
d. острое начало, быстрое обратное развитие под влиянием химиопрепаратов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

717. Больному в фазу прогрессирования туберкулемы без сопутствующих заболеваний показано
a. хирургическое лечение

b. длительная противотуберкулезная терапия
c. противотуберкулезная терапия до ликвидации вспышки, а
затем хирургическое лечение
d. длительное применение противотуберкулезных и патогенетических средств
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

718. При длительной ремиссии процесса в казеозных массах туберкулемы преобладают
a. бактериальные особи МБТ
b. трасформированные формы МБТ
c. фильтрующиеся особи МБТ
d. неспецифическая микрофлора
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

719. Кавернозный туберкулез – это клиническая форма туберкулеза, характеризующаяся
a. Наличием полости распада в лёгком с бессимптомным клиническим течением
b. Наличием сформированной каверны в лёгком без выраженной перифокальной инфильтрации и фиброза в окружающей лёгочной ткани со скудными клиническими проявлениями
c. Наличием полости распада в лёгком с немногочисленными очагами в противоположном лёгком, сопровождающаяся бактериовыделением
d. Наличием полости распада в лёгком с бессимптомным клиническим течением и бактериовыделением
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

720. Чаще всего кавернозный туберкулез лёгких формируется из
a. Инфильтративного туберкулеза лёгких
b. Цирротического туберкулеза лёгких
c. Фиброзно-кавернозного туберкулеза лёгких
d. Диссеминированного туберкулеза лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

721. Пациенты с кавернозным туберкулезом лёгких часто предъявляют жалобы на
a. Кашель с небольшим количеством мокроты
b. Боль в боку, одышку
c. Слабость, недомогание, похудание
d. Повышение температуры тела, кашель с большим количеством мокроты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

722. Прямым из перечисленных рентгенологических признаков полости распада является
a. Наличие кольцевидной тени с непрерывным замкнутым контуром в двух взаимно перпендикулярных проекциях, отсутствие лёгочного рисунка в окне просветления
b. Наличие тени дренирующего бронха, деформация лёгочного рисунка, несколько неправильная форма каверны
c. Наличие очагов бронхогенного отсева, горизонтальный уровень жидкости
d. Бронхогенная диссеминация
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

723. Основной причиной формирования фиброзно-кавернозного туберкулеза является
a. Устойчивость МБТ к противотуберкулезным препаратам
b. Несвоевременное выявление туберкулезного процесса
c. Неадекватный режим лечения
d. Усугубляющие факторы (алкоголизм, наркомания)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

724. Одним из основных клинических признаков фиброзно-кавернозного туберкулеза лёгких является
a. Чередование периодов обострения и ремиссии у больного с наличием полостей распада в лёгком и выделения МБТ
b. Частые кровохарканья, сильный кашель при наличии полости распада в лёгком
c. Выраженная слабость, потливость, повышенная температура тела
d. Одышка при физической нагрузке, наличие полости распада в лёгком
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

725. Характерные для фиброзно-кавернозного туберкулеза лёгких рентгенологические признаки – это
a. Одна изолированная или множественные тонкостенные полости от 0,5 до 8 см в диаметре на фоне малоизмененной лёгочной ткани, без очаговых теней
b. Каверна с бухтообразным внутренним контуром, неравномерными стенками, бугристым внешним контуром, чаще в передних сегментах
c. Полость с толстыми стенками и уровнем жидкости, чаще в нижних отделах лёгких, вокруг фиброз, без очаговых теней
d. Каверна с толстыми стенками, деформированная, чаще в верхних отделах лёгких с выраженными фиброзными изменениями вокруг, смещением органов средостения, очагами бронхогенной диссеминации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

726. Основной причиной неудачи химиотерапии больных фиброзно-кавернозным туберкулезом лёгких является
a. Наличие каверны с казеозным некрозом
b. Наличие грубой фиброзной капсулы в стенке каверны
c. Устойчивость микобактерий туберкулеза к лекарственным средствам и непереносимость ПТП больным
d. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза, фиброзные изменения в стенке каверны и окружающей лёгочной ткани
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

727. Наиболее частый критерий активности туберкулезных циррозов – это
a. Обнаружение МБТ в мокроте
b. Результаты пробной терапии
c. Анализ рентгено-флюорографического архива
d. Обнаружение туберкулеза бронхов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

728. Фактором, имеющим наибольшее значение в возникновении спонтанного пневмоторакса, является
a. Разрыв спайки между листками плевры, наступивший при наложении искусственного пневмоторакса
b. Перфорация туберкулезной каверны в плевральную полость
c. Разрыв субплеврально расположенной буллы при локальной или распространенной эмфиземе
d. Наличие фиброзной каверны в ткани лёгкого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

729. У больного, страдающего диссеминированным туберкулезом лёгких, при внезапном появлении жалоб на резкую боль в правой половине грудной клетки, одышку, выраженную слабость, в первую очередь следует подумать о
a. Туберкулезном плеврите
b. Спонтанном пневмотораксе
c. Дыхательной недостаточности
d. Сердечной недостаточности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

730. Наиболее информативным методом диагностики спонтанного пневмоторакса является
a. Внешний осмотр и перкуссия грудной клетки
b. Аускультация
c. Рентгенографическое исследование ОГК
d. УЗИ плевральных полостей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

731. Наиболее характерным симптомом лёгочного кровотечения является
a. Выделение пенистой крови во время кашля
b. Рвота с примесью пенистой крови
c. Выделение темной крови со сгустками из носоглотки
d. Резкая бледность кожных покровов и металлический привкус во рту
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

732. Наиболее информативным методом исследования диагностики лёгочного кровотечения является
a. Бронхиальная артериография
b. КТ ОГК
c. Перкуссия и аускультация
d. Рентгенографическое исследование ОГК
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

733. Главной причиной возникновения лёгочного кровотечения при хронических формах туберкулеза является
a. Нарушения в свертывающей системе крови
b. Хроническая гипертензия в системе лёгочной артерии
c. Тканевая аллергия с гиперсенсибилизацией эндотелия сосудов
d. Повышенная проницаемость сосудов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

734. Наиболее характерным симптомом спонтанного пневмоторакса является
a. Острая боль на стороне поражения
b. Приступ кашля с пенистой мокротой
c. Выраженная одышка и сердцебиение
d. Приступ удушья
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

735. Первым мероприятием, которое следует выполнять у больного, потерявшего сознание на высоте лёгочного кровотечение с остановкой дыхания, но с сохранения сердечной деятельности, является
a. Обеспечение проходимости дыхательных путей путем освобождения их от сгустков крови
b. Искусственное дыхание
c. Непрямой массаж сердца

d. Сердечно-лёгочная реанимация
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

736. Пожилому пациенту, страдающему хроническим деструктивным туберкулезом лёгких, осложнившимся лёгочным кровотечением, в первую очередь следует назначить препараты
a. Противокашлевые
b. Отхаркивающие
c. Понижающие давление в малом кругу кровообращения
d. Повышающие свертывание крови
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

737. Последствием лёгочного кровотечения у больного туберкулеза является
a. Развитие массивного распространенного фиброза
b. Развитие анемии
c. Прогрессирование туберкулеза
d. Генерализация туберкулеза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

738. Ведущим синдромом в клинической картине цирротического туберкулеза лёгких является
a. Бронхитический
b. Интоксикационный
c. Болевой
d. Гипертермический
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

739. Выбор режима химиотерапии при туберкулезе определяется
a. Социальным статусом больного
b. Клинической формой туберкулеза
c. Наличием бактериовыделения и лекарственной чувствительностью МБТ
d. Наличием сопутствующих заболеваний и их характером
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

740. Химиотерапия туберкулеза – это метод
a. Лечения туберкулеза с помощью различных химических веществ
b. Различного воздействия на возбудителя заболевания
c. Этиотропной терапии туберкулеза с помощью различных химических веществ
d. Лечения антибиотиками
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

741. Патогенетическое лечение туберкулеза – это терапия
a. Воздействующая на состояние организма больного и происходящие в нем патологические процессы
b. С применением противовоспалительных лекарств
c. С применением лекарственных средств, влияющих на иммунную систему
d. Направленная на улучшение переносимости химиопрепаратов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

742. Комбинированная химиотерапия у больных туберкулезом имеет цель
a. Укорочение продолжительности лечения
b. Повышение его эффективности
c. Предупреждение развития лекарственной устойчивости микобактерий

d. Профилактика осложнений туберкулеза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

743. Основными механизмами действия химиопрепаратов на микробную популяцию являются
a. Бактериостатический и бактерицидный эффект
b. Ограничение распространения в организме возбудителя заболевания со стимуляцией защитных иммунных сил организма
c. Ограничение распространения в организме возбудителя заболевания
d. Стерилизующий эффект
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

744. Выбор способов введения противотуберкулезных препаратов определяется с учетом
a. Особенностей химиопрепаратов и их биотрансформации
b. Локализации и характера туберкулезного процесса
c. Переносимости химиотерапии
d. Возраста больных
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

745. Основным фактором эффективности химиотерапии больных туберкулезом является
a. Нормализация гемограммы
b. Прекращение бактериовыделения
c. Рассасывание инфильтративных и очаговых изменений в лёгких
d. Закрытие полостей распада
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

746. Оптимальная схема интенсивной фазы лечения больного инфильтративным туберкулезом лёгких ЛЧ МБТ (+) в фазе распада
a. Изониазид+рифампицин+пиразинамид+этамбутол
b. Изониазид+этамбутол+стрептомицин+этионамид
c. Рифампицин+пиразинамид+ПАСК+этамбутол
d. Рифампицин+этамбутол+этионамид+стрептомицин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

747. Наиболее эффективный план лечения туберкулемы средних размеров в фазе распада с бактериовыделением
a. Непрерывное лечение 4-мя, а затем 3-мя противотуберкулезными препаратами до 6 месяцев
b. Химиотерапия изониазидом + рифампицином + пиразинамидом + этамбутолом до 2 месяцев, при отсутствии эффекта – резекция пораженного участка лёгкого; в послеоперационном периоде химиотерапия будет зависеть от микробиологической характеристики резекционного материала
c. Химиотерапия изониазидом + рифампицином + пиразинамидом 3 месяца, а при отсутствии эффекта резекция пораженного сегмента;
d. Химиотерапия 4-мя противотуберкулезными препаратами 2 месяца, а затем 2-мя препаратами еще 6 месяцев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

748. Оптимальным сроком для оперативного вмешательства на лёгком по поводу сохраняющейся каверны после проведенного интенсивного курса химиотерапии является
a. 2 мес
b. 3 мес

c. 4 мес
d. 6 мес
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

749. Чувствительность к туберкулину у больных туберкулезом лёгких с ВИЧ инфекцией в стадии глубокого иммунодефицита чаще бывает
a. нормергическая
b. гиперергическая
c. анергия
d. гипергическая
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

750. Лихорадящим больным ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией, подозрением на туберкулез и при отсутствии изменений на обзорной рентгенограмме грудной клетки обязательно проводится
a. биопсия увеличенных лимфоузлов
b. УЗИ плевральной полости
c. мультиспиральная компьютерная томография лёгких
d. линейная томография лёгких
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

751. При невозможности проведения полного спектра диагностических мероприятий при подозрении на туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, с выраженным иммунодефицитом при СД4+ < 100 клеток в мкл, проводится
a. терапия пневмоцистной пневмонии
b. АРВТ
c. неспецифическая антимикробная терапия
d. тест-терапия противотуберкулезными препаратами по решению врачебной комиссии с участием врача-фтизиатра
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

752. Целью антиретровирусной терапии у больных туберкулезом является
a. иммунокоррекция
b. элиминация ВИЧ
c. подавление репликации ВИЧ
d. выведение ВИЧ из организма
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

753. Для специфического лечения ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом применяют
a. противогрибковые препараты
b. антибактериальные препараты
c. иммуностимулирующие препараты
d. противовирусные препараты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

754. Чаще возбудителем туберкулеза у человека является
a. M. tuberculosis
b. M. africanum
c. M. bovis
d. M. canetti
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

755. Анаэробная гликолитическая система является основным путем ресинтеза АТФ при выполнении упражнения
a. бег на 100 м
b. бег на 800 м
c. бег на 3,2 км
d.бег на марафонскую дистанцию
e. ходьба по пересеченной местности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

756. Креатин-фосфокиназная система является основным путем ресинтеза АТФ при
a. плавании на 400 м
b. беге на 50 м
c. беге на 1,6 км
d. беге на 10 км
e. марафонском заплыве
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

757. В организме содержится количество АТФ, достаточное для жизнедеятельности в течение нескольких
a. секунд
b. минут
c. часов
d. суток
e. лет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

758.Основной целью профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) является
a. развитие и поддержание требуемого уровня профессионально важных физических и психических качеств
b. спортивное совершенствование
c. профилактика инфекционных заболеваний
d. повышение производительности труда
e. верно все перечисленное
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

759.Значительное эмоциональное и статическое напряжение, длительное напряжение внимания наиболее характерны для профессии
a. врач-хирург
b. врач-терапевт
c. врач-педиатр
d. врач-лаборант
e. провизор
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

760.Основной целью производственной физической культуры (ПФК) является
a. укрепление здоровья, повышение эффективности производительности труда
b. спортивное совершенствование
c. профилактика инфекционных заболеваний
d. профилактика профессиональных заболеваний
e. снижение заболеваемости
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

761.Самая короткая форма производственной гимнастики, длящаяся всего 20-30 сек
a. вводная гимнастика
b. физкультурная пауза
c. физкультурная минутка
d. микропауза активного отдыха
e. отдых в обеденный перерыв
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

762.Основным эндогенным источником тепла в организме человека в период активной физической деятельности является
a. желудочно-кишечный тракт
b. нервная система
c. скелетная мускулатура
d. печень
e. жировая ткань
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

763.Внутренняя температура ядра тела человека является оптимальной и составляет
a. 37,0 °C
b. 36,6 °C
c. 37,5 °C
d. 36,0 °C
e. 35,5 °C
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

764.«Внутренний перенос тепла» от внутренних органов и мышц к коже обеспечивается за счет механизма
a. кондукции
b. конвекции
c. излучения
d. испарения
e. активного транспорта
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

765.Центральным регулятором температуры тела является
a. гипоталамус
b. гипофиз
c. лимбическая система
d. продолговатый мозг
e. кора головного мозга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

766.Под управлением соматической нервной системы находится
a. сократительный термогенез
b. несократительный термогенез
c. изменение тонуса сосудов
d. потоотделение
e. мочеобразование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

767.Повышению теплопродукции в условиях холодового стресса способствуют гормоны
a. адреналин и тироксин

b. вазопрессин и альдостерон
c. инсулин и соматотропин
d. глюкокортикоиды
e. альдостерон и вазопрессин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

768.Основным энергетическим субстратом во время двигательной активности в условиях холодового стресса являются
a. глюкоза и гликоген
b. свободные жирные кислоты
c. белки
d. кетоновые тела
e. нуклеиновые кислоты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

769.В развитии большинства адаптационных реакций прослеживаются этапы
a. срочной и долговременной адаптации
b. срочной, долговременной и следовой адаптации
c. срочной, промежуточной, долговременной и следовой адаптации
d. долговременной и следовой адаптации
e. компенсации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

770.Состояние перенапряжения и срыва специфических и неспецифических механизмов адаптации называется
a. дезадаптация
b. реадаптация
c. эустресс
d. дистресс
e. стресс
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

771.Адаптация к двигательной активности способствует адаптации к гипоксии, гипотермии благодаря механизму
a. положительной перекрестной адаптации
b. положительной обратной связи
c. отрицательной обратной связи
d. отрицательной перекрестной адаптации
e. срочной адаптации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

772.Для быстрого подсчета максимальной частоты сердечных сокращений (ЧССmax) используется формула
a. ЧССmax = 220 – возраст (в годах)
b. ЧССmax = 220 – рост (в см)
c. ЧССmax = 220 – вес (в кг)
d. ЧССmax = рост (в см) – возраст (в годах)
e. ЧССmax = вес(в кг) – возраст (в годах)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

773.Во время физической нагрузки больше всего снабжаются кровью
a. головной мозг

b. сердце
c. почки
d. печень
e. мышцы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

774. Физические качества человека
a. сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость
b. сила, быстрота, динамичность, ловкость, выносливость
c. сила, выносливость, быстрота, гибкость
d. сила, выносливость, быстрота, ловкость
e. сила, выносливость, быстрота, пластичность, ловкость
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

775. Физические качества человека определяются
a. наследственностью
b. влиянием физических нагрузок
c. наследственностью и долговременной адаптацией организма к физическим нагрузкам
d. влиянием тренера
e. волевыми усилиями спорстмена
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

776. Увеличение объема скелетных мышц в процессе адаптации к физическим нагрузкам происходит за счет
a. гипертрофии и гиперплазии мышечных волокон
b. гиперплазии мышечных волокон
c. гипертрофии мышечных волокон
d. увеличения количества мышечных волокон
e. роста соединительной ткани
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

777. Для развития силы используют
a. внешние сопротивления
b. вес собственного тела
c. упражнения с самосопротивлением, внешние сопротивления, вес собственного тела
d. внешние сопротивления и вес собственного тела
e. гантели и гири
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

778. Аэробная производительность организма зависит от
a. функционального резерва систем кровообращения, дыхания, крови, клеточного дыхания
b. функционального резерва системы кровообращения
c. количества гемоглобина
d. жизненной емкости лёгких
e. активности ферментов аэробного метаболизма скелетных мышц
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

779. Физическое качество «выносливость» преимущественно развивают следующие виды спорта
a. лыжи, плавание, бег на длинные дистанции, спортивная ходьба, велосипедный спорт
b. бокс, пауэрлифтинг, лыжи, плавание, бег на длинные дистанции
c. художественная и спортивная гимнастика
d. горнолыжный спорт, бег на короткие дистанции, плавание, велосипедный спорт, тяжелая атлетика

e. гонки на мотоциклах
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

780.Средством развития ловкости являются
a. физические упражнения повышенной координационной сложности
b. упражнения на скорость
c. силовые упражнения
d. аэробные нагрузки
e. циклические упражнения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

781.Средствами развития гибкости являются
a. физические упражнения с большой амплитудой
b. многократные физические упражнения с возрастающей амплитудой
c. силовые упражнения
d. упражнения на скорость
e. упражнения на выносливость
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

782.Основные составляющие здоровья человека
a. психическое, физическое, материальное
b. физическое, психическое, социальное (духовное)
c. социальное, физическое
d. материальное, психическое, идейное
e. физическое, психическое
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

783.Факторами, определяющими популяционное здоровье, являются
a. генетический, медицинский, экологический
b. образ жизни, генетика, медицина, экология
c. медицина, благосостояние, экология
d. экология, образ жизни, медицина
e. качество, доступность и своевременность медицинской помощи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

784.Основным фактором, определяющим уровень популяционного здоровья в экономически развитых странах, является
a. доступность, своевременность, качество медицинской помощи
b. образ жизни населения
c. материальное благосостояние и доходы населения
d. экология
e. материальное благосостояние
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

785.Жизнедеятельность человека – это
a. Состояние организма
b. Совокупность процессов в организме и в окружающей среде для удовлетворения биологических и социальных потребностей
c. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека
d. Оптимальное функционирование органов и тканей организма человека
e. Способ существования белковых тел
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

786.Здоровье – это
a. Состояние организма
b. Оценка физического развития
c. Критерий морали
d. Показатель материального благополучия
e. Результат жизнедеятельности организма
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

787.Болезнь – это
a. Состояние организма
b. Диагноз
c. Индивидуальная особенность
d. Показатель здоровья
e. Критерий морали
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

788.Адаптация человека – это
a. Отсутствие опасности
b. Положение, не приводящее к смерти
c. Состояние защищенности жизнедеятельности организма от внутренних факторов
d. Процесс приспособления организма к внешней среде
e. Состояние болезни
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

789.Повышению устойчивости организма к воздействию внешних факторов способствуют
a. Рациональное питание
b. Дезинфекция
c. Дезинсекция
d. Дезактивация
e. Нейтрализация
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

790.Очаг бактериологического поражения - это территория с людьми, подвергшаяся воздействию
a. Химического оружия
b. Бактериологического оружия
c. Ядерного оружия
d. Геофизического оружия
e. Обычного оружия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

791.Под "обычным оружием" понимают
a. Биологическое (бактериологическое) оружие
b. Ядерное оружие
c. Оружие массового поражения
d. Огневые и ударные средства артиллерийских, авиационных, и инженерных боеприпасов
e. Химическое оружие
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

792.Классификация вооруженных конфликтов
a. Большая война, малая война, крупномасштабная война
b. Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война

c. Гражданская война, партизанская война, национальная война
d. Приграничная война, межгосударственный конфликт, малая война
e. Региональная война, крупномасштабная война, вооруженный конфликт
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

793. Управление Вооруженными силами РФ осуществляет
a. Командующий сухопутными войсками
b. Командующий воздушно-космическими силами
c. Министр обороны РФ через министерство обороны и генеральный штаб ВС РФ
d. Начальник генерального штаба
e. Командующий военно-морского флота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

794. Виды вооруженных сил РФ - это
a. Сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот.
b. Специальные войска, тыл, войска стратегического назначения
c. Воздушно-десантные войска, специальные войска, тыл
d. Космические войска, строительные войска, ракетные войска
e. Ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, тыл
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

795. Формированием службы медицины катастроф местного уровня является
a. Санитарный пост
b. Бригада скорой медицинской помощи
c. Санитарная дружина
d. Бригада специализированной медицинской помощи
e. Бригада квалифицированной медицинской помощи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

796. Территориальный орган по предупреждению и ликвидации последствий ЧС
a. Комиссия по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
b. Управление по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
c. Формирования ГО общего назначения
d. Формирования служб ГО
e. Противопожарная служба
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

797. Бригады скорой медицинской помощи в районе чрезвычайной ситуации работают
a. В очаге поражения
b. В лечебно-профилактическом учреждении
c. На временном пункте сбора пораженных
d. На пункте экстренной медицинской помощи
e. На этапах медицинской эвакуации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

798. Формирования СМК, прибывающие в район катастрофы для усиления скорой помощи - это
a. Бригады экстренной медицинской помощи
b. Бригады специализированной медицинской помощи
c. Подвижные медицинские комплексы медицины катастроф
d. Лечебные учреждения Министерства здравоохранения

e. Бригады квалифицированной медицинской помощи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

799.Медицинской сортировкой называется метод распределения пораженных
a. По признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятий
b. По необходимости оказанию неотложной медицинской помощи
c. На «ходячих» и «носилочных»
d. На группы по возрастному признаку
e. На группы по половому признаку
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

800.Для обеззараживания воды в очагах чрезвычайных ситуаций применяется
a. Цистамин
b. Пантоцид
c. Этаперазин
d. Пергидроль
e. Аспирин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

801.В мирное время для оказания медицинской помощи при ЧС применяется система лечения
a. Одноэтапная
b. Двухэтапная
c. Трехэтапная
d. Четырехэтапная
e. Многоэтапная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

802.Оптимальным сроком оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях является
a. 30 минут
b. 1 час
c. 2 часа
d. 4 часа
e. 6 часов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

803.Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при катастрофах
a. Любая, которую можно использовать
b. Первая медицинская, первая врачебная, квалифицированная
c. Первая медицинская, доврачебная, специализированная
d. Первая, доврачебная, первая врачебная
e. Первая, специализированная, квалифицированная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

804.Метод работы при оказании медицинской помощи при массовом поступлении пораженных
a. Быстрое выведение из очага катастрофы
b. Оказание неотложной помощи
c. Четко организованная эвакуация
d. Медицинская сортировка
e. Экстренная эвакуация
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

805.Радионуклиды, определяющие радиационную обстановку в первые недели после аварии
a. Цезий 137
b. Йод 131
c. Барий 140
d. Стронций 90
e. Кальций 121
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

806.Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно- опасных объектах применяют
a. Тарен
b. Промедол
c. Этаперазин
d. Йодистый калий
e. Цистамин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

807.Препарат, заменяющий йодистый калий при радиационных авариях
a. 5% настойка йода
b. 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата
c. 70% этиловый спирт
d. 96% этиловый спирт
e. Таргин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

808.Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях
a. Ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз и противохимический пакет
b. Аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный и противохимический пакеты
c. Костюм противохимической защиты, ватно-марлевая повязка и аптечка индивидуальная
d. Фильтрующий противогаз, аптечка индивидуальная и противохимический пакет
e. Общевойсковой защитный комплект, аптечка индивидуальная и противохимический пакет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

809.Коллективные средства защиты
a. Больницы
b. Формирования гражданской обороны
c. Убежища и укрытия
d. Фильтрующие противогазы
e. Общественный сооружения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

810.Средства первой помощи при тяжелой степени острой лучевой болезни
a. Противорвотные
b. Успокаивающие
c. Сердечно-сосудистые
d. Антибиотики
e. Обезболивающие
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

811.К методам временной остановки кровотечения относится

a. Перевязка сосуда в ране
b. Прошивание раны
c. Наложение кровоостанавливающего зажима
d. Шинирование
e. Форсированное сгибание конечностей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

812.В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть повязку, смоченную
a. этиловым спиртом
b. 5% раствором уксусной кислоты
c. 2% раствором питьевой соды
d. 2% раствором новокаина
e. Питьевой водой
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

813.Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне ЧС - это
a. Особо опасные инфекции
b. Простудные
c. Сердечно-сосудистые
d. Кожи и подкожной клетчатки
e. Опорно-двигательного аппарата
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

814.Для спасения пострадавших при ЧС особую роль играет
a. Оснащенность медицинской службы
b. Характер ЧС
c. Фактор времени
d. Оповещение населения
e. Наличие средств механизации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

815.Автор высказывания: "Я не вручу никакой женщине абортивного пессария"
a. Гален
b. Ибн Сина
c. Маймонид
d. Гиппократ
e. Парацельс
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

816.Первый в истории международный свод правил о проведении экспериментов на людях
a. Нюрнбергский кодекс
b. Хельсинкская декларация
c. Сиднейская декларация ВМА
d. Лиссабонская декларация
e. Конвенция Совета Европы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

817.Этически допустимая разновидность вреда, который может возникнуть во взаимоотношениях медработника и пациента

a. Вред, вызванный неквалифицированными, непрофессиональными действиями врача, медсестры
b. Вред, вызванный неоказанием помощи, бездействием
c. Вред, вызванный небрежностью либо злым умыслом, например, корыстной целью
d. вред, вызванный объективно необходимыми в данной ситуации действиями (например, наличие боли или неудобства при проведении лечения)
e. Моральный вред
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

818.Главное отличие права от морали
a. Осуществляет регулирование на уровне индивидуального нравственного сознания и общественного мнения
b. Реализуется через законы, правительственные постановления и судебные решения через прямое или косвенное принуждение.
c. Предполагает свободное и добровольное исполнение его требований
d. Представляет собой систему запретов, идеалов, требований, принятую и разделяемую в обществе
e. Является особой формой самоопределения личности
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

819.Золотое правило нравственности
a. "Должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не к речам о добродетели"
b. "Человеческая личность бесконечна: это есть аксиома нравственной философии"
c. "Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе"
d. "Добро можно утверждать только при помощи добрых дел"
e. "Человек должен рассматриваться как цель, а не как средство для решения чьих бы то ни было задач"
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

820.Не способны дать информированное согласие
a. Иностранные граждане
b. Лица женского пола
c. Лица, не достигшие 21 года
d. Лица с тяжелыми формами заболеваний, блокирующими сознание
e. Лица, не достигшие 18 лет
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

821.Метод генной инженерии, ориентированный на повторение генотипа человека или животного, создание и тиражирование генетических копий людей (животных) путем бесполого размножения и иных манипуляций с генетическим материалом)
a. Клонирование
b. Позитивная евгеника
c. Негативная евгеника
d. Вмешательство в геном человека
e. Генная терапия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

822.Пациент (участник исследования) может отказаться от участия в эксперименте согласно этическим требованиям
a. Перед началом эксперимента (до того, как подписал договор об участии в эксперименте)
b. В ходе эксперимента, если не выдан аванс компенсации за участие в эксперименте

c. В ходе эксперимента, если пациент (участник исследования) вернул аванс компенсации
d. На заключительном этапе, если результаты эксперимента уже предопределены
e. На любом этапе эксперимента, независимо от получения аванса
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

823.Положение, относящееся к деонтологической этике
a. Задача достижения общего блага важнее интересов отдельного индивида
b. Действие считается нравственно оправданным в той мере, в какой оно ведет к максимизации общего блага
c. Мотивом поступка должно являться выполнение долга
d. Польза - основа нравственности и критерий человеческих поступков
e. Добродетельная жизнь человека связана с самоограничением
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

824.Принцип биоэтики, появившийся в последней трети XX века
a. Принцип справедливости
b. Принцип уважения автономии пациента
c. Принцип вежливости
d. Принцип благодеяния
e. Принцип "не навреди"
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

825.Тип забора органов от трупа для трансплантации, который называется "презумпция несогласия" ("информированное согласие")
a. Медики могут забирать органы умершего для трансплантации, т.к. тело умершего - государственная собственность
b. Если умерший при жизни не высказывал возражений против этого или если возражений не высказывают его родственники, то предполагается согласие умершего на эту процедуру
c. Если отсутствует согласие (явственно выраженное при жизни) на предоставление органов для трансплантации, то предполагается несогласие умершего на эту процедуру
d. Если родственники умершего не дают согласия на изъятие органов
e. Если родственники умершего дают согласие на изъятие органов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

826.Определение эвтаназии
a. Всякое действие или, наоборот, бездействие, которое, по своей сути или намерению, приводит к смерти, имеющей целью устранение боли и страдания
b. Самоубийство пациента
c. Прекращение жизни лишних людей
d. Медицинская и социально-психологическая помощь умирающим больным
e. Облегчение страданий больных людей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

827.Ксенотрансплантация
a. Пересадка тканей и органов от зародыша
b. Пересадка тканей и органов от трупа
c. Пересадка тканей и органов от животных
d. Пересадка тканей и органов от живого донора, являющегося родственником реципиента
e. Пересадка тканей и органов от живого донора, не являющегося родственником реципиента
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

828.Наиболее древняя, традиционная модель взаимоотношений между врачом и пациентом, для которой характерно сравнение отношения врача с пациентом с отношением "отец-ребенок"
a. Совещательная
b. Коллегиальная
c. Техническая
d. Патерналистическая
e. Интерпретационная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

829.Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться
a. На основании свободного, осознанного и информированного согласия больного
b. На основании медицинских показаний
c. На основании редкости картины заболевания и его познавательной ценности
d. На основании требования родственников
e. На основании извлечения финансовой выгоды
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

830."Добровольное принятие пациентом курса лечения или терапевтической процедуры после предоставления врачом адекватной информации" - это формулировка определения
a. Компетентного пациента
b. Автономии пациента
c. Правила правдивости
d. Правила конфиденциальности
e. Информированного согласия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

831."Та информация о пациенте, которую получает врач, не может быть передана третьим лицам без разрешения этого пациента" - это формулировка
a. Правила правдивости
b. Правила конфиденциальности
c. Правила вежливости
d. Принципа справедливости
e. Принципа благодеяния
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

832.В России искусственное прерывание беременности только по желанию женщины проводится на сроке:
a. До 10 недель
b. До 12 недель
c. До 16 недель
d. До 22 недель
e. До 28 недель
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

833.Характеристика активной добровольной эвтаназии
a. По просьбе больного врач содействует наступлению его смерти путем обеспечения его необходимым для этого средствами или информацией
b. Врач вводит летальную дозу препарата по просьбе компетентного больного
c. Врач вводит летальную дозу препарата без ведома и согласия пациента
d. Врач прекращает жизнеподдерживающее лечение по просьбе родственников больного, без его ведома и согласия

e. Врач прекращает жизнеподдерживающее лечение по просьбе компетентного больного
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

834.Паллиативная помощь
a. Медицинская помощь принудительного характера
b. Нетрадиционные методы лечения, профилактики и оздоровления, основанные на принципах народной медицины
c. Жизнеобеспечивающее лечение (ИВЛ, искусственное кровообращение, парентеральное питание)
d. Медицинская помощь, временно облегчающая проявления болезни, но не излечивающая ее
e. Медицинская помощь, оказываемая пациенту непосредственно после операции
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

835.Хоспис – это учреждение:
a. Обеспечивающее уход за умирающими больными
b. Обеспечивающее уход за онкологическими больными
c. Обеспечивающее уход за социально незащищенными больными
d. Обеспечивающее уход за больными на дому
e. Обеспечивающее уход за престарелыми больными
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

836.Отношение к эвтаназии в России согласно российскому законодательству
a. Активная эвтаназия запрещена, а пассивная разрешена только с письменного согласия больного
b. Запрещена только активная эвтаназия
c. Запрещена только пассивная эвтаназия
d. Разрешены оба вида эвтаназии
e. Запрещены и пассивная и активная эвтаназия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

837.Новый критерий смерти согласно Сиднейской декларации ВМА
a. Необратимое прекращение функции коры головного мозга
b. Необратимое прекращение функции больших полушарий головного мозга
c. Необратимое прекращение всех функций головного мозга, включая ствол мозга и первых шейных сегментов
d. Длительное отсутствие самостоятельного дыхания и сердцебиения
e. Отсутствие сознания в течение 3 месяцев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

838.Положение, относящееся к либеральной ("за") позиции по вопросу об искусственном аборте
a. Эмбрион - это потенциальный человек, поэтому он обладает неотъемлемыми правами и достоинством
b. Нельзя заставлять женщину вынашивать нежелательный плод, иначе нарушается принцип автономии пациента
c. Аборт – это убийство невинного человеческого существа
d. К опасным и неизбежным последствиям аборта относится нарушение физического и душевного здоровья женщины
e. Эмбрион обладает особым онтологическим и моральным статусом и не является частью организма матери
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

839.Высказывание в отношении суррогатного материнства, которое можно отнести к консервативной ("против") позиции
a. Для семьи, бездетной из-за неспособности жены зачать или выносить плод, это единственный способ получить ребенка, который будет генетически «своим» для мужа
b. Суррогатное материнство - это не коммерциализация деторождения, а глубоко человечный акт любви и сотрудничества
c. Суррогатное материнство превращает детей в подобие товара, создавая ситуацию, в которой богатые люди смогут нанимать женщин для вынашивания своих потомков
d. Суррогатное материнство по сути дела не так уж сильно отличается от процедуры усыновления, так как родители получают желанное дитя
e. Суррогатное материнство не только не наносит вреда детям, но и является единственным способом утверждения ценности семейной жизни для бездетных пар
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

840.Показание, являющееся в РФ социальным показанием для искусственного прерывания беременности (до 22-х недель)
a. Смерть мужа во время беременности
b. Наличие инвалидности I-II группы у мужа
c. Пребывание женщины в местах лишения свободы
d. Многодетная семья (более 3-х детей)
e. Беременность в результате изнасилования
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

841.В РФ по Семейному кодексу считается матерью родившегося ребенка при суррогатном материнстве (при возникновении спорной ситуации)
a. Женщина, родившая ребенка
b. Женщина, чья яйцеклетка использовалась
c. Зависит от того, как составлен договор
d. Решение принимает суд в каждом отдельном случае в зависимости от обстоятельств
e. Решение принимает комиссия, созданная в медицинском учреждении, где проводилось искусственное оплодотворение, возглавляемая главным врачом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

842.В РФ можно проводить клинические исследования лекарственных средств
a. на несовершеннолетних, не имеющих родителей
b. на беременных женщинах
c. на лицах с психическими заболеваниями и признанных недееспособными в порядке, установленном Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
d. на военнослужащих
e. на лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также на лицах, находящихся под стражей в следственных изоляторах
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

843.Возможно сообщение сведений о ребенке, составляющих врачебную тайну, его родителям или законному представителю (без согласия пациента)
a. До 14 лет
b. До 15 лет
c. До 16 лет
d. До 18 лет
e. Зависит от уровня развития ребенка

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

844.По Хельсинкской декларации нетерапевтический эксперимент
a. Метод исследования, который проводит не терапевт, но любой другой специалист
b. Основан на практике работы с пациентами
c. Исследование без ведения протокола
d. Медицинское исследование, направленное на развитие медицинской науки, апробирование лекарственных средств. Проводится чаще на здоровых людях
e. Исследование, направленное на исцеление больного
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

845.Древнерусское государство Киевская Русь возникло в
a. IX в.
b. XV в.
c. XVII в.
d. XVIII в.
e. XIX в.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

846.Правитель Киевской Руси, при котором было принято христианство
a. Ярослав Мудрый
b. Владимир Святой
c. Святослав Игоревич
d. Игорь Старый
e. Олег Вещий
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

847.Первый свод законов Киевской Руси назывался
a. Соборное уложение
b. Судебник
c. Русская правда
d. Табель о рангах
e. Конституция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

848.С именами Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия связано развитие
a. Книгопечатания
b. Зодчества
c. Иконописи
d. Летописания
e. Музыки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

849.Победу в «Ледовом побоище» одержал
a. Дмитрий Донской
b. Пётр I
c. Святослав Игоревич
d. Александр Невский
e. Иван Грозный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

850.Татаро-монгольское нашествие на русские земли в XIII веке возглавил

a. Чингисхан
b. Батый
c. Тамерлан
d. Тохтамыш
e. Узбек
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

851.Первая большая победа русских войск над главными военными силами Орды произошла на
a. Бородинском поле
b. Реке Неве
c. На Чудском озере
d. Куликовом поле
e. Под Полтавой
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

852.Героем древнерусских былин является
a. Степан Разин
b. Григорий Распутин
c. Илья Муромец
d. Емельян Пугачёв
e. Борис Годунов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

853.Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497 г., называлось
a. «Заповедные лета»
b. «Юрьев день»
c. «Урочные лета»
d. «Отходничество»
e. «Месячина»
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

854.Первым из русских правителей титул царя получил
a. Ярослав Мудрый
b. Иван IV Грозный
c. Михаил Романов
d. Пётр I
e. Борис Годунов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

855.Событие, в результате которого прекратилась зависимость Русских земель от Орды
a. «Ледовое побоище»
b. «Стояние на реке Угре»
c. «Азовское сидение»
d. «Битва народов»
e. Полтавская битва
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

856.Результатом внешней политики Ивана IV Грозного было
a. Присоединение к России Крыма
b. Присоединение к России Левобережной Украины

c. Присоединение к России Казанского и Астраханского ханства
d. Присоединение к России Польши
e. Завоевание Россией выхода в Балтийское море
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

857.Система мер, предпринятых Иваном Грозным для укрепления самодержавной власти
a. Местничество
b. Опричнина
c. Земщина
d. Хованщина
e. Нестяжательство
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

858.К Смутному времени относится
a. Иван Грозный
b. Дмитрий Донской
c. Борис Годунов
d. Елизавета Петровна
e. Княгиня Ольга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

859.Воцарение династии Романовых относится к
a. XV вв.
b. XVI вв.
c. XVII вв.
d. XVIII вв.
e. XIX вв.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

860.Кунсткамера, основанная Петром I, представляет собой
a. Естественно-научный музей
b. Театр
c. Картинную галерею
d. Православный храм
e. Ботанический сад
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

861.Россия стала империей в период правления
a. Ивана Грозного
b. Петра I
c. Александра II
d. Николая II
e. И.В. Сталина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

862.К эпохе дворцовых переворотов относится правление
a. Петра I
b. Павла I
c. Александра I
d. Анны Иоанновны
e. Княгини Ольги
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

863.Инициатором открытия Московского университета является
a. Е.Р. Дашкова
b. Г.Р. Державин
c. В.Н. Татищев
d. Н.И. Новиков
e. М.В. Ломоносов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

864.К периоду правления Александра I относится
a. Первая мировая война
b. Гражданская война
c. Отечественная война 1812 года
d. Северная война
e. Крымская война
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

865.Современником Николая I являлся
a. А.С. Пушкин
b. Л.Н. Толстой
c. А.П. Чехов
d. А.Н. Радищев
e. Е. М.А. Булгаков
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

866.Отмена крепостного права произошла в
a. 1861 г.
b. 1865 г.
c. 1961 г.
d. 1855 г.
e. 1888 г.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

867.П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский прославились как
a. Математики
b. Путешественники
c. Химики
d. Физики
e. Литераторы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

868.К царствованию Николая II относится
a. Создание Синода
b. Создание ядерного оружия
c. Медный бунт
d. Кровавое воскресенье
e. Закрепощение крестьян
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

869.В результате Октябрьской рефолюции 1917 г. к власти пришли
a. Кадеты
b. Монархисты

c. Анархисты
d. Славянофилы
e. Большевики
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

870.Лидером партии большевиков был
a. А.В. Колчак
b. В.И. Ленин
c. П.Н. Милюков
d. Н.И. Махно
e. П.А. Столыпин
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

871.К периоду правления И.В. Сталина относится понятие
a. Реабилитация
b. ГУЛАГ
c. Перестройка
d. Освоение целины
e. СНГ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

872.План нападения фашистской Германии на СССР назывался
a. «Цитадель»
b. «Тайфун»
c. «Ост»
d. «Барбаросса»
e. «Натиск на Восток»
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

873.Политика, проводимая М.С. Горбачевым получила название
a. Оттепель
b. Эпоха застоя
c. Перестройка
d. Коллективизация
e. Военный коммунизм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

874.Массовое строительство жилых домов с отдельными квартирами для семей началось при
a. И.В. Сталине
b. Н.С. Хрущёве
c. Л.И. Брежневе
d. М.С. Горбачёве
e. Б.Н. Ельцине
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

875.Мысленное объединение частей в единое целое это
a. Синтез
b. Анализ
c. Сравнение
d. Характеристика
e. Моделирование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

876.Мысленное разделение целого на его части есть
a. Синтез
b. Анализ
c. Аналогия
d. Дедукция
e. Индукция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

877.Логическое рассуждение от общего к частному называется
a. Аналогией
b. Моделированием
c. Индукцией
d. Дедукцией
e. Характеристикой
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

878.Логическое рассуждение от частного к общему называется
a. Обобщением
b. Моделированием
c. Индукцией
d. Дедукцией
e. Аналогией
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

879.К теоретическому познанию относится
a. Эксперимент
b. Измерение
c. Наблюдение
d. Идеализация
e. Сравнение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

880.Сторонники аскетизма проповедуют
a. Отречение от мирских соблазнов
b. Альтруизм во имя служения идеалов
c. Извлечение пользы из всего
d. Наслаждение жизнью
e. Общественную активность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

881.Понимание всякого действия человека как предопределенного заранее это
a. Фатализм
b. Волюнтаризм
c. Нигилизм
d. Прагматизм
e. Цинизм
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

882.Непреднамеренное искажение знания это
a. Ложь
b. Фантазия
c. Заблуждение
d. Истина

e. Сомнение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

883.Способность человека решать проблемы без осознания способа решения это
a. Созерцание
b. Наблюдение
c. Интеллект
d. Интуиция
e. Умозаключение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

884.Единичный представитель биологического вида или социальной группы это
a. Индивид
b. Человек
c. Герой
d. Личность
e. Индивидуальность
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

885.Форма научного знания, содержащая предположение и нуждающаяся в проверке, это
a. Закон
b. Принцип
c. Определение
d. Теория
e. Гипотеза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

886.Систему правил, приемов, процедур, применяемых для получения достоверного знания, называют
a. Теорией
b. Методом
c. Парадигмой
d. Знанием
e. Умением
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

887.Нормы, в которых зафиксировано формальное равенство людей, это
a. право
b. мораль
c. религия
d. политика
e. философия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

888.Представления человека о добре и зле, счастье, долге, воплощаются в нормах
a. Политики
b. Науки
c. Искусства
d. Права
e. Морали
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

889.Философская дисциплина, исследующая происхождение и природу нравственности, морали это

a. Эстетика
b. Этика
c. Эргономика
d. Логика
e. Антропология
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

890. Формой чувственного познания является
a. Ощущение
b. Суждение
c. Гипотеза
d. Предчувствие
e. Осмысление
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

891. Источником познания мира является разум, считают
a. Интуитивисты
b. Сенсуалисты
c. Спиритуалисты
d. Рационалисты
e. Эмпиристы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

892. Источником познания мира являются чувства, считают
a. Интуитивисты
b. Сенсуалисты
c. Спиритуалисты
d. Рационалисты
e. Экзистенциалисты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

893. Результатами эмпирического исследования являются
a. Научные факты
b. Научные теории
c. Научные гипотезы
d. Научные проблемы
e. Научные идеи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

894. Знание, истинность которого не доказана, называется
a. Гипотетическим
b. Теоретическим
c. Эмпирическим
d. Заблуждением
e. Обобщением
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

895. Способностью субъекта оценивать свой внутренний мир и поведение является
a. Психика
b. Самосознание
c. Воля
d. Эмоции
e. Память
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

896.Логический прием перенесения некоторых признаков, присущих одному предмету, на другой, подобный первому это
a. Обобщение
b. Аналогия
c. Моделирование
d. Абстрагирование
e. Конструирование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

897.Первая историческая форма целостного и образного восприятия мира это
a. Мифология
b. Наука
c. Политика
d. Философия
e. Религия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

898.Субъективное отношение человека к чему-либо это
a. Понятие
b. Мнение
c. Факт
d. Истина
e. Знание
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

899.В отличие от мнения, знание
a. Выражает субъективную позицию человека
b. Не требует обоснования
c. Обладает признаком истинности
d. Интуитивно
e. Не нуждается в подтверждении
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

900.Вопрос о смысле жизни вызван мыслью о том, стоит ли жить, если каждый человек
a. Бездуховен
b. Смертен
c. Ограничен
d. Слаб
e. Подавлен
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

901.Философия стремится к достижению знания
a. Рационального
b. Технического
c. Прикладного
d. Обыденного
e. Интуитивного
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

902.Одной из базовых характеристик научного типа познания является
a. Стихийность.
b. Произвольность.
c. Систематичность.

d. Опора на веру.
e. Субъективность.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

903. Учение, отрицающее существование Бога, называется
a. Атеизм.
b. Атомизм.
c. Скептицизм.
d. Волюнтаризм.
e. Фатализм.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

904. Понятие истины применимо к
a. Вопросу
b. Знанию
c. Предположению
d. Оценке
e. Предчувствию
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

905. Сочетание «ti» произносится как [ци] в слове
a. intestínum
b. eminéntia
c. óstium
d. mediastínum
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

906. Сочетание «ngu» не произносится как [нгв] в слове
a. língua
b. inguinális
c. únguis
d. ángulus
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

907. Правильная форма Gen.sg. существительного это
a. ganglioni
b. ganglion
c. ganglii
d. ganglionin
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

908. Правильный перевод термина «передняя пластинка» это
a. lamina anteriora
b. lamina anterior
c. lamina anterius
d. lamina anteria
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

909. Правильный перевод термина «большое затылочное отверстие» это
a. foramen occipitale major
b. foramen occipitale majus

c. foramen occipitale magnus
d. foramen occipitale magnum
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

*910.*Правильно термин «мышцы-вращатели» переводится как
a. musculi levatores
b. musculi flexores
c. muscules rotatores
d. muscula pronatores
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

911.Правильный перевод термина «решетчатые кости» это
a. ossa cribrosa
b. osses ethmoidales
c. osses cribroses
d. ossa ethmoidalia
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

912.Термин «сосуды сосудов» правильно переводится как
a. vasa vasorum
b. vasis vasium
c. vases vasum
b. vasa vasum
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

913.В словаре у существительных дается
a. форма Nom.Sg. / окончание Gen.Sg. / обозначение рода
b. форма Nom.Sg. / окончание Nom.Pl. / обозначение рода
c. форма Nom.Sg. / форма Gen.Sg.
d. форма Nom.Sg. / обозначение рода / обозначение числа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

914.Словарная форма прилагательного содержит
a. форму именительного падежа единственного числа мужского рода
b. форму единственного и множественного числа мужского рода
c. форму мужского и окончание среднего рода;
d. форму мужского рода, окончания женского и среднего рода
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

915.Правильный вариант перевода термина «короткая артерия» это
a. arteriae brevis
b. arteria brevis
c. arteriae breve
d. arteriarum breviarum
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

916.Вторая часть записи в словарной форме posterior,ius это
a. форма Gen.Sg. для всех родов
b. форма женского рода Nom.Sg.
c. форма среднего рода Nom.Sg.

d. вторая форма некорректна (не существует)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

917. Термин «костная перегородка носа» переводится как
a. septum osseum nasi
b. sulcus nasi ossei
c. septum nasi osseum
d. sulcus osseus nasalis
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

918. Форма Gen. Sg. прилагательного «posterior, ius» переводится как
a. posterioris
b. posteris
c. posterius
d. posteriori
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

919. В термине «тело подъязычной кости» - corpus ossis … недостает прилагательного
a. hypoglossi
b. sublingualis
c. hyoidei
d. subacuti
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

920. Понятие «сужение» обозначает ТЭ
a. -sclerosis
b. -stenosis
c. -stasis
d. -spasmus
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

921. В термине dactyl… «судорога пальцев» недостает ТЭ
a. -algia
b. -odynia
c. -spasmus
d. -plegia
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

922. Недостающим окончанием в термине bronchitis chronic…является
a. -is
b. -us
c. –a
d. -ae
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

923. Понятие «грыжа» обозначает ТЭ
a. -lithus
b. -cele
c. –cysta
d. -plasia
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

924. В термине histo… «распад тканей» недостает ТЭ
a. -malacia
b. -lysis
c. –sclerosis
d. -rrhexis
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

925. Правильный перевод термина «место меньшего сопротивления» это
a. locus minimi resistentiae
b. locus minoris resistentiae
c. locus minimae resistentiae
d. locus minorae resistentiae
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

926. Термин haematuria обозначает
a. наличие мочевины в крови
b. наличие сахара в крови
c. наличие сахара в моче
d. наличие крови в моче
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

927. Выражение Anamnesis morbi переводится
a. сведения о жизни
b. сведения о лечении
c. сведения о болезни
d. сведения о смерти
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

928. Выражение Status naturalis обозначает
a. хороший прогноз
b. местное состояние
c. место наименьшего сопротивления
d. естественное состояние
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

929. Термин encephalomyelitis переводится
a. воспаление головного мозга
b. воспаление мозговой оболочки
c. воспаление головного и спинного мозга
d. воспаление спинного мозга
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

930. Термин metrorrhagia обозначает
a. кишечное кровотечение
b. маточное кровотечение
c. кровотечение из прямой кишки
d. носовое кровотечение
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

931. Понятие «сухость слизистой полости рта» обозначается термином
a. xerocheilia
b. xerostomia

c. xerostoma
d. xerosis
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

932. Термин haematogenus переводится
a. почечного происхождения
b. происходящий из крови
c. кроветворение
d. желудочного происхождения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

933. Термин pneumatosis обозначает
a. воспаление лёгкого
b. скопление воздуха в какой-либо части тела
c. скопление воздуха в плевральной полости
d. уплотнение лёгкого
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

934. Правильное написание термина «покраснение кожи» по- латыни это
a. eritrodermia
b. erytrodermia
c. erytrodaermia
d. erythrodermia
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

935. Правильный вариант написания термина «двусторонний паралич одноименных частей тела» это
a. dyplegia
b. periplegia
c. hemiplegia
d. diplegia
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

936. «Лечение психическим воздействием» называется
a. психиатрия
b. психотерапия
c. психоанализ
d. психопатология
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

937. В термине …luxatio «подвывих» недостает приставки
a. hypo-
b. de-
c. sub-
d. re-
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

938. Термин dermatosis означает
a. воспаление кожи
b. гнойное заболевание кожи
c. сухость кожи

d. общее название заболеваний кожи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

939. Приставка infra- имеет значение
a. внутри
b. перемещение
c. под, ниже
d. между
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

940. Термин arthrosis переводится
a. боль в суставах
b. хроническое заболевание хрящей
c. воспаление сустава
d. хроническое заболевание суставов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

941. Термин toxicosis означает
a. наличие ядовитых веществ в крови
b. заболевание, вызванное содержанием ядовитых веществ в крови
c. страх отравления
d. наличие ядовитых веществ в моче
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

942. В термине «кариес зубов» caries dent… недостает окончания
a. -is
b. -um
c. -ium
d. -es
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

943. В термине «порок сердца» vitium cord… недостает окончания
a. -is
b. -ium
c. -i
d. -um
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

944. В термине «бронхиальная астма» asthma… недостает слова
a. bronchialis
b. bronchiale
c. bronchiali
d. bronchialium
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

945. Выражение habitus aegroti переводится
a. состояние больного
b. внешний вид больного
c. доверие больного
d. жалобы больного
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

946.В рецептах не сокращаются
a. названия лекарственных форм
b. названия органов растений
c. указания провизору
d. наименования химических соединений
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

947.Слово «капля, капли» в рецептах сокращается как
a. gt., gtt.
b. gut.
c. gts.
d. gtt.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

948.Правильный вариант сокращения слова «таблетки» это
a. tab.
b. tabb.
c. tabl.
d. tabul.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

949.Фразы «Повторить дважды» переводится
a. Repete bis
b. Repetatur
c. Repetatur bis
d. Repetere bis
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

950.Автором выражения «Primum noli nocere» является
a. Гален
b. Цельс
c. Гиппократ
d. Абу Али Ибн Сина
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

951.В выражении «pro dos…» недостает окончания
a. -e
b. -i
c. -es
d. -ibus
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

952.Выражение «pro die» переводится
a. разовая доза
b. высшая доза
c. суточная доза
d. минимальная доза
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

953.В термине Extractum Belladonn… пропущено окончание
a. -um
b. -i

c. -a
d. -ae
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

954. Выражение «Prognosis dubia» переводится
a. для прогноза
b. хороший прогноз
c. сомнительный прогноз
d. прогноз в отношении выздоровления
e. прогноз в отношении жизни
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

955. Частотный отрезок xanth- имеет значение
a. белый
b. желтый
c. синий
d. красный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

956. Частотный отрезок thi(o)- переводится
a. чай
b. сера
c. этил
d. щитовидная железа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

957. «Вспомогательное средство» обозначается выражением
a. remedium externum
b. remedium adjuvans
c. remedium constituens
d. remedium laxans
e. remedium purgans
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

958. В термине Solutio Synoestroli oleos… пропущено окончание
a. -a
b. -ae
c. -i
d. -o
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

959. В термине Extractum Belladonnae sicc… недостает окончания
a. -ae
b. -us
c. -i
d. -um
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

960. Обязывающие нормы
a. Запрещают совершать определенные действия
b. Предоставляют право совершать положительные действия
c. Устанавливают обязанность совершать определенные положительные действия

d. Рекомендуют не выполнять определенные действия
e. Устанавливают обязанность совершать определенные отрицательные действия
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

961. Какой элемент правовой нормы предусматривает условие ее применения
a. Гипотеза
b. Юридический факт
c. Преамбула
d. Диспозиция
e. Санкция
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

962. Высшей юридической силой обладает
a. Указ Президента РФ
b. Постановление Правительства РФ
c. Закон
d. Подзаконный акт
e. Постановление Верховного Суда РФ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

963. Возникающая на основе права юридическая связь между субъектами, в результате которой возникают юридические права и обязанности, называется
a. Действием
b. Правоотношением
c. Взаимоотношением
d. Социальным отношением
e. Юридическим фактом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

964. В состав правоотношения входят
a. Объект и субъекты правоотношения
b. Объект, субъекты правоотношения их права и обязанности
c. Юридические факты, права и обязанности субъектов правоотношения
d. Права и обязанности субъектов правоотношения
e. Объект правоотношения, юридические факты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

965. Подберите понятие к данному определению: «Общественно-вредное, противоправное и виновное деяние дееспособного, вменяемого лица»
a. Правонарушение
b. Правореализующее поведение
c. Поведение, безразличное для права
d. Аморальное поведение
e. Поведение, причиняющее вред человеку
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a
966. Гражданско-правовая ответственность носит характер
a. Нравственный
b. Волевой
c. Имущественный
d. Материальный
e. Процессуальный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

967. Какое определение соответствует понятию «конституция»
a. Это крупный юридический акт, содержащий все законы страны
b. Это присяга на верность государству
c. Это основной закон государства, определяющий его устройство, образование органов власти, закрепляющий права человека и т.д.
d. Это крупный нормативный акт, предусматривающий наказание за особо тяжкие правонарушения
e. Это крупный нормативный акт, содержащий указание на допустимое в РФ поведение граждан и юридических лиц
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

968. Председатель Правительства Российской Федерации назначается
a. Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы
b. Государственной Думой
c. Советом Федерации
d. Правительством Российской Федерации
e. Советом безопасности РФ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

969. Права и свободы гражданина могут быть ограничены лишь
a. Указами Президента РФ
b. Нормами Конституционного суда РФ
c. Постановлениями Правительства РФ
d. Федеральными законами
e. Постановлениями Верховного Суда РФ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

970. Владение вещью означает
a. Отчуждение вещи
b. Физическое господство собственника над вещью
c. Совершение в отношении вещи актов, определяющих ее юридическую судьбу
d. Извлечение из вещи полезных свойств
e. Распоряжение вещью
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

971. День открытия наследства – это
a. День оглашения завещания
b. День составления завещания
c. День смерти наследодателя
d. День, названный в завещании
e. День, названный супругом умершего
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

972. Сделка, совершенная лишь для вида, называется
a. Притворной
b. Мнимой
c. Оспоримой
d. Хитроумной
e. Злонамеренной
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

973. Правоспособность гражданина прекращается
a. Его совершеннолетием
b. Его смертью
c. Его недееспособностью
d. Его инвалидностью
e. Признанием его эмансипированным
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

974. Семейный кодекс РФ предусматривает в отношении имущества супругов режимы
a. Государственный и семейный
b. Семейный и законный
c. Договорный и законный
d. Только законный
e. Только договорный
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

975. Супруг после расторжения брака может предъявить иск о разделе имущества в течение
a. 2-х лет
b. 5-ти лет
c. 3-х лет
d. 1 года
e. 6 месяцев
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

976. Лицо, имеющее право на получение алиментов вправе обратиться в суд об их взыскании
a. В течение одного года с момента возникновения права на алименты
b. Независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты
c. В течение трех лет с момента возникновения права на алименты
d. В течение пяти лет
e. В течение 1 месяца
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

977. С какого дня лицо считается подвернутым административному наказанию
a. Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания
b. Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным постановлением о назначении административного наказания
c. Со дня совершения им административного правонарушения
d. На следующий день после совершения административного правонарушения
e. По истечении трех дней со дня совершения им административного правонарушения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

978. Максимальный срок административного ареста за совершение административного правонарушения в сфере законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах составляет
a. 30 суток
b. 15 суток
c. 20 суток
d. 3 суток
e. 25 суток
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

979. Максимальная величина административного штрафа за административное правонарушение, установленная для граждан, составляет
a. Не более 3000 рублей
b. Не более 5000 рублей
c. Не более 10000 рублей
d. Не более 1000 рублей
e. Не более 15000 рублей
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

980. Обязательным документом при заключении трудового договора является
a. Характеристика с последнего места работы
b. Резюме
c. Документы медицинского обследования
d. Документ об образовании
e. Документ о месте жительства или пребывания
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

981. Нормальная продолжительность рабочего времени в течение рабочей недели составляет
a. 35 часов
b. 25 часов
c. 40 часов
d. 36 часов
e. 45 часов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

982. Общий срок испытания при приеме на работу не может превышать
a. 3 месяца
b. 6 месяцев
c. 2 месяца
d. 1 месяца
e. 4 месяца
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

983. Обязательным этапом рассмотрения коллективного трудового спора является:
a. Трудовой арбитраж
b. Работа посредника
c. Примирительная комиссия. +
d. Забастовка
e. Локаут
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

984. Субъектами преступления могут быть
a. Юридические лица
b. Банки
c. Финансовые учреждения
d. Физические лица
e. Медицинские учреждения
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

985. Понятие преступления определяется как
a. Умышленное деяние, запрещенное нормативно-правовыми актами РФ под угрозой наказания

b. Уголовно-наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта, запрещенное УК РФ
c. Виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания
d. Противоправное общественно - опасное действие субъекта права
e. Умышленное деяние опасное для жизни человека, запрещенное УК РФ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

986. Подлежат ли уголовной ответственности лица с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость
a. Подлежат
b. Подлежат лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления
c. Не подлежат
d. Подлежат лишь в случае, если преступлением причинен крупный ущерб
e. Подлежат лишь в случае причинения тяжкого вреда здоровью
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

987. Какое определение понятия здоровья дано в ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
a. Отсутствие болезни
b. Состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма
c. Нормальное функционирование организма
d. Физическое благополучие человека
e. Физическое, психическое и социальное благополучие человека
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

988. Основным принципом охраны здоровья является
a. Приоритет здоровья нации
b. Приоритет интересов медицинского учреждения при оказании медицинской помощи
c. Приоритет социального благополучия
d. Приоритет охраны здоровья стариков
e. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

989. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается
a. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
b. В отношении лиц, больных наркоманией
c. В отношении лиц, больных игроманией
d. В отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения
e. Во всех названных случаях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

990.Современная экономика- это
a. рыночная экономика
b. экономика ограниченных ресурсов
c. политическая экономика
d. смешанная экономика
e. административно-командная
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

991. Объект экономики
a. экономическая сфера общества
b. ограниченные ресурсы
c. рост потребностей
d. НТП
e. глобальные проблемы человечества
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

992. Автором первой схемы кругооборота общественного продукта является
a. Смит
b. Монкретьен
c. Маркс
d. Кенэ
e. Кейнс
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

993. Процесс движения материальных благ от одного субъекта к другому называется
a. распределением
b. обменом
c. производством
d. потреблением
e. дисконтированием
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

994. Факторы производства – это
a. условия производства
b. средства производства
c. ресурсы
d. условия поставки товара (контракта)
e. продукты производства
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

995. Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью есть
a. рыночная стоимость
b. меновая стоимость
c. потребительская стоимость
d. альтернативная стоимость
e. прибавочная стоимость
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

996. Рост доходов потребителей- шоколада при прочих равных условиях приведет к
a. увеличению предложения и увеличению спроса на шоколад
b. смещению кривой спроса на шоколад вниз-влево
c. увеличению величины спроса на шоколад
d. увеличению спроса на шоколад
e. сокращению эластичности шоколада
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

997. Торговый баланс положителен, если
a. страна ввозит товаров меньше, чем вывозит
b. импорт страны высок

c. экспорт страны высок
d. страна вывозит товаров больше, чем вывозит
e. экономические границы страны закрыты
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

998. Макроэкономика отражает
a. рынок, интересы частника
b. государство, интересы всех
c. Верно А и В
d. нет правильного ответа
e. рынок
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

999. Фиаско рынка проявляется в
a. отсутствии стимулов к производству товаров и услуг коллективного пользования
b. неспособности уравновешивать экономические интересы продавцов и покупателей
c. отсутствии механизмов «вымывания» неконкурентоспособных предприятий
d. неспособности сигнализировать фирмам объемы и структуру производства
e. отсутствии механизмов цифровизации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1000. Дефицит госбюджета можно финансировать за счет
a. расширения перечня взимаемых налогов
b. прибылей госпредприятий
c. изъятия средств из «золотого запаса»
d. эмиссии денег и обязательств
e. продажи государственных территорий
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1001. Что относится к факторам экономического роста
a. прирост капитала
b. рост образовательного уровня
c. улучшение распределенных ресурсов
d. совершенствование технологии на основе НТП
e. все ответы верны
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

1002. Если предложение сократилось на 10% в ответ на 5%-ное снижение цены, то предложение характеризуется
a. высокой эластичностью
b. неэластичностью
c. абсолютной неэластичностью
d. единичной эластичностью
e. абсолютной эластичностью
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1003. Общая сумма собираемых в государстве налогов 720 млрд.д.е., ВНП – 1840 млрд. Уровень налогообложения в стране
a. 3,9%
b. 23%
c. 61%
d. 39%

e. 35%
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1004. К функциям коммерческого банка относятся
a. управление счетами правительства
b. хранение обязательных резервов коммерческого банка
c. открытие и ведение счетов клиентов, в т.ч. иностранных
d. распоряжение денежными средствами клиентов без их согласия
e. кредитование региональных бюджетов
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1005. Коэффициент Джини стремится к нулю, если
a. большая часть населения не имеет минимума средств к существованию
b. дифференциация доходов в обществе незначительна
c. наблюдается рост дифференциации доходов
d. наблюдается резкое сокращение доходов основной массы населения
e. в стране высокий уровень инклюзивности
Правильный ответ: b

1006. Определение дефляции
a. процесс снижения общего уровня цен в экономике
b. неспособность фирмы или человека в срок оплатить свои долги
c. цена единиц одной валюты в единицах другой валюты
d. план государственных расходов и доходов на год
e. нет правильного ответа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1007. К общим чертам рынков монополистической и совершенной конкуренции относятся
a. отсутствие существенных барьеров для вхождения в отрасль
b. Выпуск уникальных товаров
c. выпуск однородных товаров
d. множество продавцов и покупателей, оперирующих на рынке
e. наличие контроля за ценами товаров
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1008. Основные экономические проблемы общества
a. что производить
b. для кого производить
c. как производить
d. a и b
e. a, b и c
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

1009. Рост доходов потребителя графически выражается
a. в параллельном сдвиге бюджетной линия вправо вверх
b. в изменении наклона бюджетной линии
c. в уменьшении наклона бюджетной линии
d. в параллельном сдвиге линии влево вниз
e. в перпендикулярном сдвиге бюджетной линии
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1010. Олигополист максимизирует прибыль, когда

a. его предельные издержки равны предельной выручке
b. предельные издержки равны цене продукции
c. средние издержки равны цене продукции
d. средние издержки равны предельным издержкам
e. полупеременные издержки превышают постоянные
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1011. Увеличение количества применяемых факторов в n раз вызвало рост объема производства больше чем в n раз. Это характеристика
a. закона возрастающей производительности
b. постоянной отдачи от масштаба
c. убывающей отдачи от масштаба
d. возрастающей отдачи от масштаба
e. экстенсивного роста
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1012. Совокупная прибыль фирмы рассчитывается как
a. сумма совокупных постоянных и переменных издержек
b. разность цены и средних валовых издержек
c. разность валового дохода и валовых издержек
d. произведение цены и количества продукции
e. суммарная функция стоимости всех средств производства
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1013. Политика высоких цен означает, что рост общих доходов происходит за счёт
a. повышения качества
b. повышения цены
c. понижения цены
d. увеличения количества товара или услуги
e. нет верного ответа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1014. Переходный период не сопровождается
a. воздействием государства на экономику через систему финансовых регуляторов
b. трансформационным спадом
c. утратой государством функций единоличного распоряжения экономическими ресурсами
d. бюджетным кризисом
e. экономическим ростом
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1015. Деньги служат
a. средством обращения
b. средством сохранения ценности
c. счетной единицей
d. все ответы верны
e. средством расчета
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1016. Товар, объём спроса на который падает с ростом дохода при каждом значения цены
a. нормальный товар
b. товар роскоши
c. взаимозаменяемый товар

d. товар низкого качества
e. взаимодополняемый товар
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1017. Если уровень цен растет, а объем выпуска в экономике падает, то это может быть проиллюстрировано смещением кривой совокупного
a. предложения влево
b. предложения вправо
c. спроса влево
d. спроса вправо
e. все ответы верны
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1018. В качестве недостатков административно-командной экономики можно выделить
a. отсутствие рынка общественных благ
b. торможение развития нтп
c. подавленную инфляцию в виде дефицита
d. широкое распространение ручного труда
e. централизованное управление
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1019. Согласно технологическому подходу экономические системы делятся
a. развитые, развивающиеся, отсталые, бедные
b. доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные
c. первобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические, коммунистические
d. традиционные, рыночные, смешанные
e. рыночные, административно-командные, социалистические
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1020. Какое сочетание клавиш отвечает за копирование в буфер обмена
a. Ctrl+X
b. Ctrl+V
c. Ctrl+C
d. Ctrl+F
e. Ctrl+A
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1021. В MS Excel нельзя удалить:
a. имя ячейки
b. столбец
c. содержимое ячейки
d. строку
e. диаграмму
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1022. Какая из ссылок является абсолютной в MS Excel
a. #A#5
b. R1C2
c. C22
d. A5
e. *A*5

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1023. В MS Excel выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в этот диапазон
a. 6
b. 3
c. 4
d. 5
e. 8
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1024. Программа MS Excel используется для
a. создания текстовых документов
b. создания электронных таблиц
c. создание графических изображений
d. все варианты верны
e. для отправки писем
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1025. Минимальной составляющей таблицы MS Excel является
a. книга
b. ячейка
c. нет верного ответа
d. формула
e. лист
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1026. Минимальная единица информации
a. 1 бит
b. 8 бит
c. N =2i
d. 1 байт
e. log2N
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1027. Количество информации, которое можно получить при ответе на вопрос типа «да-нет»
a. нисколько
b. 1 байт
c. 8 бит
d. 1 бит
e. N =2i
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1028. Выбором каких пунктов запускается форматирование списков по алфавиту в MS Word?
a. вставка/ссылка/сноска
b. главная/редактирование
c. вставка/объект
d. главная/абзац/сортировка
e. разметка страницы/параметры страницы
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1029. Файлы Excel имеют расширение
a. .bmp

b. .exe
c. .mdb
d. .xls
e. .doc
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1030. В MS Excel строки обозначаются
a. целыми числами
b. латинскими буквами
c. числами и буквами
d. русскими буквами
e. произвольно
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1031. Байт - это
a. группа из 8 байтов информации
b. группа из 8 битов информации
c. группа из 1024 битов информации
d. группа из 1024 байтов информации
e. группа из 256 битов информации
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1032. В MS Excel имя ячейки образуется
a. из имени столбца и номера строки
b. произвольно
c. из номера строки
d. из имени столбца
e. из названия листа, имени столбца и номера строки
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1033. Какое сочетание клавиш отвечает за вырезание из текста
a. Ctrl+X
b. Ctrl+V
c. Ctrl+C
d. Ctrl+F
e. Ctrl+A
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1034. Какое сочетание клавиш отвечает за вставку из буфера обмена
a. Ctrl+X
b. Ctrl+V
c. Ctrl+C
d. Ctrl+F
e. Ctrl+A
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1035. С какого символа начинается формула в Excel
a. с любого
b. пробел
c. =
d. +
e. *

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1036. Электронная таблица MS Excel – это
a. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных
b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц
c. устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами
d. системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке таблиц
e. стандартная программа для создания текстовых документов в виде таблиц
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1037. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности в MS Excel называют
a. сортировка
b. группировка
c. фильтрация
d. форматирование
e. рецензирование
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1038. Файлы Word имеют расширение
a. .bmp
b. .exe
c. .mdb
d. .xls
e. .doc
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

1039. Что позволяет увидеть включенная кнопка «Непечатаемые символы»?
a. пробелы между словами и конец абзаца
b. все знаки препинания
c. ошибки в тексте
d. нумерацию строк
e. размер шрифта
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

1040. Сочетание каких клавиш отменяет последнее выполненное действие
a. Ctrl+X
b. Ctrl+V
c. Ctrl+C
d. Ctrl+Z
e. Ctrl+A
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

1041. При нажатии на кнопку с изображением дискеты на панели инструментов происходит следующее
a. запись документа на дискету
b. сохранение документа
c. считывание информации с дискеты
d. отмена последнего выполненного действия
e. закрытие документа

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1042. С ячейками таблицы MS Word нельзя выполнять следующие действия
a. Выделять
b. Объединять
c. Добавлять
d. Разбивать
e. Нет правильного ответа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

1043. Инструмент автозаполнения в MS Excel нельзя использовать при копировании формулы
a. вниз
b. вверх
c. влево
d. вправо
e. нет правильного ответа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: e

1044. Когда можно поменять свойства шрифта в MS Word?
a. перед распечаткой документа
b. только после окончательного редактирования;
c. в любое время
d. только в начале редактирования
e. после сохранения документа
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: c

1045. К текстовым редакторам относятся следующие программы:
a. PowerPoint
b. MS Word
c. Internet Explorer
d. Калькулятор
e. MS Excel
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1046. Какие типы фильтров существуют в MS Excel
a. тематический фильтр, автофильтр
b. автофильтр, расширенный фильтр
c. текстовый фильтр, числовой фильтр
d. расширенный фильтр, тематический фильтр
e. текстовый фильтр, расширенный фильтр
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1047. При выполнении расчетов в MS Excel в ячейке появилась группа символов ######## это означает, что
a. ширина ячейки меньше, чем длина полученного результата
b. допущена синтаксическая ошибка в формуле
c. ячейки должны быть одного размера
d. полученное значение является иррациональным
e. расчет формулы в ячейке дал деление на ноль
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: a

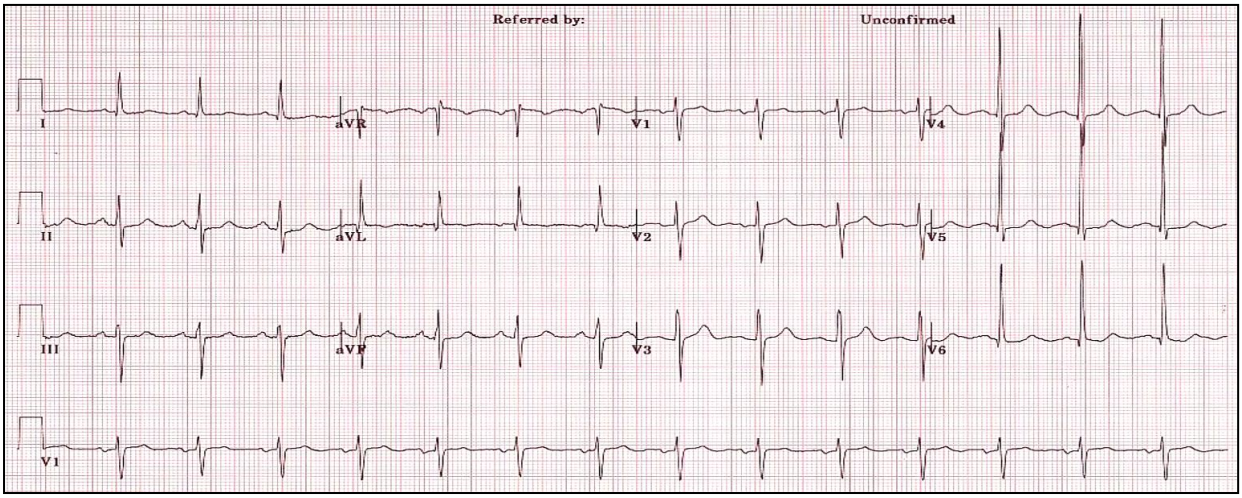
1048. Текстовый редактор — это
a. программное обеспечение, используемое для создания приложений
b. прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов и работы с ними
c. прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач бухгалтерского учета
d. прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы с ними
e. прикладное программное обеспечение для отправки писем
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: b

1049. К стандартным программам Windows относится
a. MS Word
b. MS Excel
c. PowerPoint
d. Блокнот
e. Outlook
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: d

Перечень задач для II этапа государственного экзамена

Задача № 1

Больной Е. 67 лет был экстренно направлен врачом-терапевтом участковым в больницу с жалобами на удушье, стеснение в груди, сухой кашель.
Анамнез: в течение последних 15 лет страдает гипертонической болезнью, систематически не лечится. Неделю назад (самочувствие не страдало) уровень системного артериального давления (АД) в покое составил 182/100 мм рт. ст. Вышеописанные жалобы появились впервые внезапно ночью во время сна.
Объективно: состояние тяжелое. Возбужден. Положение ортопноэ, разлитая бледность кожных покровов с цианозом губ, акроцианоз. Дыхание шумное с частотой 40 в минуту.
В лёгких по всем полям разнокалиберные влажные хрипы. Пульс - 120 в минуту, ритмичен, напряжен. АД - 200/120 мм рт. ст.
Левая граница сердечной тупости смещена латерально на 2 см.
Тоны сердца выслушиваются с трудом из-за хрипов в лёгких.
Печень не пальпируется, отёков нет.
Температура тела нормальная.
Представлена ЭКГ (скорость 25 мм/с).



Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.

2. Назовите отклонения от нормы, видимые на представленной ЭКГ, и сформулируйте ЭКГ-заключение.

3. Какой синдром является ведущим в клинической картине данного заболевания?

4. Среди каких неотложных состояний требуется провести дифференциальную диагностику?

5. С введения каких препаратов следует начинать купирование данного неотложного состояния?

Задача № 2

Пациент К. 50 лет обратился к участковому врачу в связи с впервые возникшим приступом сердцебиения, сопровождающимся мышечной дрожью, слабостью, незначительным затруднением дыхания. Приступ возник около 2 часов назад при сильном эмоциональном стрессе. Ранее при регулярной диспансеризации никаких заболеваний выявлено не было, АД было всегда в пределах нормы. На ранее снятых ЭКГ без патологических изменений. Весьма значительные физические нагрузки переносит хорошо.

При осмотре: сознание ясное. Кожные покровы обычной окраски и влажности. В лёгких везикулярное дыхание, ЧДД - 18 в минуту. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца аритмичные, шумов нет, ЧСС - 144 удара в минуту, пульс - 108 в минуту. АД - 130/80 мм рт. ст.

Печень не увеличена.

Периферические отёки отсутствуют.

Температура тела 36,9°С.

Представлена ЭКГ отведение II (скорость 25 мм/с):



Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.

2. Назовите отклонения от нормы, видимые на представленной ЭКГ, и сформулируйте ЭКГ-заключение.

3. Какой синдром является ведущим в клинической картине данного заболевания?

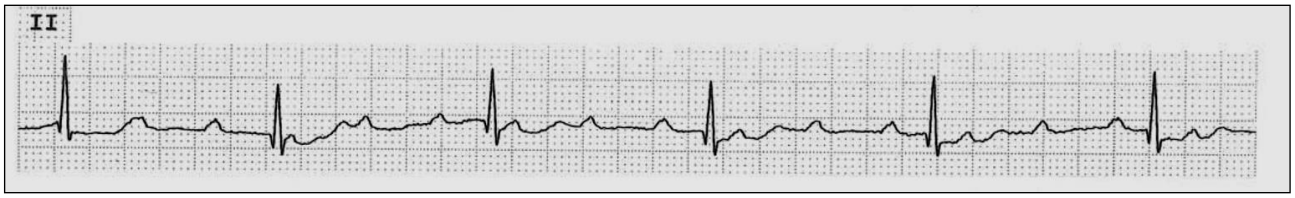
4. Среди каких сходных состояний требуется провести дифференциальную диагностику?

5. С введения каких препаратов следует начинать купирование данного неотложного состояния?

Задача № 3

Больной 75 лет на приеме у врача-терапевта участкового предъявляет жалобы на приступы головокружения, иногда с кратковременной потерей сознания, участившиеся в течение последнего месяца. Кроме этого, имеется одышка при незначительной физической нагрузке (иногда в покое) и отёки на ногах, которые появились также около месяца назад и в последующем усиливались.

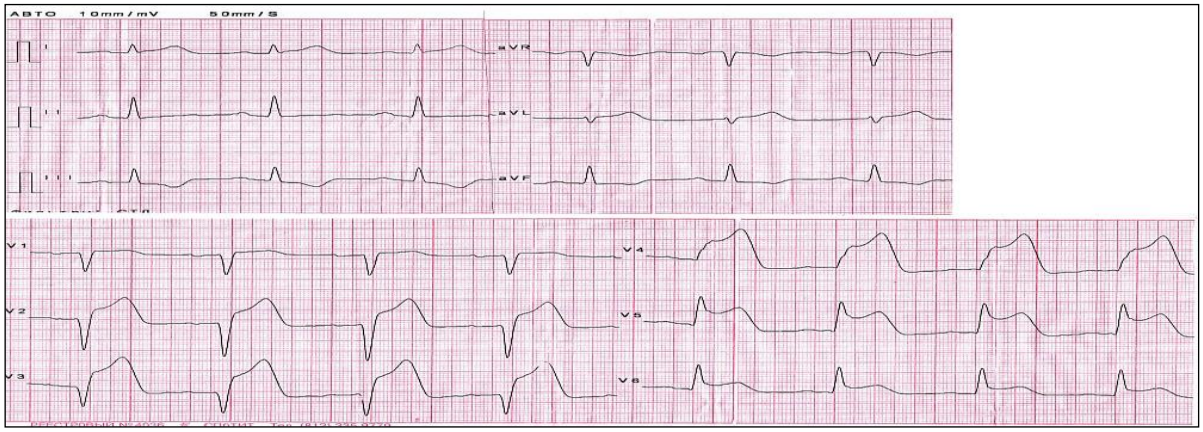
Анамнез: больным себя считает около 10 лет, когда впервые появились сжимающая боль в области сердца и одышка при ходьбе до 200 м, боль эффективно купируется нитроглицерином. Год назад впервые возник приступ потери сознания в течение нескольких минут, сопровождавшийся непроизвольным мочеиспусканием. В последний месяц аналогичные приступы участились, появилось повышение АД.
Объективно: сознание ясное. Выраженный цианоз губ, граница относительной сердечной тупости сердца смещена влево на 2 см. Тоны сердца глухие, ритмичные. Временами выслушивается громкий («пушечный») I тон. ЧСС - 46 ударов в минуту. АД - 180/100 мм рт. ст. В лёгких жёсткое дыхание, нестойкие незвонкие мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами.
Печень выступает из-под рёберной дуги на 5 см, край её плотный, чувствительный при пальпации. Симметричные отёки на ногах до верхней трети голеней.
Представлена ЭКГ (скорость 25 мм/с):



Задание
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Назовите отклонения от нормы, видимые на представленной ЭКГ, и сформулируйте ЭКГ-заключение
3. Какой синдром является ведущим в клинической картине данного заболевания?
4. Среди каких сходных состояний требуется провести дифференциальную диагностику?
5. Какой метод купирования данного неотложного состояния, проявляющегося обмороками, является наиболее эффективным?

Задача № 4

В поликлинику обратился мужчина 42 лет с впервые возникшим приступом интенсивной сжимающей загрудинной боли без отчетливой иррадиации, сопровождающейся тошнотой, профузным потоотделением, одышкой. К моменту обращения длительность приступа около 3 часов. Курит много лет, 10-15 сигарет в день.
Артериальной гипертензии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, неврологических заболеваний, травм головы, коагулопатий и значительных кровотечений в анамнезе нет.
Сознание ясное. Кожные покровы бледные, гипергидроз. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД - 18 в минуту. Тоны сердца ритмичны. ЧСС - 90 ударов в минуту, АД - 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена.
Экстренно снята ЭКГ.



Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.

2. Назовите отклонения от нормы, видимые на представленной ЭКГ, и сформулируйте ЭКГ-заключение.

3. Какова тактика врача общей практики в данной ситуации?

4. Среди каких неотложных состояний требуется провести дифференциальную диагностику?

5. Какие лабораторные маркеры рекомендуется использовать для подтверждения диагноза?

Задача № 5

Мужчина 47 лет вызвал бригаду скорой помощи в связи с появлением давящей боли за грудиной. Боль появилась 40 минут назад, в покое, не купировалась 2 дозами изосорбида динитрата (изокет спрей). Пациент отмечает выраженную слабость, потливость.

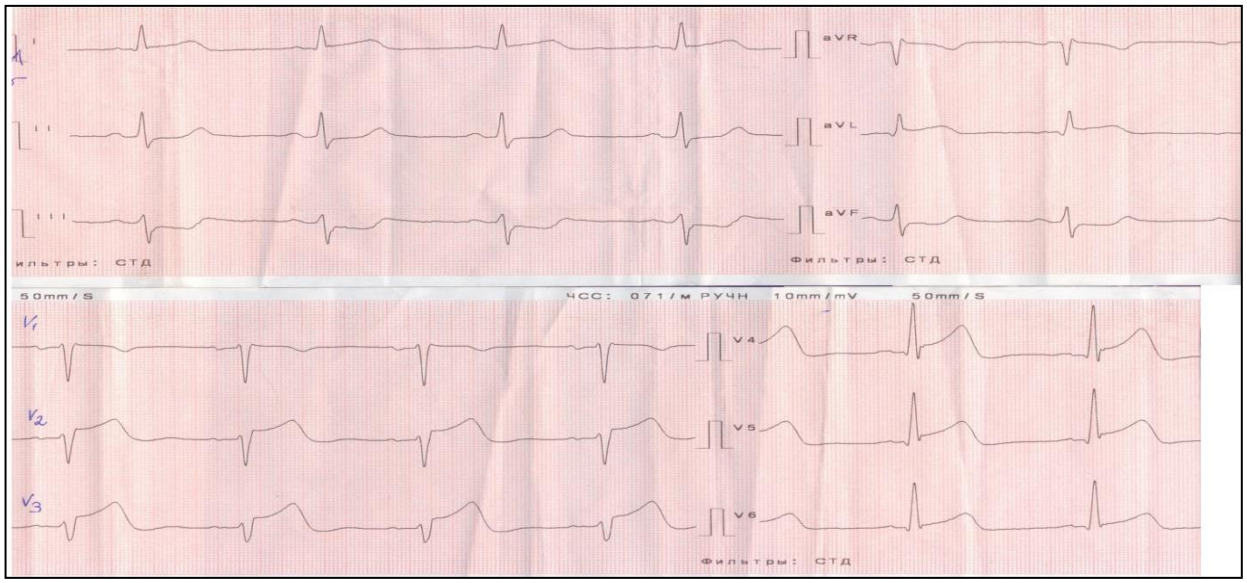
Ранее боли за грудиной не беспокоили, физическую нагрузку переносил хорошо. В течение 6 лет периодически повышалось артериальное давление (АД) до 160/100 мм рт. ст. При повышении АД принимал каптоприл, постоянно гипотензивные препараты не получал. Курит 25 лет по 1 пачке сигарет в день. Наследственность не отягощена.

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы влажные. Частота дыхательных движений - 18 в минуту. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные, частота сердечных сокращений – 70 ударов в минуту, АД – 160/100 мм рт. ст.

Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. Пульс на сосудах нижних конечностях сохранён.

Зарегистрирована ЭКГ.

Больной доставлен в приёмное отделение больницы с отделением рентгеноэндоваскулярных вмешательств в течение 20 минут. Результаты биохимического исследование крови: тропониновый тест отрицательный, креатинин - 90 мкмоль/л, глюкоза - 6,5 ммоль/л.



Задание

1. Сформулируйте синдромальный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Какой метод реперфузии показан больному? Обоснуйте свой выбор.
5. Какая антитромботическая терапия показана больному при поступлении в стационар, если известно, что на догоспитальном этапе она не проводилась?

Задача № 6

Мужчина 55 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на боли сжимающего характера за грудиной, возникающие при ходьбе на расстояние менее 200 метров или при подъёме на один пролёт лестницы, иррадиирущие в левое плечо, проходящие через 3-5 минут после остановки. Нитроглицерином не пользовался. Беспокоит также одышка при подъёме на один пролёт лестницы, утомляемость, которая появилась несколько недель назад.
Из анамнеза известно, что аналогичные боли беспокоят в течение полутора лет. Вначале они возникали на большую, чем сейчас нагрузку, но последние несколько месяцев носят описанный выше характер. Больной получает Бисопролол 5 мг в сутки и Кардикет 40 мг 2 раза в сутки. На этом фоне приступы сохраняются.
Курил в течение 20 лет по ½ пачки в день. Бросил курить 5 лет назад.
Семейный анамнез: отец внезапно умер в возрасте 59 лет.
При осмотре: состояние удовлетворительное. Индекс массы тела – 24 кг/м^2. Окружность талии – 96 см. Кожные покровы чистые, обычной окраски. В лёгких дыхание везикулярное, незвонкие, нестойкие мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами лёгких. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 70 ударов в минуту, АД – 130/85 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и селезёнка не увеличены. Периферических отеков нет. Дизурии нет.
В анализах: общий холестерол – 6,5 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 0,9 ммоль/л, ХС-ЛПНП – 3,5 ммоль/л, ТГ – 2,7 ммоль/л, глюкоза натощак – 5,1 ммоль/л, креатинин – 96 мкмоль/л, СКФ (по формуле CKD-EPI) – 86,6 мл/мин.
На ЭКГ: ритм синусовый с частотой 82 в минуту, нормальное положение электрической оси сердца, соотношение зубцов R и S в грудных отведениях не нарушено.
Выполнена ВЭМ – проба прекращена на нагрузке 75 Вт из-за появления дискомфорта в грудной клетке, одышки и депрессии ST на 2 мм в отведениях V4, V5, V6.
«Двойное произведение» составило 195.

Тест с шестиминутной ходьбой, выполненный перед выпиской – 200 метров.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Больному проведена Эхокардиография. Фракция выброса составила 38%. Какие лечебные мероприятия необходимо назначить пациенту? Обоснуйте свой выбор.
5. Проведена коронарография. Обнаружен стеноз ствола левой коронарной артерии 70%. Какова тактика дальнейшего ведения пациента? Обоснуйте Ваш выбор.

Задача № 7

Мужчина 52 лет госпитализирован с приёма в поликлинике с жалобами на лихорадку до 39,5°С, повышенную потливость, озноб, головокружение, одышку при небольшой физической нагрузке, слабость, отсутствие аппетита, похудание на 10 кг за последние 2 месяца.
Вредные привычки: в течение многих лет злоупотребляет алкоголем, в течение 30 лет курит по 1 пачке в день.
Около 2,5 месяцев назад перенёс экстракцию зуба. Через неделю после манипуляции появились субфебрилитет и повышенная потливость. В течение двух недель лечился народными средствами, на фоне чего появилась лихорадка с ознобами, повышенная потливость, боли в мышцах и суставах. Ещё в течение недели за медицинской помощью не обращался. При обращении в поликлинику по месту жительства при рентгенографии органов грудной клетки патологии не выявлено.
В анализах крови отмечались лейкоцитоз - 14×10^9/л, увеличение СОЭ до 24 мм/ч. Был назначен ампициллин в дозе 2 г/сут, на фоне чего отметил снижение температуры тела до субфебрильных цифр и болей в суставах. Сохранялись повышенная потливость, резкая слабость, отсутствие аппетита. Через 5 дней после завершения приема антибиотиков вновь отметил повышение температуры тела до 39°С с ознобом.
При осмотре. Состояние тяжёлое. Заторможен. Ортопноэ. Температура тела 39,5°С. Пониженного питания. Кожные покровы бледные с желтушным оттенком, влажные, тургор снижен, на ладонях безболезненные геморрагические пятна 3-5 мм в диаметре. Отёков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. При сравнительной перкуссии лёгких - звук с коробочным оттенком, с притуплением в нижних отделах. Границы лёгких в норме. При аускультации дыхание жёсткое, влажные хрипы в нижних отделах обоих лёгких. ЧД - 24 в минуту. Верхушечный толчок в шестом межреберье по левой передней подмышечной линии. Границы относительной сердечной тупости: правая - на 1 см кнаружи от правого края грудины, верхняя - верхний край III ребра, левая - по левой передней подмышечной линии в VI межреберье. При аускультации сердца: тоны сердца ритмичные, ослабление I тона в VI межреберье по левой передней подмышечной линии, ослабление II тона во II межреберье справа от грудины. Во II межреберье справа от грудины и в точке Боткина-Эрба - мягкий дующий протодиастолический шум, в VI межреберье по левой передней подмышечной линии - систолический шум. Пульс высокий, скорый, ритмичный, симметричный на обеих руках. ЧСС - 115 ударов в минуту. АД - 130/40 мм рт. ст. Пульсация сонных артерий.
Живот мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курлову: 14×12×10 см. Пальпация печени умеренно болезненна. Селезёнка пальпируется у края реберной дуги, мягкая, болезненная. Поперечник - 10 см, длинник - 12 см.
Общий анализ крови: гемоглобин - 85 г/л, лейкоциты - 22×10^9/л, палочкоядерные нейтрофилы - 8%, сегментоядерные нейтрофилы - 78%, эозинофилы - 1%, лимфоциты - 8%, моноциты - 5%. СОЭ - 38 мм/ч. Биохимический анализ крови: общий билирубин - 41,2 мкмоль/л, СРБ +++, фибриноген - 6,5 г/л, альбумины - 40%, ревматоидный фактор +.

Общий анализ мочи: удельный вес - 1010, белок - 0,99 г/л, лейкоциты - 5-6 в поле зрения, выщелоченные эритроциты - 5-8 в поле зрения.
ЭхоКГ: толщина задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки - 1,0 см. Расширение полости левого желудочка: конечный диастолический размер левого желудочка - 6,0 см, размер левого предсердия - 5,5 см. На створке аортального клапана имеется эхогенное образование размерами 1,0×0,8 см. Аортальная регургитация III степени, митральная регургитация II степени.

Задание

1. Выделите синдромы, имеющиеся у больного.
2. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.
3. Какое самое главное дополнительное исследование необходимо выполнить больному для уточнения диагноза? Как правильно выполнить данное исследование?
4. Назовите основные принципы лечения больного и показания к раннему хирургическому лечению.
5. Какие меры и кем должны были быть предприняты для профилактики развития данного заболевания?

Задача № 8

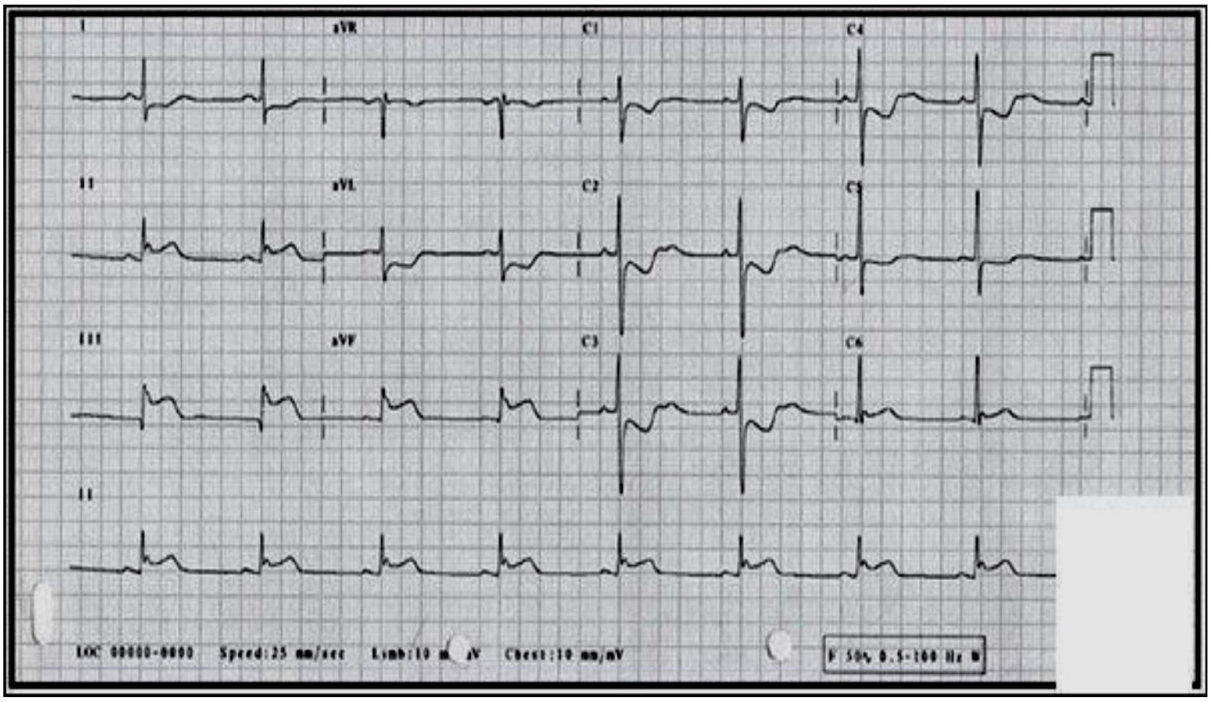
Пациент 69 лет направлен врачом-терапевтом участковым в клинику с жалобами на выраженную одышку при незначительной физической нагрузке, приступы удушья по ночам. Ухудшение состояния наблюдается около недели до госпитализации.
Из анамнеза: 6 лет назад диагностирована дилатационная кардиомиопатия. Больной постоянно получал подобранное лечение: Гипотиазид - 12,5 мг в сутки, Фозиноприл - 20 мг ежедневно, Карведилол - 12,5 мг 2 раза в день. Наблюдалась слабость при физической нагрузке.
Пациент сообщил, что несколько дней назад после переохлаждения появился кашель, повышалась температура тела до 37.4°С. Вследствие нарастания слабости, прекратил приём Карведилола, использовал обильное питьё, витамины. Состояние ухудшилось.
Объективно: вес - 76 кг, рост - 168 см. Цианоз. При аускультации: незвонкие, нестойкие мелкопузырчатые хрипы над нижними отделами лёгких с двух сторон; тоны сердца глухие, ритмичные, протодиастолический ритм галопа. ЧСС - 105 ударов в минуту. АД - 105/70 мм рт. ст. Симметричные отёки нижних конечностей (до верхней трети голени).
В анализах крови: натрий - 138 ммоль/л, калий – 3,9 ммоль/л.
ЭКГ: синусовый ритм, блокада левой ножки пучка Гиса, редкие желудочковые экстрасистолы, QRS 0,13 сек.
ЭхоКГ: диффузная гипокинезия стенок левого желудочка, фракция выброса - 36%, конечный диастолический размер левого желудочка - 69 мм.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Чем обусловлена тяжесть состояния пациента? Что способствовало развитию декомпенсации сердечной недостаточности? Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Какие группы препаратов следует назначить больному? Как быть с назначенным ингибитором АПФ Фозиноприлом в связи с АД 105/70 мм рт. ст. (отменить, уменьшить или увеличить дозу)? Как быть с Карведилолом?
5. Если, несмотря на проведение адекватной терапии, не удастся добиться стойкой компенсации сердечной недостаточности, имеются ли резервы в лечении?

Задача № 9

Больной А. 63 лет, преподаватель ВУЗа. Сегодня в покое около 3 часа назад без видимой причины появилась и стала нарастать одышка смешанного характера.
Пациент госпитализирован.
Анамнез заболевания: около 5 лет страдает гипертонической болезнью. Антигипертензивные препараты принимает нерегулярно.
Объективно: при поступлении состояние средней степени тяжести, ортопноэ, кожа бледная, акроцианоз, число дыханий - 26 в минуту, при аускультации выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы над всеми отделами лёгких.
Перкуторно границы сердца расширены влево, пульс на лучевой артерии 100 в минуту, ритмичный, тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС - 100 в минуту, АД - 130/90 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, размеры печени по Курлову - 9×8×7 см.
Вскоре после поступления состояние больного резко ухудшилось: появился продуктивный кашель с небольшим количеством розовой мокроты, усилилась одышка, увеличилось количество влажных хрипов над всеми лёгочными полями. ЭКГ прилагается.

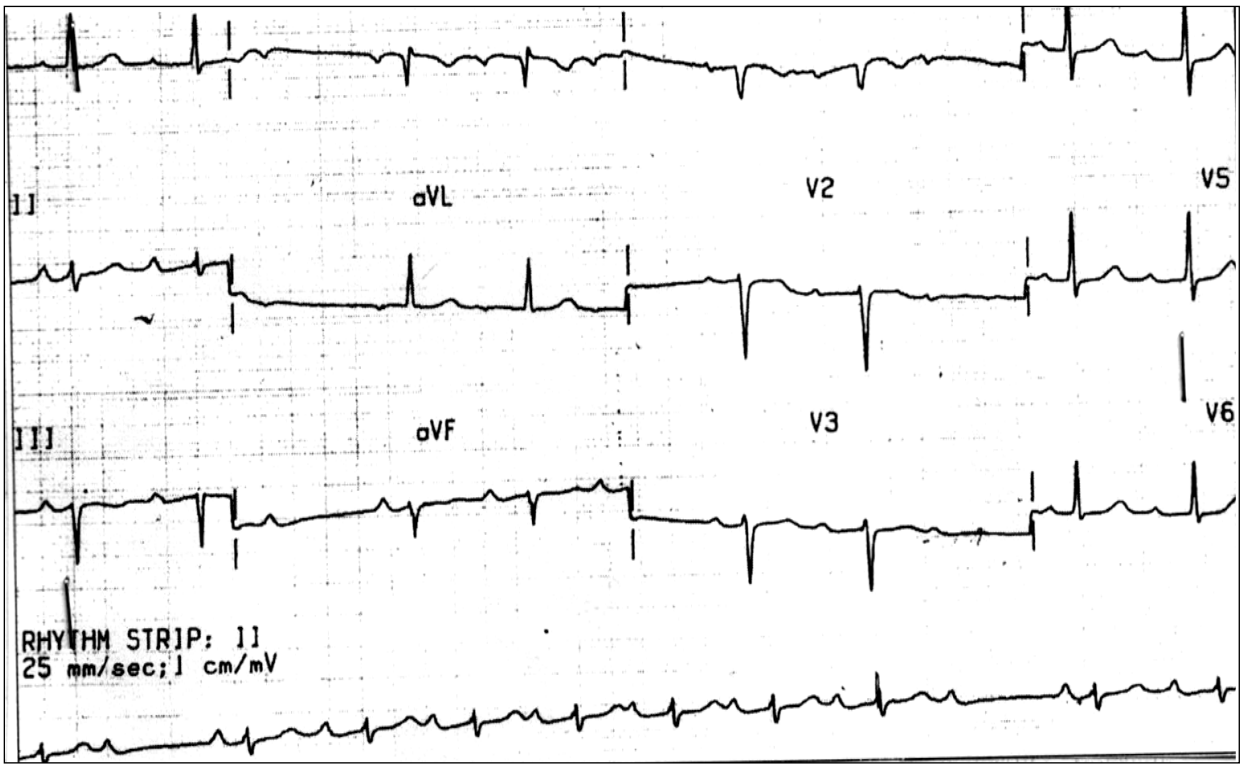


Задание
1. Выделите синдромы, определите ведущий (объясните механизм его возникновения).
2. Предположите наиболее вероятный диагноз.
3. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
4. Составьте план обследования для уточнения диагноза.
5. Определите план лечения.

Задача № 10

Больной 65 лет, пенсионер, поступил в клинику с жалобами на редкий пульс, перебои в работе сердца, ощущение его замирания и остановки, чувство нехватки воздуха при подъеме на 1 лестничный пролёт, давящие боли за грудиной при подъеме на 1 лестничный пролёт, купирующиеся приемом нитроглицерина в течение 1-2 мин; кратковременные эпизоды потери сознания.

Из анамнеза: четыре года назад перенёс инфаркт миокарда. Через год стали появляться ангинозные боли при обычной физической нагрузке. Неделю назад ощутил перебои в работе сердца, инспираторную одышку, отметил кратковременные эпизоды потери сознания, что и явилось причиной госпитализации.
Объективно: состояние средней степени тяжести, акроцианоз, отёков нет. В нижних отделах лёгких небольшое количество незвучных мелкопузырчатых хрипов. Тоны сердца глухие, аритмичные, ЧСС - 42 ударов в минуту, Ps - 42 в мин. АД - 110/65 мм рт. ст.
Живот мягкий, безболезненный. Печень с нормальными свойствами.
Записана ЭКГ:



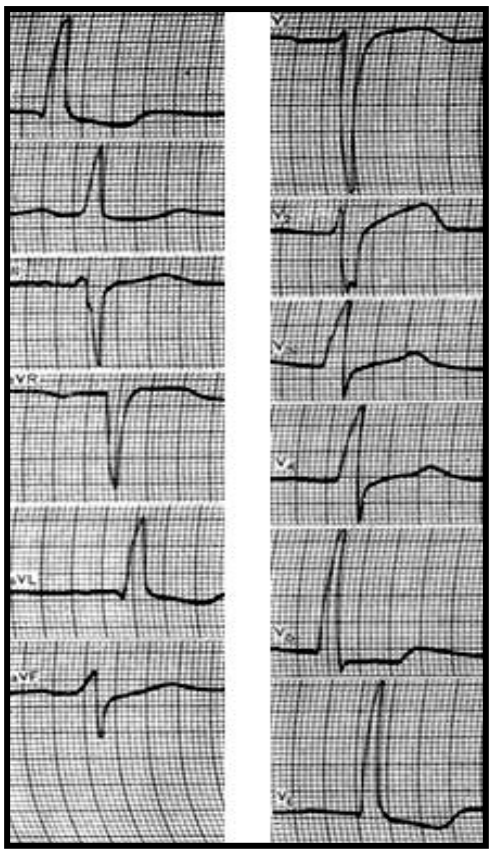
Задание
1. Выделите синдромы, определите ведущий.
2. Интерпретируйте представленную электрокардиограмму.
3. Сформулируйте диагноз.
4. Составьте план дополнительных обследований.
5. Назначьте лечение.

Задача № 11

Больной Н. 50 лет, инженер, обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на приступы сжимающих болей за грудиной, продолжительностью до 3-5 минут, иррадиирущих в левую руку, возникающих при обычной ходьбе через 100 м и подъёме на один пролет лестницы, сопровождаются общей слабостью.
Анамнез заболевания: считает себя больным в течение 2 лет, когда впервые стал отмечать появление этого характера болей за грудиной вначале при быстрой ходьбе или при психоэмоциональном напряжении. Врачом было назначено лечение, однако лекарства принимал нерегулярно. Со временем боли стали появляться при обычной физической нагрузке до 2-4 раза в неделю, купировались после приема нитроглицерина через 1-2 мин и в покое через 3-5 мин.

Настоящее ухудшение отмечает в течение последних 2 недель: вышеописанные боли в грудной клетке стали появляться ежедневно до 2-3 раза в день, их продолжительность увеличилась (купируются приёмом нитроглицерина через 3-5 мин).
Из анамнеза жизни: внезапная смерть отца в возрасте 60 лет. Курит по 1 пачке в день, физически мало активен, злоупотребляет спиртными напитками.
Объективно: состояние удовлетворительное. Вес - 95 кг, рост - 170 см. Окружность талии - 112 см. Кожные покровы и видимые слизистые обычного цвета, чистые, нормальной влажности. Отёков нет. Грудная клетка правильной формы, соответствует гиперстеническому типу конституции. Перкуторно над лёгкими ясный лёгочный звук. Дыхание везикулярное, хрипов нет.
Пульс одинаков на обеих лучевых артериях, ритмичный, 80 в минуту, удовлетворительных качеств. АД - 150/95 мм рт. ст. Верхушечный толчок расположен в V межреберье по срединно-ключичной линии. Шумы в сердце не выслушиваются.
Живот правильной формы, участвует в дыхании, мягкий, безболезненный. Край печени не пальпируется. Почки не пальпируются.
Общий анализ крови: гемоглобин - 140 г/л, эритроциты – $4{,}8\times10^{12}$/л, ЦП – 0,875, лейкоциты – $5{,}7\times10^{9}$/л, эозинофилы – 4%, палочкоядерные нейтрофилы – 3%, сегментоядерные нейтрофилы – 52%, лимфоциты – 35%, моноциты – 6%; СОЭ – 6 мм/ч.
Общий анализ мочи: обычный цвет, прозрачная, pH кислая, удельный вес – 1018; белок, сахар не обнаружены, лейкоциты – 1-2 в поле зрения, эпителий - 1-2 в поле зрения, эритроциты, цилиндры, соли не выявлены.
Креатинин – ~~0,088~~ 88 мкмоль/л (62-115 мкмоль/л), АСТ – 10 Ед/л (5-37), АЛТ – 12 Ед/л (4-42), общий холестерол – 6,2 ммоль/л (4,0), калий – 3,7 ммоль/л (3,4-5,3).
ЭхоКГ: КДР ЛЖ - 5,5 см (норма – до 5,5 см), КСР ЛЖ - 3,5 см (норма – до 3,5 см), ФВ – 68% (норма - 60-80%), ПЖ - 2,0 см (норма - до 2,2 см), ЛП – 3,9 см (норма – до 4 см), МЖП – 1,2 см (норма - 0,8-1,1 см), ЗСЛЖ – 1,2 см (норма - 0,8-1,1 см).

Записана ЭКГ.



Задание

1. Выделите ведущие синдромы (объясните механизмы их возникновения).
2. Дайте заключение по ЭКГ и ЭхоКГ.
3. Составьте дифференциально-диагностический ряд.
4. Уровень тропонина I в сыворотке крови при повторных исследованиях в пределах референсных значений. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
5. Назовите факторы риска ИБС у пациента.

Задача № 12

Мужчина 37 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на головные боли. Из анамнеза известно, что головные боли появились два года назад. Появление головных болей связывает с ангиной. Тогда же отметил появление мочи цвета «мясных помоев», при этом мочеиспускание было безболезненным, болей в поясничной области не было. Моча цвета «мясных помоев» регистрировалась в течение 2 дней, затем приобрела обычный желтый цвет. К врачам не обращался. Эпизод мочи цвета «мясных помоев» в течение суток повторился спустя год во время ОРВИ. Обследование также не проводилось.
Семейный анамнез: мать – 60 лет, часто болеет ангинами, в течение 2 лет – гипертоническая болезнь. Отец умер в возрасте 55 лет от онкологической патологии.
При осмотре: состояние удовлетворительное. Индекс массы тела – 24,2 кг/м^2. Кожные покровы чистые, обычной окраски. Отёков нет. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 70 удара в минуту, АД – 160/100 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и селезёнка не увеличены. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный.
В анализах крови: эритроциты - 4,57×10^{12}/л, гемоглобин - 137 г/л, лейкоциты - 5,51×10^9/л, лейкоцитарная формула не изменена; тромбоциты - 254×10^9/л, СОЭ - 26 мм/час. Общий холестерол – 4,9 ммоль/л, ТГ – 1,7 ммоль/л, ХС-ЛПВП – 1,2 ммоль/л, ХС-ЛПНП - 2,8 ммоль/л; глюкоза натощак – 4,2 ммоль/л, креатинин – 135 мкмоль/л, СКФ (по формуле CKD-EPI) - 57 мл/мин, мочевина – 9,4 ммоль/л, мочевая кислота – 0,40 ммоль/л, общий билирубин - 7,4 мкмоль/л (непрямой), АЛТ - 39 МЕ/л, АСТ - 28 МЕ/л, общий белок - 70 г/л, альбумины - 36 г/л.
В анализах мочи: относительная плотность - 1014, цвет желтый, реакция кислая, белок - 0,88 г/л, эритроциты - 10-15 в поле зрения, лейкоциты - 3-4 в поле зрения, эпителий плоский – единичные клетки в поле зрения, бактерии отсутствуют, слизи нет, ураты +.
Суточная протеинурия - 400 мг.
УЗИ почек: положение почек обычное, размеры - 11×5,6 см, паренхима - 1,7 см. Чашечно-лоханочный комплекс не изменён. Дополнительных образований и конкрементов не выявлено.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Препарат какой группы антигипертензивных лекарственных средств Вы бы рекомендовали пациенту в составе комбинированной терапии? Обоснуйте свой выбор.
5. Стоит ли продолжать принимать так называемые нефропротекторы в период ремиссии заболевания.

Задача № 13

Больная И. 34 лет, оператор машинного доения, поступила в терапевтическое отделение с жалобами на повышение АД до 220/120 мм рт. ст., головные боли, сердцебиение, перебои в области сердца, тошноту, сухость во рту, зуд кожных покровов. Считает себя больной около 15 лет, когда появились отёки под глазами, при амбулаторном обследовании было выявлено наличие белка и эритроцитов в моче, по поводу чего в дальнейшем несколько лет находилась под наблюдением терапевта, диагноз не помнит. После переезда в сельскую местность (5 лет назад) в поликлинику не обращалась.

В течение последнего года стала замечать головные боли, головокружение, которые больная связывала с повышением АД до 180/110 мм рт. ст. (измеряла самостоятельно; адаптирована к 140-160/90 мм рт. ст.). По совету фельдшера при повышении АД принимала эналаприл по 20 мг/сут. с удовлетворительным эффектом; постоянной гипотензивной терапии не получала. В течение последних 6 месяцев отмечает отсутствие эффекта от приема эналаприла, АД постоянно повышено до 180-200/100-110 мм рт. ст., эпизодически - 240/140 мм рт. ст., неоднократно вызывала бригаду скорой помощи, от госпитализации отказывалась по семейным обстоятельствам. Месяц назад появилась тошнота, склонность к поносам, а 2 недели назад присоединился зуд кожных покровов.

При осмотре: общее состояние тяжёлое. Кожные покровы бледные, сухие, со следами расчёсов, в подмышечных областях как бы припудрены белой пудрой. Одутловатость лица, пастозность стоп, голеней, передней брюшной стенки. Грудная клетка симметрична, голосовое дрожание проводится с обеих сторон. При перкуссии над всеми отделами лёгочный звук. Дыхание везикулярное, хрипов нет. АД - 220/120 мм рт. ст. Верхушечный толчок смещен на 1 см влево от левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, ритм неправильный (5-7 экстрасистол в минуту), I тон ослаблен над верхушкой и основанием мечевидного отростка, акцент II тона над аортой; слева от грудины с эпицентром в V межреберье выслушивается шум трения перикарда. Язык сухой, живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, безболезненная. Ободочная кишка умеренно болезненная. Почки не пальпируются. Катетером получено 150 мл мочи.

Общий анализ крови: эритроциты - $2{,}6\times10^{12}$/л, НВ - 72 г/л, ЦП - 0,9; лейкоциты - $5{,}7\times10^{9}$/л, эозинофилы - 2%, палочкоядерные нейтрофилы - 3%, сегментоядерные нейтрофилы - 68%, лимфоциты - 25%, моноциты - 2%; СОЭ - 40 мм/ч.

Общий анализ мочи: цвет - жёлтый, pH нейтральная, удельный вес - 1005, белок - 6,8 г/л, лейкоциты - 2-4 в поле зрения, эритроциты - 10-12 в поле зрения, цилиндры зернистые - 3-4 в поле зрения, восковидные - 2-3 в поле зрения.

Биохимическое исследование крови: общий белок - 58 г/л, альбумины - 29 г/л. АСТ - 0,43 ммоль/л, АЛТ - 0,45 ммоль/л, глюкоза - 3,8 ммоль/л, холестерол - 7,5 ммоль/л; креатинин - 1,4 ммоль/л, мочевина - 38,2 ммоль/л.

ЭКГ: ритм синусовый, 96 в минуту, электрическая ось сердца отклонена влево, единичные желудочковые экстрасистолы, гипертрофия и систолическая перегрузка миокарда левого желудочка.

УЗИ почек: правая почка - 80×36 мм, подвижна, контуры ровные, нечёткие, толщина паренхимы - 11 мм; левая почка - 84×44 мм, контуры ровные, нечёткие, толщина паренхимы - 9 мм. Паренхима обеих почек «неоднородна», с гиперэхогенными включениями.

Конкременты, объёмные образования не выявлены.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Дайте рекомендации по дальнейшему лечению.

Задача № 14

Больного 38 лет беспокоят жажда, снижение аппетита, кожный зуд, резко выраженная слабость, уменьшение количества мочи до 300 мл/сут, тошнота, однократная рвота при поступлении. В течение 10 лет повышение цифр артериального давления до 200/110 мм рт. ст.
При объективном исследовании в клинике нефрологии кожные покровы бледные с субиктеричным оттенком, сухие, следы расчёсов. Отёков нет. В лёгких везикулярное дыхание.
Тоны сердца ритмичные, акцент II тона над аортой.
Частота сердечных сокращений - 90 в минуту. Артериальное давление - 220/120 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезёнка не пальпируются.
Анализ крови: гемоглобин - 72 г/л, лейкоциты - $6{,}2\times10^9$/л. Лейкоцитарная формула не изменена. СОЭ - 22 мм/ч.
Общий анализ мочи: относительная плотность - 1,006, белок – 0,66 г/л, эритроциты - 3-5 в поле зрения, лейкоциты - 3-4 в поле зрения.
Креатинин сыворотки крови - 1160 мкмоль/л. Калий крови - 7,0 ммоль/л.
Размеры почек при УЗИ: правая – 8,0×3,5 см, левая – 8,2×3,8 см, корковый слой почек подчеркнут и истончён.

Задание
1. Поставьте наиболее вероятный диагноз.
2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?
3. Какое лечение следует назначить данному больному?
4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?
5. Какие симптомы и признаки являются характерными для финальной стадии данного заболевания?

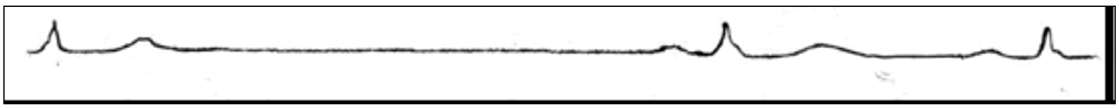
Задача № 15

Больная 38 лет, инженер, обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на повторные приступы сердцебиения, возникающие без всяких причин, без какой-либо связи с движением, волнениями, приёмом пищи, сопровождающиеся стеснением в груди, нехваткой воздуха, дрожанием всего тела. Приступы купируются самостоятельно.
После купирования одного из приступов сердцебиения была кратковременная потеря сознания.
Вне приступа беспокоит слабость, быстрая утомляемость, головокружение.
Больной считает себя в течение года. Началось все с недомогания, длительного субфебрилитета, артралгий, перебоев в работе сердца. Ставился диагноз миокардита, лечилась в стационаре. При выписке врачи рекомендовали принимать препараты белладонны, т. к. была постоянная наклонность к брадикардии - частота пульса была в пределах 50-55 в минуту.
Три месяца назад возник первый приступ сердцебиения, затем он повторился через три недели, а в последнее время приступы бывают по 3-4 раза в неделю.
ЭКГ картина во время приступа:



Анамнез жизни: в прошлом практически здорова, серьезных заболеваний не было, всегда была физически активна, ходила на лыжах, посещала бассейн.
Гинекологический анамнез без особенностей, роды 1 без осложнений.
Объективно: в момент осмотра состояние больной удовлетворительное.
Пульс - 48 в минуту, неритмичный (5-7 выпадений, или пауз, в минуту). АД - 130/70 мм рт. ст.

Границы относительной сердечной тупости в V межреберье по срединно-ключичной линии.
В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет.
Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень не увеличена. Отёков нет.
На ЭКГ сразу после осмотра больной:



Задание

1. Ваш предположительный основной диагноз.
2. Критерии основного диагноза
3. С какими состояниями следует проводить дифференциальный диагноз?
4. Укажите дополнительные методы обследования с целью уточнения диагноза.
5. Лечебная тактика.

Задача № 16

Больной 52 лет, 3-й день после операции аппендэктомии. При попытке подняться с постели внезапно появилась одышка, сухой кашель, давящая боль по всей передней поверхности грудной клетки, резкая общая слабость, через сутки присоединилось кровохаркание.
Объективно: состояние средней тяжести, цианоз, набухание шейных вен. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движений – 36 в минуту.
Тоны сердца приглушены, ритм правильный, акцент 2 тона на лёгочной артерии. АД – 88/60 мм рт. ст.
ЭКГ: отклонение электрической оси сердца вправо, глубокий зубец S в I отведении, зубец Q в III отведении, глубиной 1/3 зубца R и продолжительностью 0,02 секунды.
Депрессия сегмента ST и отрицательный зубец T в V1–V3 отведениях, высокие зубцы P в стандартных отведениях.

Задание

1. Поставьте наиболее вероятный диагноз.
2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?
3. Какое лечение следует назначить данному больному?
4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?
5. Какие симптомы являются характерными для данного заболевания?

Задача № 17

Мужчина 35 лет, инженер-электрик, жалуется участковому терапевту на выраженную слабость, одышку, сердцебиение при подъеме до 2-го этажа, потливость по ночам, появление синяков по всему телу, частые носовые кровотечения без видимой причины, десневые кровотечения при гигиене полости рта, ощущение тяжести в правом подреберье. Считает себя больным около месяца. Существенное ухудшение самочувствия в течение последней недели.
Ежегодно проходит профосмотры; последний – 4 месяца назад, патологии не выявлено. Хронические заболевания отрицает.
При осмотре: температура тела 38,1°С. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, влажные, множественные экхимозы различной локализации разной стадии «цветения». Отё-

ков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Над лёгкими ясный лёгочный звук, везикулярное дыхание, хрипов нет. АД - 110/70 мм рт. ст. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ритмичные, ясные, 98 в минуту, мягкий систолический дующий шум на верхушке.
Живот мягкий, безболезненный. Нижний край печени пальпируется на уровне пупка, плотный, ровный, умеренно болезненный; поверхность печени ровная, плотная. В левом подреберье пальпируется нижний полюс селезёнки на 3 см ниже края рёберной дуги, плотный, ровный, умеренно болезненный. Почки не пальпируются.
Общий анализ крови: гемоглобин - 76 г/л, эритроциты - $2{,}9\times10^{12}$/л, ЦП – 0,79, тромбоциты – 21×10^{9}/л, лейкоциты - 35×10^{9}/л, бласты – 21%, эозинофилы - 0%, палочкоядерные нейтрофилы - 0%, сегментоядерные нейтрофилы - 79%, лимфоциты - 0%, моноциты - 0%; СОЭ - 76 мм/ч.
Общий анализ мочи: жёлтая, прозрачная, pH – кислая, удельный вес – 1016; белок, сахар – нет, лейкоциты – 1-2 в поле зрения, эпителий – 2 в поле зрения, эритроциты, цилиндры, соли – нет.
Биохимический анализ крови: билирубин общий – 48,8 мкмоль/л, креатинин – 89 мкмоль/л, глюкоза – 4,3 ммоль/л, общий холестерол – 5,9 ммоль/л, калий – 3,9 ммоль/л, общий белок – 76 г/л,
Коагулограмма: АЧТВ - 50 с (норма - 32-42 с), ПТИ – 105%, фибриноген – 6 г/л.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз.

Задача № 18

Больная 65 лет, пенсионерка, обратилась в поликлинику с жалобами на общую слабость, утомляемость, сердцебиения, одышку при физической нагрузке, тошноту, отрыжку, тяжесть в эпигастрии. Признаки желудочной диспепсии около 15 лет. В последние полгода появились слабость, сердцебиения, одышка при нагрузке, онемение нижних конечностей. К врачам не обращалась.
Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, лёгкая желтушность кожи и склер лимонного оттенка. Лицо одутловато. Рост - 160 см, масса тела – 68 кг. В лёгких везикулярное дыхание. Границы сердца смещены влево на 1 см, тоны немного приглушены, ЧСС - 90 в минуту, АД - 130/80 мм рт. ст. Язык малинового цвета, сосочки сглажены. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает на 1 см из-под края рёберной дуги, селезёнка не увеличена.
Клинический анализ крови: гемоглобин – 72 г/л, эритроциты – $1{,}6\times10^{12}$/л, ЦП – 1,35, ретикулоциты – 0,1%, тромбоциты – 90×10^{9}/л, лейкоциты – $3{,}8\times10^{9}$/л, лейкоцитарная формула без особенностей, СОЭ – 30 мм/час, MCV – 110 фл. В мазке крови обнаружены гиперсегментированные нейтрофилы, тельца Жолли и кольца Кебота.

Задание
1. Какой наиболее вероятный диагноз у данной больной?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Укажите вероятные причины данного заболевания.

Задача № 19

Больная 28 лет при обращении в поликлинику предъявляет жалобы на утомляемость, общую слабость, эпизоды головокружения, сердцебиение и одышку при физической нагрузке.
Из анамнеза: сухость кожи и ломкость ногтей отмечает в течение нескольких лет. Слабость, головокружения появились год тому назад во время беременности. Месячные с 13 лет, обильные первые 3–4 дня, по 5–6 дней, регулярные. В настоящее время осуществляет грудное вскармливание ребенка.
Объективно: состояние средней тяжести. Бледность и сухость кожных покровов; ногти с поперечной исчерченностью, слоятся. Волосы ломкие. Тоны сердца ритмичные, ЧСС - 90 ударов в минуту, АД - 110/70 мм рт. ст. В лёгких везикулярное дыхание. Печень и селезёнка не увеличены.
Клинический анализ крови: гемоглобин – 75 г/л, эритроциты – $3{,}3\times10^{12}$/л, лейкоцитарная формула - без особенностей, СОЭ – 12 мм/час, MCV – 70 фл (норма 80-100 фл), MCH – 21,0 пг (норма 24-34 пг), анизоцитоз, пойкилоцитоз. Железо сыворотки – 6 мкмоль/л.

Задание

1. Какой наиболее вероятный диагноз у данной больной?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациентки.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Какие рекомендации необходимо дать пациентке для дальнейшей профилактики заболевания?

Задача № 20

Больной 38 лет обратился в поликлинику с жалобами на ночные боли в эпигастральной области, утомляемость, головокружения, сердцебиение при физической нагрузке.
Из анамнеза: с 17-летнего возраста болеет язвенной болезнью 12-перстной кишки, по поводу которой дважды проводилось стационарное лечение. В течение последних 3 месяцев наблюдались эпизоды ухудшения самочувствия, слабость, головокружения, периодически тёмная окраска стула.
Объективно: общее состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы и слизистые бледноватой окраски. В лёгких везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, ЧСС - 80 ударов в минуту, АД - 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной области. Печень и селезёнка не увеличены.
Клинический анализ крови: гемоглобин – 73 г/л, эритроциты – $3{,}2\times10^{12}$/л, ЦП – 0,68, ретикулоциты – 1%, лейкоцитарная формула - без особенностей, СОЭ – 10 мм/час, MCV – 70 фл., железо сыворотки – 7 мкмоль/л. ОЖСС – 115 мкмоль/л/
Заключение ФГДС: Язва на передней стенке луковицы 12-перстной кишки диаметром 0,8 см. F III тип.

Задание
1. Какой наиболее вероятный диагноз у данного больного?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Показания к исследованию костного мозга.

Задача № 21

Больная 42 лет, домохозяйка, обратилась к врачу-терапевту участковому со следующими жалобами: в течение нескольких лет периодически отмечала общую слабость, немотивированный подъём температуры до субфебрильных цифр. Месяц назад после ОРЗ появилась умеренная болезненность и припухлость II и III пястно-фаланговых суставов, II, III, IV проксимальных межфаланговых суставов обеих кистей, лучезапястных суставов; утренняя скованность в течение 3 часов. Суставной синдром сопровождался повышением температуры тела до 37,3°С. Домашнюю работу выполняет с трудом.

Объективно: кожные покровы обычной окраски, чистые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Левая граница относительной сердечной тупости по срединно-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные. АД - 130/80 мм рт. ст. Отмечается дефигурация вышеперечисленных суставов за счёт экссудативно-пролиферативных явлений, разлитая болезненность, активные и пассивные движения ограничены, болезненны.

Общий анализ крови: лейкоциты - $9{,}0\times10^9$/л, СОЭ - 35 мм/час.

Ревматоидный фактор (РФ) – 1:80.

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) – 375,8 Ед/мл.

Рентгенограмма суставов кистей: обнаружен околосуставной остеопороз, сужение суставной щели, единичные узуры

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.

4. Какой будет тактика лечения данного заболевания?

5. Какой базисный препарат целесообразно назначить в данном случае и почему?

Задача № 22

Больной Ю. 53 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на слабость, боли по всему позвоночнику (преимущественно ночью), в обоих тазобедренных, коленных суставах, утреннюю скованность до 40 минут, проходящую после физических упражнений.

Анамнез: болеет с 35 лет, вначале появились боли в пояснице и крестце (особенно ночью), позже присоединилась утренняя скованность, проходящая после непродолжительной зарядки, повышение температуры до 37-37,5°С.

Объективно: состояние удовлетворительное, положение активное. АД - 150/100 мм рт. ст. ЧСС - 74 удара в минуту. ЧДД - 18 в минуту. Температура тела 37,3°С.

Отмечается выраженный грудной кифоз и шейный гиперлордоз, сглаженность поясничного лордоза, болезненность при пальпации по ходу позвоночника, околопозвоночным линиям и тазобедренных суставов. Активные и пассивные движения вызывают боль.

Пробы: симптом Кушелевского I, II - положительный, проба Томайера – 65 см, Форестье - 22 см, проба подбородок-грудина – 5 см, экскурсия грудной клетки - 100-96 см (4 см).

Рентгенограмма позвоночника и илеосакральных сочленениях: Деформирующий спондилёз, двусторонний сакроилеит, стадия 3.

Общий анализ крови: эритроциты - $4{,}2\times10^{12}$/л, Hb - 122 г/л, тромбоциты - 220×10^9/л, лейкоциты - 10×10^9/л, палочкоядерные нейтрофилы – 1%, сегментоядерные нейтрофилы – 63%, моноциты – 4%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 30%, СОЭ – 18 мм/ч.

Иммунологические тесты: С-реактивный белок – 5 мг/л, ревматоидный фактор – отрицательный.

Общий анализ мочи – норма.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Какой будет Ваша тактика лечения данного заболевания?
5. Каким препаратам следует отдать предпочтение при наличии у пациента внеаксиальных проявлений заболевания?

Задача № 23

Больной 64 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на припухание и боль в правом голеностопном суставе и мелких суставах правой стопы, покраснение кожи над ними, ограничение движений в них.

Анамнез: страдает внезапными приступами болей в суставах правой стопы около 8 лет, когда впервые на фоне относительного благополучия ночью появились интенсивные боли в первом пальце правой стопы. В последующем артрит неоднократно рецидивировал. Боль в области правого голеностопного сустава присоединилась в течение последних 6 месяцев. Неоднократно безболезненно с мочой отходили конкременты желтовато-бурового цвета размером до 3–4 мм.

Объективно: телосложение правильное, повышенного питания. В области хрящевой части ушных раковин пальпируются безболезненные плотные образования величиной 0,3 0,2 см, белесоватые на изгибе. Отмечаются костные деформации в области 1-го и 2-го плюснефаланговых суставов правой стопы, сочетающиеся с припухлостью, покраснением кожи и повышением местной температуры над этими же суставами. Правый голеностопный сустав припухший, болезненный при пальпации. Кожа над суставом блестит, синевато- багрового цвета, горячая. АД - 170/105 мм рт. ст. ЧСС - 84 удара в минуту.

Границы относительной сердечной тупости расширены влево на 2 см от срединно-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, приглушены.

Мочевая кислота - 780 мкмоль/л, холестерол крови - 6,7 ммоль/л, триацилглицеролы – 2,7 ммоль/л, ЛПВП – 1,0 ммоль/л; глюкоза натощак – 6,2 ммоль/л, через 2 часа после приема 75 г глюкозы – 6,4 ммоль/л.

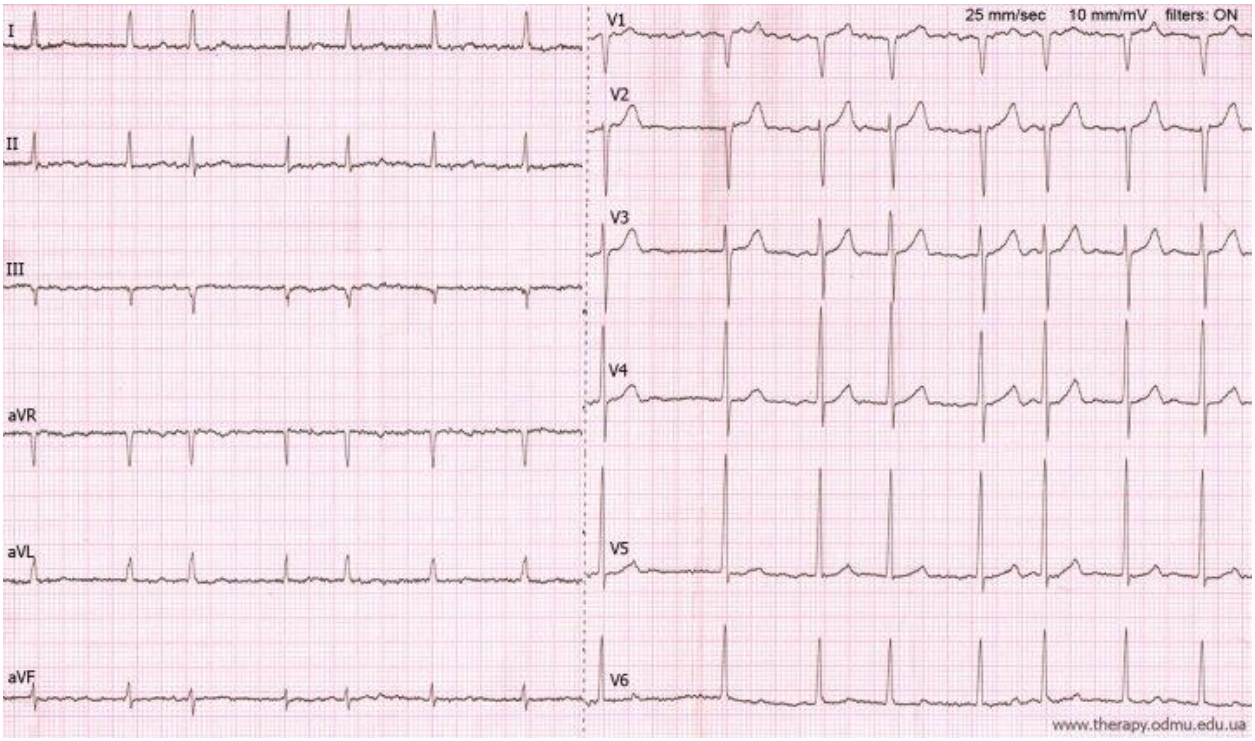
Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Какой будет Ваша тактика лечения в период острого приступа и в межприступный период?
5. Каким препаратам следует отдать предпочтение для коррекции артериальной гипертензии и гиперхолестеролемии и почему?

Задача № 24

Мужчина 39 лет на приеме у врача-терапевта участкового предъявляет жалобы на одышку, сердцебиение, кашель. Небольшую одышку и периодические сердцебиения отмечает в течение 5 лет. Около недели назад заболел ангиной с появлением высокой температуры, кашля. В ночь перед обращением к врачу не мог спать из-за выраженной одышки, усиливающейся в горизонтальном положении. В подростковом возрасте были частые ангины, на фоне которых беспокоили боли в крупных суставах. Наблюдался у невропатолога по поводу хореи.

Объективно: Состояние средней степени тяжести. Температура тела - 37,4°С. Ортопноэ, акроцианоз, отёки нижних конечностей. ЧДД - 28 в минуту. В нижних отделах лёгких мелкопузырчатые хрипы. Приподнимающий верхушечный толчок. При перкуссии сердце увеличено влево и вправо. При аускультации сердца – аритмия с отсутствием периодов правильного ритма, ЧСС 110 в минуту. На верхушке трёхчленная мелодия с низким глухим дополнительным компонентом, систолический и протодиастолический шумы. Систолический шум на верхушке усиливается на выдохе, проводится в аксиллярную область, акцент II тона на лёгочной артерии. Трёхчленная мелодия выслушивается и в точке Боткина. Пульс слабого наполнения, аритмичен, 96 в минуту. Артериальное давление - 100/60 мм рт. ст. Печень увеличена, слегка болезненна при пальпации.
Параклиническое обследование:
Общий анализ крови: СОЭ - 32 мм/час, лейкоциты – $11,3x10^9$/л.
Биохимическое исследование крови: С – реактивный белок (++++). ДФА – 0,500 (N до 0.200).
ЭКГ:



Задание
1. Ваш предположительный диагноз.
2. Критерии основного диагноза.
3. Какие осложнения основного заболевания Вы предполагаете?
4. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
5. Лечебная тактика, выбор препаратов.

Задача № 25
Женщина 65 лет, пенсионер, обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на боли в коленных, тазобедренных, дистальных межфаланговых суставах кистей, в поясничном отделе позвоночника, возникающие при нагрузке и движениях, больше к вечеру, затихающие в покое; утреннюю скованность до 20 минут. Не может точно определить давность заболевания. Отмечает постепенное, в течение 5-7 лет, нарастание вышеописанных болей в перечисленных суставах и поясничном отделе позвоночника. Ранее не обследовалась, не лечилась. Последние 20 лет пациентка работает уборщицей в школе (продолжает работать и на пенсии), отмечает частые интенсивные физические нагрузки.

При осмотре: рост - 160 см, вес - 80 кг. Кожные покровы телесного цвета, повышенной влажности. Отёков нет. Коленные суставы деформированы, кожные покровы над ними обычной окраски, местная температура не изменена, небольшое ограничение подвижности за счет болезненности, при активных движениях в коленных суставах слышен хруст. Отмечается болезненность при пальпации и ограничение подвижности дистальных межфаланговых суставов; их внешний вид представлен ниже. Остальные суставы не изменены. Болезненна пальпация остистых и поперечных отростков поясничного отдела позвоночника, движения в этом отделе ограничены из-за болезненности.
Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения, 78 в минуту.
АД - 135/80 мм рт. ст., границы относительной сердечной тупости в пределах нормы.
Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный.
Общий анализ крови: гемоглобин - 130 г/л, лейкоциты - $6{,}7\times10^9$/л, эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы – 4%, сегментоядерные – 57%, лимфоциты – 30%, моноциты - 6%, СОЭ - 20 мм/ч.
Рентгенография коленных суставов: сужение суставных щелей, субхондральный склероз, краевые остеофиты.
Рентгенография кистей: многочисленные остеофиты дистальных межфаланговых суставов, умеренно выраженное сужение суставных щелей, остеосклероз.

Задание
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз и трудоспособность пациента.

Задача № 26
Женщина 25 лет, учитель, предъявляет жалобы на затруднение вдоха при ходьбе, подъеме на 2-й этаж, сухой кашель, повышение температуры до 38,6°С, сердцебиение, слабость. Два года назад, после ангины, возникли колющие боли в области верхушки сердца без связи с физической нагрузкой, различной длительности и интенсивности; появились летучие боли в коленных и плечевых суставах. За медицинской помощью не обращалась. Ухудшение 3 недели, лечилась амбулаторно по поводу ОРВИ (принимала Парацетамол). Несмотря на проводимое лечение, сохранялись слабость, кашель, колебания температуры в течение суток.
При осмотре: кожа и видимые слизистые бледные, чистые, цианоз губ, кончика носа, цианотический румянец. Отёков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, влажные незвучные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах. Пульс малый, ослаблен на левой лучевой артерии, 90 в минуту. АД - 110/70 мм рт. ст. Границы относительной сердечной тупости: правая - 2 см вправо от правого края грудины, верхняя – нижний край II ребра, левая – на 0,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, трёхчленный ритм, на верхушке сердца – хлопающий I тон, диастолический шум, во втором межреберье слева от грудины – акцент II тона, над мечевидным отростком – ослабление I тона.
Живот симметричный, мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.
Общий анализ крови: гемоглобин - 130 г/л, эритроциты - $4{,}2\times10^{12}$/л, лейкоциты –$12{,}1\times10^9$/л, эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы - 8%, сегментоядерные нейтрофилы - 53%, лимфоциты - 30%, моноциты - 6%, СОЭ - 37 мм/час.
Общий анализ мочи: относительная плотность - 1019, белок – нет, лейкоциты – 3-4, эпителий

- 1-2 в поле зрения.
Биохимический анализ крови: фибриноген - 6,2 г/л, общий белок – 57 г/л, альбумины – 34%, глобулины: α1 – 6%, α2 – 14%, β – 18%, γ – 28%, СРБ – 7,5 мг/л (N - 1-6 мг/л).

Задание
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз и трудоспособность пациента.

Задача № 27
Женщина 35 лет, бухгалтер, обратилась к врачу-терапевту участковому с жалобами на общее недомогание, слабость, похудание на 5 кг за 3 месяца, мигрирующие боли в межфаланговых суставах кистей и голеностопных суставах, красные пятна неправильной формы на лице, субфебрильную температуру тела. Считает себя больной около 6 месяцев. Начало заболевания постепенное. Появились боли в межфаланговых суставах, их припухлость и гиперемия, поочерёдно на правой и левой кисти. Постепенно присоединились слабость, недомогание. За медицинской помощью не обращалась. 2 месяца назад (июль) - отдых в Таиланде. После возвращения отметила ухудшение самочувствия: усилилась слабость, присоединились боли в голеностопных суставах, стала худеть без видимой причины, повысилась температура тела до 37,5°С, без ознобов. Отметила наличие красных пятен на лице, долгое время считала их последствиями загара. Во время очередного планового медосмотра выявлены анемия и изменения в моче, в связи с чем обратилась к участковому терапевту.
При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые бледные, «сосудистая бабочка» в области переносицы и щек неправильной формы, волосы тусклые, ломкие, имеются участки облысения. Подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Отеков нет. Пальпируются подчелюстные, подмышечные, паховые лимфоузлы 0,5-1 см в диаметре, мягкой консистенции, безболезненные при пальпации. Тонус и сила мышц в норме, одинаковые с обеих сторон. Части скелета пропорциональны, кости при пальпации и поколачивании безболезненны. Отмечается припухлость проксимальных и дистальных межфаланговых суставов кистей и голеностопных суставов, болезненность при движениях в них, местная гиперемия. Грудная клетка нормостеническая, симметричная, равномерно участвует в дыхании. Перкуторно над лёгкими ясный лёгочный звук. Дыхание везикулярное, хрипов нет.
Пульс ритмичный, 78 в минуту, АД - 120/80 мм рт. ст. Верхушечный толчок визуально и пальпаторно не определяется. Границы относительной сердечной тупости: правая - на 0,5 см от правого края грудины, верхняя - нижний край III ребра, левая - на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии.
Аускультативно: тоны глухие, ритмичные, ЧСС - 78 в минуту. Отёчность и гиперемия красной каймы губ. Живот симметричный, мягкий, безболезненный во всех отделах при поверхностной и глубокой пальпации. Печень не увеличена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, пальпация в их проекции безболезненна.
Общий анализ крови: гемоглобин - 100 г/л, эритроциты - $2,9\times10^{12}$/л, ЦП - 0,9; лейкоциты - $2,7\times10^{9}$/л, эозинофилы - 4%, палочкоядерные нейтрофилы - 3%, сегментоядерные - 52%, лимфоциты - 35%, моноциты - 6%; СОЭ - 30 мм/ч, тромбоциты - - 98×10%.
Общий анализ мочи: светло-жёлтая, прозрачная, pH - кислая, удельный вес – 1016, белок - 0,3 г/л, сахар - нет, лейкоциты - 1-2 в поле зрения, эпителий почечный - 2-4 в поле зрения, эритроциты - 3-4 в поле зрения, цилиндры гиалиновые - 5-8 в поле зрения, цилиндры восковидные - 2-3 в поле зрения, соли - нет.
Биохимическое исследование крови: билирубин общий - 38,8 мкмоль/л, прямой - 8,2 мкмоль/л, непрямой - 30,6 мкмоль/л, креатинин – 90 мкмоль/л, глюкоза - 4,3 ммоль/л, АСТ - 10,0 ммоль/л,

АЛТ - 19,0 ммоль/л, холестерол - 4,0 ммоль/л, калий - 3,9 ммоль/л, общий белок - 86 г/л, альбумины - 45%, α1 - 3,5%, α2 – 10,5%, β - 13,6%, γ - 27,4%, фибриноген - 6,2 г/л, СРБ - + + +, серомукоид - 0,32 г/л.
Обнаружены антитела к ДНК, антинуклеарный фактор, LE-клеток - 6 на 1000 лейкоцитов.
ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС - 64 удара в минуту. Электрическая ось отклонена влево. Диффузные дистрофические изменения миокарда левого желудочка.
Рентгенография органов грудной клетки: без патологии.
Рентгенография суставов кистей и голеностопных суставов: патологических изменений не выявлено.

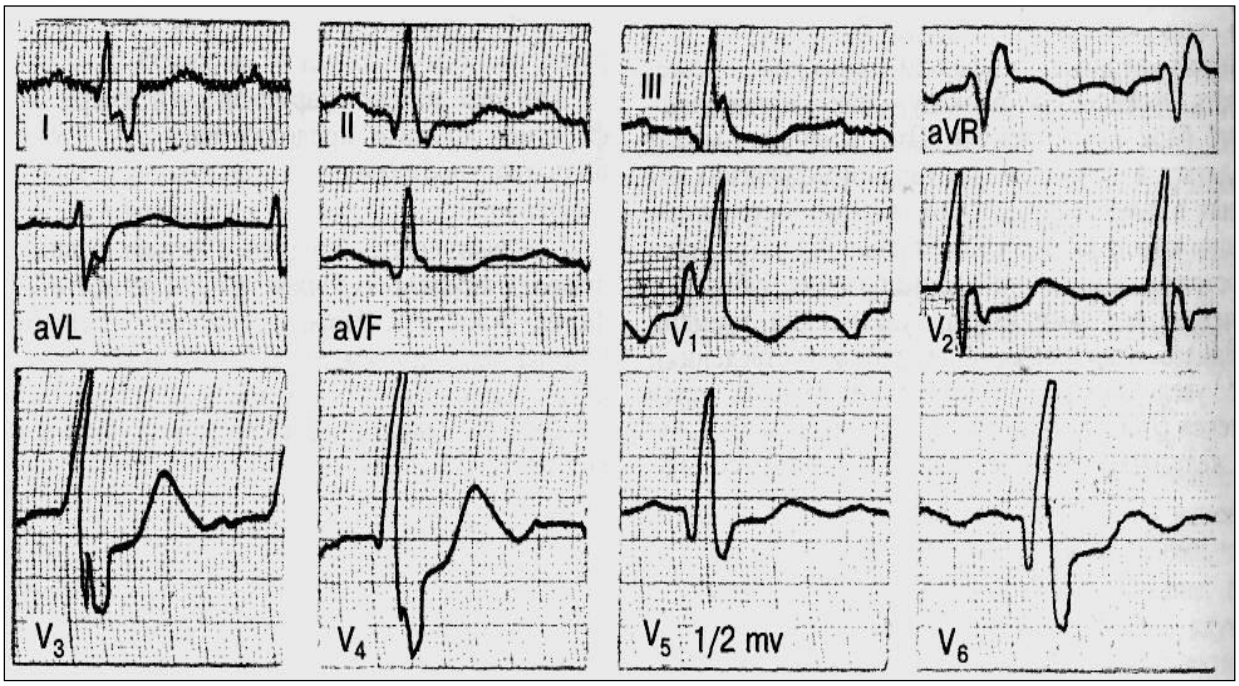
Задание
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз и трудоспособность пациента.

Задача № 28
Женщина 44 лет, программист, поступила в терапевтическое отделение с жалобами на нарастающую общую слабость, боль, ограничение движений и онемение, преимущественно пальцев, в обеих кистях, незначительный сухой кашель, сердцебиение при физической нагрузке, снижение аппетита, сухость во рту, затруднение жевания и глотания.
Считает себя больной с 32 лет: после сильного переохлаждения впервые стала отмечать онемение пальцев обеих рук при мытье их холодной водой, постепенно продолжительность онемения увеличивалась, оно стало возникать при незначительном понижении температуры воздуха. Одновременно появилась повышенная потливость обеих ладоней. Постепенно в течение 6 месяцев присоединилась общая слабость, снижение аппетита, в связи с чем больная обратилась в поликлинику по месту жительства. Было сделано исследование общего анализа крови, рентгенография органов грудной клетки, ФГДС, однако причина астенизации не была выявлена. Онемение пальцев рук сохранялось, постепенно появились ограничение подвижности пальцев и боли в ногтевых фалангах кистей.
При повторном осмотре через год был выставлен диагноз ревматоидного артрита, и больной назначили Преднизолон по 20 мг/сут, с помощью которого боли были купированы, но онемение кистей рук сохранялось, и больная самостоятельно прекратила принимать Преднизолон. В 42 года после инсоляции больная стала отмечать затруднение глотания, присоединение сухого кашля и сердцебиения при ходьбе. В последние 6 месяцев резко усилились боли в ногтевых фалангах при попытке работы на клавиатуре компьютера.
При осмотре: кожные покровы равномерно гиперпигментированы. Кожа кистей и пальцев рук холодная, уплотнена, равномерно утолщена, не берётся в складку, морщины над межфаланговыми суставами отсутствуют. Ногтевые фаланги всех пальцев укорочены. Мышцы плечевого и тазового пояса атрофичны, предплечий – уплотнены, ригидны. Объём пассивных и активных движений в межфаланговых суставах резко снижен. Дыхание поверхностное, 24 в минуту. Выявлено уменьшение экскурсии лёгких и симметричное ослабление везикулярного дыхания в нижних отделах. АД - 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца неритмичные, 88 в минуту, единичные экстрасистолы; I тон над верхушкой и основанием мечевидного отростка ослаблен. Живот мягкий, безболезненный как при поверхностной, так и при глубокой пальпации.
Общий анализ крови: эритроциты - $3{,}1\times10^{12}$/л, гемоглобин - 95 г/л, ЦП - 0,85; лейкоциты - $15{,}3\times10^{9}$/л; эозинофилы – 2%, палочкоядерные нейтрофилы – 8%, сегментоядерные нейтрофилы – 72%, лимфоциты – 17%, моноциты – 1%; СОЭ - 27 мм/ч.
Биохимический анализ крови: общий белок - 75 г/л; альбумины - 40%, глобулины - 60%, 1 - 3,8%, 2 – 12%; – 12%; – 32,2%; фибриноген – 6,6 г/л; СРБ (++).

Повторные исследования LE клеток в крови отрицательны.
Рентгенография органов грудной клетки: «сотовое» лёгкое, явления пневмосклероза, преимущественно в нижних отделах.
Рентгенография кистей: остеолиз дистальных фаланг, эпифизарный остеопороз.

Приложение:

ЭКГ:



Лицо больной



Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациентки.
4. Определите тактику лечения данной больной. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз болезни и трудоспособность пациентки.

Задача № 29

Больной 44 лет жалуется на боль в левом подреберье с иррадиацией в левую надключичную область, усиливающуюся при глубоком дыхании, тошноту, рвоту с примесью желчи, кашель с мокротой. Около 6 часов назад появился озноб. Затем боль в левом подреберье, рвота съеденной пищей.

Вызванной бригадой скорой медицинской помощи диагностирован острый гастрит, введены анальгетики и спазмолитики. После некоторого облегчения боли возобновились (2 часа назад), была повторная рвота.

При осмотре врачом вновь вызванной скорой медицинской помощи больной лежит на левом боку. Состояние средней тяжести, слева над проекцией нижней доли определяется крепитация, частота дыхательных движений (ЧДД) – 26 в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены. Ритм правильный, 96 в минуту.

Живот мягкий, при пальпации болезненный в эпигастрии.

Температура тела 39,4 °С.

На ЭКГ: ритм синусовый, нормальное положение электрической оси сердца.

При рентгенографии – затемнение над диафрагмой и в нижней доле слева.

Задание

1. Поставьте наиболее вероятный диагноз.
2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?
3. Какое лечение следует назначить данному больному?
4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?
5. Какие симптомы являются обязательными для данного заболевания?

Задача № 30

Женщина 45 лет, продавец, обратилась в поликлинику с жалобами на приступы удушья и одышку после физической нагрузки и спонтанные ночью, на дискомфорт в груди. Впервые заболела после тяжёлой пневмонии 11 лет назад. Затем приступы повторялись после физической нагрузки и во время простудных заболеваний. Приступы удушья снимала ингаляцией Сальбутамола (3-4 раза в сутки).

В анамнезе: внебольничная 2-сторонняя бронхопневмония, острый аппендицит. Наличие аллергических заболеваний у себя и родственников отрицает. Гемотрансфузий не было. Вредных привычек нет.

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Кожа и слизистые чистые, физиологической окраски. Язык влажный. Лимфоузлы не увеличены. В лёгких: перкуторно – коробочный звук, аускультативно – дыхание жёсткое, сухие хрипы по всем лёгочным полям, свистящие при форсированном выдохе. Частота дыхательных движений – 18 в минуту.

Границы сердца не изменены. Тоны сердца приглушены, ритмичны. АД - 140/90 мм рт. ст.

Пульс – 69 в минуту, хорошего наполнения и напряжения.

Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезёнка не пальпируются. Физиологические отправления не нарушены.
Анализ крови: гемоглобин – 126 г/л, эритроциты – $3,9\times10^{12}$/л, лейкоциты - $9,5\times10^{9}$/л, палочкоядерные нейтрофилы – 3%, сегментоядерные нейтрофилы – 63%, эозинофилы – 5%, моноциты – 6%, лимфоциты – 13%; СОЭ - 19 мм/ч.
Биохимический анализ крови: общий билирубин - 5,3 мкм/л; общий белок - 82 г/л, мочевина - 4,7 ммоль/л.
Анализ мочи: удельный вес - 1028, белок - отриц., эпителий - 1-3 в поле зрения.
Анализ мокроты: слизистая, без запаха. При микроскопии: лейкоциты - 5-6 в поле зрения, эозинофилы - 10-12 в поле зрения, клетки эпителия бронхов, ед. альвеолярные макрофаги. ВК - отриц. (3-кратно).
Рентгенография грудной клетки: повышена прозрачность лёгочных полей, уплощение и низкое стояние диафрагмы. Лёгочный рисунок усилен. Корни лёгких увеличены, тень усилена. Тень сердца увеличена в поперечнике.

Задание
1. Выскажите предполагаемый предварительный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования.
4. Дифференциальный диагноз.
5. План лечения (назовите необходимые группы лекарственных препаратов).

Задача № 31
Мужчина 23 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на приступы удушья, возникающие 1-2 раза в месяц, с затруднённым выдохом, сопровождающиеся свистящими хрипами и тяжестью в груди, приступообразным кашлем с трудноотделяемой мокротой.
В последнее время приступы участились до 2-х раз в неделю, возникают и ночью.
Из анамнеза известно, что приступы появились около года назад, отмечаются в течение всего года, появляются при контакте с домашней пылью, пыльцой растений, шерстью животных, резких запахах, прекращаются самостоятельно или после приёма таблетки Эуфиллина.
У бабушки больного также были подобные приступы удушья. В течение трёх лет в мае-июне отмечает слезотечение, заложенность носа, чихание.
Состояние пациента удовлетворительное, частота дыхания – 24 в мин. Кожные покровы чистые, обычной окраски. При аускультации выслушивается большое количество сухих свистящих рассеянных хрипов на выдохе.
Тоны сердца ритмичные, ясные, 90 ударов в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст.
Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и селезёнка не увеличены. Дизурии нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон.
В анализах крови: лейкоциты – $6,0\times10^{9}$/л; сегментоядерные нейтрофилы – 63%; лимфоциты – 23%; эозинофилы – 10%; моноциты – 4%, СОЭ – 10 мм/ч.
Общий анализ мокроты: консистенция вязкая, характер слизистый, лейкоциты – 1-5 в п./зр., эозинофилы – 20-30 в п./зр., спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена.
IgE сыворотки крови повышен в 3 раза.
Спирометрия: прирост ОФВ1 после ингаляции Сальбутамола – 25%.
Рентгенография органов грудной клетки: очаговых или инфильтративных теней не выявлено.

Задание
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Назовите группы лекарственных препаратов, которые Вы бы рекомендовали пациенту в настоящее время. Обоснуйте свой выбор.
5. Через неделю после старта терапии пациент вновь пришел на приём к врачу. Жалоб не предъявляет, приступы прекратились. В лёгких при объективном обследовании хрипы не выслушиваются. Выберите дальнейшую тактику лечения больного и объясните Ваш выбор.

Задача № 32

Мужчина 47 лет доставлен в приёмное отделение с жалобами на повышение температуры тела до 38,5°С градусов, кашель с трудноотделяемой мокротой «ржавого» цвета, боли в правой половине грудной клетки, усиливающиеся при кашле, чувство нехватки воздуха, головокружение.

Из анамнеза известно, что пациент заболел 3 дня назад – после переохлаждения повысилась температура тела, появился кашель. Лечился самостоятельно (Аспирин, Парацетамол), но состояние ухудшалось: появились вышеперечисленные жалобы.

Бригадой скорой помощи доставлен в стационар.

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, цианоз губ, кончиков пальцев. Правая половина грудной клетки отстаёт при дыхании. Притупление перкуторного звука, усиление бронхофонии в IV-V межреберье по срединно-ключичной линии справа.

При аускультации в том же отделе дыхание бронхиальное, крепитация.

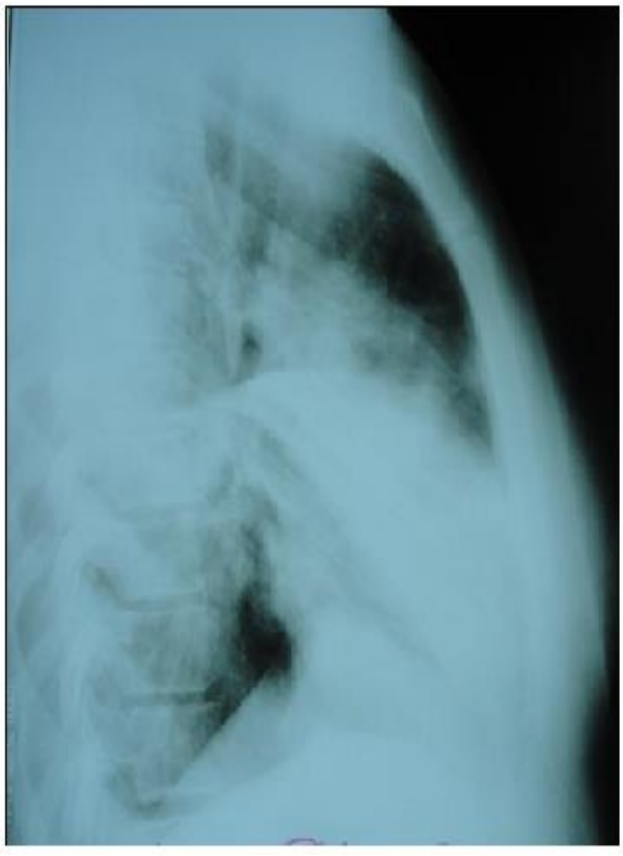
Тоны сердца приглушены, учащены. ЧСС – 96 ударов в минуту, АД – 85/50 мм рт. ст. Сатурация – 80%.

Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах.

В общем анализе крови: лейкоциты – 22×10^9/л, юные формы – 10%, палочкоядерные нейтрофилы – 23%, сегментоядерные нейтрофилы – 30%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 30%, моноциты – 5%. СРБ – 125 мг/л.

Выполнена рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях.





Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова тактика лечения данного пациента, назовите препараты «стартовой» терапии и препараты резерва?
5. Какова тактика диспансерного наблюдения пациента после выписка из стационара?

Задача № 33

Больная 60 лет поступила в клинику с жалобами на одышку, боли в левой половине грудной клетки при кашле и дыхании, кровохарканье, повышение температуры до 38°С, слабость. Заболела остро 2 дня назад, когда внезапно возник приступ удушья, сопровождающийся болями в левой половине грудной клетки, сердцебиением; была кратковременная потеря сознания.

Врачом неотложной помощи была предложена госпитализация, от которой больная отказалась. Сегодня приступ одышки повторился, появилось кровохарканье; больная госпитализирована.

Состояние больной тяжёлое, кожные покровы бледно-цианотичные. Наблюдаются отёки нижних конечностей, больше левой, варикозное расширение вен, гиперемия кожи левой голени с цианотичным оттенком. Частота дыханий - 26 в минуту.

Пульс - 110 в минуту, ритмичный, малого наполнения.

АД - 90/60 мм рт. ст.; I тон на верхушке сердца ослаблен, акцент II тона над лёгочной артерией.

При перкуссии лёгких определяется притупление лёгочного звука в левой подлопаточной области, здесь же выслушивается шум трения плевры.

На ЭКГ зарегистрировано увеличение зубцов Q в III отведении и S в I отведении, подъем сегмента ST и отрицательный зубец Т в III отведении, блокада правой ножки пучка Гиса.

Задание

1. Какой наиболее вероятный диагноз у данного больного?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Показания и методы хирургического лечения.

Задача № 34

Больной М. 65 лет обратился в поликлинику с жалобами на одышку при небольшой физической нагрузке, периодически малопродуктивный кашель (особенно при переохлаждении, в сырую погоду), ощущение хрипов и тяжести в груди, сердцебиение.

Из анамнеза: курит 30 лет по пачке в день. Одышка появилась 3 года назад и стала прогрессировать за последний год. В течение последнего месяца, после перенесённого ОРЗ, одышка усилилась, мокроты стало выделяться больше, она приобрела жёлто-зелёный цвет. Несколько лет наблюдается с диагнозом «стенокардия II ФК, ХСН I ст., ФК II», 2 года назад перенёс крупноочаговый инфаркт миокарда переднебоковой, в связи с чем постоянно принимает Сталол, Кардиомагнил, Моночинкве (Изосорбида-5-Мононитрат).

Объективно: общее состояние средней тяжести. Больной пониженного питания, грудная

клетка расширена в поперечнике, при перкуссии грудной клетки - лёгочный звук с коробочным оттенком.
При аускультации лёгких - дыхание ослабленное, в нижних отделах лёгких сухие хрипы, выдох удлинен, ЧДД - 24 в минуту, ЧСС - 100 в минуту. АД - 130/80 мм рт. ст.
На ЭКГ: рубцовые изменения на боковой стенке левого желудочка. Единичные желудочковые экстрасистолы.
Спирография: ЖЕЛ - 52%, ОФВ1 - 37%, индекс Тиффно - 57,2.
На рентгенограмме органов грудной клетки - признаки эмфиземы и пневмосклероза лёгких.
Общий анализ мокроты: лейкоциты – до закрытия полей зрения, нейтрофилы - 90%, лимфоциты - 10%.

Задание
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Обоснуйте диагноз. Определите индекс курильщика у больного.
3. Составьте и обоснуйте план дообследования больного.
4. Какая базисная терапия необходима больному в соответствии с его диагнозом?
5. Что бы Вы изменили в базисной терапии ИБС? Обоснуйте почему.

Задача № 35
Больной Б. 35 лет доставлен в клинику машиной скорой помощи с жалобами на чувство стеснения в груди, затруднённое дыхание, особенно выдох, мучительный кашель. Болен 10 лет бронхиальной астмой. До этого – несколько лет наблюдался с диагнозом «хронический бронхит». 5 лет принимал Преднизолон 2 таблетки в сутки и ингаляции Беротека при удушье. Обострения бронхиальной астмы 3-4 раза в год, часто требующие госпитализации в стационар.
Настоящее ухудшение состояния связывает с отменой неделю назад Преднизолона. Аллергоанамнез – спокойный. Приступам удушья предшествует короткий эпизод мучительного кашля, в конце приступа он усиливается, и начинает выделяться в небольшом количестве тягучая слизистая мокрота.
Объективно: состояние тяжёлое, при осмотре кожные покровы больного бледные, с синюшным оттенком. Больной сидит в положении «ортопноэ». Больной повышенного питания (прибавил в весе за 3 года 15 кг). «Кушингоидное лицо», стрии на бёдрах и животе.
Разговаривает отдельными словами, возбуждён. Грудная клетка находится в положении глубокого вдоха. Мышцы брюшного пресса участвуют в акте дыхания. Дыхание резко ослаблено, небольшое количество сухих свистящих хрипов, 32 дыхательных движения в минуту.
Перкуторно над лёгкими коробочный звук по всем лёгочным полям, особенно в нижних отделах. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс - 120 в минуту, ритмичный. АД - 140/90 мм рт. ст., SpO2 - 85%.
В течение суток получил более 15 ингаляций Беротека.
Врачом скорой помощи уже внутривенно введено 10,0 мл 2,4% раствора Эуфиллина, 60 мг Преднизолона.

Задание
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Обоснуйте диагноз. Чем объяснить ухудшение состояния больного?
3. Что показано больному в первую очередь в этой ситуации?
4. Какое дообследование необходимо провести больному при стабилизации состояния?
5. Правильную ли терапию больной получал последние годы? Почему? Какую базисную терапию назначите больному?

Задача № 36

Больной Н. 49 лет поступил с приёма врача-терапевта участкового в терапевтическое отделение с жалобами на повышение температуры тела до 38,2°С с ознобом, одышку, кашель со скудной мокротой, боль в правом боку при глубоком дыхании. Болен в течение 5 дней.

Объективно: состояние средней тяжести, цианоз губ, кожные покровы бледные. Левая половина грудной клетки отстаёт при дыхании, под лопаткой слева укорочение перкуторного звука, там же выслушивается крепитация, частота дыхательных движений (ЧДД) – 25 в мин.

Тоны сердца приглушены, ритмичны, пульс – 100 в мин., АД – 100/70 мм рт. ст.

Живот мягкий, безболезненный, печень и селезёнка не увеличены. Отёков нет.

На рентгенограмме в области нижней доли левого лёгкого выявлена инфильтрация.

В гемограмме: гемоглобин – 126 г/л; лейкоциты – 12 тысяч, палочкоядерные – 11%, сегментоядерные – 46%, СОЭ – 38 мм/час.

Больному был назначен Ампициллин в/м.

На 5 день лечения состояние больного ухудшилось, температура тела повысилась до 40,1°С, появилась обильная гнойная мокрота, наросли признаки интоксикации.

На компьютерной томографии лёгких в нижней доле слева выявлена полость до 1,2 см в диаметре.

Задание

1. Поставьте наиболее вероятный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. Какое лечение следует назначить данному больному?

4. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?

5. Какие симптомы являются обязательными для данного заболевания?

Задача № 37

Мужчина 52 лет, программист, жалуется на постоянную слабость, снижение веса на 5 кг за последние 2 месяца, увеличение лимфатических узлов в области головы, шеи и в подмышечных областях; сердцебиение и одышку смешанного характера при обычной физической нагрузке; ощущение тяжести в области правого подреберья; изжогу и отрыжку преимущественно после еды; снижение аппетита. Появление этих симптомов пациент ни с чем не связывает.

При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые бледные, чистые, суховатые. Отёков нет. Пальпируются затылочные, околоушные, передние и задние шейные, над- и подключичные, подмышечные лимфоузлы, округлые, до 2 см в диаметре, мягко-эластичные, однородные, с гладкой поверхностью, безболезненные, подвижные, не спаянные с кожей и между собой, кожа над ними не изменена.

В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 16 в минуту. Границы относительной сердечной тупости не изменены. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС – 98 в минуту. АД – 120/70 мм рт. ст. Язык влажный, обложен небольшим количеством серого налёта.

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Край печени пальпируется на 3 см ниже края рёберной дуги, плотно-эластичный, ровный, слегка болезненный. Селезёнка не пальпируются.

Общий анализ крови: гемоглобин – 101 г/л, эритроциты – $3{,}0\times10^{12}$/л, ЦП – 1,01, ретикулоциты – 1%, тромбоциты – 115×10^{9}/л, лейкоциты – $23{,}1\times10^{9}$/л, палочкоядерные нейтрофилы – 1%, сегментоядерные нейтрофилы – 23%, лимфоциты – 75%, моноциты – 1%, СОЭ – 40 мм/ч.

УЗИ органов брюшной полости: УЗИ-признаки гепатомегалии, спленомегалии. Диффузная неоднородность печени и поджелудочной железы. Конкрементов, объёмных образований не выявлено.

Биохимический анализ крови: общий белок – 68 г/л, общий билирубин – 45 мкмоль/л, АСТ – 0,92 ммоль/л, АЛТ – 0,81 ммоль/л.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Определите тактику лечения данного пациента. Обоснуйте свой выбор.
5. Определите прогноз болезни и трудоспособность пациента.

Задача № 38

Больной 44 лет обратился в поликлинику с жалобами на слабость, утомляемость, одышку и сердцебиение при небольшой физической нагрузке, жжение в языке, чувство онемения в подошвах стоп. Кожа и слизистые бледные с желтушным оттенком. Лицо отёчное, бледное, волосы седые. Язык чистый, малиновый, блестящий, сосочки атрофированы.

Тоны сердца глухие, слабый систолический шум на верхушке, на лёгочном стволе. Пальпируется печень на 2 см ниже правой рёберной дуги, перкуторные размеры - 15×10×8 см. Пальпируется селезёнка, перкуторные размеры - 13×10 см. Ослаблены рефлексы, снижена глубокая чувствительность на стопах и кистях.

Клинический анализ крови: гемоглобин – 63 г/л, эритроциты – $1{,}4\times10^{12}$/л, лейкоцитарная формула - без особенностей, MCV - 110 фл, тельца Жолли и кольца Кебота, пойкилоцитоз. Билирубин – 55 мкмоль/л, непрямой – 45 мкмоль/л.

Результаты стернальной пункции: эритроидная гиперплазия костного мозга, мегалобластный тип кроветворения, соотношение эритроидных и миелоидных элементов - 1:1, снижено количество мегакариоцитов, определяются гигантские метамиелоциты.

Задание

1. Какой наиболее вероятный диагноз у данного больного?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Назовите критерии эффективности лечения заболевания.

Задача № 39

Больной 55 лет 5 лет назад получал полихимиотерапую и лучевую терапию по поводу рака лёгкого. В течение полугода появилась слабость, головокружение, одышка при ходьбе.

При тщательном обследовании больного, включая КТ органов грудной и брюшной полости, данных за прогрессирование основного заболевания и развитие метастазов не получено.

Клинический анализ крови: гемоглобин – 65 г/л, эритроциты – $2{,}1\times10^{12}$/л, ретикулоциты – 0,3%, лейкоциты – $1{,}9\times10^{9}$/л, тромбоциты – 90×10^{9}/л, СОЭ – 35 мм/ч.

Результаты стернальной пункции: костный мозг в основном представлен жировой тканью, в которой определяются редкие и мелкие островки миелоидной ткани.

Лейкоцитарная формула без особенностей.

Задание

1. Какой наиболее вероятный диагноз у данного больного?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз?

Задача № 40

Больная К. 60 лет госпитализирована в ЦРБ по месту жительства в связи с выраженной слабостью, одышкой, сердцебиением при малейшей физической нагрузке. Слабость ощущала несколько лет, последние 2 года стала отмечать боли в позвоночнике. В молодости была донором крови 8 раз, имеет 3-х детей, было 4 аборта. Участковым терапевтом в связи с выявленной анемией (эритроциты - $3{,}12\times10^{12}$/л) назначен Сорбифер Дурулес по 2 таблетки в день в течение 1,5 месяцев. Эффекта не получено.
Общий анализ крови: эритроциты - $1{,}5\times10^{12}$/л; гемоглобин - 50 г/л, ЦП - 1,0; ретикулоциты - 0,4%; тромбоциты - 98×10^{9}/л; лейкоциты - $2{,}6\times10^{9}$/л (палочкоядерные нейтрофилы – 3%, сегментоядерные нейтрофилы – 30%, лимфоциты – 60%, моноциты – 7%), анизоцитоз ++++, пойкилоцитоз +++; СОЭ - 72 мм/ час.

Задание

1. Можно ли предварительно поставить один из следующих диагнозов: «апластическая анемия»? «острый лейкоз»? «множественная миелома»?
2. Как правильно поставить предварительный диагноз?
3. Нуждается ли больная в консультации гематолога, в стернальной пункции?
4. В биохимических анализах выявлено: общий белок крови - 140 г/л, альбумины - 30%, глобулины - 70%, выявлен М-градиент в зоне гамма-глобулинов. Сократится ли Ваш диагностический поиск?
5. В каком отделении должна лечиться данная больная?

Задача № 41

Больная 47 лет при обращении в поликлинику предъявляет жалобы на повышение температуры тела до 38°С, озноб, общую слабость, головокружение, одышку, сердцебиения, желтушное окрашивание кожи и склер, боль в пояснице, левом и правом подреберьях, потемнение мочи.
Неделю назад после переохлаждения повысилась температура до 38°С; были катаральные явления в течение 3 дней, по поводу чего принимала парацетамол 500 мг 2-3 раза в день. Температура нормализовалась, но появилось желтушное окрашивание кожи и склер, нарастающая слабость. В прошлом также были эпизоды желтухи. Заболела остро 3 дня назад, когда в течение одних суток появились вышеописанные жалобы.
Объективно: состояние больной средней тяжести. Температура 37,3°С. Кожа бледно-желтушной окраски с лимонным оттенком, склеры иктеричны. Лимфатические узлы не увеличены. Пульс - 100 в минуту, ритмичный, АД - 95/60 мм рт. ст. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, болезненный в правом и левом подреберьях. Печень на 2 см выступает из-под рёберной дуги, умеренно болезненная, селезенка выступает из-под реберной дуги слева на 3 см, болезненная при пальпации. Суточный диурез около 1 литра.
Результаты лабораторных методов исследования:
Клинический анализ крови: гемоглобин – 90 г/л, эритроциты – $3{,}0\times10^{12}$/л, ЦП – 0,85, MCV 100 фл, ретикулоциты – 3%, лейкоциты $9{,}6\text{x}10^{9}$/л, лейкоцитарная формула – лимфоциты 32%, с/я нейтрофилы 57%, п/я нейтрофилы 4%, тромбоциты $214\text{x}10^{9}$/л, СОЭ – 18 мм/час. Биохимия крови: глюкоза 4,8 ммоль/л, гликозилированный гемоглобин 3,8%, общий билирубин 53,4 мкмоль/л, непрямой билирубин 44,6 мкмоль/л, АСТ 15 Е/л, АЛТ 17 Е/л, ЛДГ 725 Е/л. Общий анализ мочи: выявлен свободный гемоглобин. Иммунологическое исследование: положительная прямая проба Кумбса.

Задание

1. Выделите синдромы у данной больной и определите ведущий синдром.
2. Сформулируйте и обоснуйте поставленный Вами диагноз.

3. Составьте дифференциальный диагностический ряд и проведите дифференциальную диагностику основного заболевания.
4. Каковы Ваши дальнейшие действия как врача-терапевта поликлиники?
5. Какие методы лечения применяются при данном заболевании?

Задача № 42

Больной 21 года вызвал на дом врача экстренно в связи с жалобами на выделение большого количества алой крови из прямой кишки при дефекации, учащенный стул до 5 раз в сутки, повышение температуры тела до 38°С, общую слабость. Появление крови в стуле отмечает в течение последних 3-х недель, постепенно стал учащаться стул, изменилась консистенция до кашицеобразной, появилась общая слабость, субфебрильная температура, ухудшение в течение 2-х дней.
При осмотре кожные покровы бледные. АД - 110/70 мм рт. ст. Пульс - 96 в минуту, ритмичный. Язык обложен белым налётом. Живот мягкий, болезненный в левой подвздошной области. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.
Пациент направлен в стационар для подбора терапии и дальнейшего обследования с целью уточнения диагноза.

Задание
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз?
3. Какие исследования необходимо выполнить больному?
4. Какие эндоскопические и гистологические признаки данного заболевания?
5. Какие схемы терапии могут быть использованы у больного?
6. Назовите возможные осложнения заболевания.

Задача № 43

Студентка 21 года обратилась в поликлинику с жалобами на периодическую диарею, боль и вздутие живота в течение последних 6 месяцев, необъяснимую потерю веса (около 5 кг).
Заметила, что диарея становится не такой выраженной, если она перестаёт с едой употреблять хлеб.
Также обеспокоена зудящей сыпью на разгибательных поверхностях обоих локтей, спонтанно образующимися небольшими кровоизлияниями в кожу.
Отмечает, что начала чувствовать общую слабость и недомогание последний месяц.
При осмотре температура тела - 36,8°С, ЧСС – 80 ударов в минуту, АД - 115/75 мм рт. ст., ЧДД - 16 в минуту, сатурация O_2 - 99%.
Из анамнеза: болеет сахарным диабетом I типа.
По данным общего анализа крови (снижение гемоглобина и эритроцитов) и биохимического анализа крови (снижение сывороточного железа, ферритина, повышение свободного трансферрина), установлена железодефицитная анемия.

Задание
1. Сформулируйте предварительный диагноз.
2. Каковы этиология и патогенез данного заболевания?
2. Какие изменения стула характерны для данного заболевания?
3. Назовите и опишите осложнение (синдром), развивающееся при длительном неконтролируемом течении данного заболевания?

4. Какие исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза заболевания?
5. Каковы основные принципы лечения данного заболевания?

Задача № 44

К врачу-терапевту участковому обратился мужчина 35 лет (рост 184 см, вес 64 кг) с жалобами на интенсивные боли натощак и проходящие после приема пищи и вновь возникающие через 2-3 часа в эпигастральной области. Боли купировались также и после приема антацидов или омепразола 20 мг на непродолжительный период. Также отмечал отрыжку кислым, тошноту, однократную рвоту на высоте болей, приносящую облегчение.
Считает себя больным около 15 лет, когда появились неинтенсивные боли в подложечной области. При проведении ФГДС ранее был определен поверхностный гастрит и рубцовая деформация луковицы ДПК, а при pH-метрии выявлено было повышение кислотности желудочного содержимого.
Пациент больше не обращался в поликлинику и не обследовался. Периодические боли возникали ежегодно в осенне-весенний период. Лечился самостоятельно, старался соблюдать диету. Настоящее обострение началось в марте, длится уже 10 дней. Из анамнеза: курит в течение 8 лет по 15 сигарет в день. Наследственность отягощена по язвенной болезни (у отца язвенная болезнь ДПК).
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, чистые. Язык влажный, небольшой сероватый налет на корне. При пальпации живота: определяется локальная болезненность в эпигастральной и в пилородуоденальной областях. Печень: размеры по Курлову: 9×8×7см, край ровный, эластичный, безболезненный. Пузырные симптомы отрицательные. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Задание
1. Сформулируйте наиболее вероятный предварительный диагноз.
2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз?
3. Какие дополнительные исследования могут быть выполнены для подтверждения и уточнения диагноза?
4. Каково стандартное лечение данного заболевания (с указанием доз и кратности введения)?
5. Каковы возможные осложнения данного заболевания?

Задача № 45

Пациент К. 29 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на частые слабые ноющие боли в эпигастральной области, уменьшающиеся после приёма пищи; чувство быстрого насыщения; отрыжку кислым. Также отмечает общую слабость, неустойчивость стула. Указанные жалобы периодически беспокоят в течение последних 5 лет, текущее ухудшение самочувствия - 1,5 недели назад.
Самостоятельно принимал антациды с кратковременным положительным эффектом.
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски, чистые. Со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем без особенностей. Язык влажный, обложен белым налётом. Живот обычной формы, при пальпации мягкий, болезненный в эпигастральной области.
В клиническом анализе крови: эритроциты - $4{,}8\times10^{12}$/л, гемоглобин - 140 г/л, ЦП - 0,87, тромбоциты - 380×10^{9}/л, лейкоциты - $7{,}2\times10^{9}$/л, СОЭ - 16 мм/ч.
В биохимическом анализе крови: АЛТ - 21 Ед/л, АСТ - 18 Ед/л, амилаза - 53 Ед/л, щелочная

фосфатаза - 78 Ед/л.
Выполнено ФГДС: в просвете желудка большое количество слизи. Явления умеренной атрофии в пилорическом отделе желудка, отёк и гиперемия в фундальном отделе желудка. Перистальтика активная. Желудок хорошо расправляется воздухом. Хелпил-тест +++.

Задание

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз, план обследования для подтверждения диагноза.
2. Есть ли необходимость проведения эрадикационной терапии в данном случае?
3. Предложите план лечения.
4. Какие факторы естественной защиты слизистой оболочки желудка и факторы агрессии Вы знаете?
5. Какие осложнения данного заболевания возможны в случае отсутствия специфического лечения?

Задача № 46

Врач-терапевт участковый поликлиники вызвал машину скорой медицинской помощи с целью возможной госпитализации для женщины 45 лет, у которой предположил диагноз «Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром. Бронхиальная астма, обострение».
Из анамнеза известно, что в течение последних 10 лет, после значительного уменьшения физической активности, отмечает постоянное увеличение массы тела, на фоне чего стала отмечать приступообразный, преимущественно сухой мучительный кашель, сопровождающийся ощущением нехватки воздуха.
Через некоторое время стала также отмечать боли за грудиной при физической нагрузке, наиболее выраженные во время работы в огороде (прополка грядок).
Была обследована амбулаторно. Выставлен диагноз «Бронхиальная астма тяжёлого, непрерывно рецидивирующего течения. ИБС: стенокардия напряжения III ФК. Ожирение III степени.
Назначенное лечение - Преднизолон, ингаляционные глюкокортикоиды, бронхолитики, - имело незначительный эффект.
Приём нитратов, со слов больной, был эффективен, приводя к купированию загрудинной боли в течение получаса.
В течение последних 2-3 недель отмечает появление загрудинной боли и в ночное время в первой половине ночи, особенно после плотного позднего ужина, что стало поводом для обращения за медицинской помощью.
Бригадой скорой помощи по данным клинической картины, а также по данным ЭКГ и высокочувствительного тропонин-теста, диагноз ОКС отвергнут.
При аускультации дыхание жёсткое, хрипов нет.
Рентгенография органов грудной клетки – пневмофиброз.

Задание

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз заболевания, который объединяет жалобы больной.
2. Какие осложнения возможны при данном заболевании?
3. Какие специальные методы исследования применяются при данном заболевании?
4. Какие рекомендации по изменению образа жизни и питания необходимо дать пациентке?
5. Какие препараты применяются для лечения данного заболевания (указать группу и название препарата)?

Задача № 47

Пациент 55 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на боли различной интенсивности в области желудка (эпигастральной области), периодически с иррадиацией в спину; возникают чаще через 1,5-2 часа после обильной, острой или жирной еды, приема алкоголя, длящиеся до 3 часов, усиливающиеся в ночное время, в положении лёжа на спине, уменьшающиеся в положении сидя с наклоном вперёд, подтянув ноги к груди. Иногда боли иррадиируют в левую половину грудной клетки. Также отмечает выраженную тошноту, отсутствие аппетита, вздутие живота. После каждого приёма пищи в течение 1 часа возникает кашицеобразный, иногда водянистый стул, содержащий капли жира. Отмечает слабость, снижение массы тела, за последний год – на 7кг, периодически боли в икроножных мышцах.
Анамнез заболевания: Появление симптомов отмечает около 7 лет назад, в последние 3 года отмечает обострения до 4-5 раз в год. Настоящее обострение в течение трех дней, после эпизода злоупотребления алкоголем.
Из анамнеза жизни: более 10 лет ежедневно употребляет алкоголь, в основном крепкие алкогольные напитки в среднем 200 мл в день, в выходные дни – до 500 мл, курит по 2 пачки сигарет в день.
Объективно: состояние относительно удовлетворительное, рост тела 176 см, вес- 50 кг. Кожа, слизистые умеренной бледности, тургор кожи снижен. Периферические лимфоузлы не увеличены. ЧД – 16 в мин. Дыхание жесткое, единичные сухие хрипы с обеих сторон. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС – 90 в мин., АД 140/90 мм рт. ст. При пальпации живота: болезненность в зоне Шоффара, положительный симптом Мейо-Робсона, наличие телеангиоэктазий в проекции поджелудочной железы. Печень + 1 см из-под края реберной дуги, при пальпации край печени эластичный, безболезненный, пузырные симптомы отрицательные. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.
В ОАК: лейкоциты - 7,8 х 10^9/л; эритроциты – 3,0 х 10^{12} /л; гемоглобин – 98 г/л; СОЭ – 18 мм/час.
В биохимическом анализе крови: альфа-амилаза – 128 Ед/л, активность липазы 90 Ед/л; общий билирубин 22,0 ммоль/л; ГГТП -110 МЕ/л; АСТ 66 Ед/л, АЛТ 35 Ед/л; калий – 3,3 ммоль/л; общий белок: 60 г/л; альбумины – 30 г/л.
Амилаза в моче – 480 Ед/л.
Копрограмма: стеаторея++, нейтральный жир ++, мыла ++, креаторея ++. Панкреатическая эластаза 1 в кале – 120 мкг/г.

Задание
1. Выделите основные синдромы, дайте заключение по лабораторным исследованиям, сформулируйте наиболее вероятный предварительный диагноз, обоснуйте его.
2. Составьте план дальнейшего обследования. Перечислите диагностические признаки заболевания по данным визуализирующих методов исследования.
3. Каковы основные задачи консервативного ведения/лечения пациентов с данным заболеванием?
4. Перечислите основные медикаментозные и немедикаментозные лечебные мероприятия, показанные для данного больного.
5. Составьте план дальнейшего наблюдения пациента в амбулаторной практике.

Задача № 48

Больной 49 лет предъявляет жалобы на выраженную слабость, постоянную сонливость, похудание на 6 кг за полгода, носовые кровотечения и из дёсен, увеличение живота в объёме, зуд. Состояние средней тяжести. Из анамнеза – длительное злоупотребление алкоголем.

При осмотре: Кожные покровы желтушные, отечность нижних конечностей, сосудистые звёздочки в области шеи, груди, пальмарная эритема, контрактура Дюпюитрена. Имеется атрофия мышц верхнего плечевого пояса, дефицит веса (вес 58 кг при росте 177 см – ИМТ - 17). Определяются подкожные гематомы на руках и ногах, гинекомастия.
Живот увеличен в объёме. При перкуссии выявляется жидкость в брюшной полости.
Печень пальпируется на 4 см ниже уровня рёберной дуги, край острый, плотный. Перкуторные размеры - 13×11×6 см. Увеличены перкуторные размеры селезенки 17×12 см. Отмечает уменьшение выделения мочи до 500мл в сутки.
Белок общий - 59 г/л, альбумины – 29 г/л. ССК – ПТИ 35%, билирубин 116 ммоль/л- прямой - 34,8 ммоль/л.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Назовите синдромы поражения внутренних органов.
3. Обоснуйте, почему выделили указанные синдромы.
4. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
5. Назначьте лечение пациента.

Задача № 49

Больная М. 21 года, обратилась в приемное отделение дежурного терапевтического стационара в порядке скорой помощи с жалобами на боли в нижних отделах грудной клетки, усиливающие при глубоком вдохе, покашливание без отделения мокроты, сердцебиение, головные боли, боли в суставах; на болезненность и увеличение подчелюстных лимфатических узлов, появление яркого румянца на щеках.
Анамнез заболевания: заболела две недели назад, после возвращения домой из отпуска, во время которого пациентка отдыхала на морском курорте в Турции. Заболевание началось с резкого повышения температуры тела до 39° С, появления боли и припухлости коленных, голеностопных, локтевых суставах, а также болезненности в лучезапястных и проксимальных межфаланговых суставах обеих кистей. Пациентка самостоятельно принимала НПВП, температуры тела снизилась до субфебрильной, уменьшились боли в суставах. Три дня назад – вновь фебрильная лихорадка, появились боли в нижних отделах грудной клетки, сердцебиение. Сегодня вызвала бригаду скорой помощи.
Из анамнеза жизни известно, что с подросткового возраста плохо переносит солнечные лучи, но значения этому не придавала. 6 месяцев назад была госпитализирована в гинекологическое отделении в связи с угрозой и прерыванием первой беременности (14 недель), тяжело переживала потерю ребенка.
Объективный осмотр. Общее состояние тяжелое, Т тела 38,7°С. Кожные покровы бледные. Подчелюстные лимфоузлы при пальпации увеличены, болезненны и уплотнены. Определяется припухлость и покраснение коленных, голеностопных и локтевых суставов, кожа над ними горячая. Движения в суставах болезненны, объем движений органичен.
В области декольте дисковидные высыпания.
Пульс - 118 в минуту, ритмичный. АД - 190/40 мм рт. ст. В нижних отделах лёгких выслушивается жесткое дыхание, шум трения плевры с обеих сторон по заднеаксиллярной линии. Правая граница относительной тупости сердца на 1 см смещена вправо от правого края грудины, левая - на 1,5 см левее левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца ослаблены, ритм галопа. При аускультации систолический шум на верхушке сердца. Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Периферические отеки нижних конечностей.
Общий анализ крови: СОЭ – 65 мм/час, гемоглобин – 86 г/л, эритроциты – 2,8 $x10^{12}$/л; лейкоциты – 2,5 $x10^{9}$/л; лимфопения; тромбоциты – 80 $x10^{9}$/л. Общий анализ мочи: выраженная про-

теинурия, суточная потеря белка 4 г, измененные эритроциты, зернистые и восковидные цилиндры.

Задание

1. Выделить ведущие синдромы для обоснования предполагаемого диагноза заболевания.
2. Указать диагностические критерии заболевания.
3. Перечислить возможные осложнения основного заболевания.
4. Указать дополнительные методы обследования для уточнения диагноза.
5. Определить тактику лечения и выбор препаратов.

Задача № 50

Мужчина 39 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на повышение температуры тела до $38,5^0$ С, кашель с небольшим количеством вязкой мокроты желтоватого цвета, одышку инспираторного характера при незначительной физической нагрузке, боль в левой половине грудной клетки ноющего характера, усиливающуюся при кашле и глубоком дыхании, общую слабость, потерю аппетита. Неделю назад «простудился», появился насморк, кашель с небольшим количеством вязкой светлой мокроты, чувство першения в горле. Лечился самостоятельно аспирином и бисептолом, состояние не улучшилось. Вчера вечером повысилась температура тела, появилась боль в грудной клетке и одышка. усилился кашель, стала отходить мокрота желтого цвета.
Курит в течение 10 лет около 10 сигарет в день, периодически по утрам кашель с небольшим количеством мокроты. 2 месяца назад кашель усилился, отмечалась экспираторная одышка, лечился антибиотиками – названия не помнит.
Объективно: общее состояние средней тяжести. Одышка в покое с ЧД 22 в 1 минуту. Над лёгкими перкуторный тон с коробочным оттенком. Слева ниже угла лопатки определяется притупление перкуторного звука, в этой области выявлено усиление голосового дрожания. При аускультации лёгких выслушивается жесткое дыхание, сухие хрипы над всеми отделами лёгких, а в зоне притупления перкуторного звука – мелкопузырчатые влажные хрипы. Тоны сердца несколько приглушены. Пульс - 96 в 1 минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД - 115/75 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный.
Результаты дополнительного обследования:
Общий анализ крови: эр. - $4,5x10^{12}$/л, Нв - 120 г/л, цв.п. - 0,9 ; тромбоциты - $240x10^9$/л, лейкоциты - $12,0x10^9$/л, пал. - 8%, сегм. - 52%, лимф. - 32%, мон. - 8%, СОЭ - 30 мм/час.
Рентгенограмма органов грудной клетки:



Задание

1. *Выделите ведущий клинический синдром*
2. *Оцените общий анализ крови и рентгенограмму данного пациента. Дайте заключение.*
3. *Обоснуйте и сформулируйте клинический диагноз.*
4. *Определите место проведения лечения для данного пациента. Обоснуйте.*
5. *Назначьте лечение данному пациенту. Когда и как оценивать эффективность начальной терапии у данного больного? Действия врача при неэффективности стартовой терапии пациента.*
6. *Определите продолжительность терапии для данного пациента и решите вопрос об отмене антибиотика или продолжении лечения*

Задача № 51

Больной М. 72 лет, пенсионер, обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на головные боли, головокружение, шум в ушах, повышение АД до 210/120 мм рт. ст.

Анамнез заболевания: высокие цифры АД появились 2 года назад, принимал Метопролол, Гипотиазид, однако добиться существенного снижения АД не удавалось. В течение полугода отмечает усталость при ходьбе, боли в ногах, которые заставляют останавливаться (при прохождении менее 200 метров). Госпитализирован для уточнения диагноза и подбора лекарственной терапии.

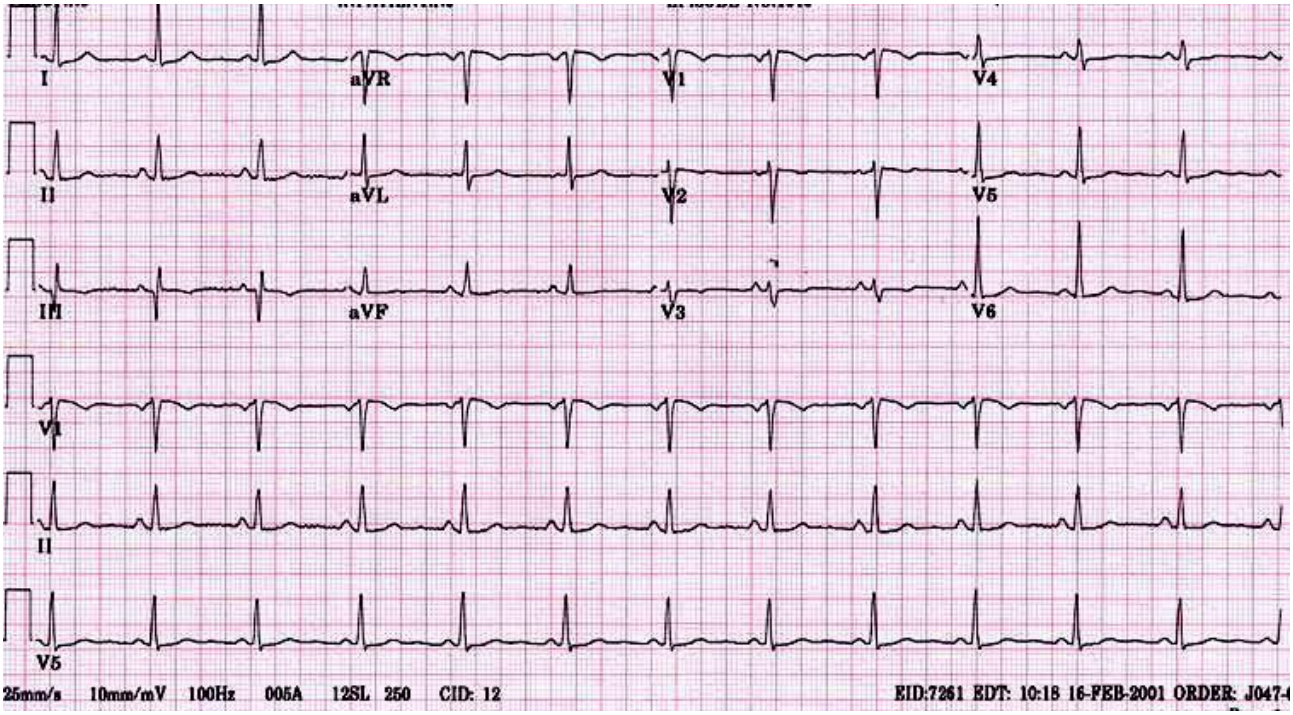
Объективно: состояние удовлетворительное. Рост – 178 см, вес – 96 кг. Отёков нет. Над всей поверхностью лёгких перкуторно - лёгочный звук, при аускультации - дыхание везикулярное, хрипов нет. Область сердца визуально не изменена.

Границы сердца: правая - 1 см кнаружи от правого края грудины, верхняя - II ребро, левая - 1,5 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии в V межреберье. Верхушечный толчок в V межреберье, кнаружи от левой срединно-ключичной линии, разлитой. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Акцент II тона над аортой, систолический шум на аорте без проведения на сосуды шеи. Пульс - 76 в минуту, ритмичный. Сосудистая стенка вне пульсовой волны плотная. АД - 195/115 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю рёберной дуги. Над брюшной аортой выслушивается систолический шум.

Симптом поколачивания отрицательный. Снижена пульсация на артериях тыла обеих стоп.

Общий анализ крови: гемоглобин - 145 г/л, эритроциты - $4{,}5\times10^{12}$/л, лейкоциты - $7{,}9\times10^{9}$/л, СОЭ - 12 мм/час, цветовой показатель - 1,0.

Общий анализ мочи: удельный вес - 1020, белок – 0,033 г/л, лейкоциты – ед. в поле зрения, единичные гиалиновые цилиндры.
Биохимический анализ крови: глюкоза - 5,2 ммоль/л (3,5-6,1), холестерол - 7,2 ммоль/л (4,0), мочевина - 9,0 ммоль/л (2,4-8,3), креатинин - 130 мкмоль/л (62-115), калий - 5,4 ммоль/л (3,4-5,3), натрий - 135 ммоль/л (130-156). Расчетная СКФ по формуле CKD-EPI – 47 мл/мин/1,73 м^2.
Изотопная ренография: снижение амплитуды васкулярного сегмента ренограммы справа.
Осмотр глазного дна: ангиопатия сосудов сетчатки.
ЭХО-КГ: ПЖ - 2,1 см (норма - до 2,3 см), МЖП - 1,25 см (норма - ~~1,0~~ до 1,1 см), ЗСЛЖ - 1,25 см (норма - до 1,1 см), КДРЛЖ - 5,8 см (норма - до 5,5 см), КСРЛЖ - 3,7 см (норма – до 3,5 см).
Фракция выброса - 54% (норма - 60-80%). Кальциноз митрального, аортального клапанов.
Представлена ЭКГ.



Задание

1. Выделите ведущие синдромы (объясните патофизиологические механизмы их возникновения).
2. Дайте заключение по результатам параклинического обследования.
3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.
4. Составьте план обследования для уточнения диагноза.
5. Составьте план лечения.

Задача № 52

Пациентка 45 лет, впервые обратилась к участковому врачу после переезда из другого города с жалобами на приступообразный кашель по утрам с отделением небольшого количества вязкой слизистой мокроты, иногда, чаще в ночное время, переходящий в приступ удушья (более 2 раз в неделю), купирующийся ингаляциями сальбутамола, небольшую слабость. Во время приступа удушья принимает вынужденное положение, облегчающее её состояние. Больной

себя считает около 5 лет, когда стала у себя отмечать заложенность носа, возникновение приступов кашля, часто по ночам, эпизоды дыхательного дискомфорта при физической нагрузке. В поликлинике по месту прежнего жительства состояние расценивалось как хронический бронхит.

Курила в течение 5 лет по 1 -2 сигареты в сутки, бросила после появления приступов удушья. Другие вредные привычки и перенесенные заболевания отрицает.

Объективно: нормостенического телосложения, температура 36,6°С. При перкуссии грудной клетки над всеми её отделами определяется коробочный звук. Над лёгкими дыхание везикулярное, ослабленное, рассеянные сухие свистящие хрипы над всей поверхностью лёгких. (При небольшой гипервентиляции количество сухих хрипов в лёгких резко увеличивается, в покое – значительно уменьшается.) Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс – 88 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД – 115/75 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Органы брюшной полости без особенностей.

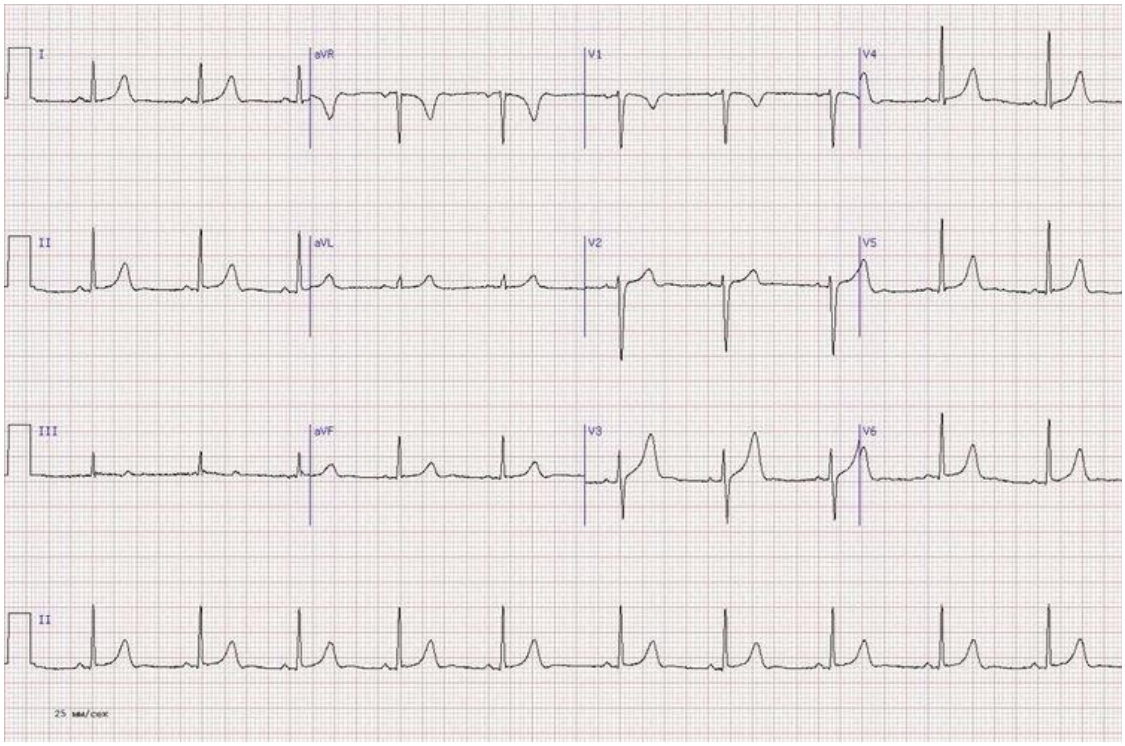
Результаты дополнительного обследования:

Общий анализ крови: Эр - 4,0 х 10^{12}/л, НЬ - 128 г/л, цв. показ. - 0, 89, Л -6,5 х 10^{9}/л, э. - 11, п. - 2, с. - 66, л. - 14, м. - 3, СОЭ - 14 мм/ч.

Спирограмма: ЖЕЛ - 100 %, ФЖЕЛ - 88 %, ОФВ1 - 72 % от должных величин. После ингаляции 400 мкг сальбутамола прирост ОФВ1 составил 18 % (300мл)



Рентгенограмма органов грудной клетки пациентки.



ЭКГ в покое данной пациентки.

Задание

1. *Выделите ведущий клинический синдром. Обоснуйте его патогенез.*
2. *Оцените общий анализ крови данной пациентки. Дайте заключение.*
3. *Оцените рентгенограмму и ЭКГ в покое данной пациентки. Дайте заключение.*
4. *Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз согласно существующей классификации.*
5. *Определите принципы медикаментозной терапии данной больной в соответствии с общепризнанными клиническими рекомендациями.*
6. *Как проводится экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза данной пациентке?*
7. *Как проводить диспансеризацию данной пациентке?*
8. *Правила выписки рецептов для данной пациентке.*

Задача № 53

Пациент 53 лет обратился в поликлинику с жалобами на головные боли, сухость во рту, жажду (выпивает до 4 литров жидкости в сутки), общую слабость, утомляемость, тошноту, рвоту, учащенное мочеиспускание, временами зуд кожи, одышку при физической нагрузке, перебои в работе сердца.

Из анамнеза: болеет 12 лет, когда впервые появились отеки лица, голеней и стоп, головные боли. В последующие годы присоединилась артериальная гипертония (АД 160/100-190/110 мм рт. ст.). В моче периодически обнаруживали белок 1,2-2,4 г/л, лейкоциты и эритроциты. От нефробиопсии отказывался. Несмотря на рекомендации врачей, планового постоянного лечения не получал. Периодически лечился стационарно, получал преднизолон, аскорутин, мочегонные. На фоне лечения состояние улучшалось: проходили отеки, белок в моче снижался до 0,33 г/л. В последнее время головные боли стали носить упорный характер, стал отмечать тошноту, рвоту, сухость во рту, жажду, кожный зуд, снизился аппетит, больной похудел.

Объективно: состояние средней тяжести. Несколько заторможен, апатичен, сонлив. Пониженного питания, ИМТ 19 кг/м^2. Кожные покровы сухие, бледные, следы расчесов. Лицо одутловатое, мягкие тестоватые отеки ног (при надавливании остается ямка). В лёгких дыхание везикулярное, в нижних отделах с обеих сторон ослабленное, хрипов нет. Сердце расширено влево на 2 см. Тоны сердца приглушены, частые экстрасистолы. ЧСС 88 уд/мин. АД 210/120 мм рт. ст. Печень и селезенка не увеличены. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. Мочеиспускание 8-10 раз в сутки, в том числе 1-2 раза ночью, моча темного цвета.
Данные дополнительных обследований:

Общий анализ крови: гемоглобин – 69 г/л, эритроциты - 2,8*10^{12}/л, лейкоциты – 9,8*10^9/л, тромбоциты – 126*10^9/л, СОЭ – 75 мм/ч.
Креатинин крови 370 мкмоль/л. СКФ по формуле SKD/ EPI 14 мл/мин/1,73м^2.
Общий анализ мочи: уд. вес 1003, белок – 0,8 г/л, лейк. – 3-8 в п/зр., эр. 35 в п/зр., цилиндры гиал. 1-2, зернистые 1-2.
Суточная альбуминурия 800 мг/сут.
ЭКГ – гипертрофия левого желудочка, уменьшение вольтажа, удлинение PQ, сглаженность и двухфазность зубца Т, частые желудочковые экстрасистолы.
УЗИ почек: правая 8,1х3,7 см, левая 9,4х 4,1 см. Контуры неровные, толщина паренхимы 14-15 мм, ткань почек диффузно гипреэхогенна, кровоток обеднен, кортико-медуллярная дифференциация нарушена. В обеих почках единичные мелкие кисты.

Задание

1. *Выделить ведущий синдром.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать диагноз.*
4. *Назначить лечение*.

Задача № 54

Пациент 24 года, при поступлении предъявляет жалобы на отеки ног, лица, боли в пояснице, мочу красного цвета и уменьшение ее суточного выделения, слабость, недомогание, головные боли, некоторое ухудшение зрения.
Из анамнеза: болеет 3 недели. Заболевание началось с болей в горле при глотании и заложенности носа с обильным гнойным отделяемым, беспокоили головные боли, температура до 39-40 С. Через 3 дня температура снизилась, самочувствие улучшилось. Неделю назад возобновились головные боли, сопровождающиеся тошнотой, появились отеки лица и голеней, моча приобрела красный оттенок. Вновь заметил периодические подъемы температуры до субфебрильных цифр.
В прошлом отмечал неоднократные ангины и обострения гайморита.
Объективно: состояние ближе к удовлетворительному. Кожные покровы чистые, бледные. Отмечаются отек лица, особенно в области век, мягкие теплые отеки голеней и стоп. Пальпируются несколько увеличенные лимфатические узлы глоточного кольца, болезненные при пальпации. Зев гиперемирован, миндалины гипертрофированы, с гнойным налетом. По задней стенке глотки – гнойное отделяемое из носа. ЧД – 17 в мин. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца чистые, звучные. ЧСС – 80 уд. в мин., АД – 170/100 мм рт. ст. Живот мягкий, чувствительный при пальпации в эпигастрии. Печень и селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. Симптом поколачивания положительный с обеих сторон. Дизурии нет.
При лабораторном обследовании: в общем анализе крови гемоглобин – 128 г/л, эритроциты - 4,8*10^{12}/л, лейкоциты – 9,8*10^9/л, тромбоциты – 126*10^9/л, СОЭ – 25 мм/ч.; в общем анализе мочи удельный вес 1018-1020, белок 0,99 г/л; эр. – 40-50 в п/зр., лейк. – 2-3 в п/зр.

Мазок из зева дал рост бета-гемолитического стрептококка.

Задание

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Составьте план лечения данного пациента.

Задача № 55

Больная В., 72 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на головные боли, возникающие на фоне повышения АД (до 170/90 мм рт. ст.), периодически умеренные боли в эпигастральной области натощак, общую слабость.
Из анамнеза: в течение 15 лет наблюдается у невролога по поводу вертеброгенной цервикалгии, люмбалгии на фоне полисегментарного остеохондроза позвоночника. Страдает частыми мигренями. Часто и бесконтрольно принимает нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по поводу различных болей. 5 лет назад выявлено повышенное АД, назначены ингибиторы АПФ и диуретик, принимает нерегулярно. Боли в эпигастральной области периодически возникают в течение 3-х лет, неинтенсивные, самостоятельно исчезают после приема пищи. Последние две недели пациентка отмечает усиление головных болей, присоединение общей слабости.
Объективно: состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы бледные. Отеки лодыжек. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на аорте, ЧСС — 68 уд/мин, АД — 160/90 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Нижний край печени у края реберной дуги справа. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон.
Результаты обследования: ЭКГ – признаки гипертрофии миокарда левого желудочка.
Общий анализ мочи: уд. вес – 1006, белок – 0,4 г/л, лейк. – 4-6 в п/зр., эритр. выщ. 22- 28 в п/зр., цил. гиал. 3-4.
ОАК: гемоглобин – 95 г/л, эритроциты - $2,9*10^{12}$/л, лейкоциты – $7,8*10^{9}$/л, тромбоциты – $126*10^{9}$/л, СОЭ – 35 мм/ч.
Биохимический анализ крови: креатинин 180 мкмоль/л; мочевина 14 ммоль/л; скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKD-EPI): 24 мл/мин/1,73м^2
ЭГДС: поверхностные эрозии слизистой и точечные кровоизлияния в антральном отделе желудка, тест на НР – отрицательный.

Задание

1. *Выделить ведущий синдром.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 56

Пациент 58 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на кашель с выделением небольшого количества слизистой мокроты, одышку при незначительной физической нагрузке (подъём на 1 этаж, ходьба в умеренном темпе), сердцебиение, слабость, утомляемость.

Кашель с мокротой, преимущественно по утрам, беспокоит около 20 лет, кашель усиливается в осеннее и зимнее время.5 лет назад появилась постепенно усиливающая одышка, 3 года периодически появляются отеки на голенях. При усилении одышки применяет беродуал. В последние годы участились обострения в связи «с простудой» до 5-6 раз в год, некоторые обострения продолжительностью до 8 недель. В прошлом году один раз был госпитализирован в стационар с обострением (выписки нет). Курит по 1 пачке сигарет в день в течение 37 лет, индекс курильщика=37. Туберкулезом ранее не болел, контакт с туберкулезными больными отрицает.

Объективно: гиперстенического телосложения, повышенного питания. ИМТ – 29 кг/м2. Выраженный диффузный цианоз. Отеки на ногах. Грудная клетка бочкообразной формы, экскурсия её ограничена. При перкуссии над лёгкими коробочный звук, границы лёгких опущены. Дыхание ослабленное, рассеянные сухие свистящие хрипы. ЧД – 24 в минуту. Границы сердца четко не определяются, тоны сердца глухие, акцент 2 тона над лёгочной артерией. ЧСС – 86 ударов в минуту. АД 130/80 мм рт. ст. Шейные вены в положении лѐжа набухают. Печень выступает из под края реберной дуги на 4 см (опущена на 2см, увеличена на 2 см), эластичная, болезненная при пальпации.

Результаты дополнительного обследования:

Проведена оценка выраженности симптомов: по шкале CAT (COPD Assessment Test) пациент набрал 28 баллов, по шкале одышки mMRC (Modified Medical Research Council Dyspnea Scale) 4 балла

Общий анализ крови: эр. - 5,44х10^{12}/л, Нв - 155 г/л, ц.п. – 0,92,0; тромбоциты - 238х10^{9}/л, лейкоциты – 6,2,0х10^{9}/л, эоз – 4%, пал. - 0%, сегм. - 58%, лимф. - 35%, мон. - 6%, СОЭ - 15 мм/час.

Спирограмма: ЖЕЛ - 58 %, ФЖЕЛ - 52 %, ОФВ1 - 29 % от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ – 57% (0,57). После ингаляции 400 мкг сальбутамола прирост ОФВ1 составил 2,12 % (30мл). Постбронходилатационный показатель ОФВ1/ФЖЕЛ 60% (0,6), ОФВ1 - 30 % от должного.

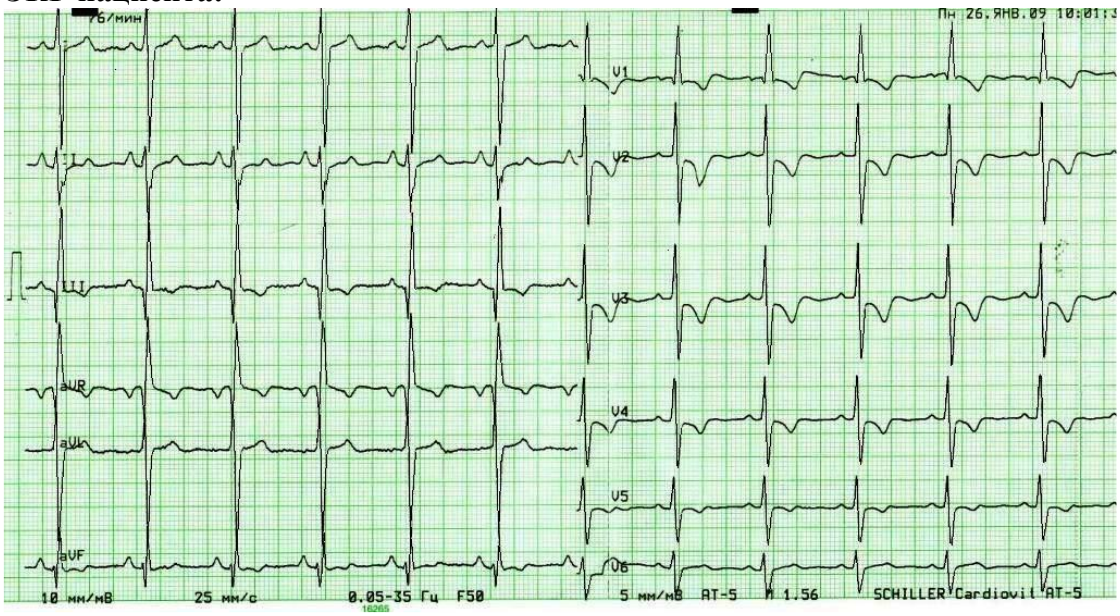
Пульсоксиметрия: сатурация кислорода (SaO2) в покое 92%, после теста с 6-минутной ходьбой 87%.

Стойкое нарушение функций дыхательной системы, согласно приказу Минтруда России № 585н составляет 70%

Рентгенограмма органов грудной клетки пациента:



ЭКГ пациента:



Задание

1. Оцените рентгенограмму органов грудной клетки и ЭКГ, дайте заключение.
2. Сформулируйте диагноз у данного больного.
3. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
4. Назначьте лечение пациенту.
5. Составьте план диспансерного наблюдения больного.
6. Есть ли у пациента признаки инвалидности? Если есть, то какой группы?

Задача № 57

Мужчина 48 лет обратился к участковому терапевту 12.05.2017 г. с жалобами на общую слабость, повышенную утомляемость, тупые ноющие боли в области правого подреберья, тошноту, отрыжку воздухом, снижение аппетита, периодически возникающий кожный зуд.

Из анамнеза известно, что пациент употребляет алкоголь (более 60 г этанола в сутки) в течение 13 лет. Два года назад появились боли ноющего характера в области правого подреберья, общая слабость, тошнота, периодически возникающий кожный зуд, усиливающийся в вечернее время. За медицинской помощью пациент не обращался. Периодически принимал баралгин, антигистаминные средства, ферментные препараты: креон по 25000 Ед. два раза в сутки; эффекта от принимаемых препаратов не отметил.

Настоящее обострение в течение последних трех дней, когда после употребления алкоголя появились слабость, почти постоянные тупые боли в области правого подреберья, тошнота, отрыжка воздухом, снижение аппетита.

Операций, гемотрансфузий не было.

Профессиональный анамнез: работает разнорабочим, работа связана со значительными физическими нагрузками.

При осмотре: состояние удовлетворительное; рост 178 см, вес 79 кг, ИМТ 24,9 кг/м2. Кожные покровы желтушной окраски, склеры иктеричны; выявляются телеангиэктазии на груди, спине, плечах, «пальмарная» эритема. В лѐгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 16 в мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС – 70 в 1 мин; АД 130/80 мм рт. ст. Язык влажный, обложен белым налѐтом у корня. Живот мягкий, при поверхностной пальпации умеренно болезненный в области правого подреберья. Размеры печени по Курлову: 9 (+2)×8×7 см; при глубокой пальпации печень плотноватой консистенции, определяется умеренная болезненность. Селезѐнка не пальпируется. Дизурий нет. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный.

Результаты исследований:

Общий анализ крови: эритроциты – 4,4×10^{12}/л; лейкоциты – 6,3× 10^9/л; нейтрофилы сегментоядерные – 64%; нейтрофилы палочкоядерные – 1%; лимфоциты – 28%; моноциты – 4%; эозинофилы – 2%; базофилы – 1%; Hb – 148 г/л; тромбоциты – 217×10^9/л; СОЭ – 18 мм/ч.
Биохимический анализ крови: общий билирубин – 30 мкмоль/л; непрямой билирубин – 26,5 мкмоль/л; прямой билирубин – 3,5 мкмоль/л; АЛТ – 203 ед/л; АСТ – 214 ед/л; ГГТП – 89 ед/л; ЩФ – 298 ед/л; ТГ – 3,9 ммоль/л; ХС-ЛПНП – 2,8 ммоль/л; ХС-ЛПВП – 1,5 ммоль/л; глюкоза – 5,0 ммоль/л; креатинин – 62 мкмоль/л; мочевина – 2,8 ммоль/л; альбумин – 43 г/л; общий белок – 71,5 г/л; альфа-1-глобулины – 3,2 г/л; альфа-2-глобулины – 5,7 г/л; бета-глобулины – 7,1 г/л; γ-глобулины – 12,5 г/л; альфа-фетопротеин – 3,1 ед/л; ферритин – 54 мкг/л; трансферрин – 2,6 г/л; калий– 3,7ммоль/л; Na– 137,5 ммоль/л; железо – 21,5 мкмоль/л; амилаза – 44 ед/л; ХС – 5,3 ммоль/л. ПТИ - 84%.
Кал на скрытую кровь – отриц. Рентгенологическое исследование лѐгких: без патологических изменений. ЭКГ – без патологических изменений. Общий анализ мочи: в пределах нормы.

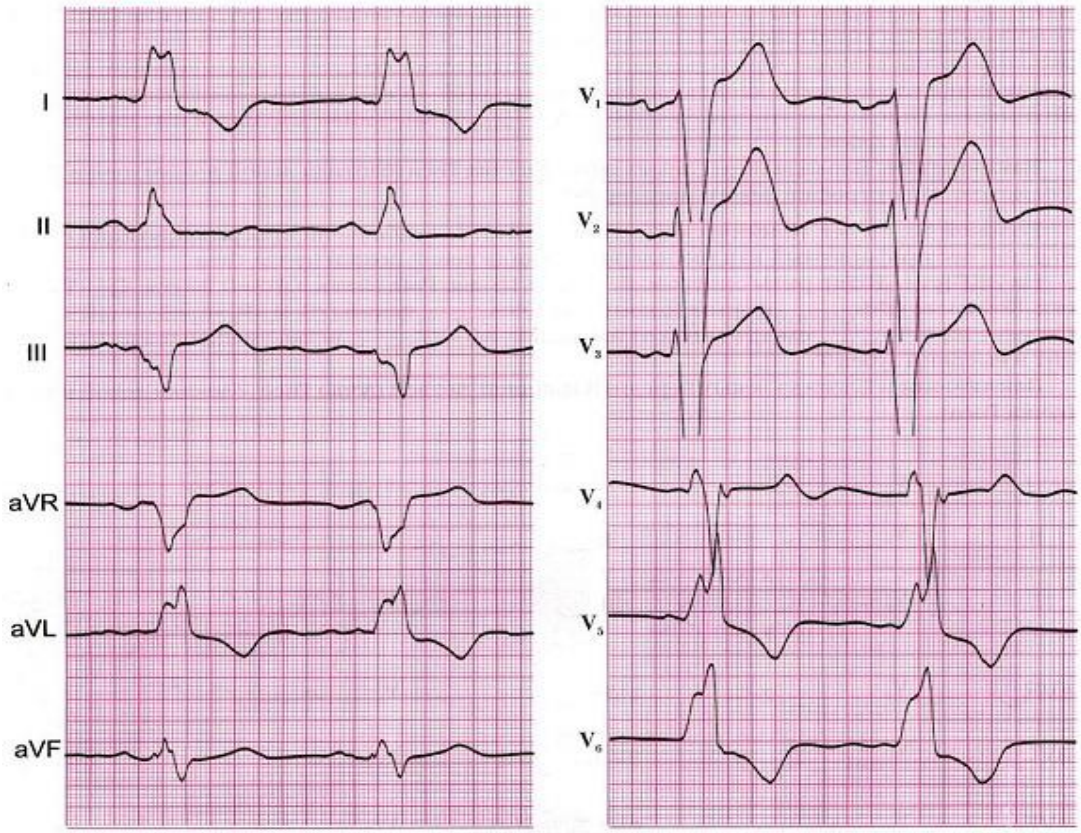
Задание

1. Сформулируйте наиболее вероятный диагноз и обоснуйте его.
2. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
3. Обоснуйте назначение медикаментозного и немедикаментозного лечения.
4. Составьте план дальнейшего наблюдения данного пациента.

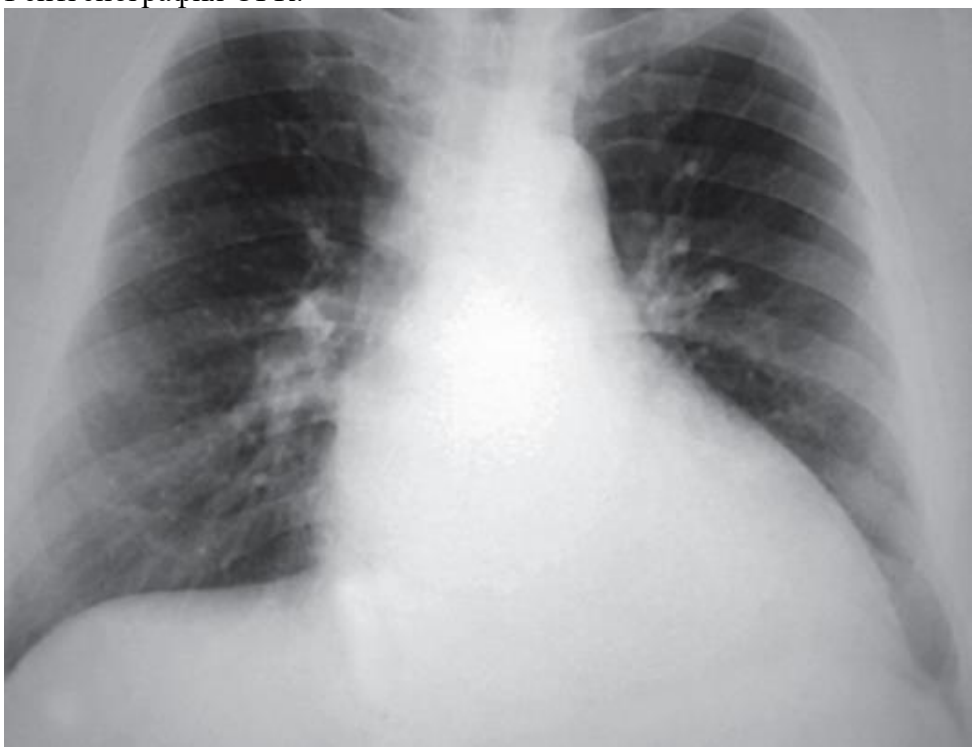
Задача № 58

Пациентка М., 64 лет, обратилась к участковому терапевту с жалобами на одышку инспираторного характера при небольшой физической нагрузке, отеки голеней до колен, общую слабость, утомляемость.
Анамнез заболевания: 10 лет страдает ИБС, 2 года назад перенесла инфаркт миокарда. 15 лет страдает гипертонической болезнью. Месяц назад впервые появилась одышка, которая постепенно нарастала, и неделю назад возникли отеки сначала стоп, затем голеней. Постоянно принимает препараты: аспирин 75 мг в сутки, изоптин СР 120 мг в сутки утром, крестор 10 мг вечером.
Объективно: Общее состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные. Отеки голеней и стоп симметричные.
Лёгкие: ЧД – 19 в мин. Перкуторный звук лёгочный, притупление ниже угла лопатки справа. При аускультации дыхание везикулярное, справа ниже угла лопатки ослаблено, слева выслушиваются ~~влажные~~ мелкопузырчатые хрипы.
Сердце: ЧСС- 100, пульс – 100, АД – 160/100 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Левая граница сердца по срединно-ключичной линии. Правая на 0,5 см кнаружи от правого края грудины.
Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см по средне-ключичной линии. Селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.
Лабораторные исследования: ОАК: Эр. – 2,8*10^9 /л; Hb – 100 г/л; лейк.- 4,5*10^{12} /л, лейкоцитарная формула б/о. ОАМ: б/о. Б/х анализ крови: креатинин – 135 ммоль/л; билирубин общ. – 18 ммоль/л; общий белок – 75 ммоль/л; холестерол общ. – 5,6 ммоль/л; ЛПНП – 2,5 ммоль/л; триацилглицеролы – 2,2 ммоль/л; глюкоза – 5,2 ммоль/л.

ЭКГ:



Рентгенография ОГК:



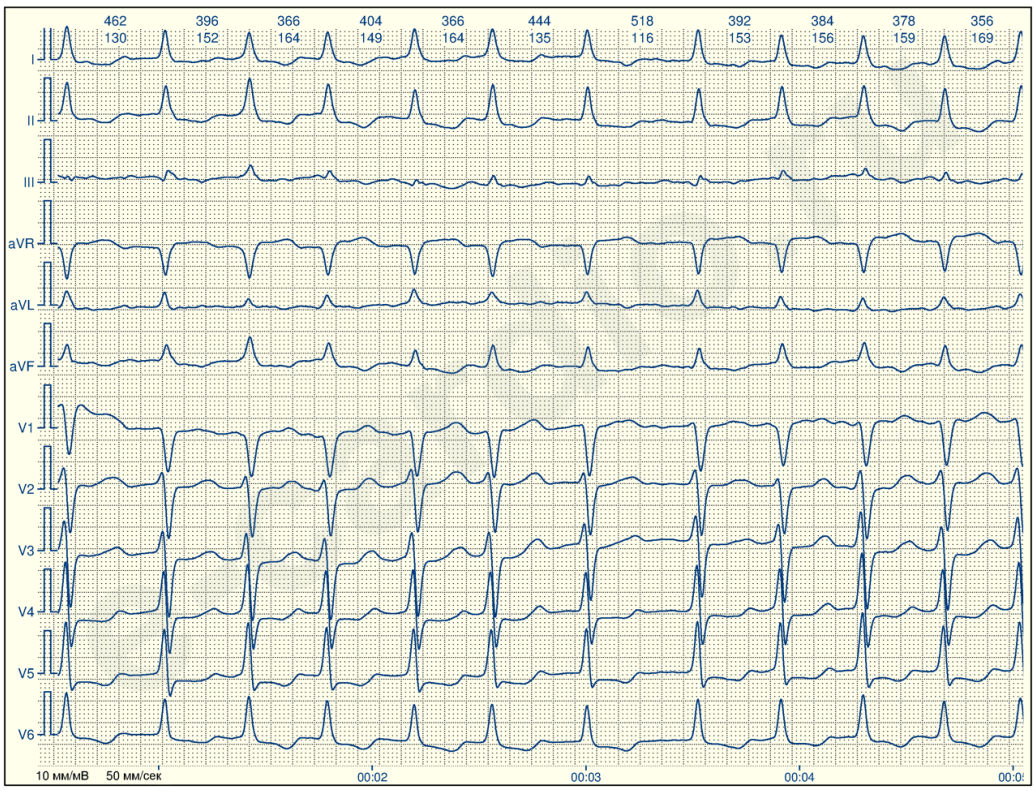
Задание

1. *Дайте заключение по параклиническим данным.*
2. *Сформулируйте и обоснуйте диагноз.*
3. *Составьте план дополнительного обследования пациентки.*

4. *Оцените терапию, получаемую пациенткой, при необходимости – внесите коррективы.*
5. *Составьте план диспансерного наблюдения пациентки.*

Задача № 59

Больная К., 70 лет, впервые обратилась на прием к участковому терапевту.
Жалобы: на общую слабость, одышку при незначительной физической нагрузке, небольшие отеки в области н/3 голеней, снижение памяти. Боли в грудной клетке, сердцебиение отрицает.
Из анамнеза: Много лет повышается АД, максимум – 180/110 мм рт. ст. Препараты принимала нерегулярно, при появлении симптомов. 15 лет назад диагностирован СД 2 тип, принимает метформин 1600 мг/сутки. Гликемию дома не контролирует, диету не соблюдает. 5 лет назад перенесла инфаркт миокарда, позже при ЭКГ-исследовании диагностировано нарушение ритма сердца. Назначались препараты, названия не помнит, недавно они закончились, поэтому обратилась в поликлинику. Отмечает усиление слабости, одышки.
Объективно: Общее состояние ближе к удовлетворительному. Повышенного питания, рост 165 см., вес 90 кг. ЧД – 20 в мин. При перкуссии – левая граница сердца на 2 см кнаружи от средне-ключичной линии. При аускультации – единичные влажные хрипы в нижних отделах лёгких, тоны сердца существенно приглушены, ритм неправильный, ЧСС – 130 в мин, АД – 165/100 мм рт. ст. Печень + 2 см. Пастозность голеней.
Результаты дополнительных исследований: ТТГ – 2,1. ОАК – гемоглобин - 135 г/л, эритроциты - 4,4х10^{12}/л, тромбоциты - 210х10^{9}/л, СОЭ - 8 мм/ч, лейкоциты - 4,5х10^{9}/л, Э-1%, П-0%, сегментоядерные - 70%, лимфоциты - 22%, моноциты - %. Гликированный гемоглобин – 9,3% и глюкоза натощак – 10,1 ммоль/л. Липидный спектр - общий холестерол – 6,0 ммоль/л, ЛПНП – 4,5 ммоль/л, ЛПВП – 0,9 ммоль/л, триацилглицеролы – 1,7 ммоль/л. Креатинин сыворотки – 93 мкмоль/л.
ЭХОКГ – гипертрофия левого желудочка, в задней стенке левого желудочка – участок гипокинеза, фракция выброса – 38%.
ЭКГ:



Задание

1. *Выделите ведущие клинические синдромы, дайте заключение по параклиническим данным.*
2. *Сформулируйте диагноз.*
3. *Составьте план дополнительного обследования*
4. *По шкале CHA2DS2-VASc оцените риск тромботических осложнений, определите, есть ли показания для терапии антикоагулянтами.*
5. *Определите цели терапии, назначьте лечение.*
6. *Составьте план диспансерного наблюдения.*

Шкала CHA2DS2-VASc

Фактор риска		Баллы
C	Congestive heart failure or Left ventricular systolic dysfunction (Хроническая сердечная недостаточность или дисфункция левого желудочка)	1
H	Hypertension (Артериальная гипертензия)	1
A_2	Age (Возраст) ≥ 75 лет	2
D	Diabetes mellitus (Сахарный диабет)	1
S_2	Stroke or TIA or thromboembolism (Инсульт, или транзиторная ишемическая атака, или тромбоэмболия в анамнезе)	2
V	Vascular disease Сосудистые заболевания, то есть заболевания периферических артерий, инфаркт миокарда, атеросклероз аорты	1
A	Age Возраст 65—74 года	1
Sc	Sex category Женский пол	1

Задача № 60

На врачебном участке наблюдается пациент Н., 63 лет с диагнозом:
Основное заболевание: Рак правой почки T3N1M1. Нефрэктомия справа от 2015 г. Химио- и таргетная от 2015 г. Прогрессирование от 2017 – метастазы в лёгкие, кости, печень.
Фоновое заболевание: Хронический пиелонефрит единственной левой почки. ХБП, СКФ 18 мл/мин/1,73 м2.
Осложнение основного заболевания: Хронический болевой синдром
Осмотр пациента на приеме.
Жалобы: на боли в межлопаточной области с иррадиацией в плечевой пояс, боль по характеру ноющая, с периодическими «прострелами» при неловких движениях, поворотах туловища. Интенсивность боли 7-8 баллов по ЦРШ. На боли в правом подреберье, постоянные, усиливаются после приема пищи, интенсивность 5-6 баллов. На кашель, одышку при умеренной физической нагрузке. На резкое снижение аппетита, потерю веса, общую слабость.
Из анамнеза: считает себя больным с 2015 года, когда при выполнении УЗИ почек было выявлено объемное образование правой почки. В дальнейшем был установлен вышеуказанный диагноз, проводилось специальное лечение. В 2017 году выявлено прогрессирование заболевания, врачебным консилиумом онкологического диспансера рекомендовано симптоматическое лечение по месту жительства.
Болевой синдром в течение года, постепенно усиливается. Последние несколько месяцев принимал трамадол 100 мг 4 раза в сутки, с хорошим эффектом. Ухудшение состояния в течение недели. Прием трамадола уменьшает боль на 20-30% на 1-2 часа. Часто просыпается ночью в связи с болью. Однократно обращался в Скорую Помощь в связи с усилением боли, вводился

морфин с хорошим обезболивающим эффектом, при этом пациент отметил выраженную сонливость, заторможенность, дезориентацию в течение суток после инъекции.
Объективный статус: Общее состояние ближе к средней степени тяжести, в связи с болевым синдромом и общей интоксикацией. Передвигается самостоятельно, медленно. Рост 178 см, вес – 70 кг. Кожа, слизистые бледные, тургор умеренно снижен. ЧД – 20 в мин. Дыхание жесткое, рассеянные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС 96 в мин., АД 140/90 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье. Край печени +5 см ниже края реберной дуги, плотный. Периферических отеков нет.

Задание

1. Сформулируйте полное диагностическое заключение по поводу боли.
2. Определите стадию ХБП.
3. Составьте план лечения болевого синдрома
4. Составьте конкретную схему фармакотерапии
5. Назовите формы рецептурных бланков для выписки рецептов.

Задача № 61

В женскую консультацию обратилась пациентка 24 лет. Жалобы на задержку менструации в течение 2 месяцев, тошноту, нагрубание молочных желез. В детстве перенесла корь, ветряную оспу. Беременность желанная. Женщина работает воспитательницей в детском саду. Две недели назад отметила сыпь на лице и груди, однократное повышение температуры до 38 °С. Данные симптомы связала с аллергической реакцией на морепродукты. Приняла таблетку антигистаминного препарата: сыпь прошла, температура больше не поднималась. К врачу не обратилась. Незадолго до этого был контакт с ребенком, больным краснухой (rubella). Объективно: состояние удовлетворительное, кожа чистая, несколько увеличены шейные лимфоузлы. Матка соответствует 10 неделям беременности, безболезненна, придатки не пальпируются. Выделения молочного цвета.

Задание

1. *Поставьте предварительный диагноз.*
2. *Составьте план обследования.*
3. *Акушерская тактика при подтверждении первичного инфицирования вирусом краснухи.*

Задача № 62

В послеродовом отделении городского родильного дома находится родильница 25-ти лет. Жалобы на озноб, повышение температуры тела, боли внизу живота. Роды произошли 2 дня назад, осложнение в третьем периоде родов - плотное прикрепление плаценты (placenta adhaerens). Проведена операция ручного отделения плаценты и выделения последа (separatio et extractio placentae manualis).
Объективно: в сознании, температура 38,3 °С, АД 120/80 мм рт. ст, пульс 96 в минуту, ритмичный, ЧДД 14 в минуту. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, незначительно болезненный в нижних отделах, дно матки на уровне пупка. Лохии кровянистые, без запаха. Молочные железы в состоянии умеренного нагрубания, при пальпации безболезненны.

Задание

1. *Поставьте клинический диагноз.*
2. *Объясните патогенез наступившего в послеродовом периоде осложнения.*
3. *Ваша тактика, медикаментозная терапия по стандарту.*

Задача № 63

В городской родильный дом доставлена роженица 23 лет, схватки начались 14 часов назад. Беременность третья. В анамнезе: срочные роды 3 года назад (мальчик 3100 грамм, 52 см), самопроизвольный выкидыш в 9 недель беременности год назад. Настоящая беременность доношенная. Схватки через 5–6 минут по 30 секунд, слабые. Роженица дремлет между схватками. Объективно: рост 163 см, вес 65 кг. Размеры таза 26-29-32-21 см. АД 110/70, 115/70 мм рт. ст. Положение плода продольное, предлежание головное, первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, positio prima, visus anterior). Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 ударов в минуту. Предполагаемая масса плода 3400 граммов.
Per vaginam: влагалище нерожавшей, шейка матки сглажена, края мягкие, растяжимые, открытие 4 см. Плодный пузырь цел. Головка плода прижата ко входу в малый таз, sutura sagittalis в правом косом размере таза, fonticulus parvus слева спереди. Мыс не достигается.

Задание
1. *Поставьте акушерский диагноз.*
2. *В какой фазе родов находится роженица?*
3. *Тактика ведения родов*

Задача № 64

Во время профилактического осмотра у 36- летней женщины обнаружена опухоль левого яичника, подвижная, гладкая, плотноэластической консистенции, размером 8×8 см. В анамнезе одни роды и два аборта. Менструальный цикл не нарушен. Содержание СА-125 в сыворотке крови 20 ЕД/мл, НЕ4 33,8 пмоль/л. При УЗИ органов малого таза: левый яичник представлен анэхогенным образованием размерами 75 х 80 мм, толщина капсулы 2,5 мм, внутренняя и наружная поверхность с ровным четким контуром, с единичными периферическими локусами при ЦДК, свободной жидкости в позадиматочном пространстве нет.

Задание
1. *Поставьте клинический диагноз.*
2. *Проведите дифференциальный диагноз между функциональной кистой яичника и цистаденомой.*
3. *Рациональное лечение при исключении признаков малигнизации.*

Задача № 65

Повторнородящая 32 лет поступила в перинатальный центр в первом периоде родов со схватками средней силы. Беременность 38 недель. В анамнезе 2 искусственных аборта, одни преждевременные роды в 33 недели беременности, которые закончились операцией экстренного кесарева сечения по поводу центрального предлежания плаценты.
Внезапно у роженицы появились сильные боли в животе, слабость, АД снизилось до 80/50 мм ртутного столба, пульс 120 в минуту. Из влагалища появились умеренные кровянистые выделения. Родовая деятельность прекратилась. Сердцебиение плода не прослушивается, головка плода сместилась вверх, отчетливо пальпируются мелкие части плода.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Мероприятия по оказанию неотложной помощи.
3.От чего зависит объем хирургического вмешательства?

Задача № 66

У пациентки 52 лет с ожирением, диабетом и артериальной гипертензией на фоне постменопаузы (3 года) появились кровянистые выделения из половых путей. В гинекологическом стационаре произведена гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала. Результат гистологического исследования: высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия, слизистая цервикального канала типичного строения.
Status genitalis: матка нормальных размеров, подвижна, безболезненна, грушевидной формы. Придатки матки не увеличены. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. Шейка матки не изменена. Кровянистые выделения из матки в небольшом количестве.

Задание
1.Поставьте предварительный диагноз и определите патогенетический вариант рака эндометрия у данной больной.
2.Проведите предварительное клиническое стадирование.
3.Перечислите возможные варианты лечения для данной больной.

Задача № 67

Первобеременная 24 лет госпитализирована в хирургическое отделение многопрофильного стационара с диагнозом: беременность 38 недель, острый аппендицит. Диагноз поставлен на основании тщательно собранного анамнеза, визуального осмотра и пальпации живота, выявления очага наибольшей болезненности при различных положениях беременной. Количество лейкоцитов в периферической крови 14,0 Г/л, в лейкоцитарной формуле обнаружен сдвиг влево с увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ 40 мм/ч.

Задание
1.Хирургическая тактика в данном случае.
2.От чего зависит тактика и объем операции при аппендиците у беременных?
3.По какой причине беременную с подозрением на острый аппендицит госпитализируют в хирургическое отделение, а не в акушерское?

Задача № 68

В дежурный гинекологический стационар обратились мать с дочерью 14 лет. У девушки обильное маточное кровотечение. Из анамнеза выяснено: менархе в 13 лет, менструации нерегулярные (через 6–8 недель, по 8–10 дней), обильные, со сгустками, безболезненные. Бывают эпизоды носового кровотечения с детского возраста.
При осмотре: кожные покровы бледные, пульс 82 в 1 минуту, ритмичный, АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный.
Status genitalis: наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу, девственная плева цела. Per rectum: матка нормальных размеров, безболезненна; придатки матки с обеих сторон не увеличены, клетчатка мягкая. Выделения из половых путей кровянистые, обильные.

Задание
1.Определение АМК в пубертатном периоде и классификация по течению.
2.Поставьте клинический диагноз.

3.Ваша тактика: диагностика и лечение по стандарту.
4. *Лечение: Схемы гормонального гемостаза и профилактика кровотечений.*

Задача № 69

Молодая нерожавшая женщина заболела остро на второй день после хирургического аборта. Жалобы на боль внизу живота, недомогание, повышение температуры тела до 39 °С, однократный озноб. Пациентка приняла таблетку аспирина, вызвала «скорую помощь» и была доставлена в дежурный гинекологический стационар. При обследовании отмечены бледность кожных покровов, тахикардия. Живот обычной формы, мягкий, болезненный при пальпации над лоном, симптомы раздражения брюшины отрицательны.
Status genitalis: матка несколько больше нормальных размеров, мягковатой консистенции, подвижная, болезненная, наружный зев закрыт. Маточные придатки не увеличены, безболезненны. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. Шейка матки визуально не изменена, выделения скудные, кровянистые, без запаха.
Лейкоциты 13,6 х 10^9, СРБ ++, СОЭ 35 мм в час

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Назначьте дообследование.
3.Назначьте эмпирическое лечение по предположительным и дополнительным критериям острого ВЗОМТ.
4.Тактика при подозрении на неполный аборт.

Задача № 70

В дежурный стационар бригадой скорой помощи доставлена пациентка 23 лет с жалобами на резкие боли внизу живота, тошноту, гнойно-кровянистые выделения из половых путей, частое мочеиспускание. Заболела остро во время очередной менструации. Женщина в браке не состоит, от беременности предохраняется ритм-методом. При поступлении состояние средней тяжести. Температура тела 39 °С, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 110 в 1 минуту. Живот умеренно вздут, имеется напряжение мышц передней брюшной стенки, положительный симптом Щеткина-Блюмберга в нижних отделах.
Status genitalis: при бимануальном исследовании определить матку и ее придатки не удается из-за резкой болезненности и напряжения мышц живота. Шеечный канал закрыт, бели гнойные с примесью крови.
Лейкоциты 14,6 х 10^9, СОЭ 25 мм в час, СРБ ++.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Назначьте дообследование пациентки.
3.Проведите дифференциальный диагноз.
4.Тактика по стандарту: базисное лечение, показания к хирургическому вмешательству.

Задача № 71

Пациентка 39 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на ноющие боли внизу живота и в поясничной области в течение последних трёх месяцев. Менструальный цикл не

нарушен. Страдает язвенной болезнью желудка, на диспансерном учёте в районной поликлинике по поводу язвенной болезни желудка не состоит.
Status genitalis: матка не увеличена, плотной консистенции. В области придатков матки с обеих сторон определяются подвижные плотные опухоли с бугристой поверхностью диаметром до 10 см. В позадиматочной клетчатке определяется инфильтрат в виде «петушиного гребня». Шейка матки визуально не изменена.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Назначьте дообследование.
3.Тактика для данной пациентки после уточнения диагноза.

Задача № 72

Женщина 38 лет направлена в гинекологическую клинику для проведения гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием, в связи с наличием хронического аномального маточного кровотечения и анемии (гемоглобин 80 г/л, сывороточное железо 7 мкмоль/л, ОЖСС 110 мкмоль/л, коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) 13,3%, ферритин сыворотки 8,0 нг/мл). Ритм менструаций сохранён.
В анамнезе 1 срочные роды и 2 самопроизвольных выкидыша. Контрацепция барьерная.
Status genitalis: шейка матки нормальных размеров, визуально не изменена, зев закрыт. Тело матки увеличено соответственно 8-недельному сроку беременности, тугоэластической консистенции. Маточные придатки не увеличены. Пациентка не желает подвергаться оперативному вмешательству с удалением матки, поскольку планирует беременность.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Обоснование диагноза
3.Составьте план обследования.
4.Ваша тактика после уточнения диагноза.
Задача № 73

В женскую консультацию обратилась больная 32 лет с жалобой на беспорядочные кровянистые выделения из половых путей. Из анамнеза выяснено, что пациентка в течение 4 лет периодически проходит лечение по поводу «эрозии» шейки матки в виде фармакоагуляции Солкогилом и применения влагалищных свечей. В анамнезе 1 роды и 2 аборта. От беременности предохраняется презервативом.
Status genitalis: шейка матки увеличена, на шейке визуализируется образование в виде «цветной капусты» диаметром до 3-х см. Тело матки нормальных размеров, придатки матки не увеличены, безболезненны, своды глубокие, свободны, околоматочная клетчатка не инфильтрирована, шейка матки при пальпации плотная, бугристая. Кровянистые выделения после осмотра.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Составьте план обследования по стандарту.
3.Тактика после верификации диагноза.

Задача № 74

У больной 38 лет, внезапно на работе развился приступ острых болей в нижних отделах живота. Менструальный цикл без изменений, в анамнезе 2 родов. От беременности предохраняется презервативом. В течение 3 лет пациентка находится на диспансерном наблюдении по поводу интрамуральной миомы матки. При поступлении в дежурный гинекологический стационар: АД 120/80 мм ртутного столба, пульс 90 в 1 минуту, удовлетворительного наполнения. Живот болезненный в нижних отделах, над лоном прощупывается верхний полюс плотной опухоли, исходящей из малого таза. Перитониальные симптомы отрицательные.
Status genitalis: матка увеличена до 14–15 недель беременности, бугристая, за счет множества узлов, один из них спереди 10×7×8 см, резко болезненный при пальпации. Клетчатка малого таза не инфильтрирована. Шейка матки без патологических изменений.
Уровень лейкоцитов12,3х10^9 г/л, СОЭ 30 мм/ час, СРБ ++.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Объясните патогенез наступившего осложнения.
3.Ваша тактика в первые сутки от появления болей.

Задача № 75

Женщина 48 лет направлена в гинекологическую клинику для хирургического лечения по поводу множественной миомы матки. Величина матки соответствует 24 неделям беременности. При осмотре в зеркалах обнаружены старые разрывы шейки матки и эктропион.
Результат гистологического исследования эндометрия: типичная гиперплазия эндометрия.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Необходимый объём обследования перед госпитализацией.
3.Решите вопрос об объеме оперативного вмешательства.

Задача № 76

Пациентка 32 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на болезненные, обильные менструации, мажущие тёмно-кровянистые выделения из половых путей до и после менструации. Менструации через 28 дней, по 7–8 дней, обильные в первые два дня, болезненные с менархе. Для купирования боли принимает анальгетики, спазмолитики – эффект недостаточный. В анамнезе одни срочные роды. Контрацепция - барьерная.
Status genitalis на 26 день цикла: шейка матки без патологических изменений, из цервикального канала выделяются тёмные кровянистые выделения в небольшом количестве. Тело матки шаровидной формы, несколько увеличено, плотной консистенции, подвижно, болезненно при пальпации. Маточные придатки не увеличены, безболезненны при пальпации. Клетчатка малого таза не инфильтрирована.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Объясните патогенез наиболее вероятной причины дисменореи.
3.Диагностические мероприятия и лечение.

Задача № 77

В женскую консультацию обратилась больная 52 лет с жалобами на боли внизу живота в течение 2-х лет, диспепсию, увеличение живота в объеме. Проводилось лечение у гастроэнтеролога по поводу колита. В анамнезе 3 родов, 4 аборта. Последний визит к гинекологу был 3 года назад. Постменопауза 2 года (МГТ не проводится). Объективно: живот увеличен, болезненный в нижних отделах, при перкуссии определяется наличие жидкости в брюшной полости.
Status genitalis: тело матки отдельно не определяется, в области придатков матки пальпируются плотные опухоли, малоподвижные, умеренно болезненные. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. Шейка матки визуально не изменена, выделения светлые.

Задание
1.Сформулируйте клинический диагноз.
2Составьте план обследования по стандарту.
3.Составьте план лечения.

Задача № 78

Машиной «скорой помощи» в гинекологическую клинику доставлена больная 22 лет с жалобой на выраженную слабость, головокружение после приступа острой боли в животе. Дома была кратковременная потеря сознания. Последняя менструация пришла 2 недели назад в ожидаемый срок. Пациентка незамужняя, половой партнёр постоянный. От беременности предохраняется ритмическим методом.
Объективно: кожные покровы бледные, влажные. АД 90/60 мм рт. ст., пульс 103 в мин. При исследовании живота отмечается положительный симптом Куленкампфа.
Status genitalis: матка не увеличена, в правильном положении, хорошо подвижна. Придатки матки пальпаторно не определяются, небольшая болезненность справа. Бели светлые.
Гемоглобин 90 г/л, эритроциты 3,9 х 10^{12}, Ht 32%, лейкоциты 6,8х10^{9}, СОЭ 19 мм/ час, СРБ +.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Проведите дообследование.
3.Проведите дифференциальный диагноз.
4.Тактика: мероприятия по неотложной помощи.

Задача № 79

В гинекологическое отделение по экстренной помощи поступила больная 31 года. Жалобы на боли в животе, слабость, головокружение, тошноту. Заболела внезапно, на работе. Отмечает задержку менструации на 10 дней. Имела 3 беременности: срочные роды и два искусственных аборта. От беременности предохраняется ритмическим методом. На догоспитальном этапе начата инфузионная терапия 0,9% раствором NaCl, введена транексамовая кислота (1 г в 100 мл 0,9% раствора NaCl). Объективно: состояние тяжёлое, резкая бледность, заторможенность, на вопросы отвечает с трудом. АД 70/55, 65/50 мм рт. ст., пульс 120 в мин., нитевидный, легко сдавливается. ЧДД 22 в минуту. Температура 36,6 ^{0}□С. Язык влажный. При пальпации живота отмечен симптом Куленкампфа.
Status genitalis: слизистая влагалища и шейки матки бледная, выделения из шейки матки тёмные, кровянистые, скудные. Задний влагалищный свод нависает. Пальпация матки и придатков матки затруднена из-за резкой болезненности, смещение матки вызывает сильную боль, определяется симптом «плавающей матки».

Задание
1. Поставьте предварительный диагноз.
2.Определите лечебно-диагностический алгоритм для данного случая, мероприятия по неотложной помощи.
3.Объём хирургического вмешательства, тактика послеоперационного ведения.

Задача № 80

Пациентка 26 лет поступила в дежурный гинекологический стационар с жалобами на боли в животе справа в течение 2 дней, слабость, головокружение, тёмные кровянистые выделения из половых путей. Боли иррадиируют в прямую кишку. Последняя менструация в срок 1,5 месяца назад. Половая жизнь с 23 лет, имела одну беременность, которая закончилась выкидышем. Контрацепция – прерванный половой акт. Объективно: состояние удовлетворительное, кожа бледная, температура 37,20 С, пульс 84 в мин., АД 110/70, 105/70 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в нижних отделах, больше справа, определяется слабо положительный симптом Щёткина-Блюмберга.
Status genitalis: слизистая влагалища и шейки матки обычной окраски, шейка матки визуально не изменена, выделения из цервикального канала скудные, тёмно-коричневого цвета. Тело матки несколько увеличено, смещение его вызывает резкую боль. Слева придатки матки не определяются. Справа от матки пальпируется опухолевидное образование тестоватой консистенции с нечёткими контурами. Содержание ХГЧ в сыворотке крови 480 МЕ/мл.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Проведите дифференциальный диагноз между прерывающейся внематочной беременностью и угрожающим выкидышем при малом сроке беременности.
3.Ваша тактика после исключения маточной беременности.

Задача № 81
В перинатальный центр доставлена роженица 33 лет, схватки через 2-3 мин. по 50 сек., сильные. Беременность 40 недель. Роды начались 4 часа назад, одновременно излились воды. Беременность шестая, в анамнезе одни срочные роды (partus maturus) и четыре искусственных выкидыша
Объективно: рост 152 см, вес 65 кг. АД 130/80,125/80 мм рт. ст. Пульс 90 в минуту. Размеры таза: 28-28-30-18 см. ВСДМ 38 см. ОЖ 105 см. Индекс Соловьева 1,6. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 удара в минуту. Признак Вастена «положительный». Во время схватки роженица беспокойна, кричит. Пальпация нижнего сегмента болезненна.
Per vaginum: влагалище рожавшей, шейка матки сглажена, открытие маточного зева 9 см. Передняя губа шейки матки отёчна. Головка плода прижата ко входу в малый таз, стреловидный шов (sutura sagittalis) в поперечном размере плоскости входа в малый таз, отклонен кпереди. Диагональная конъюгата (conjugata diagonalis) 11 см.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Объясните этиопатогенез наступившего в родах осложнения.
3.Мероприятия по оказанию неотложной помощи.

Задача № 82

В отделении анестезиологии и реанимации перинатального центра находится родильница 36-ти лет после операции кесарева сечения (caesarean section), выполненного двое суток назад в связи с наличием рубца на матке. С первых суток послеоперационного периода отмечается повышение температуры тела 37,9-38,6 °С. Проводится антибактериальная, инфузионная и симптоматическая терапия.
При осмотре: контакту доступна, на вопросы отвечает, температура тела 38,1 °С, пульс 124 в минуту, АД 110/70, 110/60 мм ртутного столба, язык сухой, обложен белым налетом. Живот вздут, мягкий, болезненный в нижних отделах, симптом Щеткина-Блюмберга слабоположительный. Перистальтика кишечника не выслушивается, газы не отходят, проводимая стимуляция кишечника малоэффективна.
Лейкоциты 20 х10^9, эритроциты 3,1 х 10^{12}, Нв 90 г/л, Ht 50%, тромбоциты 160 х 10^{12}; билирубин 20 мкмоль/л, креатинин крови110 мкмоль/л, лактат 2 ммоль/л, прокальцитонин 2 нг/мл.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Определите лечебную тактику

Задача № 83

В перинатальный центр из женской консультации бригадой скорой медицинской помощи доставлена первобеременная женщина 20 лет. Срок беременности 37 недель. Жалобы на плохой сон, головную боль, рвоту, мелькание «мушек» перед глазами. Чувствует себя плохо в течение 2-х недель, когда впервые появились отёки и головная боль. На учёте по беременности не состоит. В женской консультации пациентке была проведена противосудорожная терапия: магния сульфат 4 г сухого вещества (16 мл 25% раствора), дана таблетка Метилдопа 250 мг.
Объективно: рост 166 см, вес 83 кг. Кожа несколько бледная, одутловатость лица, отеки ног, передней брюшной стенки. Пульс 92 в минуту, АД 175/115, 180/110 мм рт. ст. Матка увеличена соответственно сроку гестации, при пальпации приходит в тонус. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 132 удара в минуту.
В приемном покое проведено внутреннее акушерское исследование: влагалище нерожавшей, шейка матки отклонена кзади, длиной до 2 см, плотной консистенции, зев закрыт, головка плода прижата ко входу в малый таз. Мыс не достигается.
После влагалищного исследования развился приступ судорог с потерей сознания.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Алгоритм оказания медицинской помощи в данной ситуации.
3.Укажите выбор времени и способа родоразрешения при данной акушерской патологии.
4.Оцените действия медицинских работников на догоспитальном этапе.

Задача № 84

В родильном блоке городского родильного дома находится роженица 28-ми лет. Беременность 40 недель. Срочные роды. Родовая деятельность продолжается 11 часов, излитие амниотической жидкости произошло 2 часа назад. Схватки сильные, через 2–3 минуты по 50 секунд, резко болезненные. Поведение роженицы беспокойное.
Объективно: АД 130/90, 140/90 мм рт. ст., пульс 96 в минуту. Матка во время схватки плотная, вне схватки почти не расслабляется. Положение плода продольное, предлежание головное,

первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima). Головка плода прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, 150 ударов в минуту.
Per vaginam: влагалище нерожавшей, шейка матки сглажена, края ее плотные, открытие маточного зева 5 см. Во время схватки тонус шейки матки повышается. Плодного пузыря нет. Предлежит головка, прижата ко входу в малый таз, стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева у симфиза.
Внезапно состояние роженицы резко ухудшилось: озноб, одышка, цианоз, АД 70/40, 60/40 мм рт. ст. Пульс 130 в минуту, нитевидный. Сердцебиение плода не выслушивается.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз
2.Проведите дифференциальный диагноз причины шока у роженицы.
3.Мероприятия по оказанию неотложной помощи.
4.Акушерская тактика.

Задача № 85

В перинатальный центр по экстренной помощи доставлена беременная 19 лет, беременность 35 недель. Беременность первая, последний месяц беременная женскую консультацию не посещала. Заболела остро 1 час назад. Появились сильные боли в животе, слабость. Позднее из влагалища началось кровотечение (приблизительно 100 мл).
Объективно: состояние средней тяжести. Сознание сохранено, кожные покровы бледные. АД 100/50, 100/60 мм рт. ст., пульс 100 в мин. Матка соответствует сроку беременности, напряжена, не расслабляется. Части плода определяются с трудом. Сердцебиение плода глухое, 100 уд/мин.
Per vaginam: влагалище нерожавшей, шейка матки сформирована, зев закрыт. Предлежит головка, расположена над входом в малый таз. Выделения кровянистые тёмного цвета со сгустками приблизмительно 200 мл.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Современный алгоритм оказания медицинской помощи при данном заболевании.
3.Обоснуйте выбор времени и способа родоразрешения при данной акушерской патологии.
4.Перечислите возможные осложнения, возникающие в ходе родоразрешения при этой патологии.

Задача № 86

В родильном зале городского родильного дома находится роженица 24 лет. Беременность третья, роды первые. В анамнезе один медикаментозный аборт, один самопроизвольный выкидыш (abortus spontaneus) в 13 недель с выскабливанием полости матки.
Объективно: состояние удовлетворительное. Рост 165 см, вес 70 кг. Соматически здорова. Т – 36,5, пульс – 90 в минуту, удовлетворительного наполнения, АД 110/60. Отеков нет.
Через 11 часов от начала схваток родилась живая доношенная девочка весом 3450 г. Через 10 минут после рождения ребенка признаков отделения плаценты нет, из влагалища выделяются умеренные кровянистые выделения. Кровопотеря 200 мл. А/Д 110/70, 110/60 мм рт. ст., пульс 94 в минуту.
Через 20 минут от рождения ребенка кровотечение продолжается в прежнем темпе. Признаков отделения плаценты нет. Кровопотеря 350 мл.

Задание
1.Сформулировать предварительный диагноз.
2.Объяснить данную клиническую ситуацию, обозначить факторы риска.
3.Обосновать тактику врача в данной сложившейся ситуации.

Задача № 87

В гинекологическое отделение городского родильного дома по «скорой помощи» поступила больная 20 лет с жалобами на повышение температуры тела, озноб, общую слабость, боли в животе, кровянистые выделения из влагалища. Задержка менструации на 3 месяца. Половая жизнь с 18 лет, в браке не состоит. С целью прерывания беременности пациентка вводила в полость матки катетер 3 дня назад.
Объективно: состояние тяжелое, в сознании, вялая, на вопросы отвечает с трудом. Цвет кожи землисто-серый, петехии, иктеричность склер, ладоней. Температура тела 39,2 °С, АД 100/60 мм рт. ст., пульс 140 в минуту, ритмичный, SpO2 92%, ЧДД 24, оценка по шкале Глазго 14 баллов. Язык сухой, обложен серым налетом. Живот мягкий, печень на 2 см выступает из-под края реберной дуги, пальпируется селезенка. Моча выведена катетером: 50-60 мл, бурого цвета.
Status genitalis: влагалище нерожавшей, матка увеличена до 12 недель беременности, болезненна при пальпации, придатки матки не увеличены, шейка матки укорочена до 2 см, наружный зев пропускает палец. Выделения умеренные, гнойного характера, с неприятным запахом.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Сепсис, определение. Шкала SOFA (упрощенная и расширенная)
3.Тактика ведения
4.Принципы интенсивной терапии, объем хирургического вмешательства.

Задача № 88
В перинатальный центр экстренно доставлена беременная 23 лет с обильным кровотечением из половых путей в сроке беременности 33 недели. В анамнезе 2 артифициальных аборта. Кровотечение началось около часа назад. В начале –незначительное, затем – выраженное. Приблизительный объём кровопотери до приезда бригады скорой медицинской помощи около 600 мл. Пренатальный скрининг II триместра беременности не прошла.
Объективно: кожные покровы и видимые слизистые бледные, умеренной влажности. Пульс 106 в мин. АД 90/60 мм рт. ст., 80/60 мм рт. ст., сатурация – 97%. Матка в нормотонусе, соответствует сроку гестации 33 недели. Положение плода продольное, предлежание головное, первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, positio prima visus anterior). Головка плода расположена высоко над входом в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, ритмичное, до 100 ударов в минуту. Околоплодные воды не изливались.
С целью выявления причины акушерского кровотечения проведено ультразвуковое исследование, при котором обнаружено, что плацента полностью перекрывает внутренний зев шейки матки.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Объясните, почему диагностический алгоритм при вагинальном кровотечении начинается с УЗИ, а не с влагалищного исследования.
3.Тактика: неотложные мероприятия и способ родоразрешения.
4.Возможные осложнения аномалии расположения плаценты

Задача № 89

В индивидуальном родильном зале перинатального центра находится родильница 32 лет. Беременность и роды четвертые. Родовая деятельность развивалась удовлетворительно, и через 9 часов родилась живая доношенная девочка массой 4450 гр. С целью профилактики кровотечения роженице введено внутримышечно 10 ЕД окситоцина.
Через 15 минут после рождения ребенка самостоятельно отделилась плацента и выделился послед – целый. Кровопотеря составила 250 мл. Через 20 минут из половых путей началось кровотечение. Проведена катетеризация 2 периферических вен, мочевого пузыря, начато введение кристаллоидов. Матка мягкая, при наружном массаже выделилось около 300 мл жидкой крови и сгустков. Матка стала несколько плотнее, затем снова расслабилась.
Состояние удовлетворительное, пульс 96 мин, АД 110/60 мм рт. ст, 110/70 мм рт. ст., сатурация O_2 98%.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Проведите дифференциальный диагноз по протоколу (четыре «Т»).
3.Тактика: последовательность мероприятий по остановке кровотечения, профилактика шока.

Задача № 90

Из ЦРБ в перинатальный центр доставлена первобеременная 25-ти лет. Беременность 35 недель. Жалобы на жажду, одышку, отеки ног, частое мочеиспускание. Диагноз сахарного диабета 1 типа установлен в возрасте 6 лет. Дебют сопровождался быстрым снижение массы тела в течение месяца, полиурией, полидипсией, кетоацидозом. Начата инсулинотерапия инсулинами средней (Протафан) и короткой продолжительности действия (Новорапид). Течение диабета характеризуется наклонностью к гипергликемии, кетоацидоз в возрасте 8–11 лет, позже эпизоды ацетонурии. Полинейропатии и нефропатия с 12 лет. Проходила лечение сулодексидом – микроальбуминурии нет. Ежегодно госпитализации для коррекции терапии. В 11 лет переведена на инсулин пролонгированного действия (Лантус), на время беременности Лантус заменен на Левемир.
Самоконтроль проводит до 5 раз в сутки, ХЕ учитывает. Гликемия 6–7 ммоль/л натощак, после еды 9–10 ммоль/л. Гипогликемии чаще в утренние часы, симптомы ощущает (чувство голода, дрожь, потоотделение).
Биохимический анализ крови: общий белок 65,5 г/л; мочевина 1,8 ммоль/л; креатинин 56,1 мкмоль/л; триацилглицеролы 1,37 ммоль/л; холестерол 6,56 ммоль/л; индекс атерогенности 2; гликированный НЬ 7,2%; ЛПНП 3.68 ммоль/л; ЛПВП 2,29 ммоль/л; глюкоза 7,8 ммоль/л. При УЗИ внутренних органов выявлен жировой гепатоз.
Объективно: рост 165 см, вес 92 кг. Отеки ног, передней брюшной стенки. Размеры таза нормальные. АД 120/80, 115/70 мм рт. ст. ВСДМ 44 см, ОЖ 106 см.
Положение плода продольное, предлежание головное, первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima). Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 ударов в минуту, слева ниже пупка.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Тактика ведения. Перечислите показания к досрочному родоразрешению.
3.Тактика: выбор метода досрочного родоразрешения.

Задача № 91

В послеродовом отделении ЦРБ находится родильница 29 лет. Срочные роды 5 дней назад, осложнились ранним излитием околоплодных вод и слабостью родовых сил. Ребенок приложен к груди через 2 часа после родов, сосет активно. На третьи сутки после родов отмечено нагрубание молочных желез, затруднённое сцеживание молока.
На пятые сутки после родов появился озноб, повышение температуры тела до 38,4 °С, головная боль, слабость, боль в правой молочной железе. Молочные железы в состоянии выраженного нагрубания, имеются трещины на сосках. В правой молочной железе в наружном квадранте пальпируется болезненное уплотнение, кожа над ним гиперемирована, горячая.

Задание
1.Поставьте клинический диагноз.
2.Перечислите предрасполагающие факторы заболевания. Клиническая классификация мастита.
3.Дополнительное обследование и лечение по стандарту.
4.Показания и способы подавления лактации.

Задача № 92

В санпропускнике многопрофильного стационара находится беременная 28-ми лет. Беременность 27 недель. Жалобы на боли в поясничной области справа, повышение температуры тела, озноб, слабость, головную боль. До настоящего времени считала себя здоровой, беременность протекала без осложнений.
Объективно: рост 160 см, вес 58 кг. Кожа чистая, бледная, горячая. Температура 38 °С, пульс 92 в мин, АД 120/80, 120/85 мм рт. ст. Справа в поясничной области при поколачивании определяется болезненность. Мочеиспускание безболезненное. Анализ мочи: моча соломенно-жёлтого цвета, мутная, удельный вес 1017, белок 0,066 г/л, лейкоциты сплошь в поле зрения. Живот мягкий, матка в нормальном тонусе, соответствует сроку 27 недель беременности. Положение плода продольное, предлежание головное, первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, positio prima). Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд в мин.

Задание
1.Поставьте диагноз.
2.Определение гестационного пиелонефрита. Факторы риска.
3.Дополнительное обследование и лечение по стандарту.
4.Возможные осложнения для беременной и плода.

Задача № 93

В отделении патологии беременности перинатального центра находится пациентка 23 лет. Беременность 36,4 недель. В анамнезе одни роды. В связи с заболеванием сердца (Ревматическая болезнь. Стеноз митрального клапана) 3 года назад ей была произведена операция протезирования митрального клапана двустворчатым шарнирным протезом с хорошим исходом. В течение 1 триместра беременности принимала Клексан, со 2 триместра принимает Варфарин.
Жалобы при поступлении на одышку и сердцебиение.
Объективно: рост 160 см, вес 63,5 кг. Кожные покровы нормальной окраски, небольшие отеки ног. Пульс в покое: 96 в минуту, единичные экстрасистолы. АД 100/70, 110/70 мм рт. ст., ЧДД

21 в минуту. Тоны сердца ясные, в лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. Печень пальпировать не удается из-за высокого стояния матки. Проводимая терапия: Варфарин, Панангин и Омепразол.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Медикаментозные средства для лечения беременных с ревматической болезнью сердца.
3.Тактика: выбор способа родоразрешения и обезболивания.

Задача № 94

В отделении патологии беременности городского родильного дома находится повторнобеременная 21 года. Беременность 27 недель. Жалобы на головокружение, слабость, утомляемость. Первые роды 1,5 года назад осложнились задержкой частей плаценты и кровотечением в раннем послеродовом периоде. Была проведена ручная ревизия полости матки (revisio cavi uteri manualis). Ребенка кормила грудью до 8 месяцев. Объективно: рост 163 см, вес 56 кг. Кожа бледная. Пульс 90 в мин, ритмичный. АД 95/60, 100/60 мм рт. ст. ЭКГ – синусовая тахикардия. Матка вне тонуса, ВДМ 24 см, ОЖ 85 см. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 165 ударов в минуту.
Анализ крови: Нв – 72 г/л, эр. – 2,2х1012, л – 5,2 х109, э – 2%, с – 74%, п/я – 3%, л – 18%, м – 3%, ретикулоциты – 14%, анизопойкилоцитоз, гипохромия эритроцитов. Содержание железа в сыворотке крови – 8 мкмоль/л, ферритин 3 нг/мл. Общий анализ мочи без патологических изменений.
При проведении допплерографии нарушений маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока не выявлено.

Задание
1.Поставьте акушерский диагноз.
2.Медикаментозное лечение по стандарту.
3.Возможные осложнения во время беременности и родов.

Задача № 95

В отделении патологии беременности перинатального центра находится пациентка 24 лет. Беременность 33 недели. В детстве перенесла скарлатину, корь, часто болеет ангинами. На учете у терапевта не состоит.
Объективно: рост 164 см, вес 61 кг. Кожа бледная, пастозность лица, отеки голеней. Пульс 86 в минуту. АД 120/70, 115/70 мм ртутного столба. Матка увеличена соответственно 31-32 неделям беременности. Положение плода продольное, предлежание головное, первая позиция, передний вид (situs longitudinalis, praesentatio capitis, visus anterior, position prima). Сердцебиение плода ясное ритмичное, 130 ударов в минуту.
При обследовании обнаружены изменения в анализах мочи: белок 2,65 г/л; микроскопия осадка мочи: лейкоциты 6-8 в поле зрения, эритроциты до 10 в поле зрения, гиалиновые и зернистые цилиндры, клетки почечного эпителия. Анализ мочи по Нечипоренко: л - 2600, эр - 25100. Анализ мочи по Зимницкому: суточный диурез 1100 мл, дневной 420 мл, ночной 680 мл. Колебания удельного веса 1007-1012. СКФ 63 мл/мин/1,73 м2

Задание
1. Поставьте акушерский диагноз,
2. Проведите дифференциальный диагноз экстрагенитального заболевания.
3. Тактика ведения пациентки на данном этапе.

Задача № 96

Больная 48 лет 1,5 месяца назад оперирована по поводу хронического калькулезного холецистита, выполнена эндоскопическая холецистэктомия. До операции болела около 6 лет, имел место эпизод кратковременной желтухи, купировался самостоятельно. В настоящее время предъявляет жалобы на интенсивные боли в правом подреберье и эпигастрии в течение 6-7 дней, желтушность склер, темную пенистую мочу и обесцвеченный стул в последние 2 суток.
Объективно: состояние удовлетворительное, пульс 80 уд/мин., АД 145/80 мм рт. ст., кожные покровы желтушные, склеры иктеричны. Живот не вздут, печень по краю реберной дуги, край острый, слабо болезненный при пальпации. Температура 37.2 С.
На УЗИ установлено, что печень обычной эхогенности, желчный пузырь не визуализируется, внутрипеченочные желчные протоки расширены, холедох 15 мм в диаметре.
Лабораторно:
ОАК: Hb 120 г/л, Эр.4,0*1012/л, ЦП 1,0 L 19*109/л.
ОАМ: тем/ж, удельный вес 1015, белок 0,03, глюкоза отр., лейкоцит 0-1 в п/з, эп. ед-но в п/з, желчные пигменты +++
БАК: билирубин общий/прямой - 60/40 мкмоль/л, альфа-амилаза 83 Е/л, креатинин 0,12 ммоль/л, глюкоза 6,9 ммоль/л, мочевина 9,1 ммоль/л, АСТ 40 ед/л, АЛТ 60 ед/л, общий белок 70 г/л.
ССК: фибриноген общ. 3,73 г/л, МНО 0,5, РФМК 3,0 г/л

Задание:
1. *Предположите наиболее вероятный диагноз.*
2. *Какое необходимо провести дополнительное обследование, предположите результаты.*
3. *Составьте дифференциально-диагностический ряд*
4. *Определите дальнейшую лечебную тактику*
5. *Перечислите возможные осложнения в случае неадекватного лечения*

Задача № 97

Молодой человек, 26 лет, жалуется на боли в правой кисти в течение недели. После физической работы на ладони в области подушечки 3-4 межпальцевого промежутка появилась мозоль, которая нагноилась, выраженный отек тыльной поверхности кисти. Три дня назад мозольный абсцесс пациент самостоятельно вскрыл в домашних условиях, выделилось скудное количество гноя, однако через несколько часов боль в кисти усилилась, распространилась на всю ладонь, стала нарастать припухлость тыла кисти.
Объективно: пальцы правой кисти равномерно отечны, находятся в полусогнутом положении, несколько разведены в стороны друг от друга, болезненно как сгибание, так и разгибания 3-4 пальцев. В области межпальцевого промежутка 3-4 пальцев – лишенная эпидермиса раневая поверхность 1х0,5см со скудным отделяемым. Ладонная ямка кисти сглажена, болезненна при пальпации. Отмечается болезненность передней поверхности дистальных отделов предплечья, отек на тыльной поверхности кисти. Зондовая пальпация тыла кисти, а также по ходу сухожилий сгибателей на уровне основной и средней фаланг всех пальцев - слабо болезненна, в проекции ладонного апоневроза – резко болезненна. Температура тела повышена до 39°С. В подмышечной области пальпируются болезненные увеличенные лимфатические узлы.

Задание:
1. *Сформулируйте диагноз.*
2. *Обоснуйте поставленный диагноз. Опишите последовательность развития осложнений и путь распространения гнойно-воспалительного процесса в анализируемой клинической ситуации.*
3. *Какие обследования Вы назначите пациенту.*

4. Перечислите, какие еще осложнения возможны у данного больного и почему? Где и какое лечение показано пациенту?

Задача № 98

У больной 30 лет около 6 часов назад появились боли в эпигастральной области, однократная рвота желудочным содержимым. При осмотре в поликлинике состояние удовлетворительное. Язык влажный, слегка обложен. Живот не вздут, мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии и правой подвздошной области. Положительные симптомы Ровзинга, Ситков-ского, Бартомье-Михельсона. Перитонеальные симптомы отсутствуют. Температура тела 37,8°С, ЧСС 80, лейкоциты крови 11,0 х 109/л. Гинекологический анамнез без особенностей, очередная менструация должна начаться через 2-3 дня.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *Укажите варианты расположения червеобразного отростка и особенности клинической картины острого аппендицита в зависимости от локализации аппендикса.*
4. *С какими урологическими, гинекологическими и инфекционными заболеваниями чаще всего приходится дифференцировать аппендицит.*
5. *Каким должен быть алгоритм действий врача общей практики в анализируемой клинической ситуации? Диагностическая и лечебная тактика врача приемного покоя?*

Задача № 99

В хирургическую клинику по скорой помощи доставлена больная 82 лет. За 12 часов до обращения появились сильные боли по всему животу, сильная слабость, холодный липкий пот, вздутие живота, была двукратная рвота, которая не принесла облегчения, жидкий стул с примесью темно-багрового цвета крови в небольшом количестве. При осмотре состояние больной тяжелое. Язык сухой. Живот равномерно вздут, при пальпации определяется бо-лезненность больше справа и образование тестоватой консистенции без четких контуров. Передаточная пульсация абдоминального отдела аорта – сохранена. Аускультативно – перистальтические шумы прослушиваются слабо. Перитонеальные симптомы в среднем и нижнем этаже брюшной полости – сомнительные.
В анамнезе ИБС: постоянная форма фибрилляции предсердий, тахиформа. ПИКС неуточненной давности. Хроническая сердечная недостаточность 1, ФК 2 по NYHA. Гипертоническая болезнь 3 стадия. Контролируемая АГ. Хроническая болезнь почек С1 (Скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKD-EPI): 97 мл/мин/1,73м2). Риск ССО 4. Целевое АД 130/70 мм рт ст. Шкала HAS-BLED - балла, шкала CHA (2) DS (2)-VASc - баллов.

ОАК: Hb 95 г/л, Эр.2,8*10^{12}/л, ЦП 1,0, L 20*10^{9}/л.
ОАМ: желт., сл мут., удельный вес 1015, белок 017., глюкоза отр., лейкоцит 0-1 в п/з, эпителий ед в п/з.
БАК: билирубин общий/прямой 10,6/0 мкмоль/л, альфа-амилаза 83 Е/л, креатинин 120 мкмоль/л, глюкоза 7,9 ммоль/л, мочевина 9,1 ммоль/л, АСТ 14е/л, АЛТ 20 е/л, общий белок 65 г/л.
ССК: фибриноген общ. 5,2 г/л, МНО 0,85, РФМК 5,0 г/л
Обзорная рентгенография брюшной полости: определяется выраженная пневматизация петель тонкой кишки с формирующимися горизонтальными уровнями в правой подвздошной области, единичный толстокишечный уровень справа.

УЗИ ОБП: Заключение: Диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы. ЖКБ с признаками хронического холецистита.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику?*
4. *Необходимый объем исследований?*
5. *Причины развития данного патологического состояния?*
6. *Какое лечение показано у данного больного?*

Задача № 100

Женщина 45 лет, не болевшая и ранее не обследовавшаяся, предъявляет жалобы на боли в правом подреберье с иррадиацией в правую половину грудной клетки, тошноту, повторную рвоту желудочным содержимым с примесью желчи. Заболела остро 2 суток назад - около 8 часов вечера появились довольно сильные боли, описанные выше, уменьшившиеся в интенсивности на следующее утро. В течение двух дней отмечается субфебрилитет. Общее состояние средней степени тяжести. Отмечается субиктеричность склер. Положителен симптом Ортнера. В правом подреберье пальпируется болезненный желчный пузырь. Перитонеальных знаков нет. Температура тела 37,2℃.
ОАК: Hb 135 г/л, Эр.3,8*10^{12}/л, L 12*10^{9}/л.
ОАМ: желт., сл мут., удельный вес 1015, белок отр., глюкоза отр., лейкоцит 0-1 в п/з, эпителий ед в п/з.
БАК: билирубин общий/прямой 22/5 мкмоль/л, альфа-амилаза 50 Е/л, креатинин 0,12 ммоль/л, глюкоза 6,9 ммоль/л, мочевина 5,1 ммоль/л, АСТ 25 е/л, АЛТ 45 е/л, общий белок 70 г/л.
ССК: фибриноген общ. 2,0 г/л, МНО 0,5, РФМК 3,0 г/л
УЗИ: Печень не выступает из-под края реберной дуги, поверхность ровная, КВР 155 мм, ткань неоднородная, обычной эхогенности. Желчные протоки не расширены.
Желчный пузырь 103*52 мм, стенка толщиной 4 мм, в шейке визуализируется компонент размером 20*15 мм с наличием акустической тени. Поджелудочная железа видна фрагментами, на видимых участках ткань неоднородная, повышенной эхогенности.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз? Обоснуйте поставленный Вами диагноз (перечислите диагностические критерии острого холецистита).*
2. *Составьте план обследования пациентки.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Показания к оперативному лечению при данной патологии?*
5. *Укажите вероятные причины данного заболевания.*

Задача № 101

Больной, 38 лет, обратился с жалобами на боли в эпигастрии, усиливающиеся после еды, похудание, периодические повышения температуры тела до субфебрильных цифр. Около года назад лечился в стационаре по поводу острого панкреатита. Злоупотребляет алкоголем. Ухудшение состояния в течение последних 6 месяцев. Амбулаторно перенес 3 отчетливых обострения. В момент осмотра состояние относительно удовлетворительное. Живот участвует в ды-

хании, мягкий, практически безболезненный. Около пупка рубец от лапароцентеза. В эпигастрии пальпируется инфильтрат, образование без четких контуров, неподвижное. Общий анализ крови и мочи, билирубин, мочевина, креатинин, амилаза. щелочная фосфатаза, трансаминизы - в пределах нормы. При УЗИ - в области тела и хвоста поджелудочной железы определяется жидкостное образование до 8 см с хорошо выраженными стенками, без внутренних структур.

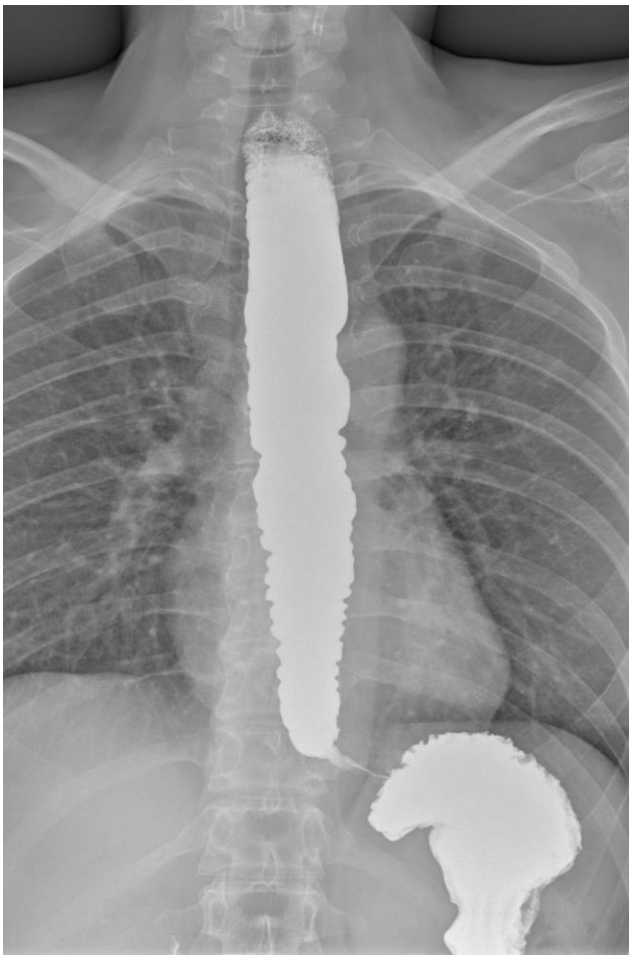
Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Укажите возможные причины данного заболевания.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии*

Задача № 102

Больная 30 лет в течение последних 6 месяцев отмечает нарушение глотания. При рентгенологическом исследовании выявлено, что пищевод умеренно расширен на всем протяжении, натощак содержит небольшое количество содержимого, газовый пузырь желудка отсутствует. Контуры пищевода ровные, четкие. Периодически порции бария проникают в желудок.





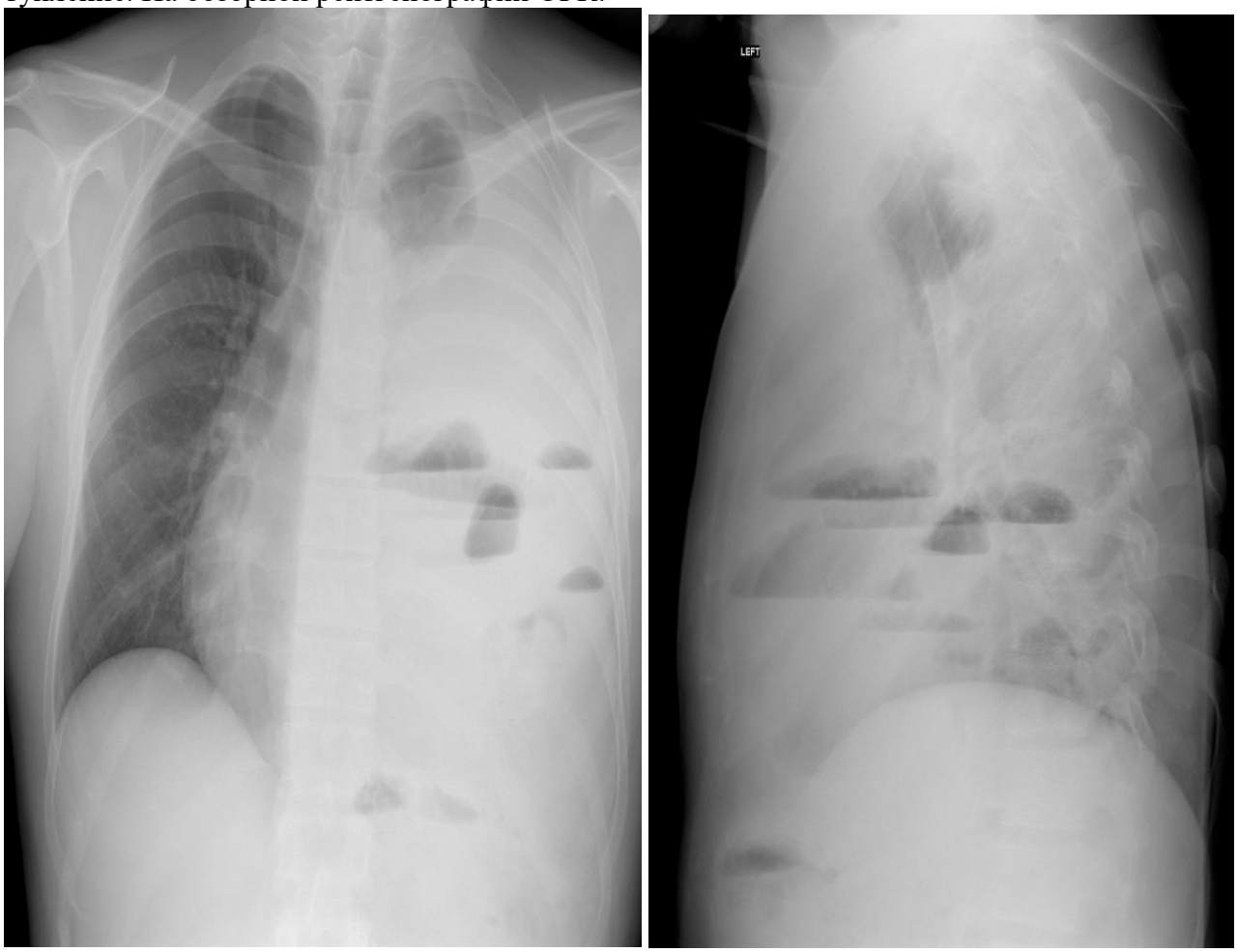
Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз? Обоснуйте Ваш диагноз.*
2. *Составьте план необходимого обследования больного.*

3. *Проведите дифференциальную диагностику у данного пациента.*
4. *Какова Ваша лечебная тактика?*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 103

У больного 25 лет при резком поднятии тяжелого предмета появились резкие боли в левом подреберье, левой половине грудной клетки с иррадиацией в левое плечо, одышка. Объективно: акроцианоз, частота дыхания 40, тахикардия 120 в мин., мерцательная аритмия. При аускультации в левой половине грудной клетки дыхание не прослушивается, перкуторно притупление. На обзорной рентгенографии ОГК:



Задание:
1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Перечислите рентгенологические признаки данного заболевания.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 104

Больной 53 лет, в анамнезе 10 лет назад резекция желудка, последние полгода отмечает умеренно выраженную дисфагию, проявляющуюся чувством “задевания”, “царапания” при прохождении грубой пищи по пищеводу. За неделю до госпитализации появилась осиплость голоса. При ларингоскопии - снижение тонуса голосовой складки. При рентгенологическом исследовании пищевода на уровне Th VIII-IX определяется сужение пищевода, просвет до 5 мм с неровными контурами. Газовый пузырь желудка сохранен.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Перечислите признаки неоперабельности при данной патологии.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 105

Мужчина 58 лет доставлен в приемное отделение с обильной рвотой "кофейной гущей" и повторной меленой, последовавшими вслед за коллапсом 3 часа назад. В течение двух недель этому предшествовала общая слабость, неоднократный черный плохо оформленный стул. Последние несколько лет отмечает боли в эпигастральной области, которые недавно начали иррадиировать в спину. Никогда ранее не лечился и не обследовался.
Состояние больного средней степени тяжести, пульс 96 в мин., АД 105/75 мм рт. ст.
ФГДС: при срочной гастроскопии в области угла желудка найден глубокий язвенный кратер 3,0 х 3,0 см с активным кровотечением из крупного сосуда в дне язвы.

Задание:

1. *Сформулируйте Ваш диагноз?*
2. *Какова Ваша лечебная тактика?*
3. *Назначьте больному консервативную терапию.*
4. *Показания к экстренной операции у данного больного?*
5. *Возможные варианты хирургического лечения.*

Задача № 106

Женщина 40 лет поступает с жалобами на схваткообразные боли в животе, повторную обильную рвоту с примесью желчи. Больна в течение трех дней. Несколько лет назад перенесла холецистэктомию по поводу хронического калькулезного холецистита. Объективно: живот асимметричен и чуть болезнен, без перитонеальных симптомов, определяется "шум плеска". При обзорной рентгеноскопии живота определяются множественные тонкокишечные уровни.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Основные принципы консервативной терапии?*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии*

Задача № 107

Больной 76 лет поступил в дежурный стационар с жалобами на выраженную интенсивную боль в верхнем отделе живота и околопупочной области с иррадиацией в поясницу, левое бедро, наружные половые органы, слабость, головокружение. Из анамнеза выявлено, что в течение последнего года отмечал ноющую боль в животе, неустойчивый стул со склонностью к запорам, неприятные ощущения в поясничной области, онемение стоп. В течение 30 лет страдает гипертонической болезнью, АД 140/90 мм рт. ст., отмечаются повышения до 180 мм рт. ст. Два года назад перенес инфаркт миокарда. При объективном обследовании артериальное давление 90/60 мм рт. ст., пульс 110 в мин. Кожные покровы бледные. Живот мягкий, не напряжен, перитонеальные симптомы отрицательны. В эпигастральной области определяется пульсирующее объемное образование без четких контуров, не смещаемое, резко болезненное. Аускультативно над образованием определяется систолический шум.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Проведите дифференциальную диагностику у данного больного.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 108

Больной 54 лет трое суток назад после рыбалки стал отмечать боли за грудиной и эпигастрии с иррадиацией в спину и левую лопатку, усиливающиеся при глотании, принимал нитроглицерин, без эффекта. Состояние резко ухудшалось: боли усилились, появилась одышка, резкая слабость, головокружение. При поступлении состояние тяжелое, бледен, Ад 100/40 мм рт. ст., пульс 110 в мин., Т=39 градусов, в надключичной области слева крепитация, дыхание частое, поверхностное, сердечные тоны глухие, ритмичные. При пальпации мышечное напряжение в эпигастральной области. На обзорной рентгенографии органов грудной клетки расширение и эмфизема заднего средостения.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Проведите дифференциальную диагностику у данного больного.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 109

В приемный покой доставлен мужчина 48 лет с жалобами на слабость, головокружение, умеренные боли в левом подреберье. Из анамнеза известно, что 12 часов назад он упал с лестницы и ударился левой реберной дугой. Вначале чувствовал себя удовлетворительно, а 2 часа назад при ходьбе внезапно наступила слабость, головокружение, обморочное состояние. Больной лежит в вынужденном положении на левом боку. Кожные покровы бледные, пульс 120 в мин., АД 90/50 мм рт. ст. Пальпаторно отмечается умеренное напряжение мышц брюшной стенки, притупление звука в левом подреберье и внизу живота.

Задание:

1. *Какой наиболее вероятный диагноз?*
2. *Перечислите необходимые дополнительные обследования.*
3. *Какова Ваша лечебная тактика?*
4. *Проведите дифференциальную диагностику у данного больного.*
5. *Варианты хирургического лечения при данной патологии.*

Задача № 110

Больная 62 лет обратилась в поликлинику на прием к неврологу. Из анамнеза: 5 часов назад внезапно появились нестерпимые боли в левой кисти и предплечье, сопровождающиеся слабостью и онемением пальцев. Три года назад пациентка перенесла ОНМК. Пульс аритмичный, 100 в мин. Аускультативно диастолический шум на верхушке сердца.
Status localis: при осмотре асимметрии верхних конечностей нет, активные движения в кисти и лучезапястном суставе пораженной конечности ограничены, пассивные сохранены, сила левой кисти значительно снижена по сравнению с правой, левая кисть холоднее правой. Бледность кожных покровов с незначительным цианотичным оттенком левой кисти, н/3 предплечья, гипостезия кожных покровов кисти. В аксиллярной области пульсация отчетливая, в области нижней трети плеча и дистальнее не определяется.

Задание:

1. *Назовите наиболее вероятный диагноз. Обоснуйте диагноз.*
2. *Какие инструментальные исследования могут подтвердить диагноз?*
3. *Дальнейшие действия врача невролога.*
4. *Какова дальнейшая тактика лечения? Какие операции выполняются при данном заболевании?*
5. *В назначении каких препаратов нуждается больная?*

Задача № 111

Больная 46 лет, в возрасте 20 лет перенесла вирусный гепатит В, в последующем вплоть до настоящего времени считала себя здоровой. Поводом к настоящей госпитализации явилась внезапно возникшая общая слабость, бледность, головокружение, двукратно черный дегтеобразный стул. Объективно: состояние средней тяжести, АД 90/60 мм рт. ст., пульс 96, кожные покровы бледные, склеры субиктеричные, язык сухой, обложен белесоватым налетом. Живот значительно увеличен в объеме. При эндоскопическом исследовании выявлено варикозное расширение вен нижнегрудного и абдоминального отделов пищевода III ст., продолжающееся кровотечение из дефекта в стенке одной из вен. Анализ крови: Hb 90г/л, эр. 2.9 х 10^{12}/л, L 10.6 х 10^{9}/л, билирубин общий 25,5 ммоль/л, прямой 7,5 ммоль/л, АЛТ 34МЕ/л (N10-35), АСТ – 58 МЕ/л.

Задание:

1. *Назовите наиболее вероятный диагноз.*
2. *Какие дополнительные исследования следует провести у пациентки?*
3. *В назначении каких препаратов нуждается больная?*
4. *Какова Ваша тактика лечения?*
5. *Развитие каких осложнений можно предполагать у пациентки?*

Задача № 112

Больной С., 22 лет, поступил в дежурный хирургический стационар с жалобами на тупые, ноющие боли в правой подвздошной области, на повышение температуры тела до 38 С по вечерам, на слабость, тошноту, сухость во рту. Больным себя считает в течение 5 дней, когда, как ему кажется, после употребления недоброкачественной пищи появились умеренные боли в эпигастрии, которые сопровождались двухкратной рвотой, принесшей облегчение. Затем боли локализовались в правой подвздошной области. Для снятия болей принимал спазмолитики, анальгетики. Ввиду продолжающихся болей и появления температуры обратился к участковому терапевту, который направил его в дежурный хирургический стационар.
Объективно: Т=38,2 ^{0}С, язык густо обложен белым налетом, суховат. Со стороны органов грудной клетки патологии не выявлено. ЧСС 88 в мин. Живот обычной формы, правая половина отстает в акте дыхания. В правой подвздошной области определяется объемное образование без четких контуров размером 8х10 см, малоподвижное, болезненное при пальпации. Положительный симптом Ровзинга, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. ОАК: L-9,4 х 10^9/л, ОАМ без патологии. Пальцевое исследование прямой кишки: ампула пустая, стенки безболезненные, нависания нет.

Задание:

1. *Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз.*
2. *Какие исследования необходимо провести для подтверждения диагноза?*
3. *Проведите дифференциальную диагностику.*
4. *Какова тактика лечения у данного больного?*
5. *Развитие каких осложнений можно предполагать у пациента?*
6. *Какова диагностическая и лечебная тактика на амбулаторном этапе после выписки больного из стационара?*

Задача № 113

Пациентка П., 38 лет, поступила в дежурный хирургический стационар в порядке скорой помощи с жалобами на сильные боли в правом подреберье, иррадиирующие в правую половину грудной клетки, затылок, правую верхнюю конечность. Больна в течение 48 часов. Ранее подобных приступов болей не наблюдалось. Объективно: Т- 37,7 С, кожные покровы бледные с легким желтушным оттенком, умеренная иктеричность склер, мягкого неба. Язык умеренно обложен белым налетом. Органы грудной клетки без патологии. Живот: округлой формы, правая половина отстает в акте дыхания, при поверхностной пальпации умеренное напряжение и болезненность в правом подреберье, пальпируется увеличенный болезненный желчный пузырь.
В ОАК: L - 10,2 х 10^9/л, Э-5, П-7, С-70, М-2, Л-18, СОЭ-18 мм/ч. Билирубин 120 мкм/л, прямой 80, непрямой 40, щелочная фосфатаза 420 Е/л, УЗИ: печень не увеличена, имеются отдельные участки повышенной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки расширены равномерно в обеих долях. Желчный пузырь размером 85х35 мм, стенка утолщена, в просвете неоднородное содержимое, конкременты от 0,1 до 0,3 см. Холедох расширен до 1,5 см. В дистальной его части определяется эхопозитивное образование размером 0,8х0,6 см, с акустической тенью. ЭФГДС: в желудке слизь, очаговая гиперемия слизистой. БДС на обычном месте, не выбухает, желчь в ДПК не поступает.

Задание:

1. *Назовите наиболее вероятный диагноз.*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *Назовите УЗИ признаки данного заболевания*
4. *Какие дополнительные исследования следует провести у пациентки?*

5. *Какова Ваша тактика лечения?*

Задача № 114

Пациентка 58 лет поступила в приемный покой ОКБ через 6 часов от начала заболевания с жалобами на нестерпимые, опоясывающего характера боли в верхней половине живота, рвоту, не приносящую облегчения, слабость, головокружение, неотхождение газов. Заболевание связывает с употреблением жирной, пережаренной пищи. В анамнезе ЖКБ, хр. холецистит в течение 4 лет. При объективном обследовании обнаружена легкая иктеричность склер, сухой обложенный язык. Тахикардия до 100 уд. в мин. При пальпации живота отмечается выраженная ригидность мышц в эпигастрии, отсутствие пульсации аорты, вздутие поперечно-ободочной кишки.

Задание

1. *Назовите наиболее вероятный диагноз.*
2. *Активность каких ферментов необходимо определить в данном случае?*
3. *Назовите УЗИ признаки данного заболевания*
4. *Какова Ваша тактика лечения?*
5. *Развитие каких осложнений можно предполагать у данного пациента?*

Задача № 115

Больной П., 53 лет, поступил в дежурный хирургический стационар с жалобами: на слабость, липкий холодный пот, рвоту типа “кофейной гущи” в объеме до 1600мл, мелькание “мушек” перед глазами. В анамнезе у больного хр. гастрит с пониженной секрецией желудочного сока. Предшествующая алкоголизация. Кожные покровы бледные, язык обложен грязно-серым налетом, суховат. Пульс слабого напряжения и наполнения, ЧСС 100 в мин., АД 100/60 мм рт. ст. При пальпации отмечается умеренная болезненность в эпигастрии. При эндоскопическом исследовании в кардиальном отделе желудка найден линейный разрыв слизисто-подслизистого слоя, длиной до 4 см, из которого струйкой стекает алая кровь. Осмотреть желудок в других отделах не представляется возможным из-за наличия в нем пищевых масс, смешанных с бурой кровью.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *Определите степень кровопотери.*
4. *Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?*
5. *Причины данного заболевания?*

Задача № 116

Больной Х., 32 лет, был оперирован в экстренном порядке по поводу флегмонозного аппендицита, осложненного местным серозным перитонитом. Рана ушивалась с микроирригатором. На 5 сутки после операции у больного появились неопределенного характера боли в области оперативного вмешательства. К вечеру боли усилились, стали носить схваткообразный характер, сопровождались рвотой. Дежурный хирург при осмотре обнаружил мягкий живот, умеренно болезненный в области оперативного вмешательства, симптомов раздражения брюшины нет.

ОАК: L - 7,4 х 10^9/л.

При выполнении обзорной рентгенографии брюшной полости обнаружены чаши Клойбера по ходу тонкого кишечника.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *О чем свидетельствую полученные рентгенологические данные?*
4. *Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?*
5. *Профилактика данного заболевания?*

Задача № 117

В хирургическую клинику обратился пациент 43 лет с жалобами на наличие болей в эпигастрии с распространением в подвздошную область. Проснулся утром от резкой боли в эпигастрии. Прием но-шпы и альмагеля незначительно снизил болевой синдром, но появилась резкая слабость, тошнота. Находится на диспансерном учете по язвенной болезни.
При осмотре: состояние больного средней тяжести. Положение вынужденное -лежит, поджав ноги к животу. В положении на спине боли усиливаются. Патологии со стороны органов грудной клетки не выявлено. Живот напряжен во всех отделах, но больше в эпигастрии, здесь же резкая болезненность. Печеночная тупость отсутствует. Симптом Мейо-Робсона сомнителен. Симптомы Ортнера, Георгиевского-Мюсси отрицательны. Глубокая пальпация живота невозможна. Назначенная инъекция атропина, димедрола и анальгина желаемого эффекта не дали.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз.*
3. *Какие исследования следует провести больному в приемном отделении?*
4. *Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?*
5. *Ваши действия при категорическом отказе больного от операции?*
6. *операции?*

Задача № 118

В стационар обратился мужчина 28 лет с жалобами на боли в левой половине живота, тошноту, однократную рвоту, болезненное образование в области мошонки.
Болел около 7 часов. Из анамнеза известно, что подобные боли имели место и раньше, в мошонку выходило округлой формы образование, но оно самостоятельно вправлялось. Сейчас этого не произошло.

Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?*
3. *Анатомия пахового канала.*
4. *Методы операций при паховых грыжах.*
5. *Объем резекции некротизированной кишки при ущемлении грыжи.*

Задача № 119

Больной Х., 32 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на потерю в весе, рвоту застойным желудочным содержимым, судороги, вздутие в эпигастральной области. Из анамнеза выяснено, что ранее страдал язвенной болезнью, периодически отмечал боли в эпигастральной области, связанные с приемом пищи, принимал Маалокс. Больной лечился самостоятельно, за медицинской помощью не обращался.

Объективно: больной пониженного питания. Язык сухой, обложен беловатым налетом, изо рта неприятный, кислый запах. Живот участвует в акте дыхания, безболезненный при пальпации.

В ОАК: L - 8,2 х 10^9/л, Э-4, П-7, С-70, М-2, Л-18, СОЭ-18 мм/ч. В биохимическом анализе крови: билирубин 12 мкм/л, прямой 2, непрямой 10, щелочная фосфатаза 120 Е/л, общий белок -56 г/л

При рентгенологическом исследовании с контрастом через 24 часа визуализирована следующая картина.



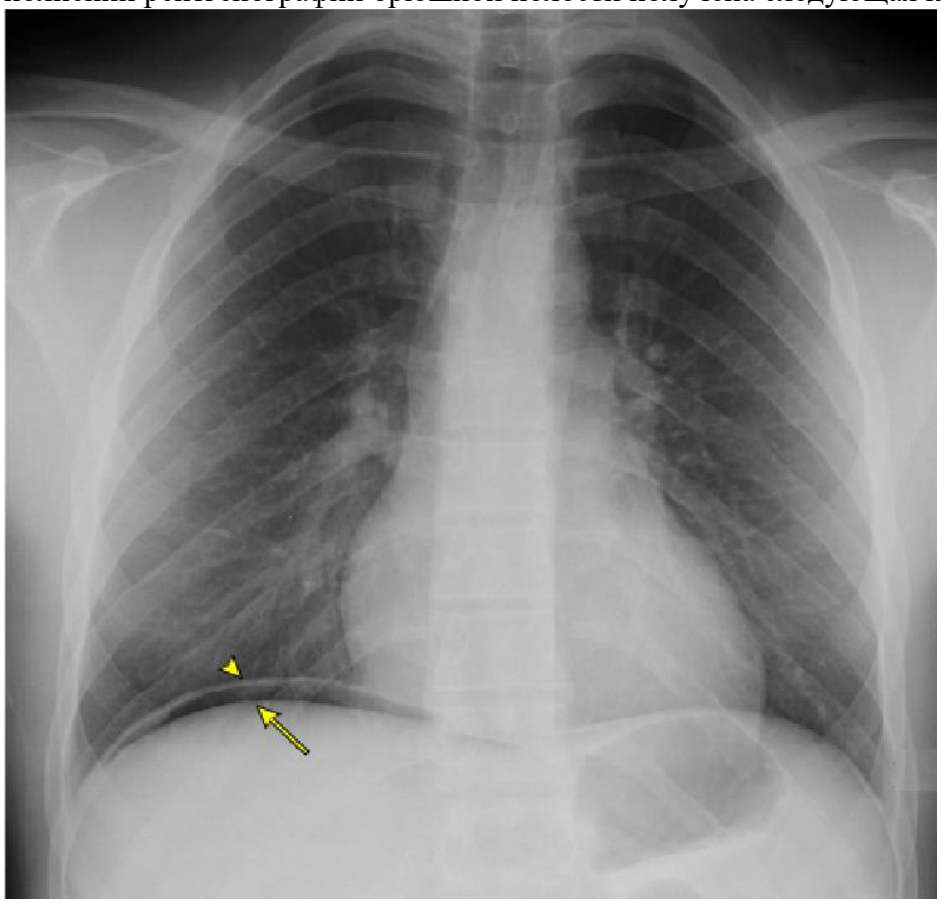
Задание:

1. *Какой диагноз наиболее вероятен?*
2. *Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Опишите и прокомментируйте полученную рентгенологическую картину.*
3. *Какие дополнительные исследования подтвердят или опровергнут Ваш диагноз?*
4. *Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?*
5. *Профилактика данного заболевания?*

Задача № 120

В хирургическую клинику доставлен таксист через 8 часов с момента заболевания. Во время дальней поездки он почувствовал резкую боль в эпигастрии, имевшаяся под рукой сода и купленные в аптеке по дороге гастрофарм и анальгин, облегчения как раньше это бывало, не дали. Болевые ощущения, первоначально возникшие в эпигастрии, стали распространяться по всей правой половине живота. При толчках автомобиля боли усиливались. С течением времени боли приобрели тупой характер, но распространились по всему животу и больше в нижних отделах.

При осмотре: кожные покровы бледноваты. Язык сухой, обложен белым налетом. Пульс 76 в минуту, ритмичный. АД 120/89 мм рт. ст. Со стороны лёгких и сердца патологии не определяется. Живот правильной формы, умеренно напряжен во всех отделах. Печеночная тупость сохранена. При перкуссии выявляется болезненная точка в эпигастрии. В отлогих местах притупление. Симптомы раздражения брюшины во всех отделах слабоположительные. При выполнении рентгенографии брюшной полости получена следующая картина:



Задание

1. Какой диагноз наиболее вероятен?
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. О чем свидетельствую полученные рентгенологические данные?
4. Какова Ваша дальнейшая лечебная тактика?
5. Какие варианты оперативного лечения существуют при данной патологии?

Задача № 121

Больной Р., 22 лет, студент, обратился к врачу поликлиники в связи с обнаружением увеличенных лимфоузлов в области шеи. О давности этого заболевания сообщить не может. Температура тела нормальная.

Объективно: состояние удовлетворительное. Следы множественных инъекций на руках. Переднешейные, заднешейные и подмышечные лимфоузлы увеличены до 1,5–2,0 см, плотно-эластичной консистенции, безболезненные. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено.
Увеличения внутренних лимфоузлов не обнаружено (МРТ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки).

Задание
1. *Укажите наиболее вероятный диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте алгоритм обследования больного.*
3. *Приведите принципы этиотропной терапии данного заболевания.*
4. *Укажите основные профилактические и противоэпидемические мероприятия при данной инфекции.*

Задача № 122

Больной А., 20 лет, поступил в инфекционную клинику на 2-й день болезни с жалобами на диффузную головную боль, боли в мышцах шеи и конечностей, рвоту, светобоязнь, раздражительность и лихорадку (39–40 °С).
Данные эпидемиологического анамнеза: за 10 дней до заболевания – факт присасывания клеща (в область волосистой части головы); специфический иммуноглобулин введен через 2 суток после удаления клеща.
Объективно: выраженная ригидность мышц затылка, положительные симптомы Кернига и Брудзинского, пульс – 124 в минуту, АД – 140/85 мм рт. ст.
Анализ спинномозговой жидкости: вытекала струей, прозрачная, цитоз – 0,036 Г/л (из них 78% – лимфоциты), белок – 0,16 г/л, глюкоза – 2,7 ммоль/л.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*
3. *Проведите дифференциальный диагноз с инфекционными заболеваниями с менингеальным синдромом.*
4. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*

Задача № 123

Больной К., 46 лет, обратился к терапевту с жалобами на повышение температуры тела до 37,5 °С, умеренную головную боль и недомогание. В области шеи – очаг гиперемии размером 7×5 см с четкими контурами, горячий на ощупь, умеренно болезненный; пальпируются увеличенные регионарные лимфоузлы.
Данные эпидемиологического анамнеза: 6 дней назад – факт присасывания клеща в область шеи; продолжительность присасывания клеща – несколько часов; клеща удалил самостоятельно; исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита и ДНК боррелий не проведено.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте план специфических исследований.*
3. *Определите лечебную тактику в данной клинической ситуации.*
4. *Укажите возможные исходы инфекционного процесса при данном заболевании.*

Задача № 124

Больной А., студент, обратился к врачу межвузовской поликлиники в 1-е сутки заболевания с жалобами на умеренную головную боль в области лба и глазниц, сухой кашель, неприятные ощущения за грудиной и заложенность носа. Заболел остро, температура тела повысилась до 38,5 °С, отметил потливость, чувство ломоты во всем теле, боли в мышцах спины и конечностей, не смог продолжать занятия. В группе имеются студенты с насморком и кашлем.
При осмотре выявлены среднетяжелое состояние, гипергидроз, гиперемия кожи лица, инъекция сосудов склер и конъюнктив, яркая диффузная гиперемия и отечность слизистой ротовой полости, мягкого неба и язычка с обильной мелкой зернистостью. Дыхание везикулярное, 18 в минуту, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, пульс – 96 в минуту, АД – 110/80 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Менингеальные явления отсутствуют.

Задание
1. *Укажите наиболее вероятный диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Представьте спектр инфекционных заболеваний, с которыми необходимо провести дифференциальный диагноз в данной клинической ситуации.*
3. *Определите лечебную тактику в данной клинической ситуации.*
4. *Приведите перечень показаний к госпитализации больных при данном заболевании.*

Задача № 125

Больная Ч., 28 лет, педагог, вызвала врача в связи с плохим самочувствием и невозможностью продолжать работу в школе. Больна в течение 3 дней. Заболевание началось с насморка и кашля, вскоре поднялась температура тела до 38 °С. Предъявляет жалобы на головную боль, слабость, першение в горле, резь в глазах и слезотечение.
При осмотре отмечены заложенность носа, чихание, влажный кашель, скудные слизисто-кровянистые выделения из носа, раздражение кожи под носом и над верхней губой. Слизистая глотки умеренно гиперемирована, рыхлая, миндалины увеличены, слизистые наложения в лакунах. Конъюнктивы гиперемированы, в большей степени слева. Пальпируются увеличенные подчелюстные и переднешейные лимфоузлы. В лёгких и сердце – без патологии. Пульс – 80 в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст. Живот безболезненный, край печени – у реберной дуги. Менингеальных явлений нет. Физиологические отправления в норме.

Задания
1. *Укажите наиболее вероятный диагноз.*
2. *Приведите особенности патогенеза данного заболевания.*
3. *Составьте план специфических исследований (с учетом спектра дифференцируемых заболеваний).*
4. *Представьте перечень возможных осложнений при данной инфекции.*

Задача № 126

Больная С., 36 лет, обратилась к терапевту 16.04 с жалобами на боль в горле при глотании, повышение температуры тела до 39 °С и умеренную головную боль.

Данные анамнеза заболевания: заболела 14.04, когда появилась боль в горле, с увеличением интенсивности в динамике; утром 15.04 при осмотре ротоглотки с помощью зеркала пациентка увидела налет на миндалинах; полоскание раствором поваренной соли улучшения не принесло; 16.04 утром больная обнаружила припухлость под нижней челюстью справа и обратилась к врачу.
Врачом отмечены тяжелое состояние пациентки, бледность лица, наличие тестообразного отека шеи до ключиц (кожа над поверхностью отека обычного цвета), увеличенные и слегка болезненные подчелюстные лимфоузлы справа. При осмотре ротоглотки выявлены багрово-синюшная окраска слизистой, резкая отечность правой миндалины и наличие на ней сплошного налета грязно-серого цвета, переходящего на мягкое небо, язычок и правую дужку; при попытке снять налет шпателем слизистая кровоточила. Дыхание не затруднено, голос обычный. Тахикардия (120 ударов в минуту), АД – 170/90 мм рт. ст.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз.*
2. *Представьте патогенетическое обоснование клинического синдромокомплекса.*
3. *Составьте дифференциально-диагностический алгоритм.*
4. *Приведите принципы этиотропной терапии данного заболевания.*

Задача № 127

В поликлиническое отделение медицинской организации обратился больной П., 19 лет. При осмотре предъявлял жалобы на повышение температуры тела, слабость, отсутствие аппетита, сонливость, заложенность носа, появление опухолевидных образований слева и справа на шее.
При объективном обследовании состояние пациента средней степени тяжести, температура тела – 38,9 °С. Кожа чистая, нормальной окраски. При пальпации в области шеи определяются увеличенные и умеренно болезненные лимфоузлы (в том числе и заднешейные) плотноэластической консистенции. Аксиллярные и паховые лимфоузлы также увеличены. Разлитая гиперемия слизистой ротоглотки, гиперемия и отечность миндалин. Увеличение печени и селезенки.
В гемограмме: лейкоциты – 9,0 Г/л, сегментоядерные нейтрофилы – 17%, палочкоядерные нейтрофилы – 2%, лимфоциты – 64%, моноциты – 17%, эозинофилы – 0%, атипичные мононуклеары (15%), СОЭ – 20 мм/час.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте план специфических исследований и приведите диагностические маркеры данного заболевания.*
3. *Определите тактику ведения больного.*
4. *Укажите возможные исходы инфекционного процесса при данном заболевании.*

Задача № 128

Больная П., 62 лет, вызвала врача в связи с плохим самочувствием, наличием лихорадки, головной боли, тошноты и рвоты во время подъема температуры тела.
Больна в течение нескольких дней. До обращения к врачу отмечала подъем температуры тела до 39 °С, сопровождающийся потрясающим ознобом и жаром; затем через несколько часов начиналось профузное потоотделение, температура тела снижалась до субнормальных цифр, состояние улучшалось; через сутки вновь возник аналогичный лихорадочный приступ. При

осмотре выявлены бледность кожных покровов с желтушным оттенком, увеличение печени и селезенки.
Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что за 12 дней до развития заболевания отдыхала в Индии.

Задание
1. *Укажите предполагаемый диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте алгоритм обследования больной.*
3. *Приведите принципы этиотропной терапии данного заболевания.*
4. *Представьте перечень мероприятий для индивидуальной профилактики данного заболевания.*

Задача № 129

Больная Д., 39 лет, обратилась к участковому терапевту на 3-й день болезни с жалобами на схваткообразные боли внизу живота, преимущественно в левой подвздошной области, ложные позывы к дефекации, тянущие судорожные боли в заднем проходе, учащенный кашицеобразный стул с примесью слизи и прожилками крови до 8 раз в сутки, отсутствие аппетита и слабость.
Температура тела – 37,6 °С, пульс – 88 в минуту, АД – 110/75 мм рт. ст. Со стороны лёгких и сердца отклонений не выявлено. Язык обложен белым налетом. Живот умеренно вздут, пальпируется болезненная спазмированная сигмовидная кишка.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*
3. *Проведите дифференциальный диагноз с инфекционными заболеваниями с диарейным синдромом.*
4. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*

Задача № 130

Больная А., 36 лет, заболела остро: ночью появился водянистый стул без патологических примесей, к утру стул стал более обильным и приобрел вид «рисового отвара», присоединились рвота, слабость и головокружение. С диагнозом пищевой токсикоинфекции поступила в инфекционный стационар, где в приемном отделении были сделаны промывание желудка и подкожная инъекция кордиамина. Состояние пациентки в динамике ухудшилось: водянистый стул без счета, рвота более 20 раз (рвотные массы типа «рисового отвара»), жажда, судороги икроножных мышц.
Объективно: состояние очень тяжелое, сознание сохранено. Кожные покровы холодные на ощупь, диффузный цианоз, резкое снижение тургора подкожной клетчатки («руки прачки»). Черты лица заострившиеся, глазные яблоки запавшие, симптом «темных очков». Осиплость голоса. Периодические судороги мышц конечностей. Температура тела – 35,6° С, пульс нитевидный, АД – 40/0 мм рт. ст., тахипноэ (36 дыханий в минуту). Явления анурии.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз (с указанием степени дегидратации) и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*

3. Составьте программу регидратационной терапии (масса тела больной – 60 кг).
4. Составьте алгоритм противоэпидемических мероприятий в очаге данного заболевания.

Задача № 131

Больной Н., 28 лет, заболел остро. 5.03 в 12^{00} появились озноб, головная боль и головокружение; к вечеру повысилась температура тела до 39 °С, имели место тошнота, однократная рвота и кратковременная потеря сознания. 6.03 несколько раз был обильный водянистый стул зеленоватого цвета без патологических примесей, беспокоили периодические схваткообразные боли в околопупочной области. Осмотрен участковым терапевтом и направлен на госпитализацию в инфекционный стационар.
При поступлении: состояние средней степени тяжести; пациент возбужден. Температура тела – 37,5 °С. Кожные покровы бледно-розового цвета, чистые, умеренно влажные. Язык обложен белым налетом, суховат. В лёгких – везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, пульс – 88 в минуту, АД – 100/65 мм рт. ст. Живот вздут, болезненный при пальпации в эпигастральной и околопупочной областях. Печень и селезенка не увеличены. Стул обильный, водянистый, каловый, зеленоватого цвета, зловонный, с примесью слизи.
Из эпидемиологического анамнеза: за несколько часов до заболевания употреблял в пищу свежие куриные яйца.

Задание
1. Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.
2. Приведите критерии степеней дегидратации при острых кишечных инфекциях.
3. Назначьте план специфических исследований.
4. Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.

Задача № 132

Больная А., 24 лет, вызвала врача скорой медицинской помощи 21.01 по поводу наличия слабости, ощущения сухости во рту, «тумана», расплывчатости контуров предметов перед глазами и их двоения, затруднения при глотании пищи и слюны, осиплости голоса, головной боли и головокружения. Заболела остро вечером 20.01, когда появились вздутие живота и, почти одновременно, вышеописанные симптомы. В течение следующих суток состояние продолжало ухудшаться.
Данные эпидемиологического анамнеза: 20.01 днем была в гостях, где употребляла в пищу соленые грибы и соки домашнего приготовления; одна из гостей, К., 36 лет, уже госпитализирована в стационар с аналогичными проявлениями заболевания.
Объективно: состояние средней степени тяжести, активна. Лицо бледное. В лёгких – без патологических изменений. Частота дыхательных движений – 18–28 в минуту, тоны сердца приглушены. Язык сухой, обложен бело-желтым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Вспомнила, что вечером 20.01 были жидкий однократный стул и боли в животе разлитого характера. Из неврологических симптомов выявлены птоз слева, ограничение движения правого глазного яблока, снижение зрачковых реакций, затруднение глотания жидкости (поперхивания нет), небольшая осиплость голоса и затруднение речи.

Задание
1. Укажите предполагаемый диагноз.

2. *Представьте патогенетическое обоснование клинического синдромокомплекса.*
3. *Составьте план обследования больной.*
4. *Определите тактику ведения больной.*

Задача № 133

В приемное отделение городской больницы на 9-е сутки заболевания поступил больной К., 37 лет, с жалобами на повышение температуры тела до 39–40 °С, постоянную головную боль в лобно-височных областях, бессонницу, задержку стула в течение 2 дней и вздутие живота.
Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что больной за 10 дней до болезни находился в командировке в Таджикистане, где не всегда соблюдал правила личной гигиены (перебои с водой).
Объективно: состояние средней степени тяжести; заторможен, на вопросы отвечает адекватно. Кожные покровы бледные, сухие, на коже живота – единичные розеолы. Язык утолщен, обложен густым белым налетом у корня, края ярко-красные. В лёгких – везикулярное дыхание, справа выслушиваются единичные сухие хрипы. Тоны сердца глухие, систолический шум на верхушке и в точке Боткина. Пульс – 74 в минуту, АД – 100/60 мм рт. ст. Живот вздут, положительный симптом Падалки. Печень выступает из подреберья на 2 см по срединно-ключичной линии. Симптом Ортнера отрицательный. Размеры селезенки по Курлову – 13×8 см, пальпируется ее нижний полюс. Симптом Пастернацкого отрицательный. Диурез не изменен.
В гемограмме: лейкоциты – 3,8 Г/л, анэозинофилия. Анализ мочи – без особенностей.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*
3. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Приведите спектр специфических осложнений при данной инфекции, укажите их генез и диагностические критерии.*

Задача № 134

В инфекционную клинику обратился больной К., 26 лет, с диагнозом направления «скарлатина» и жалобами на общую слабость, головную боль, миалгии и артралгии (в коленных и голеностопных суставах), расстройство стула, умеренные боли в правой подвздошной области и повышение температуры тела до 39 °С.
При осмотре выявлены гиперемия и одутловатость лица с выраженным бледным носогубным треугольником, наличие обильной и симметрично расположенной скарлатиноподобной сыпи на коже туловища, верхних и нижних конечностей. Изменения конфигурации и объема движений в коленных и голеностопных суставах не обнаружено. На верхушке сердца – систолический шум на фоне общего приглушения сердечных тонов.
В гемограмме – лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, эозинофилия и увеличение СОЭ до 30 мм/час.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте дифференциально-диагностический алгоритм.*
3. *Назначьте план обследования больного.*
4. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*

Задача № 135

Больная Д., 47 лет, вызвала скорую медицинскую помощь по поводу высокой лихорадки, сухого надсадного кашля и плохого самочувствия.
Больна в течение 3 дней. Заболела остро: повышение температуры тела до 38,3 °С, озноб, выраженная слабость и сухой кашель. За медицинской помощью не обращалась, самостоятельно принимала парацетамол. На 3-е сутки отметила ухудшение самочувствия, появление ощущения заложенности в грудной клетке и сильного сухого надсадного кашля. Из эпидемиологического анамнеза – контакт на работе с сотрудниками, имеющими симптомы острой респираторной инфекции. В анамнезе жизни – сахарный диабет 2 типа в течение 5 лет.
При осмотре: состояние средней степени тяжести, температура тела – 38,8 °С, пульс – 96 ударов в минуту, АД – 120/80 мм рт. ст., ЧДД – 17 в минуту, SpO2 – 96%. Кожные покровы обычной окраски, чистые. Незначительная гиперемия слизистой ротоглотки. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких – жесткое дыхание по всем полям, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме.
Результат экспресс-теста на АГ SARS-CoV-2 положительный.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Определите маршрутизацию больной.*
3. *Составьте алгоритм обследования больной и план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Приведите перечень наиболее вероятных осложнений при данном заболевании (генез, диагностические критерии, стратегия мониторинга и интенсивной терапии).*

Задача № 136

В инфекционную клинику на 6-й день болезни поступила больная К., 20 лет, с жалобами на высокую температуру тела, озноб, головокружение, тошноту, плохой аппетит, режущие боли в правом подреберье и эпигастральной области, пожелтение кожи и потемнение мочи. Из анамнеза выяснено, что за 3 недели до заболевания употребляла в пищу свежесоленых язей.
При объективном обследовании выявлены субиктеричность склер и кожных покровов, обложенность языка, болезненность при пальпации живота в правом подреберье и точке желчного пузыря, положительный симптом Ортнера и гепатомегалия. Температура тела – 38,5 °С, пульс – 108 в минуту, АД – 115/85 мм рт. ст.
В гемограмме – лейкоцитоз (12,0 Г/л), эозинофилия (35%), увеличение СОЭ (24 мм/час).

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план обследования больной с учетом спектра дифференцируемых заболеваний.*
3. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Укажите основные профилактические мероприятия при данной инфекции.*

Задача № 137

Больной Т., 19 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на общую слабость, плохой аппетит, головную боль, боли в горле при глотании и повышение температуры тела до 38,5 °С. Заболевание началось остро 5 дней назад; на 4-й день заметил потемнение мочи и обесцвечивание кала.
Эпидемиологический анамнез: контакт с больным острым респираторным заболеванием 2 недели назад.
Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела – 36,8 °С. Кожные покровы, склеры и слизистая оболочка мягкого неба субиктеричные, экзантемы и энантемы нет. Язык слегка обложен желтым налетом, влажный. В лёгких – везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, пульс – 52 в минуту, удовлетворительных качеств. Живот мягкий, чувствительный при пальпации в правом подреберье. Нижний край печени – на 1 см ниже края реберной дуги, чувствительный. Селезенка не пальпируется. Симптомы Кера и Ортнера отрицательные. Моча темная, кал светлый.
В общем анализе крови: лейкоциты – 3,0 Г/л, СОЭ – 4 мм/час. Анализ мочи: уробилин ++, билирубин ++.

Задание
1. *Сформулируйте предварительный диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Укажите типичные изменения биохимического анализа крови при данном заболевании.*
3. *Приведите специфические маркеры данного заболевания.*
4. *Представьте основные профилактические и противоэпидемические мероприятия при данной инфекции.*

Задача № 138

Больной Л., 23 лет, обратился к участковому терапевту с жалобами на слабость, отсутствие аппетита, тошноту, боли в крупных суставах, повышение температуры тела до 37,8 °С и потемнение мочи. Болен в течение 8 дней, в последние дни отметил появление желтушной окраски склер и кожи, усиление интенсивности болей в суставах и ухудшение общего самочувствия.
Из эпидемиологического анамнеза: в течение 2 лет – регулярное парентеральное введение наркотиков и беспорядочные половые связи.
Объективно: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы и склеры желтушной окраски, сыпи нет. Язык обложен у корня желтым налетом. Суставы обычной конфигурации, движения – в полном объеме. Нижний край печени выходит из-под реберной дуги на 2 см, гладкий, болезненный при пальпации. Симптомы Кера и Ортнера отрицательные. Селезенка не пальпируется. Моча темная, кал сероватого цвета.
Задание
1. *Сформулируйте предварительный диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Составьте алгоритм обследования больного.*
3. *Приведите специфические маркеры данного заболевания.*
4. *Определите тактику ведения больного.*

Задача № 139

Больная И., 36 лет, обратилась к участковому терапевту с жалобами на быструю утомляемость, периодические тошноту и чувство тяжести в правом подреберье, усиливающиеся после приема жирной пищи, плохой аппетит и эпизоды потемнения мочи. Выяснено, что пациентка работает операционной медицинской сестрой хирургического отделения.
При осмотре выявлены субиктеричность склер, обложенность языка, гепатомегалия и увеличение селезенки.

В биохимическом анализе крови: общий билирубин – 25 мкмоль/л (прямой – 7, непрямой – 18), тимоловая проба – 6 ед., активность АЛТ – 110 Е/л, АСТ – 70 Е/л.

Задание

1. Укажите предполагаемый диагноз.
2. Составьте алгоритм обследования больной с учетом спектра дифференцируемых заболеваний.
3. Определите лечебную тактику в данной клинической ситуации.
4. Укажите прогноз при данном заболевании.

Задача № 140

Больная О., 56 лет, поступила в инфекционную клинику с жалобами на повышение температуры тела до 38,7 °С, озноб, сла¬бость, головную боль, наличие покраснения на коже левой голени, сопровождающегося ощущением жжения.

Данные анамнеза заболевания: заболела накануне ночью, когда появились лихорадка и выраженный озноб; утром при вставании с кровати отметила боли в левой нижней конечности; в анамнезе жизни – сахарный диабет 2 типа в течение 10 лет.

При осмотре: на коже верхней трети левой голени (с распространением на бедро) – яркая эритема, четко отграниченная от здо¬ровой кожи валиком, с неровными краями, горячая на ощупь, умеренно болезненная при пальпации, преимущественно по периферии; на фоне эритемы – несколько крупных пузырей, заполнен¬ных серозным содержимым; в области го-лени и бедра – выраженный отек тестоватой консистенции; пальпируются увеличенные и болезненные паховые лимфоузлы слева. Тоны сердца приглушены, тахикардия (104 удара в минуту).

Задание

1. Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.
2. Составьте дифференциально-диагностический алгоритм.
3. Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.
4. Укажите возможные осложнения при данной инфекции.

Задача № 141

Больная К., 38 лет, работает дояркой. Поступила в инфекционную клинику на 52-й день болезни. Заболевание началось постепенно: имели место периодические ознобы, повышение температуры тела в вечерние часы до 38,5 °С, головная боль, слабость и выраженная потливость; неоднократно обращалась за медицинской помощью в фельдшерско-акушерский пункт, проводили лечение ОРВИ; на фоне лечения отмечала временное улучшение и продолжала работать, однако состояние в динамике ухудшалось, появились раздражительность и боли в крупных суставах конечностей.

При объективном осмотре выявлены гипергидроз, плотные чувствительные узелки до 1 см в подкожной клетчатке пояснично-крестцовой области, увеличение подчелюстных, подмышечных и паховых лимфатических узлов до размера боба, гепато- и спленомегалия. Объективных изменений суставов нет.

Задание

1. Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.
2. Назначьте план специфических исследований.
3. Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.

4. *Укажите возможные исходы инфекционного процесса.*

Задача № 142

Больная З., 22 лет, поступила в инфекционный стационар на 3-е сутки заболевания. Заболела через несколько дней после контакта с лихорадящим пациентом: появились насморк, кашель, озноб, повышение температуры тела до 38,5 °С и диффузная головная боль, усиливающаяся в динамике, несколько позже – неоднократная рвота и светобоязнь.
Неврологический статус: сознание ясное, ригидность затылочных мышц на 2 см, положительный симптом Кернига D и S, очаговых симптомов нет.
Гемограмма: лейкоциты – 28,2 Г/л, палочкоядерные нейтрофилы – 11%, сегментоядерные нейтрофилы – 68%, эозинофилы – 0%, лимфоциты – 15%, моноциты – 6%, СОЭ – 24 мм/час.
Результаты исследования ликвора: мутный, молочно-белого цвета, цитоз – 13 Г/л (нейтрофилы – 80%, лимфоциты – 20%), белок – 5,4 г/л, глюкоза – 3,8 ммоль/л.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*
3. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Укажите наиболее вероятное осложнение в данной клинической ситуации и приведите его диагностические критерии.*

Задача № 143

Врач скорой медицинской помощи вызван к больному Н., 30 лет. Со слов родственников, Н. накануне вечером прилетел из Казахстана. Утром он почувствовал себя плохо: появились сильный озноб, сменившийся жаром, резкая головная боль и боли в мышцах; температура тела повысилась до 39 °С; одновременно возникла боль в правой подмышечной области. Пациент принял Анальгин, однако боль в подмышечной области продолжала усиливаться, к вечеру состояние ухудшилось, присоединилась тошнота, речь стала невнятной.
При осмотре: температура тела – 40,2 °С. Гиперемия и одутловатость лица, инъекция сосудов склер и конъюнктив, гиперемия слизистой ротоглотки. Язык сухой, густо обложен белым налетом («меловой»), выражен его тремор. В правой подмышечной области определяется плотный, резко болезненный, плохо контурирующийся лимфоузел размером 3х3 см, кожа над ним цианотичная. В лёгких – дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания – 22 в минуту. Тоны сердца глухие, ритм правильный. Пульс – 120 в минуту. АД – 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Симптом поколачивания в поясничной области отрицательный с обеих сторон. Стула в день заболевания не было. Менингеальных симптомов нет. Больной возбужден, пытается встать, постоянно что-то невнятно бормочет.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Назначьте план специфических исследований.*
3. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Составьте план противоэпидемических мероприятий в очаге данного заболевания.*

Задача № 144

Больная Я., 16 лет, поступила в инфекционный стационар на 2-й день болезни. Заболела остро: насморк, головная боль, резкая слабость, озноб, повышение температуры тела до 39,6 °С; через 12 часов появилась сыпь на коже ягодиц; имело место носовое кровотечение на фоне прогрессирующего ухудшения общего самочувствия.
При объективном обследовании выявлены заторможенность пациентки, нормотермия (36,4 °С), тахикардия (120 ударов в минуту), гипотензия (90/40 мм рт. ст.), тахипноэ (32 в минуту), бледность кожных покровов с цианотичным оттенком, цианоз губ, наличие звездчатой геморрагической сыпи с участками некроза на коже ягодиц, глухость сердечных тонов, увеличение печени и селезенки. Олигурия.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз (основное заболевание, осложнение).*
2. *Представьте патогенетическое обоснование клинического синдромокомплекса.*
3. *Назначьте план специфических исследований.*
4. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*

Задача № 145

В приемное отделение городской больницы доставлен больной С., 32 лет, в состоянии крайнего возбуждения.
При объективном осмотре обращали внимание глубокий, шумный вдох с участием всей дыхательной мускулатуры, клонические и тонические судороги при лёгком прикосновении и небольшом шуме, спазмы глотательной мускулатуры при попытке утолить жажду, обильная саливация, гипергидроз, слуховые и зрительные галлюцинации.
Из эпидемиологического анамнеза: 30 дней назад подвергался нападению неизвестной собаки, имели место укушенные раны верхних и нижних конечностей.

Задание
1. *Сформулируйте клинический диагноз и представьте его обоснование.*
2. *Укажите специфические методы диагностики данного заболевания.*
3. *Составьте план лечебных мероприятий в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями/протоколами лечения.*
4. *Приведите основные профилактические мероприятия при данной инфекции.*

Задача № 146

В дежурный урологический стационар по экстренным показаниям доставлена больная М., 24 года с жалобами на тупую, выраженную, постоянную боль в поясничной области справа, правом подреберье, повышение температуры тела до 39°С, слабость, недомогание, тошноту, головную боль. Заболела остро, вышеперечисленные жалобы возникли 2 дня назад. За неделю до появления вышеперечисленных жалоб больная отмечает переохлаждение. На следующее утро почувствовала боль внизу живота, учащенные позывы на мочеиспускание, боли и рези при мочеиспускании. Лечилась самостоятельно – горячие ванны, мочегонные и почечные травы, фурамаг 0,05 по 2т 3 раза в день. Боль уменьшилась, мочеиспускание стало практически безболезненное, но за 2 дня до обращения появилась боль в поясничной области справа, повысилась температура тела. В анамнезе заболеваний почек и мочевого пузыря не было. Объ-

ективно: Больная гиподинамична, преимущественно лежит. Кожные покровы влажные, горячие на ощупь, язык сухой. Температура тела 39,2°С, пульс 95 в 1 мин., АД – 130/90 мм рт. ст. Пальпация проекции правой почки болезненна. Симптом поколачивания резко положительный справа.
ОАК – лейкоцитоз $14x10^9$/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. ОАМ – лейкоциты сплошь по всем полям зрения, бактерии +++, нитриты +, лейкоцитарная эстераза +, белок 0,45 г/л. УЗИ почек – снижение эхогенности паренхимы правой почки, четкая визуализация пирамидок, подвижность почек сохранена, ЧЛС не расширена.

Задание
1. *Выделить основные симптомы.*
2. *Сформулировать предварительный диагноз.*
3. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
4. *Назвать возбудителей воспалительных процессов в почке.*
5. *Назначить лечение.*

Задача № 147

В дежурный урологический стационар обратился пациент 51 года с жалобами на внезапно возникшую, выраженную, нестерпимую боль в поясничной области, левом подреберье, тошноту, рвоту, не приносящую облегчения. Заболел 3 часа назад во время работы (водитель). В течение последнего часа отмечает учащенные позывы на мочеиспускание, микции небольшими порциями, безболезненные, моча с примесью крови. Год назад по УЗИ в левой почке был выявлен камень 5 мм в диаметре. Объективно: Пациент возбужден, все время двигается, мечется по приемному покою, просит уменьшить боль. Температура тела 36,9°С. Пальпация проекции левой почки болезненна. ОАК – норма, ОАМ – свежие эритроциты в большом количестве. По УЗИ – резкое, напряженное расширение чашечно-лоханочной системы слева, камней нет. Обзорная урография: в проекции нижней трети левого мочеточника имеется округлая тень до 6 мм в диаметре, подозрительная на уроконкремент.

Задание
1. *Выделить основные симптомы.*
2. *Сформулировать предварительный диагноз.*
3. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
4. *Назвать рентгенонегативные мочевые камни.*
5. *Назначить лечение.*

Задача № 148

Пациент М, 65 лет, предъявляет жалобы на затрудненное мочеиспускание, слабую струю мочи, императивность позывов, частое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, необходимость натуживаться при мочеиспускании. Считает себя больным в течение последних трех лет, когда заметил затруднение при мочеиспускании и ослабление напора струи мочи сначала по утрам, а затем и в течение дня. Состояние больного удовлетворительное. Температура тела – 36,6°С. Пульс – 68 в 1 минуту. АД – 130/90 мм рт. ст. При пальцевом ректальном исследовании предстательная железа увеличена в размерах, шаровидной формы, тугоэластической консистенции, однородная, незначительно болезненна при пальпации, междолевая борозда сглажена, слизистая прямой кишки над простатой смещаема. При ультразвуковом исследовании выявлено наличие узлов гиперплазии предстательной железы, общий объем простаты составил 56 см3, объем остаточной мочи 120 мл, максимальная

скорость мочеиспускания 5,2 мл/с, суммарный балл симптоматики по IPSS – 26, индекс качества жизни QOL – 5, ПСА – 2,1 нг/мл.

Задание

1. *Выделить основные симптомы.*
2. *Сформулировать диагноз.*
3. *Назвать группы лекарственных средств для консервативного лечения данного больного.*
4. *Перечислить показания для проведения биопсии предстательной железы.*
5. *Назначить лечение.*

Задача № 149

В дежурный урологический стационар доставлен больной Г., 29 лет с жалобами на боль в левой поясничной области, возникшей после падения и ушиба левой поясничной области. Дважды отмечал мочеиспускание с кровью. Состояние средней степени тяжести. Пациент бледный, пульс – 95 в 1 минуту, АД – 100/65 мм рт. ст., частота дыхания 28 в 1 минуту. Со стороны органов грудной клетки и брюшной полости изменений не найдено. Имеется припухлость в левой поясничной области. Пальпация проекции левой почки резко болезненна. Ранее никогда у уролога не обследовался, никаких исследований почек не проходил. Лабораторно: кровь: лейкоциты – $10x10^9$/л, эритроциты – $2,8x10^{12}$/л, гемоглобин – 108 г/л; моча: цвета мясных помоев, эритроциты сплошь, подсчет невозможен. По данным УЗИ почек: в области нижнего полюса левой почки визуализируется прерывистый ее контур, здесь же определяется преимущественно анэхогенное образование неоднородной структуры 93х64 мм, подвижность левой почки ограничена, чашечно-лоханочная система резко расширена.

Задание

1. *Выделить основные симптомы.*
2. *Сформулировать диагноз.*
3. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
4. *Назначить лечение.*
5. *Назвать поздние осложнения травмы почки.*

Задача № 150

На приеме в поликлинике к урологу обратился пациент 18 лет с жалобами на боль умеренной выраженности в левом яичке, усиливающуюся при физической нагрузке, уменьшающейся в горизонтальном положении, и увеличение левой половины мошонки. Считает себя больным в течение 3 лет, когда впервые заметил увеличение левой половины мошонки в размерах, однако боли не было, и пациент за медицинской помощью не обращался. Последние два месяца отмечает появление и постепенное усиление боли в левом яичке. Объективно: Состояние удовлетворительное. Телосложение астеничное. Температура тела – 36,6°С. Пульс – 71 в 1 минуту. АД – 115/75 мм рт. ст. При осмотре наружных половых органов обращает внимание увеличение левой половины мошонки, ее деформация, цвет кожи мошонки при этом обычный, складчатость кожи сохранена. При пальпации яички обычных размеров, эластичные, безболезненные. В области верхнего полюса левого яичка определяются мягкоэластичные округлые, безболезненные образования, которые исчезают при горизонтальном положении пациента.

Задание

1. *Сформулировать диагноз.*

2. *Назвать причины развития левостороннего варикоцеле.*
3. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
4. *Назначить лечение.*
5. *Назвать осложнения варикоцеле.*

Задача № 151

Пациент Д. 36 лет обратился в поликлинику с жалобами на боль и чувство распирания в поясничной области слева, возникшие 5 дней назад, повышение температуры тела. Боль полностью купировалась обезболивающими средствами и анальгетиками, однако через 2-3 часа снова возникала и постепенно усиливалась. Накануне вечером температура тела повыша-лась до $38,8^0$ С. При осмотре – температура тела $38,^0$С, пульс – 95 в 1 минуту. Язык сухой, живот пальпаторно безболезненный, слегка увеличен в объѐме за счѐт подкожно-жировой клетчатки. Почки не пальпируются, проекция правой почки безболезненна, левой почки – выражено болезненна. Симптом поколачивания положителен слева. В общем анализе крови: эритроциты – 4,4*1012/л, гемоглобин – 142 г/л, цветовой показатель – 0,85, лейкоциты 18*109/л, палочкоядерные 23%, сегментоядерные 57%, лимфоциты 16%, моноциты 4%. СОЭ - 25 мм/ч. В общем анализе мочи: удельный вес – 1018, pH – 6,2, белок – 0,49 г/л, лейкоциты – 80-100 в поле зрения, эритроциты 50-60 в поле зрения. В биохимическом анализе крови: глюкоза крови 5,4 ммоль/л, креатинин 95 мкмоль/л. Рентгенография органов грудной клетки – без патологических изменений.
УЗИ почек: справа – без особенностей, слева – все чашечки расширены до 14-15 мм, лоханка 35х22мм, в лоханочно-мочеточником сегменте определяется гиперэхогенное образование 15х8 мм, с четкой акустической тенью. Подвижность левой почки ограничена. По обзорной урограмме выявлено размытость, нечеткость поясничной мышцы слева.

Задание
1. *Выделить основные симптомы.*
2. *Сформулировать диагноз.*
3. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 152

Пациент Н., 54 лет, предъявляет жалобы на общую слабость, тошноту, гнилостный запах изо рта, похудание на 10 кг за последние 2 месяца, ощущение распирания желудка даже при приеме небольшой порции пищи, в последнюю неделю отмечает рвоту съеденной накануне пищей. Рвота приносит временное облегчение.
Анамнез жизни: Курит в течение 30 лет по 1 пачке в день, алкоголь употребляет в умеренном количестве. Режим питания непостоянный, часто питается фастфудом. 15 лет назад выполнена резекция сигмовидной кишки по поводу рака.
Наследственный анамнез: у отца рак ободочной кишки в возрасте 49 лет, у матери – рак яичников в возрасте 47 лет, у бабушки – рак желудка в 51 год.
Объективно: пациент истощен, общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, кожные покровы бледные; в левой надключичной области пальпируется увеличенный, плотный лимфоузел; ЧСС 95 в минуту, тоны сердца ясные, ритмичные, АД 100/70 мм рт. ст.; ЧДД 25 в минуту, дыхание везикулярное, хрипов нет; живот мягкий, безболезненный, перитонеальные симптомы отрицательны. При аускультации живота определяется «шум плеска».
ОАК: ЭЦ – $4,2x10^{12}$/л, Hb – 120 г/л, ТЦ - $250x10^9$/л, Лейк – $5,0x10^9$/л, Б-0%, Э-3%, С-63%, П-5%, Ю-1%, Л-21% , М-5%.

ОАМ: цвет – желтый, прозрачная, уд.вес – 1021, белок – отр, глюкоза – отр, лейкоциты – 1-0-2 в п/з, эритроциты – 0-0-1 в п/з, цилиндры – гиалиновые 1-2-1 в п/з.
БАК: общ.белок – 55 г/л, креатинин – 61 мкмоль/л, мочевина – 4,2 мкмоль/л, АсАТ – 36 ЕД, АлАТ – 37 ЕД.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Какое наследственное заболевание можно заподозрить у данного пациента?*
3. *Составить план обследования.*
4. *Определить тактику лечения.*

Задача № 153

Пациентка М., 55 лет, при самостоятельном осмотре обнаружила безболезненное округлое образование в правой молочной железе.
Анамнез жизни: менархе в 10 лет, беременностей – 3, родов – 1, абортов – 2, менопауза 5 лет назад. Наследственный анамнез не отягощен.
Объективно: общее состояние удовлетворительное, кожные покровы нормальной окраски; ЧСС 64 в минуту, тоны сердца ясные, ритмичные; ЧДД 16 в минуту, дыхание везикулярное, хрипов нет; живот мягкий, безболезненный, перитонеальные симптомы отрицательны.
Status localis: молочные железы асимметричны, в верхне-наружном квадранте правой молочной железы определяется округлое безболезненное образование 3 см в диаметре, плотное, спаянное с окружающими тканями, симптом Кенига положительный.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Составить план обследования.*
3. *Определить тактику лечения.*

Задача № 154

Пациентка 42 лет, работает в отделе кадров. Семейный и аллергологический анамнезы не отягощены. Полгода назад стала замечать дискомфорт в животе, обратилась к гинекологу. Через неделю после обращения сала замечать вздутие живота, жидкий стул. Пациентке были проведены лабораторные анализы и ЭКГ – без патологии. По результатам УЗИ ОМТ выявлено новообразование яичника слева, предположительно киста. Проведена лапароскопическая овариэктомия, гистологическое исследование не проводилось. В течение всего периода обследования и лечения сохранялись и усиливались вздутие живота, жидкий стул. Было рекомендовано обратиться к инфекционисту, при дальнейшем обследовании инфекционная патология была исключена. Три месяца назад стала замечать эпизодическое появление примесей крови в кале, которую расценила как рецидив геморроя, принимала детралекс – эффекта не последовало.
Объективно: живот мягкий, увеличен за счет подкожно-жировой клетчатки. Перитонеалные симптомы отсутствуют. При пальцевом ректальном осмотре определяется нормальная слизистая прямой кишки без патологических образований. На перчатке слизь.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Какие диагностические мероприятия необходимо провести в первую очередь?*
3. *Какие ошибки были допущены при проведении обследования пациентки?*
4. *На консультацию какого специалиста должна быть направлена пациентка для определения дальнейшей врачебной тактики при подтверждении предполагаемого диагноза?*

Задача № 155

Мужчина 35 лет, работает инженером. 3 года назад был выявлен описторхоз, по поводу которого было проведено лечение. Аллергологический, анамнез не отягощен. Отец умер в молодом возрасте от рака желудка. Оперативных вмешательств не было. Неделю назад стал замечать пожелтение кожных покровов, принимал гепатопротекторы, дюспаталин – эффекта не последовало. Самостоятельно сдал анализы на вирусные гепатиты – результат отрицательный. В последние два дня стал отмечать появление кожного зуда. Утверждает, что речную рыбу в пищу после лечения описторхоза не принимал.
Объективно: кожные покровы желтушной окраски, склеры желтоватого оттенка. При пальпации живот мягкий. Перитонеальные симптомы отсутствуют. Желчный пузырь увеличен в размерах, пальпация его безболезненна. Печень не увеличена в размерах, край печени острый, ровный.
УЗИ органов брюшной полости: в головке поджелудочной железы определяется объемное образование 3х3см, поджелудочная железа имеет неоднородную структуру, отечна, забрюшинные лимфоузлы не увеличены.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Какие необходимо провести диагностические мероприятия?*
3. *Определить тактику лечения.*
4. *Какими методами можно купировать желтуху при данной патологии независимо от возможности проведения специализированного лечения?*

Задача № 156

Больная В., 60 лет. Обратилась с жалобами на болезненную опухоль в области шеи, боли в области позвоночника, потерю веса, осиплость голоса, слабость, диарею.
Данные объективного обследования: температура тела в норме, в лёгких - везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. ЧСС 90, АД 140/90. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень - по краю реберной дуги, селезенка не пальпируется.
Status localis: При пальпации в проекции щитовидной железы определяется новообразование до 3 см плотной консистенции без четких границ. Правый надключичный лимфоузел увеличен, плотный, слабоподвижен.
Анализ крови: гемоглобин - 130 г/л, эритроциты - $4{,}5\times10^{12}$/л, лейкоциты - $6{,}0\times10^{9}$ /л, тромбоциты - $200{,}0\times10^{9}$ /л, СОЭ – 24 мм/час. Общий анализ мочи: удельный вес - 1025, белок - 0,07 мг/л, реакция кислая, лейкоциты - 1-2 в поле зрения, эритроциты - 0-1 в поле зрения. Биохимические показатели крови: глюкоза- 5,5ммоль/л, АЛТ-30ед/л, АСТ-40ед/л, Белок-80г/л, альбумины-45г/л, билирубин общ.-18ммоль/л, билирубин прямой-0,9ммоль/л, креатинин-80 мкм/л. щелочная фосфатаза -820 Ед\л.
Результаты дополнительных обследований:
Кальцитонин- 4500 пг/мл, РЭА-12 нг/мл

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Какие дополнительные диагностические мероприятия необходимо провести больной?*
3. *Определить лечебную тактику?*
4. *Определить прогноз заболевания и роль для уровня кальцитонина и РЭА в прогнозировании течения данного заболевания.*

Задача № 157

У пациентки 52 лет с метаболическим синдромом (ожирение, сахарный диабет и артериальная гипертензия на фоне постменопаузы 3 года) появились кровянистые выделения из половых путей. В гинекологическом стационаре произведена гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала. Результат гистологического исследования эндометрия: высокодифференцированная аденокарцинома.
Status genitalis: матка нормальных размеров, подвижна, безболезненна, грушевидной формы. Придатки матки не увеличены. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. Шейка матки не изменена. Кровянистые выделения из матки в небольшом количестве.

Задание
1. *Поставьте предварительный диагноз и определите патогенетический вариант рака эндометрия у данной больной.*
2. *Назначьте дообследование пациентки и проведите предварительное клиническое стадирование.*
3. *Перечислите возможные варианты лечения рака эндометрия.*

Задача № 158

Больной З., 58 лет, обратился с жалобами на надсадный сухой кашель, одышку при физической нагрузке, снижение аппетита. Мокрота отделяется редко и с трудом, скудная. Иногда отмечаются прожилки крови в мокроте. Болен 2 месяца, в течение этого времени нарастала слабость. Похудел на 5 кг. Ранее к врачам не обращался. В анамнезе отмечает дважды перенесенную правостороннюю пневмонию. Работает в нефтехимическом производстве. Курит с 15 лет.
Данные объективного обследования: Общее состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, сниженного питания. Кожные покровы чистые, бледные. Периферические лимфоузлы не пальпируются. В лёгких дыхание везикулярное, несколько жестче справа. ЧД 20 в минуту. АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется
При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки: гиповентиляция нижней доли правого лёгкого, ближе к корню нижней доли определяется округлой формы негомогенная тень размером около 5 см в диаметре, с четкими контурами.
Результаты обследования:
ОАК: Эр – 4,12х10^{12}/л, Hb – 95 г/л, Тромб. - 280х10^{9}/л, Лейк – 5,0х10^{9}/л, СОЭ 30 мм/час, Б-0%, Э-1%, С-60%, П-3%, Ю-1%, Л-18% , М-5%;
Б\х: Белок 68 г/л, АСТ 24 Ед/л; АЛТ 30 Ед/л, бил общий 7,4 мкмоль/л; мочевина 6,1 ммоль/л; креатинин 78 мкмоль/л, глюкоза 4,7 ммоль/л
ОАМ: цвет – желтый, прозрачная, уд.вес – 1021, белок – отр, глюкоза – отр, лейкоциты – 1-0-2 в п/з, эритроциты – 0-0-1 в п/з, цилиндры – гиалиновые 1-2-1 в п/з.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Составьте дифференциально-диагностический ряд заболеваний*
3. *Составьте план диагностических мероприятий*
4. *Составьте план лечения больного.*

Задача № 159

Больной Б., 65 лет обратился в поликлинику к участковому терапевту с жалобами на боли в эпигастральной области, затруднения глотания кашицеобразной пищи, срыгивания пищи с примесью крови, отсутствие аппетита, общую слабость. Затруднения при глотании отмечает около двух месяцев. Похудел на 7 кг. Восемь лет назад лечился в областной больнице по поводу ожога пищевода кислотой. Долгое время проводили бужирование, находился на диспансерном учете, но на осмотры последние 8 месяцев не приезжал. Курит с 18 лет. Алкоголем не злоупотребляет.
Данные объективного обследования: Общее состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, резко пониженного питания. Кожные покровы и слизистые бледные. В надключичной области слева пальпируется увеличенный лимфоузел диаметром до 1 см, подвижный, безболезненный. В лёгких- везикулярное дыхание. Пульс - 65 в 1 мин. АД 120/80 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены. Живот мягкий безболезненный, печень не увеличена, селезенка не пальпируется.
Результаты обследования:
ОАК: Эр – 3,9х10^{12}/л, Hb – 90 г/л, Тромб. - 270х10^{9}/л, Лейк – 6,0х10^{9}/л, СОЭ 36 мм/час, Б-0%, Э-1%, С-60%, П-3%, Ю-1%, Л-20% , М-5%;
Б\х: Белок 73 г/л, альбумины 46 г/л, глобулины – 22 г/л, , АСТ 90 Ед/л; АЛТ 100 Ед/л, бил общий 15 мкмоль/л; мочевина 6,1 ммоль/л; креатинин 88 мкмоль/л, глюкоза 4,9 ммоль/л
ОАМ: цвет – желтый, прозрачная, уд.вес – 1019, белок – отр, глюкоза – отр, лейкоциты – 1-0-2 в п/з, эритроциты – 0-0-1 в п/з, цилиндры – гиалиновые 1-2-1 в п/з.

Задание
1. *Сформулировать предварительный диагноз.*
2. *Составьте дифференциально-диагностический ряд заболеваний*
3. *Составьте план диагностических мероприятий*
4. *Составьте план лечения больного.*

Задача № 160

Пациентка 48 лет обратилась с жалобами на отек, болезненность левой молочной железы. Жалобы возникли 2 недели назад, симптоматика постепенно нарастала. Температура тела 36,6 С. При осмотре: Левая молочная железа больше левой, кожа железы диффузно отечна, гиперемирована. Отмечается повышение локальной температуры. При пальпации умеренно болезненна, диффузно уплотнена за счет отека. Узловые образования не определяются. В левой подмышечной области определяются увеличенные подмышечные лимфатические узлы, плотной консистенции, безболезненные.

Задание
1. *Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.*
2. *С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику.*
3. *Назовите необходимые дополнительные исследования.*
4. *Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения.*

Задача № 161

Женщина 45 лет обратилась на прием к районному врачу-онкологу. Жалобы: на безболезненное уплотнение в правой молочной железе. Анамнез заболевания: Самостоятельно обнару-

жила в правой молочной железе образование около 3 месяцев назад, безболезненное при пальпации. Анамнез жизни: вредные привычки отрицает, хронических заболеваний нет. Менархе с 13 лет. Менструальный цикл регулярный. Роды-2, аборт 1.
Объективный статус: Состояние удовлетворительное. Вес 53 кг, рост 173 см. Молочные железы развиты правильно, симметричные. Кожные покровы физиологической окраски. Соски и ареолы не изменены. Выделений из сосков нет. При пальпации в верхне-наружном квадранте правой молочной железы определяется бугристое плотное образование до 2.5 см в диаметре, с нечеткими контурами, безболезненное. Кожных симптомов не выявлено. Увеличенных л\у нет.
Выполнена трепан-биопсия образования под ультразвуковым контролем. По результатам гистологического исследования обнаружены клетки высокодифференцированной протоковой карциномы.

Задание
1. *Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.*
2. Назначьте план дополнительных методов исследования.
3. Определите дальнейшую тактику лечения.

Задача № 162

Больной С., 34 года. Страдает сахарным диабетом с 16 лет. В течение последних лет принимает Хумалог и Лантус в суточной дозе 48 ЕД. Пять лет тому назад начал отмечать снижение зрения, около года назад появилась пастозность голеней, отечность лица, повышенное артериальное давление.
При объективном обследовании: рост – 166 см, масса тела – 77 кг. Отечность век, голеней, стоп. Пульс – 72 в минуту, АД 220/140 мм рт. ст. Левая граница сердца смещена на 1 см влево от срединно-ключичной линии. Тоны сердца ослаблены, акцент II тона над аортой. Нижний край печени не выступает из-под края реберной дуги. Гликемический профиль: глюкоза крови натощак – 15 ммоль/л, 11 ч. – 18 ммоль/л, 15 ч. – 12,2 ммоль/л, 19 ч. – 9,8 ммоль/л, 23 ч. – 10,5 ммоль/л, 3 ч. – 8,8 ммоль/л. Гликированный гемоглобин – 9,4% Анализ мочи: диурез – 1,0 л, белок – 0,6 г/л, лейкоциты – 1-2 в поле зрения. Креатинин крови – 180 мкмоль/л., альбуминурия – 26 мг/ммоль, СКФ – 41 мл/мин/1,73м^2. Глазное дно: вены расширены, извилисты, микроаневризмы, мелкие кровоизлияния в сетчатку обоих глаз, плотные очаги экссудата.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 163

Пациент Д. 52 лет обратился в поликлинику с жалобами на жажду, сухость во рту, учащённое мочеиспускание, ночью до 3 раз, частые боли в затылке, утомляемость при физической нагрузке. Данные жалобы беспокоят в течение года. Из анамнеза выяснено, что много лет избыточный вес, ведёт малоподвижный образ жизни, работает бухгалтером. Головные боли возникают после стрессов на работе. Сухость во рту возникает после съеденной сладкой пищи, которой пациент злоупотребляет. Ранее больной к врачам не обращался. У матери гипертоническая болезнь. Не курит. Аллергический анамнез не отягощён.
При осмотре повышенного питания. ИМТ 31 кг/м2, окружность талии (ОТ) 100 см. Кожные покровы и слизистые обычной окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. В лёгких – перкуторно звук лёгочный, аускультативно – дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД – 17

в минуту. Тоны сердца ослаблены, ритм правильный¸ акцент II тона над аортой, ЧСС – 64 уд. в мин., АД – 180/100 мм рт. ст. Язык влажный чистый, живот пальпаторно безболезненный, увеличен в объёме за счёт подкожно-жировой клетчатки. Размеры печени по Курлову 11*10*6 см, выступает на 2 см из-под рёберной дуги. Желчный пузырь не пальпируется. Селезёнка не увеличена. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Периферическая пульсация на артериях стоп сохранена, не снижена.
В общем анализе крови: эритроциты – $4.4*10^{12}$/л, гемоглобин – 142 г/л, ЦП – 0.85, лейкоциты $5.6*10^{9}$/л, лейкоцитарная формула без особенностей, СОЭ - 9 мм/ч.
В общем анализе мочи: удельный вес - 1018, белка нет, глюкозурия ++, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты отсутствуют.
В биохимическом анализе крови: общий холестерол 6.9 ммоль/л триацилглицеролы 3,6 ммоль/л, ЛПВП 0,9 ммоль/л, глюкоза крови 9,2 ммоль/л, HbA1c 7.6%. АЛТ 65 МЕ/л, АСТ 45 МЕ/л, билирубин общий – 17 мкмоль/л, прямой – 5 мкмоль/л, непрямой – 12 мкмоль/л. Амилаза 60 ЕД.
Рентгенография лёгких – без патологии.
ЭКГ – синусовый ритм, признаки гипертрофии левого желудочка, ЧСС 64 уд/мин.
УЗИ брюшной полости – печень увеличена (12*10*7см), неравномерно уплотнена, «блестит», желчный пузырь не увеличен стенка 4 мм, взвесь, конкрементов нет, поджелудочная железа неравномерно уплотнена, не увеличена.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 164

В медвытрезвитель доставлен с улицы молодой мужчина, который вел себя странно: то плакал, то яростно ругался и приставал к прохожим. При осмотре создается впечатление об опьянении, но в выдыхаемом воздухе запаха алкоголя нет, говорит не всегда связно, выражает недоумение по поводу своего задержания. Документов у него не оказалось. Пока выясняли личность, состояние ухудшилось, потерял сознание, появились судороги, пена изо рта, выраженная потливость (холодный липкий пот), снижение температуры тела. Среди личных вещей обнаружена шприц-ручка с инсулином.
Объективно: Нормального питания. Кожные покровы бледные, влажные и прохладные наощупь. Дыхание ровное, глубокое – 16 в минуту. Пульс ослабленный, 120 в минуту. АД 145 мм рт. ст. При пальпации живот мягкий, безболезненный, край печени не выступает из-под реберной дуги.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 165

Больная С., 58 лет. Страдает сахарным диабетом 2 типа в течение 12 лет. Принимает Новонорм 2 мг по таблетке 3 раза в день. Диету соблюдает. Контроль гликемии нерегулярный. В течение последних 6 месяцев состояние ухудшилось: отмечает уменьшение массы тела на 9 кг, появились жажда, полиурия (до 3 л в сутки), кожный зуд.

Объективно: Рост – 174 см, масса тела – 65 кг. Кожа сухая. Пульс 68 в минуту, ритмичный. АД 120/70 мм рт. ст. Левая граница относительной сердечной тупости находится в V межреберье, по срединно-ключичной линии. Тоны сердца ослаблены, систолический шум над верхушкой. Дыхание везикулярное. Нижний край печени выступает на 3 см из-под реберного края по срединно-ключичной линии, безболезненный. Симптомы Кера, Ортнера отрицательные. Гликемический профиль: 8 ч. – 13,4 ммоль/л, 11 ч. – 12,2 ммоль/л, 15 ч. –14,8 ммоль/л, 19 ч. – 12,6 ммоль/л, 23 ч. – 12,1 ммоль/л, 3 ч – 10,8 ммоль/л. Диурез – 3,5 л, глюкоза мочи – 2,5 г/л. Реакция мочи на ацетон отрицательная.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 166

Больной Д., 67 лет, обратился к хирургу с жалобами на наличие длительно незаживающей, очень болезненной язвы на кончике 4 пальца правой стопы; боли в ногах, усиливающиеся при ходьбе и проходящие в покое. Болеет сахарным диабетом в течение 5 лет. Ранее язвенных дефектов на ногах не было. Все годы получал ТССП, в настоящее время принимает манинил 3,5 мг, по таблетке 2 раза в день. Гликемия 12,6 ммоль/л. Пульсация артерий тыла стопы справа отсутствует, слева - резко ослаблена.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 167

В отделение госпитализирована больная, 64 лет, с жалобами на общую слабость, жажду, полиурию, повышение температуры тела до $37,6^0$С во второй половине дня, наличие язвенного дефекта на правой стопе. Страдает сахарным диабетом 15 лет, в течение последнего времени принимает диабетон МВ 60 мг/сут., сиофор 850 мг/сут. При поступлении состояние ближе к удовлетворительному. Status localis: стопы деформированы, поперечное плоскостопие, клювовидные пальцы, на подошвенной поверхности кожа сухая, гиперкератоз мест нагрузочного давления, пульсация на артериях стопы удовлетворительна. В области головок метатарзальных костей справа, определяется язвенный дефект, диаметром 2см, кожа вокруг дефекта умеренно гиперемирована, отмечается небольшая отечность на тыльной поверхности стопы.

Задание
1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 168

Мужчина,58 лет, предъявляет жалобы на снижение работоспособности, головные боли давящего характера в теменной области. Ухудшение в своем состоянии заметил после перехода на другую работу, связанную с большим психоэмоциональным напряжением. Объективно: состояние удовлетворительное, рост 185 см, вес 110 кг. Распределение подкожно-жировой клетчатки по абдоминальному типу. АД 150/90 мм рт. ст. При лабораторном исследовании: гликемия 6,2 ммоль/л, повышение уровня холестерола, триглицеридов, ЛПНП, ЛПОНП, снижение ЛПВП. СТТГ: 8 ч. – 5,7 ммоль/л, 10 ч. – 8,0 ммоль/л. УЗИ-признаки жирового гепатоза, хронического холецистита вне обострения.

Задание

1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 169

Больная Р., 54 лет, бухгалтер. Жалуется на общую слабость, утомляемость, снижение работоспособности, сонливость, головную боль, снижение памяти, одышку при ходьбе, зябкость, склонность к запорам. Аппетит удовлетворительный. За последний год масса тела увеличилась на 8 кг.

Объективно: Состояние удовлетворительное. Рост-164 см, масса тела - 78 кг. Температура тела 35,8 С. Распределение подкожной жировой клетчатки равномерное. Кожа сухая, бледная, прохладная. Лицо одутловатое. Кисти, голени и стопы пастозные, холодные. Плотные отеки на тыле кистей рук и ногах. Волосы на голове, в подмышечных ямках и на лобке редкие. Наблюдается выпадение волос в области наружных частей бровей. Щитовидная железа расположена в типичном месте, не увеличена, плотная, неоднородная. АД 145/80 мм рт. ст., пульс 62 в минуту, ритмичный. Левая граница относительной сердечной тупости в V межреберье, на 2 см кнаружи от срединно-ключичной линии. Тоны сердца ослаблены. Дыхание везикулярное. Органы брюшной полости без изменений.

Лабораторные данные: Общий анализ крови: гемоглобин — 95 г/л; эритроциты — $3{,}3 \times 10^{12}$/л; лейкоциты — $6{,}2 \times 10^{9}$/л; тромбоциты — 380 тыс.; СОЭ — 12 мм/ч.

Биохимический анализ крови: глюкоза — 5,0 ммоль/л; общий холестерол — 8,1 ммоль/л, ЛПНП — 5,4 ммоль/л; общий белок — 76 г/л; АСТ — 20 ммоль/л, АЛТ — 18 ммоль/л; креатинин — 74 ммоль/л; мочевина — 5,1 ммоль/л.

Гормональный анализ крови: ТТГ — 24 мМЕ/л (норма 0,4- 4,0 мкМЕ/мл), T_4 свободный — 6.1 пмоль/л (норма 9,0–22,2 пмоль/л). УЗИ щитовидной железы: объем 6,8 мл, эхогенность снижена, структура неоднородная, чередование гипо- и гиперэхогенных участков.

Задание

1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 170

К участковому терапевту обратилась женщина 36 лет с жалобами на боль в горле. По словам больной, три недели назад она отметила общую слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38,7 C^0, насморк, боль в горле при глотании. Расценив свое состояние как грипп, больная принимала аспирин, капли в нос. К врачу не обращалась, перенесла заболевание на

ногах, не прекращая ходить на работу. Температура нормализовалась, насморк и боль при глотании прошли. Три дня назад вновь резко поднялась температура тела, появились сильные боли в горле, пульсирующего характера, иррадиирующие в нижнюю челюсть, уши, усиливающиеся при поворотах головы в сторону. Нарушился сон (бессоница), появилось чувство необъяснимой тревоги. При объективном обследовании обращает на себя внимание потливость больной, ЧСС 96 ударов в минуту, АД 130/80 мм рт. ст., блеск глаз, дрожь. Кожные покровы теплые, обычной окраски, бархатистые. При пальпации определяется резкая болезненность по передней поверхности шеи, в проекции щитовидной железы. Лимфатические узлы шеи не увеличены, безболезненны.
Общий анализ крови: гемоглобин — 129 г/л; эритроциты — 4,9 $\times 10^{12}$/л; тромбоциты — 285 тыс., лейкоциты — 4,6 $\times 10^{9}$/л; лимфоциты — 5 $\times 10^{9}$/л (1,2–3$\times 10^{9}$/л); СОЭ — 58 мм/ч. Биохимический анализ крови, общий анализ мочи без патологических изменений.
УЗИ: щитовидная железа расположена в типично, объем – 12 мл, в левой доле – гипоэхогенный участок, 20×25 мм. Регионарные лимфатические узлы без особенностей.

Задание

1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 171

Больная Р., 32 лет, жалуется на раздражительность, плаксивость, мышечную слабость, постоянное сердцебиение, чувство жара, потливость, снижение массы тела на 13 кг за последние 5 месяцев при повышенном аппетите, одышку при быстрой ходьбе и подъёме по лестнице. Заболевание связывает со стрессовой ситуацией в семье за 3 месяца до обращения к врачу. Принимала Корвалол, состояние не улучшилось. В анамнезе частые ангины.
Состояние удовлетворительное, температура тела – 37,0°С. Рост 168 см, вес 51 кг, ИМТ– 18,1 кг/м^2. Кожные покровы влажные, тёплые на ощупь, бархатистые, ладони горячие, влажные, периферических отёков нет. Широко раскрытые глазные щели, умеренно выраженный двусторонний экзофтальм. Положительные симптомы Дальримпля, Кохера, Грефе, Розенбаха. Мелкий тремор пальцев вытянутых рук. Щитовидная железа видна на глаз, диффузно увеличена за счет обеих долей, эластичная, безболезненная, свободно смещается при глотании. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, 1 тон на верхушке усилен. Пульс – 118 в минуту, ритмичный. АД – 155/40 мм рт. ст., патологии со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы нет.
Лабораторные данные:
Общий анализ крови: гемоглобин 13,5 г/дл (11,7 – 16,0), эритроциты — 4,51 млн./мкл (3,80 – 5,30), гематокрит 40,7 % (35,0 – 47,0), тромбоциты 217 тыс./мкл (150 – 400), лейкоциты 5,66 тыс./мкл (4,50 – 11,00), нейтрофилы (общее число) 51,4 % (48,0 – 78,0), лимфоциты 36,4 % (19,0 – 37,0), моноциты 10,2 % (3,0 – 11,0), эозинофилы 1,1 % (1,0 – 5,0), базофилы 0,9 % (< 1,0).
Биохимический анализ крови: глюкоза натощак — 6,3 ммоль/л; общий белок — 58 г/л; мочевина — 45 ммоль/л; креатинин — 64 мкмоль/л; холестерол общий — 3,3 ммоль/л, АЛТ — 12 Ед/л, АСТ — 17 Ед/л, ЩФ — 78 Ед/л.
Общий анализ мочи: без изменений
Гормональное исследование крови: ТТГ — 0,025 мкМЕ/мл (04, - 4,0), T_4 свободный — 49,7 пмоль/л (9,0–22,2), T_3 свободный – 17,4 пмоль/л (3,1 - 6,8), АТ к ТПО – 238 (до 60).
Данные инструментальных исследований:
УЗИ щитовидной железы: щитовидная железа увеличена, эхогенность не изменена, структура мелкозернистая, кровоток резко усилен. Общий объем железы: 40 мл.

ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС — 125 уд/мин. Вертикальное положение электрической оси сердца.

Задание

1. *Выделить ведущие синдромы.*
2. *Назначить дополнительные методы обследования (при необходимости).*
3. *Сформулировать предварительный диагноз.*
4. *Назначить лечение.*

Задача № 172

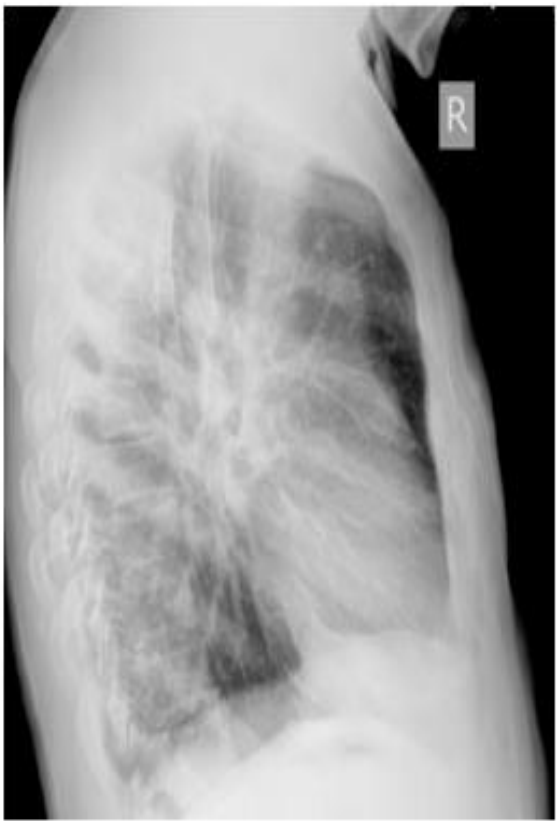
Больной А., 58 лет, работает вахтовым методом на нефтегазовом месторождении. В течение 5 лет состоит на учёте у терапевта по поводу язвенной болезни желудка с частыми обострениями. Курит по 1 пачке в день. Алкоголем не злоупотребляет. Последнее флюорографическое обследование лёгких проходил 1 год назад, без патологии. Туберкулёзный контакт отрицает. В настоящее время предъявляет жалобы на кашель со слизистой мокротой, слабость, потливость, повышение температуры до 37,5˚С, одышку, боли справа под лопаткой. Данные симптомы появились около месяца назад после переохлаждения.

Объективно: состояние средней степени тяжести, рост 176 см, вес 61 кг. Периферические лимфоузлы пальпируются справа в подмышечной области до 0,6 см в диаметре – плотные, подвижные, безболезненные. ЧДД 20 в/мин. Перкуторный звук укорочен справа под лопаткой, здесь же выслушиваются среднепузырчатые влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс 92 в/мин., АД- 145/90 мм рт.ст. Со стороны органов брюшной полости патологии не выявлено.

Общий анализ крови: Эритроциты – 3,5 х 10^{12}/л, гемоглобин -103 г/л, лейкоциты – 12,0 х 10^{9} /л, эозинофилы - 2%, палочкоядерные лейкоциты - 7%, с/я - 69%, л - 14%, м - 8%, СОЭ - 6О мм/час. Общий анализ мочи: цвет соломенный, реакция кислая, плотность -1020, глюкоза – отрицательно, белок – 0,033, лейкоциты – 1-2 в поле зрения, эритроциты – отрицательно.

В терапевтическом стационаре куда обратился пациент по скорой медицинской помощи была выполнена рентгенография ОГК, где были выявлены изменения в лёгких, требующие дифференциальной диагностики.





Задание

1. Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.

2. Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, сформулируйте предварительный клинический диагноз, определите алгоритм действия врача учреждения первичной медико-санитарной помощи (УПМСП) при работе с пациентами с заболеваниями органов дыхания с подозрением на туберкулез, выделите у данного пациента факторы риска туберкулеза.

3. Определите дальнейшую тактику врача при обнаружении у пациента КУМ.

4. Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующих туберкулез органов дыхания.

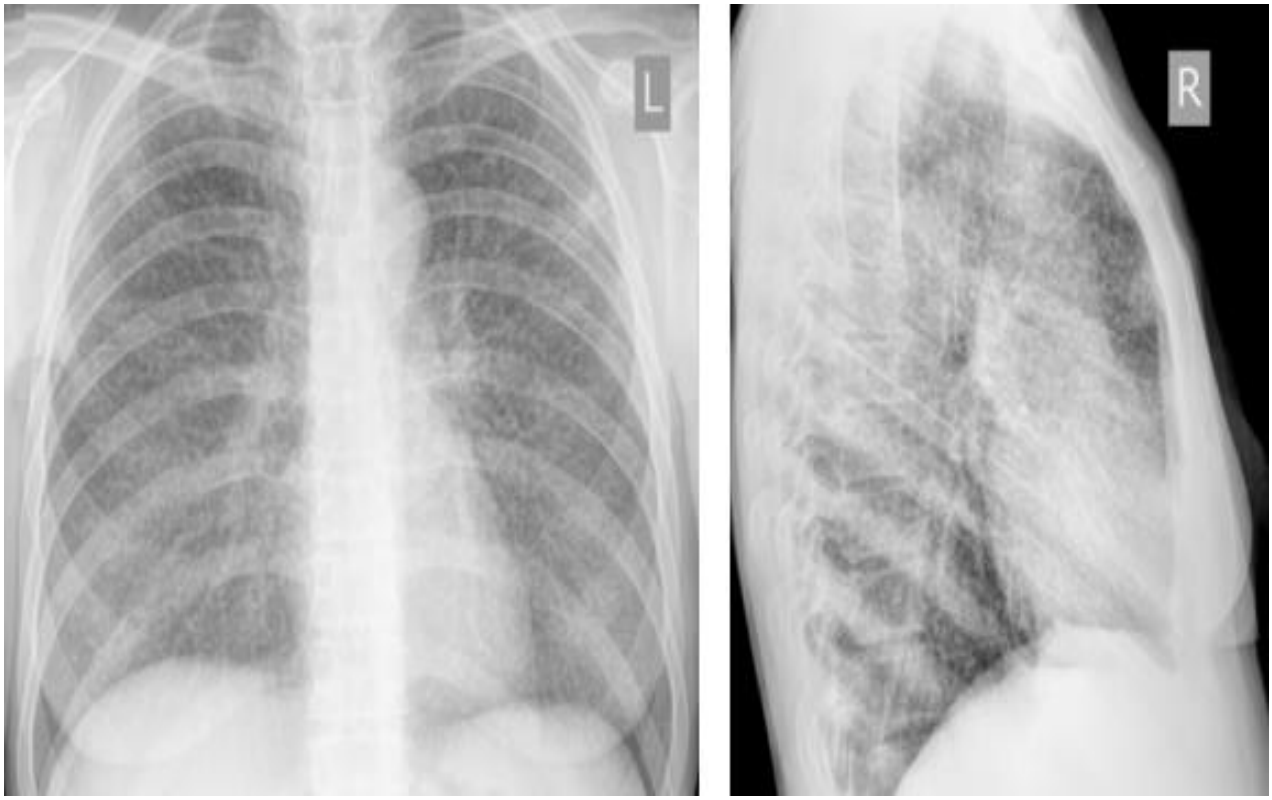
5. Сформулируйте клинический диагноз, составьте план лечения и диспансерного наблюдения представленного больного, с учетом результатов бактериологического исследования с установленной чувствительностью МБТ к HRZE.

Задача № 173

Больная М., 33 года, безработная. Состояла на учёте в противотуберкулёзном диспансере с диагнозом инфильтративный туберкулёз верхней доли левого лёгкого, МБТ (+). Пролечена в течение 6 месяцев. Курс лечения завершен как эффективный: достигнуто рассасывание инфильтрата, прекратилось бактериовыделение. Пациентка ежегодно обследовалась, данных за рецидив туберкулеза не было. Через 8 лет после заболевания родила доношенного здорового ребёнка. Роды протекали без осложнений. На 2-й день после родов появилось ухудшение самочувствия: слабость, снижение аппетита, потливость, повышение температуры до 39˚ С с ознобами, сухим кашлем и выраженной одышкой.

Объективно: состояние больной средней степени тяжести. Цианоз губ. Периферические л/узлы не увеличены. Дыхание в лёгких ослаблено, единичные сухие хрипы. Частота дыхания

30 в/мин. Тоны сердца ритмичные, пульс 110 в/мин., АД - 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный.
Общий анализ крови: эритроциты – $3,9\times10^{12}$/л, гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты - $11,2\times10^{9}$ /л, эозинофилы – 1%, палочкоядерные нейтрофилы – 7%, сегментоядерные нейтрофилы - 63%, лимфоциты - 15%, моноциты - 14%; СОЭ – 38 мм/час. В экстренном порядке была проведена рентгенография органов грудной клетки.



Задание

1. *Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.*
2. *Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, выделите факторы риска туберкулеза, сформулируйте предварительный клинический диагноз, обоснуйте его.*
3. *Определите алгоритм действия врача перинатального центра в работе с данной пациенткой. Решите вопрос о вакцинации ребёнка, возможности грудного вскармливания.*
4. *Объясните патогенез заболевания.*
5. *Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующих туберкулез органов дыхания и определите тактику лечения.*

Задача № 174

Мужчина, 37 лет, самостоятельно обратился в дежурный терапевтический стационар. При расспросе в течение последних трех месяцев беспокоит слабость, снижение аппетита, продуктивный кашель с отхождением мокроты слизисто-гнойного характера, утомляемость, повышение температуры тела до 38,2°С. В начале заболевания обращался амбулаторно к терапевту по месту жительства (рентгенологическое обследование органов грудной клетки не выполнялось); была проведена неспецифическая антибактериальная терапия по поводу хронического

бронхита (амоксиклав), без эффекта. Кроме того, отмечает, что три недели назад на боковой поверхности шеи справа чуть выше ключицы появилось опухолевидное уплотнение, которое увеличивалось в размерах и в день обращения вскрылось с небольшим желтоватым отделяемым.

Состояние удовлетворительное. Больной пониженного питания (рост –175 см, вес – 53 кг). Перкуторно в проекции верхней доли правого лёгкого притупление перкуторного звука. Аускультативно в данной области на фоне бронхиального дыхания определяются разнокалиберные влажные хрипы; слева дыхание с жестким оттенком. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 102 в минуту, АД – 125/85 мм рт.ст. Живот без особенностей. Общий анализ крови: эритроциты – $4{,}8\times10^{12}$/л, гемоглобин – 132 г/л, лейкоциты – $11{,}4\times10^{9}$/л, палочкоядерные лейкоциты – 3 %, сегментоядерные лейкоциты – 78 %, лимфоциты – 15 %, моноциты – 4 %, СОЭ – 39 мм/ч.

При осмотре шеи, справа над ключицей по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы наблюдается гиперемированное, опухолевидное образование размером с грецкий орех, в центре которого наблюдается желтоватая корочка над свищевым ходом; при пальпации подвижное, умеренно болезненное. Другие регионарные лимфатические узлы не увеличены. Проведена рентгенограмма органов грудной клетки (ОГК).



Задание

1. Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.

2. Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, сформулируйте предварительный клинический диагноз, выработайте тактику врача.

3. Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующие туберкулез органов дыхания.

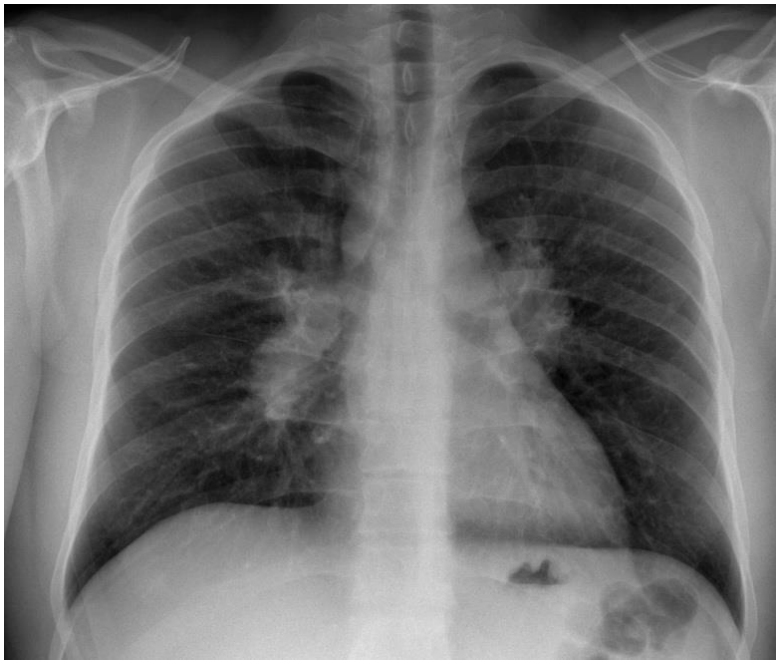
4. Определите дифференциально-диагностический ряд периферической лимфаденопатии и тактику врача.

5. Тактика лечения, прогноз.

Задача № 175

Больной Н., 19 лет, студент. Жалобы на подкашливание с выделением скудной слизистой мокроты, непостоянные боли в правой половине грудной клетки, на красно-фиолетовые высыпа-

ния на голенях, отечность и болезненность голеностопных суставов. Указанные жалобы беспокоят на протяжении двух недель, к врачу не обращался. Патологические изменения в лёгких выявлены флюорографически при заселении в общежитие.
Анамнез жизни: в детстве болел корью. Предыдущее флюорографическое обследование год назад — без патологии.
Объективно: правильного телосложения, повышенного питания. На коже голеней — узловатая эритема. Периферические лимфоузлы не увеличены. Пульс 72 в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные. АД 130/70 мм рт. ст. Грудная клетка симметричная. Перкуссия – ясный лёгочной звук. Аускультативно в лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены.
Общий анализ крови: эритроциты $4{,}1 \times 10^{12}$/л, гемоглобин – 126 г/л, лейкоциты $5{,}7 \times 10^{9}$/л, эозинфилы – 1%, палочкоядерные лейкоциты – 1%, сегментоядерные лейкоциты – 53%, лимфоциты – 37%, моноциты – 8%, СОЭ – 16 мм/ч. Был направлен на консультацию к фтизиатру с целью дифференциальной диагностики выявленных изменений в лёгких, где была поставлена проба с аллерген туберкулезным рекомбинантным (АТР), результат через 72 ч – отрицательный.



Задание

1. *Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.*
2. *Сформулируйте предварительный клинический диагноз, обоснуйте его, проведите дифференциальную диагностику с туберкулезом.*
3. *Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении при дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания.*
4. *Верифицирующие критерии саркоидоза.*
5. *Тактика лечения.*

Задача № 176

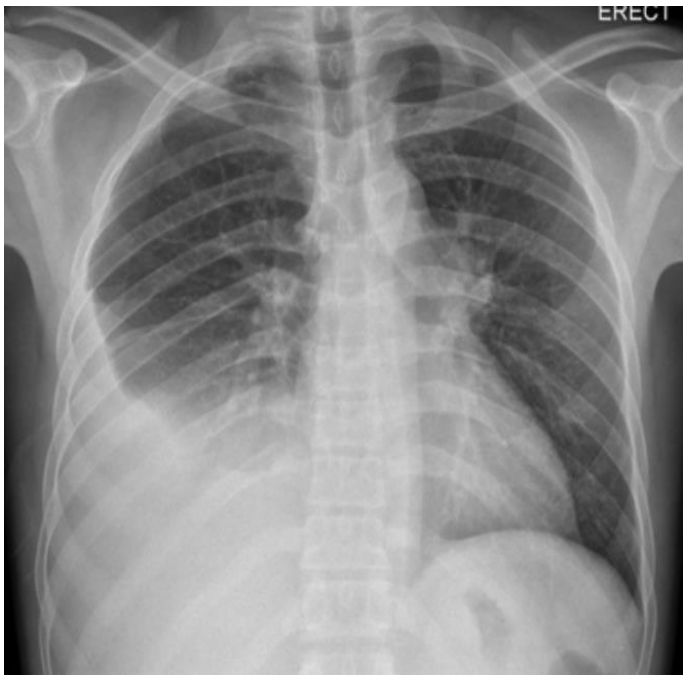
Больной 40 лет, разнорабочий продуктового рынка, поступил в приёмное отделение дежурного стационара с жалобами на слабость, боли в правой половине грудной клетки, одышку, повышение температуры до 38 °С.

Самочувствие ухудшилось резко после переохлаждения, появились сухой кашель, одышка при небольшой нагрузке, боли и тяжесть в грудной клетке, связанные с дыханием, повысилась температура. При более тщательном сборе анамнеза выяснилось, что больной около 2-х месяцев назад начал постепенно худеть, стал сильно уставать, считал это последствиями возросшей нагрузки на работе. Год назад имел контакт с родственником, больным туберкулезом, выделяющим МБТ (+).

При осмотре: состояние средней степени тяжести. Бледность кожных покровов, одышка с ЧД – 30 в минуту в покое. Пульс – 110 в минуту, удовлетворительного наполнения. Тоны сердца ясные, ритмичные. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, межреберные промежутки сглажены. Отмечается укорочение перкуторного звука, над нижними отделами правого лёгкого, голосовое дрожание ослаблено, дыхание в этих отделах не прослушивается. Живот мягкий, безболезненный, печень по краю реберной дуги, край острый, эластичный.

Клинический анализ крови: гемоглобин – 120 г/л, эритроциты – $4{,}8\times10^{12}$/л, лейкоциты – $9{,}0\times10^{9}$/л, палочкоядерные нейтрофилы – 8 %, сегментоядерные нейтрофилы – 66 %, эозинофилы – 1 %, лимфоциты – 18 %, моноциты – 7 %, СОЭ – 35 мм/ч.

Общий анализ мочи: соломенно-желтая, прозрачная, кислая, удельный вес – 1017, белок – 0,066 ‰, эпителий плоский – 2–3 в поле зрения, лейкоциты – 5–6 в поле зрения.



Задание

1. *Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.*
2. *Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, сформулируйте предварительный клинический диагноз, выработайте тактику врача при дифференциации этиологии плевральных выпотов.*
3. *Трижды производились плевральные пункции, удалено соответственно 800 мл, 400 мл, 150 мл соломенно-желтой, прозрачной жидкости, произведен анализ плеврального содержимого: белок 50 г/л, цитоз умеренно-клеточный, лимфоциты 96%, нейтрофилы 4%, КУМ, опухолевые клетки не обнаружены. Правильно поступил ли врач, трижды пропунктировав плевральную полость?*
4. *Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующие туберкулез.*

5. Картриджная ПЦР GeneXpert-технология выделила ДНК МБТ, чувствительность к рифампицину сохранена. Определите тактику лечения пациента.

Задача № 177

В приёмный покой многопрофильного стационара доставлена женщина 46 лет с жалобами на повышение температуры до 38,5 °С, боли в грудной клетке, кашель с мокротой слизисто-гнойного характера, утром в день обращения появились прожилки крови в мокроте. Профессия – преподаватель колледжа, ежегодное профилактическое флюорографическое обследование лёгких. Из анамнеза: в течение 4-х месяцев постепенно нарастала слабость, снижение аппетита, похудание. Ухудшение состояния после переохлаждения, неделю назад. В прошлом году имела туберкулёзный контакт с родственником. При осмотре: состояние средней степени тяжести. Истощена, кожные покровы бледные, акроцианоз. При кашле сплёвывает кровь, выделено 20-30 мл крови. Одышка, ЧД - 26 в минуту в покое. Правая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания. Укорочение перкуторного звука над нижней долей правого лёгкого. Там же бронхиальное дыхание, мелко- и среднепузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, ЧСС – 102 уд/./мин. Печень на 1 см выступает из-под края рёберной дуги. В остальном – без особенностей. Клинический анализ крови: гемоглобин – 95 г/л, эритроциты – $3{,}8\times10^{12}$/л, лейкоциты – $15{,}0\times10^{9}$ /л, палочкоядерные нейтрофилы - 14%, сегментоядерные нейтрофилы – 70%, эозинофилы – 1%, лимфоциты – 8%, моноциты – 7%, СОЭ – 45 мм/ч. В приемном покое куда обратилась пациентка по скорой медицинской помощи была выполнена рентгенография ОГК.





Задание

1. Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром.

2. Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, сформулируйте предварительный клинический диагноз, определите алгоритм действия врача учреждения первичной медико-санитарной помощи (УПМСП) при работе с пациентами с заболеваниями органов дыхания с подозрением на туберкулез, выделите у данного пациента факторы риска туберкулеза.
3. Определите дальнейшую тактику врача при обнаружении у пациентки КУМ и положительной (папула 10 мм) пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (проба с АТР, диаскинтест).
4. Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующие туберкулез органов дыхания.
5. Сформулируйте клинический диагноз, составьте план лечения с учетом осложнения и отсутствие на первоначальном этапе лабораторных данных по чувствительности к препаратам возбудителя туберкулеза. Определите работу с контактными лицами.

Задача № 178

Больной 27 лет обратился за медицинской помощью в дежурный стационар. Беспокоит в течение трех недель слабость, потливость, сонливость, повышенная раздражительность, потеря аппетита, влажный кашель, повышение температуры тела (37,5-38,0˚С), светобоязнь, одышка в покое. Обращался за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства. После проведённого обследования врачом-терапевтом участковым выставлен диагноз «ОРВИ, средней степени тяжести». Назначена симптоматическая терапия (жаропонижающие, антигистаминные препараты, витаминотерапия) с повторной явкой через пять дней. На фоне проводимого лечения состояние больного резко ухудшилось: нарастала интенсивность головной боли без чёткой локализации не снимаемая анальгетиками с рвотой, не связанной с приёмом пищи, без предшествующей тошноты, температура повысилась до 39 °С, стали отмечаться спонтанно возникающие и быстро исчезающие красные пятна на лице и груди. В общем анализе крови: эритроциты - $3,5\times10^{12}$/л, гемоглобин - 115 г/л, лейкоциты - $9,4\times10^{9}$/л, эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы - 7%, сегментоядерные нейтрофилы - 61%, лимфоциты - 17%, моноциты – 12%, СОЭ – 52 мм/час. Учитывая вышеперечисленные клинические симптомы, лабораторные изменения и течение заболевания, дежурным врачом-терапевтом была назначена консультация врача-невролога. При исследовании неврологического статуса выявлены положительные менингеальные симптомы (ригидность мышц затылка, Кернига, Брудзинского), расширение зрачков, расходящееся косоглазие. При проведении спинномозговой пункции обнаружено: повышенное давление (жидкость вытекает струёй), цитоз – 200 клеток в 1 мкл, состав - нейтрофилы – 10%, лимфоциты – 90%, хлориды – 70 ммоль/л, глюкоза – 0,6 ммоль/л, белок – 1,2 г/л. При проведении рентгенограммы органов грудной клетки (ОГК) был заподозрен туберкулезный процесс в лёгких, был проконсультирован фтизиатром и перенаправлен в специализированное учреждение, в котором был установлена впервые выявленная ВИЧ-инфекция, CD4+102 кл/мл.



Задание

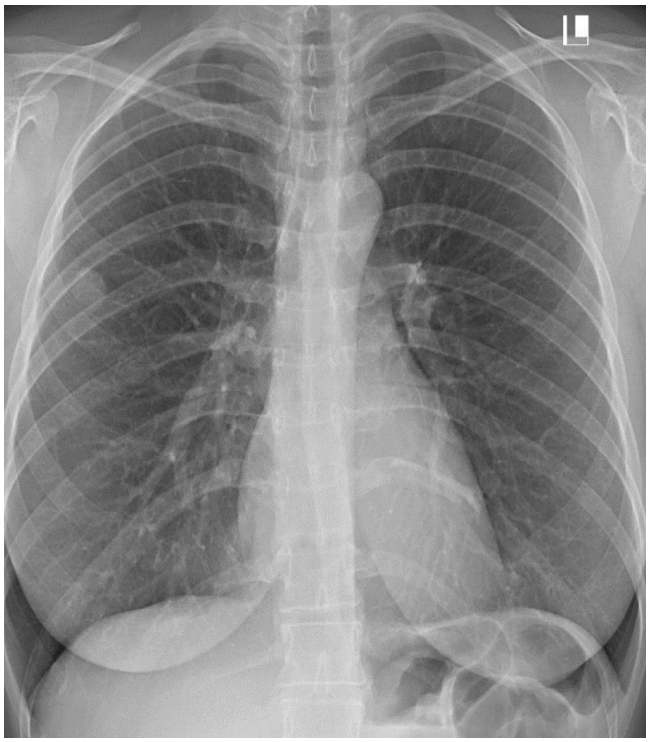
1. *Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний в лёгких и ЦНС.*
2. *Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, обоснуйте предварительный клинический диагноз. Определите по клинике какая пара черепно-мозговых нервов поражена у больного, какие ещё черепно-мозговые нервы могут поражаться при туберкулезе ЦНС.*
3. *Определите косвенные признаки ликвора туберкулезной этиологии.*
4. *Составьте алгоритм действия врача учреждения первичной медико-санитарной помощи (УПМСП) при работе с пациентом с подозрением на туберкулез. Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующих заболевание.*
5. *Сформулируйте клинический диагноз, составьте план лечения с учетом результатов бактериологического исследования мокроты и ликвора с установленной лекарственной чувствительностью МБТ к противотуберкулезным препаратам.*

Задача № 179

Женщина 35 лет изменения в лёгких выявлены при профилактическом флюорографическом обследовании. Условия жизни благополучные, профессиональных вредностей нет, работает продавцом-консультантом в торговом центре. Отмечает, что профилактическая флюорография не проводилась 4 года.

Жалоб не предъявляет, симптомы интоксикации отсутствуют. При объективном исследовании перкуторно, аускультативно патологии органов грудной клетки не выявлено. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 79 ударов в минуту, АД – 125/85 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. Общий анализ крови: эритроциты – $4{,}1\times10^{12}$/л, гемоглобин – 130 г/л, лейкоциты – $5{,}4\times10^{9}$/л, па-

лочкоядерные лейкоциты – 1 %, сегментоядерные лейкоциты – 68 %, лимфоциты – 25 %, моноциты – 4 %, СОЭ – 9 мм/ч. Для дообследования была направлена во фтизиопульмонологический медицинский центр. В мокроте КУМ методом бактериоскопии и ДНК МБТ методом Gene-Xpert MTB/RIF не обнаружены. Проба с АТР – папула 21 мм.



Задание

1. Опишите рентгенограмму ОГК. Выделите основной рентгенологический синдром. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний.

2. Перечислите клинические синдромы, интерпретируйте клинические анализы, сформулируйте предварительный клинический диагноз.

3. Определите методы диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующие туберкулез органов дыхания.

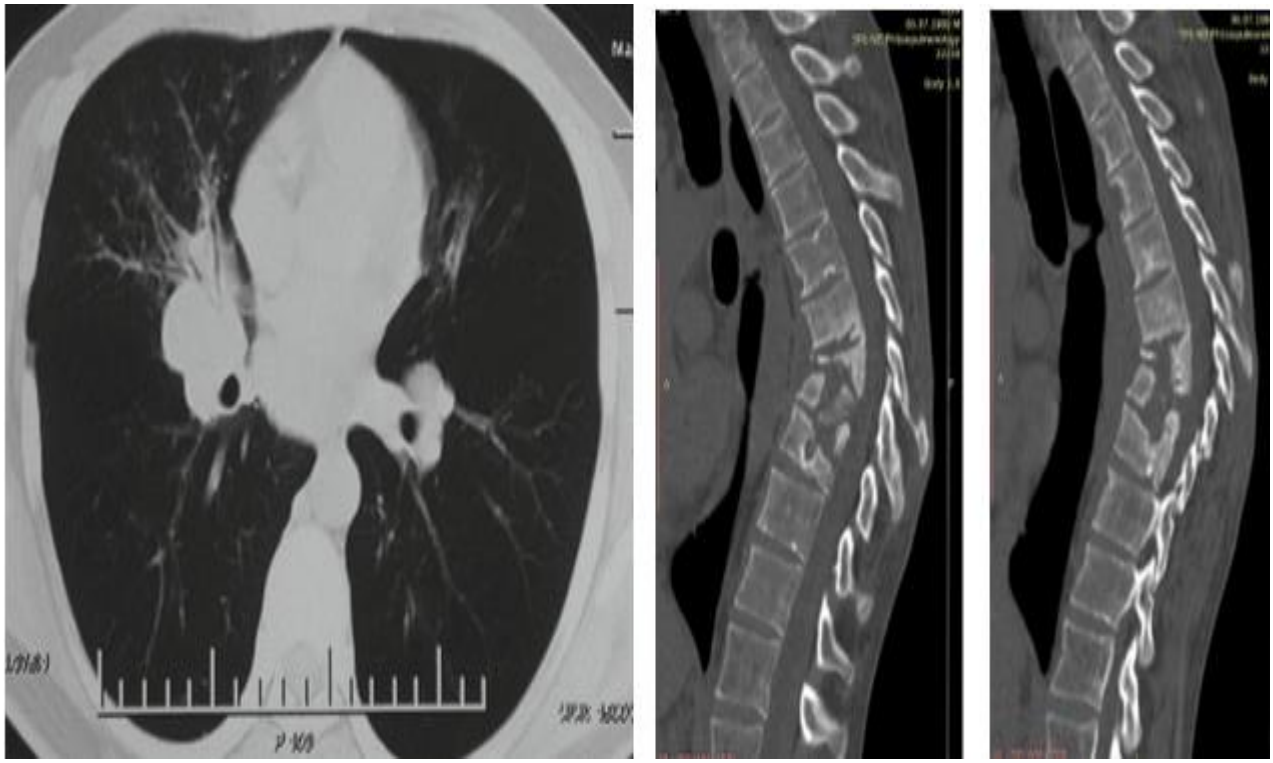
4. Определите роль иммунодиагностики в дифференциальной диагностике туберкулеза, перечислите методы и цели их применения.

5. *Тактика лечения, прогноз.*

Задача № 180

Пациент В., 37 лет. Поводом для обращения по скорой помощи в многопрофильный дежурный стационар послужили жалобы на выраженные боли в грудном и поясничном отделах позвоночника плохо купирующиеся анальгетиками, которые появились два месяца назад, усиливающиеся при изменении положения тела, с иррадиацией в левую нижнюю конечность, нарастающую слабость в ногах, подъем температуры тела до 38 ° С, на кашель с выделением мокроты слизистого характера. Из анамнеза выяснено, что страдает ВИЧ-инфекцией, которая впервые диагностирована 4 года назад в местах лишения свободы (МЛС), потребитель психоактивных веществ. После освобождения на учет в Центр по профилактике и борьбе со СПИ-Дом не встал, АРВТ не получал, проходил 2 года назад флюорографическое обследование, на дообследование не вызывался. При осмотре позвоночника наблюдаются напряженность мышц спины, выстояние остистого отростка Th7 позвонка, симптом осевой нагрузки резко положительный, в связи с этим занимает вынужденное согнувшееся положение. Парезов нижних ко-

нечностей, нарушений функций тазовых органов не выявлено. В общем анализе крови: эритроциты - $3,6\times10^{12}$/л, гемоглобин - 95 г/л, лейкоциты - $12,4\times10^{9}$/л, эозинофилы - 3%, палочкоядерные нейтрофилы - 7%, сегментоядерные нейтрофилы - 71%, лимфоциты - 7%, моноциты – 12%, СОЭ – 62 мм/час. CD 4+ 190 кл/мкл, вирусная нагрузка 630000 копий/мл. Выполнено СКТ органов грудной клетки (информативные сканы представлены для обсуждения). Проба с АТР – отрицательная.



Задание

1. *На представленных срезах КТ ОГК определите изменения в лёгочной паренхиме, средостении и позвоночнике. Представьте дифференциально-диагностический ряд синдромосходных заболеваний в лёгких и позвоночнике.*
2. *Перечислите клинические синдромы, факторы риска, интерпретируйте клинические анализы, обоснуйте предварительный клинический диагноз.*
3. *Составьте алгоритм действия врача учреждения первичной медико-санитарной помощи (УПМСП) при работе с ВИЧ-инфицированным пациентом с подозрением на туберкулез.*
4. *Перечислите обязательные методы лабораторной диагностики в специализированном противотуберкулезном учреждении, верифицирующие заболевание.*
5. *Картриджная ПЦР GeneXpert-технология выделила ДНК МБТ с устойчивостью к рифампицину. Определите тактику лечения пациента с учетом выявленной лекарственной устойчивостью возбудителя.*

Задача №181

Пациентка Р, 42 года, госпитализирована в хирургическое отделение в экстренном порядке с жалобами на невыносимые ноющие боли в левой подвздошной области и проекции лобка. Амбулаторное обследование исключило гинекологическую патологию. Боль началась три дня

назад и постепенно нарастала. В день обращения отметила субфибрильную температуру, позывы на мочеиспускание, снижение аппетита, тошноту, вздутие живота, не отхождение газов. При поверхностной пальпации определяется умеренная болезненность в левой подвздошной области. При небольшом натяжении выявляется болезненное опухолевидное образование в проекции сигмовидной кишки 15х10см, без четких контуров. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Напряжение мышц в левом гипогастрии. При лабораторном исследовании отмечается повышение уровня С-реактивного протеина. При сборе анамнеза пациентка упомянула, что при выполнении колоноскопии 2 года назад было выявлено несколько дивертикулов сигмовидной кишки. При трансвагинальном УЗИ по наружному контуру кишки определяется грыжевидное выпячивание пониженной эхогенности с размытыми контурами, с уплотненной клетчаткой вокруг. В просвете грыжевидного выпячивания гиперэхогенное включение (фекалит). Кишечная стенка в этой области утолщена до 7мм на протяжении 15 см до границы с прямой кишкой. Наличие жидкости в правом гипогастрии.

Задание:
1. Какой диагноз наиболее вероятен?
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести?
3. Какой метод исследования противопоказан в данной ситуации и почему?
4. С какими заболеваниями можно дифференцировать данное состояние?
5. Особенности лечебной тактики. В каком случае показано оперативное вмешательство?

Задача № 182

Пациентка П., 26 лет, работает поваром в столовой, после удара левой голени 2 дня назад отметила появление тяжести в левой голени к вечеру, на следующий день появился отек стопы и голени, умеренную синюшность стопы и голени. Обратилась к хирургу поликлиники. При осмотре отек до в/3 голени, боль при нажатии на икроножную мышцу и тыльной флексии стопы. По данным ультразвукового ангиосканирования вен нижних конечностей выявлен окклюзирующий тромбоз глубоких вен голени, подколенной вены и поверхностной бедренной вены до верхней трети бедра.

Задание:
1. Какой диагноз вероятен у данной пациентки?
2. Какие дополнительные исследования могут быть назначены? Назовите специфические симптомы диагностики (мануального обследования).
3. Определите стратегическую тактику в отношении этой больной.
4. Как изменится лечение, если у пациентки в анамнезе язвенная болезнь желудка с кровотечением?
5. Какие периоды антикоагулянтной терапии Вы знаете?

Задача № 183

Пациентка 76 лет, обратилась к хирургу с жалобами на увеличение в объеме стопы, голени и бедра левой н/к, распирающую боль в бедре, синюшний цвет кожи нижней конечности. Отмечает появление данных симптомов за день до посещения врача. При осмотре правая нижняя конечность не отечна, расширены притоки БПВ на голени. Левая нижняя конечность резко увеличена в объеме. При измерении голени слева увеличение на 1,5см по сравнению с правой, бедро увеличено на 2 см по сравнению с правой н/к. Кожные покровы левой конечности цианотичны. Симптомы Мозеса и Хоманса, Ловенберга положительны. Притоки БПВ расширены, полнокровны, выбухают.

Задание:

1. Поставьте диагноз.
2. Осложнением каких заболеваний может послужить это состояние?
3. Какова Ваша врачебная тактика?
4. Методы диагностики.
5. Какие методы лечения необходимы пациенту?

СПИСОК ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Гипертоническая болезнь II стадии, степень артериальной гипертензии 3. Риск 4. Гипертонический криз, осложненный отеком лёгких.
2. Идиопатическая пароксизмальная фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма, гемодинамически незначимый пароксизм.
3. ИБС. Стенокардия напряжения, функциональный класс III. Полная атриовентрикулярная блокада. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. ХСН, стадия IIБ, функциональный класс IV. Симптоматическая артериальная гипертензия III степени, риск 4.
4. ИБС: Острый трансмуральный передний распространенный инфаркт миокарда, острый период. Класс I по T. Killip, J. Kimball.
5. ИБС. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Класс I по T. Killip, J. Kimball. Артериальная гипертензия 3 стадии, риск 4.
6. ИБС: стабильная стенокардия напряжения, ФК III. ХСН, стадия IIА, ФК III**.** Комбинированная гиперлипидемия (IIb тип по D.S. Frederickson, R.S. Lee)
7. Основное заболевание: Первичный активный инфекционный эндокардит аортального клапана. Недостаточность аортального клапана III степени. Дилатация левого желудочка и левого предсердия, относительная недостаточность митрального клапана II степени. Иммуновоспалительная фаза (гепатит, гломерулонефрит). Анемия средней степени тяжести. Осложнения: ХСН, стадия IIА, ФК IV.
8. Дилатационная кардиомиопатия. Полная блокада левой ножки пучка Гиса. Редкая желудочковая экстрасистолия. ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (36 %), стадия II Б, ФК IV.
9. ИБС: острый инфаркт миокарда задненижний с подъемом сегмента ST, атипичный (астматический) вариант начала, острейший период, Класс III по T. Killip, J. Kimball. Фоновое заболевание: гипертоническая болезнь III ст., риск 4.
10. ИБС: стенокардия напряжения, ФК III. Постинфарктный кардиосклероз. Атриовентрикулярная блокада II степени, тип Мобитц I. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. ХСН, стадия II А, ФК III.
11. ИБС: прогрессирующая стенокардия. Гипертоническая болезнь III стадии; гипертрофия левого желудочка, риск 4. Ожирение I степени. Гиперхолестеролемия.
12. Хронический гломерулонефрит, гипертоническая форма (степень АГ 2). Если маркеры повреждения почек будут персистировать в течение более 3 месяцев, то обоснованным будет заключение о хронической болезни почек (ХБП) С3а, А2.

13. Хронический гломерулонефрит, смешанная форма (степень артериальной гипертензии 3, риск 4; нефротический синдром легкой степени), активная фаза. ХБП С5. Анемия средней степени тяжести. Уремический колит. Уремический перикардит. Желудочковая экстрасистолия.
14. Гипертоническая болезнь III ст. Первично-сморщенная почка. Хроническая болезнь почек, С5.
15. Миокардитический кардиосклероз. Синдром слабости синусового узла: синдром тахикардии-брадикардии. Фибрилляция предсердий, пароксизмальная форма. Синоатриальная блокада 2 степени. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса.
16. Постоперационная тромбоэмболия лёгочной артерии высокого риска.
17. Острый лейкоз (неуточненный вариант). Метапластическая анемия, средней степени тяжести. Метапластическая тромбоцитопения. Тяжелый геморрагический синдром.
18. Витамин-В12-дефицитная анемия, по-видимому, связанная с дефицитом внутреннего фактора Кастла.
19. Железодефицитная анемия, средней степени тяжести.
20. Язвенная болезнь ДПК: язва на передней стенке луковицы ДПК (d=0,8 см). хроническое рецидивирующее течение, обострение. Рецидивирующее кровотечение. F III тип. Железодефицитная (хроническая постгеморрагическая) анемия средней степени тяжести.
21. Серопозитивный ревматоидный артрит, АЦЦП+, эрозивный, развёрнутая клиническая стадия, умеренная активность (DAS28=5,0), рентгенологическая стадия II, функциональный класс недостаточности суставов II. Ревматоидный артрит, серопозитивный, АЦЦП+, развёрнутая стадия, умеренная активность (DAS28=5,0), эрозивный (рентгенологическая стадия II), ФК III.
22. Анкилозирующий спондилит, поздняя стадия, активность умеренная (BASDAI 3,2). Двусторонний сакроилиит, стадия 3. Двусторонний коксит. Внеаксиальные проявления (олигоартрит коленных суставов). ФК III. Осложнения: шейно-грудной кифоз.
23. Основное заболевание. Хроническая тофусная подагра: олигоартрит в фазе обострения, нефролитиаз; подкожные тофусы, гиперурикемия.
Сопутствующее заболевание. Гипертоническая болезнь II стадии, АГ II степени. Гипертрофия левого желудочка. Гиперлипидемия, гиперурикемия, ожирение; Риск 3. Целевое АД <130 / <80
24. Повторная ревматическая лихорадка: кардит. Комбинированный порок сердца: стеноз и недостаточность митрального клапана. Фибрилляция предсердий, тахисистолическая форма. Хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, ФК IY. Сердечная астма.
25. Первичный остеоартроз, генерализованная форма: двухсторонний гонартроз, стадия III (по Келлгрену) двухсторонний коксартроз, артроз дистальных межфаланговых суставов кистей (ДМФС); вторичный синовит ДМФС, коленных суставов. Фоновое заболевание: ожирение I степени (ИМТ-31)
26. Повторная ревматическая лихорадка: кардит. Стеноз митрального клапана. ХСН II-А. ФК II.
27. Системная красная волчанка, подострое течение, активность высокая (SLEDAI - 12 баллов): полиартрит, фотосенсибилизация, поражение кожи и придатков (васкулитная «бабочка». хейлит. алопеция)) нефрит, ХБП?, гематологические нарушения (тромбцитопения, лейкопения, анемия гемолитическая? нормохромная легкой степени), анти-ДНК+
28. Системная склеродермия, хроническое течение, генерализованная стадия., акт IIст., лимитированная форма: синдром Рейно, индурация и гиперпигментация кожи, телеангиэктазии, эзофагопатия, суставно-мышечный синдром с контактурами, акроостеолиз, диффузный фиброзирующий альвеолит с формированием «сотового лёгкого». ДН?; кардиосклероз, (хроническое лёгочное сердце?), полная блокада правой ножки пучка Гиса, экстрасистолия. ХСН Iст.
29. Внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, неуточненной этиологии, легкое течение, осл.: диафрагмальным фибринозным плевритом.
30. Бронхиальная астма, сложного генеза (инфекционно-зависимая, физического усилия), неконтролируемая, средней степени тяжести, в фазе обострения, ДН0.

31. Бронхиальная астма, атопическая форма, легкое персистирующее течение, неконтролируемая, обострение средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность I степени. Поллиноз с проявлениями аллергического риноконъюнктивита.
32. Внебольничная правосторонняя среднедолевая пневмония, вызванная неуточненным возбудителем, тяжелое течение. ДН 2 ст.
33. Варикозная болезнь: расширение вен голеней. ХВН 2. Острый тромбофлебит вен левой голени. Тромбоэмболия лёгочной артерии.
34. Хроническая обструктивная болезнь лёгких III ст. (GOLD), эмфизематозный тип, частые обострения, mMRC 3, группа D; обострение. Соп. ИБС. Стенокардия II ФК. Постинфарктный кардиосклероз (Q-образующий неуточненной давности). Желудочковая экстрасистолия. ХСН I ст., ФК II.
35. Бронхиальная астма, инфекционно-зависимая, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая, обострение. Осложнение: Экзогенный гиперкортицизм.
36. Внебольничная пневмония в нижней доле левого лёгкого, тяжелое течение. Осл.: Абсцесс нижней доли левого лёгкого с прорывом гноя в бронх.
37. Хронический лимфолейкоз, В-стадия. Метапластическая анемия легкой степени.
38. В12-дефицитная анемия, тяжелой степени.
39. Апластическая анемия.
40. Синдромный диагноз «панцитопения неясной этиологии».
41. Аутоиммунная гемолитическая анемия, острое течение, гемолитический криз.
42. Язвенный колит, проктосигмоидит, среднетяжелая атака.
43. Наследственная целиакия.
44. Язвенная болезнь ЛДПК, фаза обострения
45. Хронический атрофический гастрит, Нр-ассоциированный, фаза обострения. Функциональная диспепсия.
46. ГЭРБ: рефлюкс-эзофагит, обострение. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
47. Хронический токсический (курение, алкоголь) панкреатит, сочетанная клиническая симптоматика, часто рецидивирующий (3 и более раз в год), с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы (дефицит веса). Осложнение: синдром мальабсорбции тяжелой степени.
48. Предварительный диагноз «цирроз печени (токсического (алкогольного) генеза), активная фаза, класс «С» по Child-Pugh (14 баллов).
49. Системная красная волчанка, острое течение, активность III степени: с поражением почек, с поражением серозных оболочек, с поражением суставов, поражением кожи, гематологическими нарушениями. Вторичная Артериальная гипертензия.
50. Внебольничная пневмония, в нижней доле (8, 9 и 10 сегменты) левого лёгкого, нетяжелое течение.
51. Атеросклероз аорты, почечных сосудов. Возможный стеноз почечной артерии справа. Вазоренальная гипертония, 3 степень АГ. ГЛЖ. Хроническая болезнь почек стадии 3А. Гиперхолестеролемия. Перемежающаяся хромота, ишемия 2А степени. Риск ССО 4.
52. Бронхиальная астма.
53. Хронический гломерулонефрит. Хроническая болезнь почек 5 стадия (СКФ 14 мл/мин/1,73м^2 по формуле SKD/ EPI). Альбуминурия 3 ст. Артериальная гипертония 3 ст. почечного генеза, очень высокий риск ССО. Нефрогенная анемия тяжелой степени. Азотемическая (метаболическая) кардиомиопатия с нарушениями ритма по типу желудочковой экстрасистолии. Хроническая уремическая энцефалопатия.
54. Острый гломерулонефрит, отечно-гипертонический вариант. Фон. Хронический тонзиллит, обострение. Хронический гнойный риносинусит.
55. Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (анальгетическая нефропатия). ХБП 4 стадия (СКФ по формуле SKD/EPI 24 мл/мин.). Артериальная гипертензия 3 ст., риск ССО очень высокий. Соп. Эрозивный гастрит, индуцированный приемом НПВП. Нормохромная анемия легкой степени, неуточненная.

56. Хроническая обструктивная болезнь лёгких IV стадия; с выраженными клиническими симптомами, частыми обострениями; смешанный, преимущественно бронхитический фенотип. Осложнение: ДН 2 ст. Хроническое лёгочное сердце, декомпенсированное.
57. Алкогольная болезнь печени: Хронический гепатит, умеренной активности, неуточненная стадия фиброза.
58. ИБС: постинфарктный кардиосклероз. Осл. ХСН 2Б, ФК III. Полная блокада левой ножки п. Гиса. Фон. ГБ 3 стадии, 2 степень АГ. Дислипидемия. Риск 4. Анемия гиперхромная, легкой степени, неуточненного генеза.
59. ИБ: ПИКС, постоянная форма ФП, тахисистолия 130 уд. в мин. ХСН II Б, ФК III. Гипертоническая болезнь III стадия, II степень АГ. ГЛЖ. Сахарный диабет 2 тип. Ожирение 1 ст. Дислипидемия.
60. Хронический болевой синдром сложного генеза (соматический и нейропатический), тяжелой степени, 7-8 баллов по ЦРШ.
61. Беременность 10 недель. Первичное инфицирование краснухой в 8 недель беременности.
62. Поздний послеродовый период. Срочные роды, осложненные аномалией прикрепления плаценты: плотное прикрепление плаценты. Операция: ручное отделение плаценты и выделение последа. Острый послеродовый эндометрит, классическая форма.
63. Беременность 40 недель. Латентная фаза первого периода срочных родов в головном предлежании плода. ОАА. Первичная слабость родовой деятельности.
64. Объёмное образование левого яичника
65. Беременность 38 недель. ОАА. Первый период срочных родов в головном предлежании плода. Полный свершившийся разрыв матки по рубцу после кесарева сечения. Интранатальная гибель плода. Геморрагический шок 3 степени.
66. Рак эндометрия (аденокарцинома) I стадия, G1, I патогенетический вариант.
67. Кесарево сечение (акушерская бригада), вторым этапом - аппендэктомия.
68. Маточное кровотечение в пубертатном периоде. Подозрение на постгеморрагическую анемию.
69. Острый эндометрит после искусственного аборта (N71.0 Острые воспалительные заболевания матки)
70. Острый генитальный пельвиоперитонит (N73.3 Острый тазовый перитонит у женщин)
71. Двусторонние опухоли яичников.
72. Миома матки 8 недель. Подозрение на миоматозный узел 0-III тип по Figo. Хроническое АМК, хроническая постгеморрагическая анемия II степени тяжести.
73. Экзофитный рак шейки матки IB2? Контактное кровотечение.
74. Миома матки 14-15 недель беременности. Осложнение: Нарушение питания миоматозного узла.
75. Множественная миома матки 24 недели беременности.
Сопутствующий: Эктропион шейки матки, гиперплазия эндометрия без атипии.
76. Вторичная дисменорея.
77. Двусторонние опухоли яичников. Асцит.
78. Апоплексия правого яичника анемическая форма. Геморрагический шок II степени.
79. Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок 3 степени. Внематочная трубная беременность: разрыв маточной трубы?
80. Подозрение на внематочную беременность, прервавшуюся по типу трубного аборта.
81. Беременность 40 недель. ОАА. Первый период срочных родов в головном предлежании плода. Раннее излитие околоплодных вод. Плоскорахитический таз 1 степени, задний асинклитизм. Крупный плод (3990 г.). Клинически узкий таз II степени. Угрожающий разрыв матки.
82. Акушерский перитонит после кесарева сечения, стёртая клиническая картина. Ранняя форма.
83. Акушерский диагноз: беременность 37 недель, незрелая шейка матки, эклампсия.
84. Первый период срочных родов в головном предлежании. Дискоординированная родовая

деятельность: тетанус матки. Кардиопульмональный шок. Эмболия амниотической жидкостью? Интранатальная гибель плода.
85. Беременность 35 недель. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты средней степени тяжести. Дистресс плода. Геморрагический шок I ст.
86. III период срочных одноплодных родов в головном предлежании. Кровотечение. Аномалия прикрепление плаценты.
87. Внебольничный инфицированный аборт. Сепсис.
88. Полное предлежание плаценты. Геморрагический шок I степени. Дистресс плода.
89. Раннее послеродовое гипотоническое маточное кровотечение. Патологическая кровопотеря.
90. Беременность 35 недель. Головное предлежание плода. Сахарный диабет 1 типа в фазе декомпенсации (без достижения целевых значений). Хроническая передозировка инсулина (постгипогликемическая гипергликемия). Диабетическая полинейропатия. Диабетическая нефропатия. Диабетическая фетопатия (4664 гр). Дислипидемия. Ожирение. Жировой гепатоз.
91. Послеродовый лактационный инфильтративный мастит правой молочной железы.
92. Беременность 27 недель. Осложнения: Острый гестационный пиелонефрит, неосложненное течение.
93. Беременность 36,4 недели. Ревматическая болезнь сердца. Протезированный митральный клапан (двустворчатый шарнирный протез). ХСН 1 ст.
94. Беременность 27 недель. ОАА. Головное предлежание плода. Хроническая железодефицитная анемия средней степени. Плацентарная недостаточность с задержкой роста плода 1 ст.
95. Беременность 33 недели. Головное предлежание плода. Плацентарная недостаточность с задержкой роста плода I степени без гемодинамических нарушений. Хронический гломерулонефрит, нефритический синдром, морфологическая форма не уточнена, ХБП 2.
96. ЖКБ. Лапароскопическая холецистэктомия (1,5 месяца назад). Резидуальный холедохолити-аз. Механическая желтуха. Холангит средней степени тяжести.
97. Мозольный абсцесс ладонной поверхности правой кисти в области III-IV межпальцевого промежутка. Осложнения: комиссуральная флегмона, флегмона срединного ладонного пространства и пространства Пирогова-Парона. Подмышечный лимфаденит
98. Острый аппендицит.
99. Тромбоз мезентериальных сосудов бассейна ВБА (art. ileocolica - III сегмент). Осложнения: динамическая кишечная непроходимость, некроз кишки? перитонит?
100. ЖКБ. Острый калькулезный холецистит(обтурационный), легкой степени.
101. Хронический токсический панкреатит (алкогольный), рецидивирующего течения. Постнекротическая псевдокиста поджелудочной железы.
102. Ахалазия кардии II стадии (по Б.В. Петровскому, 1962г.)
103. Ущемленная диафрагмальная грыжа.
104. Рак пищевода нижнегрудного отдела пищевода. Дисфагия I степени.
105. Язвенная болезнь желудка. Хроническая язва угла желудка (3х3 см). Продолжающееся кровотечение (F1).
106. Спаечная болезнь кишечника. Острая кишечная непроходимость.
107. Расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты, тип В по Стэнфордской классификации, хроническое течение. Разрыв аневризмы? Фоновые заболевания: Атеросклероз. ИБС, ОИМ 2 года назад. Гипертоническая болезнь.
108. Перфорация пищевода рыбьей костью. Острый медиастинит.
109. Тупая травма живота, разрыв (двухмоментный) селезенки. Внутрибрюшное кровотечение. Геморрагический шок 3 степени.
110. Тромбэмболия плечевой артерии левой верхней конечности. Острая ишемия IIA стадии.
111. Цирроз печени вирусной этиологии (геп В). Осложнения: Портальная гипертензия. Асцит. Варикозное расширение вен пищевода III степени. Продолжающееся кровотечение. Геморрагический шок I степени. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести.

112.Острый аппендицит, аппендикулярный инфильтрат. Абсцедирование инфильтрата?
113.ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз. Механическая желтуха. Холангит.
114.Острый панкреатит. Сопутствующий диагноз: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Холедохолитиаз?
115.Синдром Мэллори-Вейса II степени (по Бельману), продолжающееся кровотечение.
116.Ранняя спаечная тонкокишечная непроходимость.
117.Перфоративная язва, перитонит.
118.Ущемленная пахово-мошоночная грыжа слева. Острая кишечная непроходимость.
119.Декомпенсированный пилородуоденальный стеноз. Язвенная болезнь желудка и ДПК? Злокачественное новообразование желудка?
120.Прободная язва. Перитонит.
121.ВИЧ-инфекция, стадия 3 (субклиническая).
122. Клещевой энцефалит, менингеальная форма, тяжелая степень тяжести.
123.Иксодовый клещевой боррелиоз, острое течение, эритемная форма, легкой степени.
124.Грипп, среднетяжелое течение.
125. Аденовирусная инфекция, среднетяжелое течение.
126. Дифтерия ротоглотки, токсическая II степени, тяжелое течение.
127. Инфекционный мононуклеоз, типичная форма, среднетяжелое течение.
128.Малярия (вероятно, вызванная *P. vivax*), первичная, неосложненная.
129.Острый шигеллез, колитический вариант, легкое течение.
130.Холера, очень тяжелое течение (обезвоживание IV степени).
131.Сальмонеллез, гастроинтестинальная форма, гастроэнтеритический вариант, средней степени тяжести.
132. Ботулизм, среднетяжелая форма.
133. Брюшной тиф, типичная форма, средней степени тяжести.
134. Псевдотуберкулез, острое течение, смешанная форма, скарлатиноподобный вариант, средней степени тяжести.
135. Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус идентифицирован, среднетяжелое течение. Фоновое заболевание: Сахарный диабет 2 типа.
136. Острый описторхоз, гепатохолангитический вариант, среднетяжелое течение.
137.Острый вирусный гепатит А, желтушный вариант.
138. Острый вирусный гепатит В, желтушный вариант.
139. Острый вирусный гепатит С, безжелтушный вариант.
140.Рожа левой нижней конечности, распространенная, эритематозно-буллезная форма, средней степени тяжести, первичная.
141. Острый бруцеллез, средней степени тяжести.
142. Менингококковая инфекция, менингит, средней степени тяжести.
143. Чума, бубонная форма, тяжелое течение.
144. Менингококковая инфекция, менингококкемия, тяжелое течение. Инфекционно-токсический шок II степени.
145. Городское бешенство, стадия возбуждения.
146.Острый уриногенный необструктивный пиелонефрит справа.
147.Мочекаменная болезнь. Камень нижней трети левого мочеточника.
148.Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 2 стадия.
149.Закрытая травма левой почки. Разрыв нижнего полюса левой почки. Осложнение основного заболевания: Почечное кровотечение. Блок левой почки. Формирование забрюшинной урогематомы. Постгеморрагическая анемия легкой степени.
150.Первичное варикоцеле слева, 2 степень.
151.Мочекаменная болезнь. Камень ЛМС слева. Осложнение: Острый обструктивный пиелонефрит слева.
152. Опухолевый стеноз выходного отдела желудка, субкомпенсация.

153.Рак правой молочной железы T2N0Mx, стадия II.
154.Колоректальный рак (ободочной кишки/верхнеампулярного/ректосигмоидного отделов прямой кишки).
155.Рак головки поджелудочной железы.
156.Рак щитовидной железы (медуллярный). T4N1M1, стадия IV.
157. Рак эндометрия (аденокарцинома) I стадия, G1, I патогенетический вариант.
158. Центральный рак нижней доли правого лёгкого T2NxMx.
159. Рак нижней трети пищевода.
160. Рак левой молочной железы. Отечно-инфильтративная форма.
161. Рак правой молочной железы IIA стадия T2N0M0.
162.Сахарный диабет, 1 тип, целевой уровень гликированного гемоглобина < 7% (достигнутый - 9,4%). Осложнения основного заболевания: Диабетическая препролиферативная ретинопатия. Диабетическая нефропатия, ХБП С3б А2.
163.Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликированного гемоглобина <7% (достигнутый – 7,6%). Сопутствующие заболевания: Алиментарно-конституциональное ожирение 1 степени (ИМТ-31 кг/м^2), абдоминальная форма. Артериальная гипертензия, 3 степень, риск IV. Дислипидемия. Стеатогепатит (?)
164. Сахарный диабет. Гипогликемическая кома
165. Сахарный диабет 2 тип, целевой HbA1c <7%
166. Сахарный диабет 2 тип, целевой уровень HbA1c <8%. ЗАНК. Синдром диабетической стопы, ишемическая форма, язвенный дефект 4 пальца правой стопы.
167. Сахарный диабет 2 тип, целевой уровень HbA1c <8%. Диабетическая сенсорная нейропатия. Синдром диабетической стопы, нейропатическая форма, язвенный дефект правой стопы, II-III ст. (по Wagner), раневая инфекция средней степени тяжести.
168. Экзогенно-конституциональное ожирение 1 степени (ИМТ=32 кг/м^2), абдоминальная форма. Нарушение толерантности к углеводам. Артериальная гипертензия (степень и риск требуют уточнения). Дислипидемия. Жировой гепатоз (стеатогепатит?).
169. Манифестный первичный гипотиреоз. Анемия.
170.Подострый (вирусный) тиреоидит. Транзиторный тиреотоксикоз, лёгкой степени тяжести.
171. Диффузный токсический зоб 2 степени (ВОЗ, 2001). Манифестный тиреотоксикоз, средней степени тяжести. Обменно-эндокринная кардиопатия, ХСН II (NYHA).
172.Инфильтративный туберкулез S2 правого лёгкого в фазе распада и обсеменения, МБТ (+), I группа диспансерного наблюдения.
173. Милиарный туберкулез, очаговая двусторонняя пневмония, милиарный карциноматоз.
174. Деструктивная пневмония верхней доли правого лёгкого. Инфильтративный туберкулез S2 справа в фазе распада и обсеменения.
175.Саркоидоз внутригрудных лимфоузлов, активная фаза.
176. Экссудативный плеврит справа. Очаговый туберкулез S1 правого лёгкого?
177.Синдром участка уплотнения / затемнения лёгочной ткани. Полисегментарная правосторонняя нижнедолевая пневмония.
178. Подострый диссеминированный туберкулез, очаговая двусторонняя пневмония. Менингизм, серозные вирусные менингиты, гнойные менингиты, опухоли головного мозга, субарахноидальные кровоизлияния, абсцессы головного мозга.
179. Синдром округлой тени. Туберкулема правого лёгкого (предположительно в S6). Шаровидная пневмония, периферический рак.
180.ВИЧ, 4В стадия, фаза прогрессирования без АРВТ, с проявлением множественных вторичных заболеваний. Генерализованный туберкулез с поражением внутригрудных лимфатических узлов, позвоночника.
181. Дивертикулярная болезнь. Острый паракишечный инфильтрат
182. Тромбоз глубоких вен левой нижней конечности на уровне бедра.
183. Острый флеботромбоз глубоких вен левой нижней конечности. Илеофеморальный тромбоз.

5. Рекомендации обучающимся

1. Для подготовки к I этапу государственного экзамена необходимо:
- повторение пройденного материала по вопросам для тестирования, изложенным в разделе 4 настоящей программы;
2. Для подготовки ко II этапу государственного экзамена необходимо:
- повторение пройденного материала по клиническим дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе ситуационных задач, изложенных в разделе 4 настоящей программы;
- посещение консультаций на клинических кафедрах в соответствии с расписанием.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Комяков, Б. К. Урология: учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 480 с. - 978-5-9704-6431-1. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464311.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов: в 2 томах. Том 2 / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 896 с. - 978-5-9704-5315-5. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453155.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
3. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов: в 2-х томах. Том 1 / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 960 с. - 978-5-9704-5314-8. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453148.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
4. Гиллер, Д. Б Фтизиатрия: учебник / Д. Б Гиллер, В. Ю. Мишин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 576 с. - 978-5-9704-5490-9. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454909.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
5. Дедов, И. И. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 416 с. - 978-5-4235-0159-4. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501594.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
6. Давыдов, М. И. Онкология: учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 920 с. - 978-5-9704-5616-3. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456163.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
7. Акушерство: учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, М. А. Курцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 656 с. - 978-5-9704-5324-7. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

8. Поликлиническая терапия: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" / под ред. И. Л. Давыдкина, Ю. В. Щукина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. - 978-5-9704-3821-3. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438213.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
9. Акушерство: национальное руководство / ред. Э. К. Айламазян [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 978-5-9704-6104-4. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461044.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
10. Хирургические болезни: учебник для студентов медицинских вузов: в 2-х томах. Том 1 / ред.: В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 720 с. - 978-5-9704-3998-2. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439982.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
11. Сумин, С. А. Анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / С. А. Сумин, И. И. Долгина. - Москва : МИА, 2015. - 496 с. - 978-5-9986-0219-1. - Текст: электронный. // ЭБС МИА: [сайт]. - URL: https://www.medlib.ru/library/signin?bookID=2302 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
12. Хирургические болезни: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" по дисциплине "Хирургические болезни": в 2-х томах. Том 2 / под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко ; рец.: А. Г. Бебуришвили, А. И. Чернооков.; Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 688 с. - 978-5-9704-3999-9. - Текст: непосредственный.
13. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник для студентов медицинских вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико, Б. К. Данилкин.; RU.Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. - 978-5-9704-3822-0. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438220.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.
14. Маколкин, В. И. Внутренние болезни: учебник / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1 on-line - 978-5-9704-4157-2. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441572.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Лучевая диагностика: учебник / под ред. Г. Е. Труфанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 484 с. - 978-5-9704-6210-2. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462102.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

2. Бокарев, И. Н. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение: учебник / И. Н. Бокарев, Л. В. Попова. - Москва : МИА, 2015. - 776 с. - 978-5-9986-0217-7. - Текст: электронный. // ЭБС МИА: [сайт]. - URL: https://www.medlib.ru/library/signin?bookID=2770 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

3. Бронштейн, А. М. Тропические болезни и медицина болезней путешественников: руководство / А. М. Бронштейн. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - 978-5-9704-3905-0. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439050.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

4. Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник для студентов высших медицинских и фармацевтических учебных заведений / М. Н. Чернявский; рец.: В. Ф. Новодранова, Р. Е. Березникова.; RU.Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), кафедра латинского языка и медицинской терминологии. - Москва : Шико, 2020. - 448 с. - 978-5-900758-98-5. - Текст: непосредственный.

5. Лекции по физической культуре: учебное пособие для студентов 1-5 курсов медицинского университета / А. В. Смышляев, В. Н. Васильев, Е. В. Немеров, Е. В. Бондаренко, О. В. Гусева; под науч. ред. А. В. Смышляева, В. Н. Васильева.; RU.Сибирский медицинский университет. - Томск: Издательство СибГМУ, 2020. - 176 с. - Текст: электронный. // ЭБС СибГМУ: [сайт]. - URL: https://irbis64.ssmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?P21DBN=ELS&I21DBN=ELS&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=-448836207&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

6. Викторова, И. А. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в амбулаторной практике: учебное пособие / И. А. Викторова, И. А. Гришечкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 184 с. - 978-5-9704-6743-5. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970467435.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

7. Ревматология: клинические рекомендации / под ред. Е. Л. Насонова.; RU.Ассоциация ревматологов России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1 on-line - 978-5-9704-4261-6. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442616.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

8. Интенсивная терапия: национальное руководство / под ред.: И. Б. Заболотских, Д. Н. Проценко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1056 с. - 978-5-9704-6259-1. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462591.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

9. Гематология: национальное руководство / ред. О. А. Рукавицын ; рец.: А. И. Воробьев, А. Г. Румянцев, А. А. Рагимов.; RU.Ассоциация врачей-гематологов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. - 978-5-9704-5270-7. - Текст: непосредственный.

10. Болезни оперированного желудка: монография / Г. Ц. Дамбаев, Н. Э. Куртсеитов, А. П. Кошель [и др.]; рец. Н. В. Мерзликин.; RU.Сибирский медицинский университет. - Томск: Издательство СибГМУ, 2020. - 196 с. - 978-5-98591-155-8. - Текст: электронный. // ЭБС СибГМУ: [сайт]. - URL: https://irbis64.ssmu.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?P21DBN=ELS&I21DBN=ELS&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=0&2_S21P03=I=&2_S21STR=-818757000&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

11. Амбулаторная урология: руководство / П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкарь, А. В. Зайцев, Л. М. Рапопорт; ред. Е. А. Мартынова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - 978-5-9704-4904-2. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

12. Гастроэнтерология: национальное руководство / ред.: В. Т. Ивашкин, Т. Л. Лапина.; RU.Российская гастроэнтерологическая ассоциация. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с. - 978-5-9704-4406-1. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

13. Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии: руководство для врачей / ред. Э. К. Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - 978-5-9704-3945-

6. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

14. Паразитология: учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки специалитета 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / Москва).; RU.Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2019. - 296 с. - 978-5-9986-0332-7. - Текст: электронный. // ЭБС МИА: [сайт]. - URL: https://www.medlib.ru/library/signin?bookID=36023 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

15. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: руководство / В. Н. Серов, И. И. Баранов, О. Г. Пекарев [и др.] - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - 978-5-9704-4054-4. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440544.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

16. Общие и частные вопросы медицинской профилактики: [руководство] / под ред.: К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - 978-5-9704-4575-4. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970445754.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

17. Пульмонология: национальное руководство / ред. А. Г. Чучалин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - 978-5-9704-5323-0. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

18. Нефрология / ред.: Е. М. Шилов, А. В. Смирнов, Н. Л. Козловская.; RU.Ассоциация нефрологов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 816 с. - 978-5-9704-3714-8. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437148.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

19. Онкология: национальное руководство / гл. ред. В. И. Чиссов, М. И. Давыдов ; науч. ред. Г. А. Франк, С. Л. Дарьялова.; RU.Ассоциация онкологов России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - 978-5-9704-3982-1. - Текст: электронный. // ЭБС КВ: [сайт]. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

20. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство: учебное пособие / ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев, Н. А. Григорьев. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный. // ЭБС КС: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.

21. Лисицын, Ю. П. История медицины: учебник для студентов медицинских вузов по дисциплинам "Общественное здоровье и здравоохранение" и "История медицины" / Ю. П. Лисицын; рец.: М. Б. Мирский, Н. С. Ягья, В. А. Медик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 400 с. - 978-5-9704-6673-5. - Текст: непосредственный.

22. Седова, Н. Н. Биоэтика: учебник / Н. Н. Седова. - Москва : КноРус, 2019. - 216 с. - 978-5-406-07184-7. - Текст: электронный. // ЭБС Book.ru: [сайт]. - URL: https://www.book.ru/book/931753 (дата обращения: 25.03.2025). - Режим доступа: по подписке.